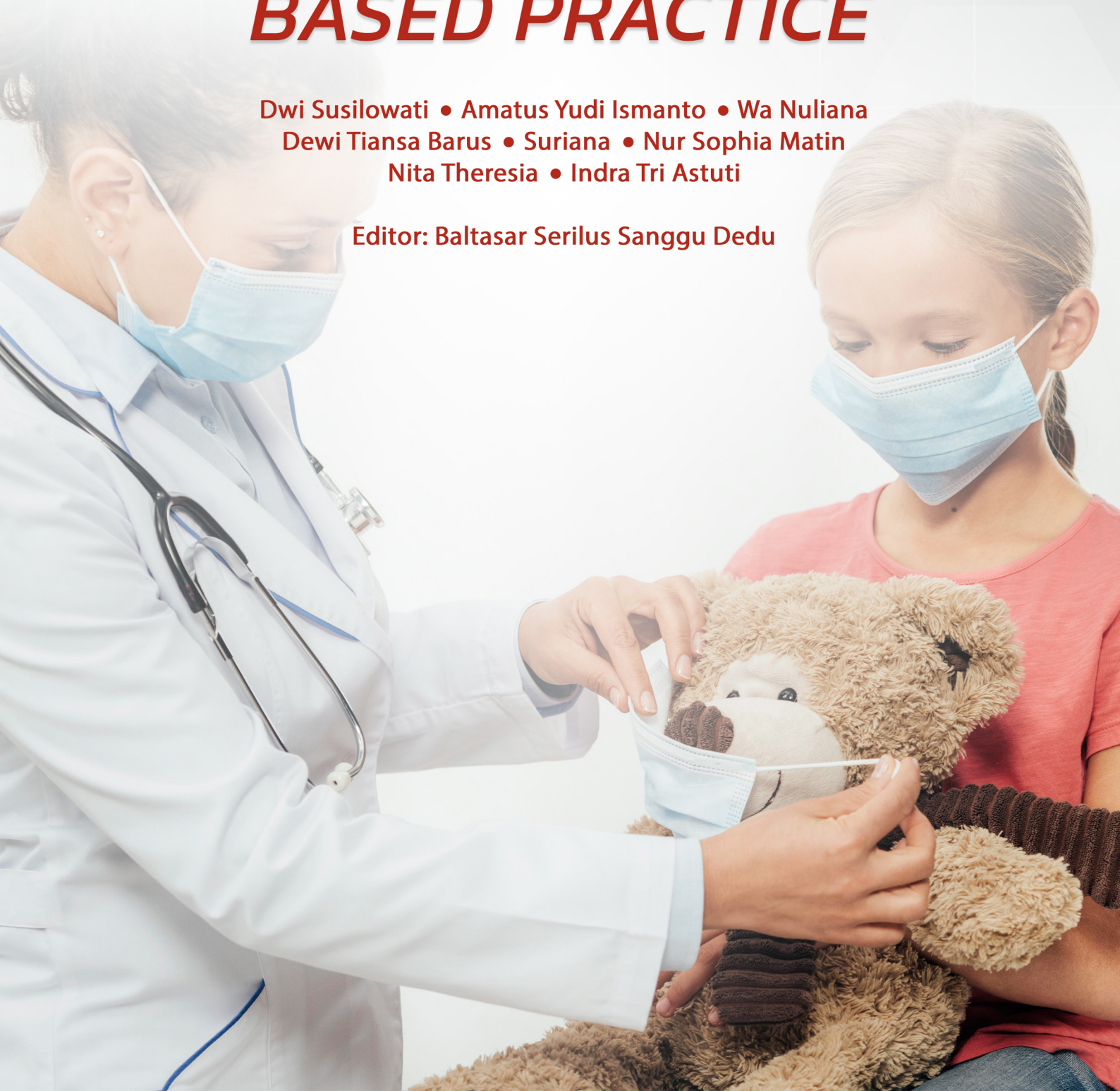


Bunga Rampai

ASUHAN KEPERAWATAN ANAK KOMPREHENSIF BERBASIS *EVIDENCE* *BASED PRACTICE*

Dwi Susilowati • Amatus Yudi Ismanto • Wa Nuliana
Dewi Tiansa Barus • Suriana • Nur Sophia Marin
Nita Theresia • Indra Tri Astuti

Editor: Baltasar Serilus Sanggu Dedu



BUNGA RAMPAI: ASUHAN KEPERAWATAN ANAK KOMPREHENSIF BERBASIS EVIDENCE- BASED PRACTICE

Penulis:

Dwi Susilowati, APPd, M.Kes.
Ns. Amatus Yudi Ismanto, Sp.Kep.An., PhD.NS
Wa Nuliana, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Dewi Tiansa Barus, S.Kep., M.K.M.
Suriana, SST., S.Kep.Ns., M.Kep.
Nur Sophia Matin, S.Keb., Bd., M.Keb.
Ns. Nita Theresia, S.Kep., M.Kes.
Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.

Editor:

Baltasar Serilus Sanggu Dedu, S.Kep., M.Sc.

Bunga Rampai: Asuhan Keperawatan Anak Komprehensif Berbasis Evidence-Based Practice

Penulis: Dwi Susilowati, APPd, M.Kes.

Ns. Amatus Yudi Ismanto, Sp.Kep.An., PhD.NS

Wa Nuliana, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Dewi Tiansa Barus, S.Kep., M.K.M.

Suriana, SST., S.Kep.Ns., M.Kep.

Nur Sophia Matin, S.Keb., Bd., M.Keb.

Ns. Nita Theresia, S.Kep., M.Kes.

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.

Editor:

Baltasar Serilus Sanggu Dedu, S.Kep., M.Sc.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7294-83-8

Cetakan Pertama: Agustus, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku bunga rampai "Asuhan Keperawatan Anak Komprehensif Berbasis Evidence-Based Practice" ini dapat tersusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons atas kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya perawat anak, dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal berdasarkan bukti ilmiah terkini.

Asuhan keperawatan anak merupakan tantangan yang unik karena melibatkan individu yang berada dalam tahap tumbuh kembang, memiliki berbagai karakteristik khusus yang memerlukan pendekatan khusus pula. Oleh karena itu, dalam buku ini disajikan berbagai topik penting yang mencakup konsep dasar hingga aplikasi praktis dalam keperawatan anak yang komprehensif.

Pembahasan buku ini dimulai dari konsep dasar keperawatan anak, diikuti dengan pengkajian yang menjadi fondasi dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan keperawatan. Lebih lanjut, berbagai gangguan kesehatan pada anak, seperti gangguan respirasi, gastrointestinal, infeksi, dan neurologis dibahas secara mendalam dengan pendekatan evidence-based practice, yang diharapkan dapat menjadi panduan dalam memberikan asuhan yang efektif dan aman bagi anak.

Topik penting lainnya yang turut diulas adalah manajemen nyeri, yang merupakan elemen krusial dalam meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup anak selama perawatan. Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada situasi kegawatdaruratan yang memerlukan kecepatan dan ketepatan tindakan agar dapat menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut pada anak.

Kami berharap buku bunga rampai ini mampu memberikan wawasan luas serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki perhatian khusus terhadap kesehatan anak. Semoga upaya ini dapat mendukung terciptanya pelayanan keperawatan anak yang berkualitas, berbasis bukti ilmiah, dan tentunya berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan anak.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya buku ini. Semoga buku ini membawa manfaat dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu keperawatan anak.

Agustus 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN ANAK 1

Dwi Susilowati, APPd, M.Kes.....	1
A. Pendahuluan/Prolog.....	1
B. Peran dan Fungsi Perawat Anak.....	3
C. Karakteristik Pertumbuhan dan Perkembangan Anak.....	7
D. Kebutuhan Dasar Anak dalam Perspektif Keperawatan.....	9
E. Prinsip Komunikasi Efektif dalam Keperawatan Anak.....	11
F. Aspek Legal dan Etik dalam Keperawatan Anak.....	13
G. Pendekatan Family-Centered Care dalam Keperawatan Anak.....	16
H. Pendekatan Atraumatic Care dalam Keperawatan Anak.....	18
I. Manajemen Nyeri pada Anak.....	20
J. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Keperawatan Anak.....	23
K. Simpulan.....	25
L. Referensi.....	26

CHAPTER 2 PENGKAJIAN KEPERAWATAN PADA ANAK.....29

Ns. Amatus Yudi Ismanto, Sp.Kep.An., PhD.NS.....	29
A. Pendahuluan/Prolog.....	29
B. Teknik dan Pendekatan Pengkajian pada Anak.....	31
C. Komponen Pengkajian Keperawatan Anak.....	33
D. Alat Ukur dan Instrumen Pengkajian dalam Keperawatan Anak.....	36
E. Pengkajian Keperawatan Anak Berdasarkan Kelompok Usia.....	38
F. Dokumentasi dan Pelaporan Hasil Pengkajian Keperawatan Anak.....	41
G. Tantangan dan Hambatan dalam Pengkajian Keperawatan Anak.....	43
H. Studi Kasus Penerapan Pengkajian Keperawatan Anak.....	46
I. Simpulan.....	48
J. Referensi.....	49
K. Glosarium.....	50

CHAPTER 3 KEPERAWATAN ANAK DENGAN GANGGUAN RESPIRASI..55

Wa Nuliana, S.Kep., Ns., M.Kep.....	55
A. Pendahuluan/Prolog.....	55
B. Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernapasan pada Anak.....	56
C. Etiologi dan Faktor Risiko Gangguan Respirasi pada Anak.....	59

D. Jenis-jenis Gangguan Respirasi pada Anak.....	61
E. Proses Pengkajian Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Respirasi	63
F. Diagnosis Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Respirasi	66
G. Intervensi Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Respirasi	69
H. Kolaborasi Interprofesional dalam Penanganan Gangguan Respirasi pada Anak.....	71
I. Pencegahan dan Promosi Kesehatan Pernapasan pada Anak.....	74
J. Tantangan, Hambatan, dan Solusi dalam Praktik Keperawatan Anak dengan Gangguan Respirasi	76
K. Simpulan	79
L. Referensi	80
M. Glosarium	81

CHAPTER 4 KEPERAWATAN ANAK DENGAN GANGGUAN GASRTROINTESTINAL83

Ns. Dewi Tiansa Barus, S.Kep., M.K.M.	83
A. Pendahuluan/Prolog	83
B. Anatomi dan Fisiologi Sistem Gastrointestinal Anak.....	85
C. Etiologi dan Faktor Risiko Gangguan Gastrointestinal pada Anak	88
D. Jenis-jenis Gangguan Gastrointestinal pada Anak	90
E. Pengkajian Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Gastrointestinal	92
F. Diagnosis Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Gastrointestinal	95
G. Intervensi Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Gastrointestinal.....	97
H. Kolaborasi Interprofesional dalam Penanganan Gangguan Gastrointestinal pada Anak	99
I. Pencegahan dan Promosi Kesehatan Gastrointestinal pada Anak	102
J. Tantangan, Hambatan, dan Solusi dalam Praktik Keperawatan Anak dengan Gangguan Gastrointestinal	104
K. Simpulan	107
L. Referensi	109
M. Glosarium	110

CHAPTER 5 KEPERAWATAN ANAK DENGAN PENYAKIT INFEKSI.....113

Suriana, SST., S.Kep.Ns., M.Kep.....	113
A. Pendahuluan/Prolog	113
B. Jenis-jenis Penyakit Infeksi yang Umum pada Anak.....	115
C. Patofisiologi Penyakit Infeksi pada Anak.....	117
D. Manifestasi Klinis dan Diagnosis Penyakit Infeksi pada Anak.....	119
E. Asuhan Keperawatan Komprehensif pada Anak dengan Penyakit Infeksi	121
F. Pendidikan Kesehatan pada Orang Tua dan Keluarga	123
G. Peran Perawat dalam Pencegahan dan Penanganan Komplikasi	126
H. Aspek Psikososial Anak dan Keluarga dalam Perawatan Penyakit Infeksi.....	128

I. Teknologi dan Inovasi Terkini dalam Penanganan Penyakit Infeksi Anak	130
J. Tantangan, Tren, dan Rekomendasi Masa Depan dalam Keperawatan Anak dengan Penyakit Infeksi	132
K. Simpulan	135
L. Referensi	136
M. Glosarium	137

CHAPTER 6 KEPERAWATAN ANAK DENGAN GANGGUAN NEUROLOGIS 139

Nur Sophia Matin, S.Keb., Bd., M.Keb.	139
A. Pendahuluan	139
B. Prinsip Dasar Pengelolaan Penyakit Infeksi pada Anak (Demam Berdarah, Campak, Cacar Air)	140
C. Teknik Pengkajian Cepat dan Intervensi Keperawatan Efektif pada Anak dengan Penyakit Infeksi Akut.....	142
D. Manajemen Isolasi dan Pencegahan Penularan Infeksi pada Anak.....	144
E. Edukasi Keluarga tentang Imunisasi dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk Mencegah Infeksi	147
F. Penutup	149
G. Referensi	150
H. Glosarium	151

CHAPTER 7 MANAJEMEN NYERI PADA ANAK 155

Ns. Nita Theresia, S.Kep., M.Kes.	155
A. Pendahuluan/Prolog	155
B. Jenis-jenis Nyeri pada Anak.....	156
C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Nyeri pada Anak	158
D. Pengkajian dan Penilaian Nyeri pada Anak.....	159
E. Intervensi Farmakologis dalam Manajemen Nyeri pada Anak.....	161
F. Intervensi Non-Farmakologis dalam Manajemen Nyeri pada Anak	164
G. Peran Perawat dalam Manajemen Nyeri pada Anak	166
H. Pendekatan Psikososial dalam Manajemen Nyeri pada Anak	168
I. Teknologi dan Inovasi Terkini dalam Manajemen Nyeri Pediatrik.....	170
J. Tantangan dan Rekomendasi dalam Manajemen Nyeri pada Anak.....	173
K. Simpulan	176
L. Referensi	177
M. Glosarium	178

CHAPTER 8 KEPERAWATAN ANAK DALAM SITUASI	
KEGAWATDARURATAN	181
Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.....	181
A. Pendahuluan/Prolog	181
B. Pengkajian Awal pada Anak dalam Kondisi Gawat Darurat	182
C. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Respirasi pada Anak.....	184
D. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Kardiovaskular pada Anak.....	186
E. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Neurologis pada Anak	188
F. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Gastrointestinal pada Anak.....	190
G. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Trauma pada Anak	192
H. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Metabolik dan Endokrin pada Anak.....	194
I. Dukungan Psikososial dalam Keperawatan Anak Gawat Darurat	196
J. Kolaborasi Tim Interprofesional dalam Keperawatan Anak Gawat Darurat...	198
K. Tantangan dan Isu Terkini dalam Keperawatan Anak Gawat Darurat	200
L. Simpulan	202
M.Referensi	203
N. Glosarium	204

CHAPTER 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN ANAK

Dwi Susilowati, APPd, M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Keperawatan anak merupakan salah satu cabang ilmu keperawatan yang secara khusus berfokus pada pemberian asuhan keperawatan kepada anak, mulai dari usia bayi baru lahir hingga memasuki masa remaja. Secara umum, keperawatan anak dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk layanan keperawatan profesional yang ditujukan untuk membantu anak mencapai kondisi kesehatan optimal, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Dalam pelaksanaannya, keperawatan anak juga berperan aktif dalam mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan anak agar berjalan normal dan sehat, serta mencegah terjadinya penyakit atau komplikasi kesehatan yang mungkin dialami anak sepanjang periode tumbuh kembangnya.

Keperawatan anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan bidang keperawatan lain karena pasien yang dilayani adalah anak-anak yang masih dalam tahap tumbuh kembang dan memiliki kebutuhan khusus yang sangat berbeda dibandingkan pasien dewasa. Oleh sebab itu, perawat anak dituntut untuk memahami betul karakteristik khas yang dimiliki anak, seperti pertumbuhan fisik yang pesat, kematangan emosi dan psikososial yang belum sempurna, serta kebutuhan khusus yang terus berubah sesuai usia dan tahap perkembangan anak.

Tujuan utama dari keperawatan anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak dapat mencapai kondisi kesehatan yang optimal melalui pelayanan kesehatan yang komprehensif, holistik, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, perawat anak memiliki tanggung jawab tidak hanya terbatas pada upaya pengobatan atau pemulihan kondisi fisik anak, tetapi juga secara aktif terlibat dalam berbagai upaya pencegahan penyakit, edukasi kesehatan kepada anak dan keluarga, serta pemberdayaan keluarga dalam merawat dan menjaga kesehatan anak di lingkungan rumah maupun komunitas.

Beberapa prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam praktik keperawatan anak antara lain prinsip family-centered care, yang berarti bahwa keluarga adalah mitra utama dalam perawatan anak. Prinsip ini menempatkan keluarga sebagai bagian integral dari proses perawatan, di mana keluarga diberdayakan untuk turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan klinis yang berkaitan dengan

perawatan anak. Prinsip berikutnya adalah atraumatic care, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk meminimalisir rasa sakit, ketidaknyamanan, atau trauma psikologis pada anak selama menjalani perawatan medis atau keperawatan. Dalam prinsip ini, perawat berupaya menciptakan suasana perawatan yang ramah anak, nyaman, dan sebisa mungkin menghindarkan anak dari rasa takut maupun kecemasan yang sering timbul dalam proses pengobatan.

Selanjutnya, keperawatan anak juga menekankan prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Artinya, setiap intervensi yang dilakukan perawat harus didasarkan pada pemahaman terhadap proses tumbuh kembang anak. Intervensi keperawatan harus dirancang agar mampu mendukung pencapaian tugas-tugas perkembangan anak secara optimal dan tidak mengganggu atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan normalnya. Prinsip terakhir yang juga penting dalam keperawatan anak adalah prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak. Prinsip ini mengharuskan perawat untuk senantiasa menjaga dan melindungi hak-hak anak sebagai pasien, seperti hak mendapatkan informasi yang jelas dan sesuai usianya, hak diperlakukan dengan penghormatan, serta hak mendapatkan privasi selama proses perawatan.

Ruang lingkup praktik keperawatan anak sangat luas dan mencakup berbagai aspek kesehatan anak mulai dari pelayanan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Pelayanan promotif dalam keperawatan anak melibatkan berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan anak melalui edukasi kesehatan, promosi nutrisi sehat, imunisasi, serta pola asuh dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal anak. Pelayanan preventif mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan mencegah timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan pada anak, seperti imunisasi lengkap, pencegahan kecelakaan anak di rumah, hingga deteksi dini gangguan tumbuh kembang yang mungkin dialami anak.

Pelayanan kuratif dalam ruang lingkup keperawatan anak melibatkan proses pengobatan atau perawatan ketika anak mengalami penyakit atau gangguan kesehatan. Dalam pelayanan ini, perawat bertugas memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif sesuai dengan kondisi klinis anak, seperti manajemen nyeri, pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan, manajemen infeksi, serta pemantauan tanda-tanda vital dan status kesehatan anak secara berkelanjutan. Sedangkan dalam aspek rehabilitatif, keperawatan anak berperan penting dalam mendukung pemulihan kondisi anak pasca penyakit atau cedera, melalui berbagai intervensi seperti terapi fisik, terapi bermain, dukungan emosional dan psikologis, serta edukasi lanjutan kepada keluarga tentang bagaimana merawat dan mendampingi anak dalam proses pemulihan kesehatan.

Selain aspek-aspek tersebut, keperawatan anak juga mencakup kolaborasi interprofesional dengan berbagai tenaga kesehatan lain seperti dokter anak, ahli gizi, psikolog, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan lain dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal dan terintegrasi. Peran kolaboratif ini penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan individualnya.

Dengan demikian, keperawatan anak merupakan bidang praktik keperawatan yang kompleks, menantang, namun sangat penting dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan anak sepanjang siklus kehidupannya. Setiap perawat yang berpraktik dalam bidang ini dituntut memiliki kompetensi yang tinggi, tidak hanya dalam aspek klinis semata tetapi juga dalam aspek psikososial, edukasi kesehatan, advokasi, serta kemampuan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak yang terkait dalam perawatan anak.

B. Peran dan Fungsi Perawat Anak

Dalam bidang keperawatan anak, seorang perawat memiliki berbagai peran dan fungsi yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal, menyeluruh, serta sesuai dengan kebutuhan khususnya selama periode tumbuh kembang. Peran dan fungsi ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait satu sama lain, mulai dari pemberian asuhan langsung, edukasi, advokasi terhadap hak-hak anak, konseling, hingga peran dalam penelitian serta kolaborasi antar profesi.

Peran pertama perawat anak adalah sebagai caregiver atau pemberi asuhan keperawatan. Dalam peran ini, perawat memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan asuhan keperawatan langsung kepada anak dalam berbagai kondisi kesehatan yang dialaminya, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Sebagai caregiver, perawat bertugas memberikan tindakan perawatan yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti nutrisi, hidrasi, kebersihan, kenyamanan fisik, serta memastikan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Selain itu, perawat juga bertanggung jawab untuk melakukan berbagai intervensi medis dan keperawatan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kesehatan anak, seperti pemberian obat-obatan, pemantauan tanda-tanda vital, manajemen nyeri, dan pengelolaan kondisi medis tertentu yang dialami anak. Dalam memberikan asuhan ini, perawat harus memperhatikan karakteristik khusus anak, termasuk tahap tumbuh kembang, kondisi emosional, serta tingkat pemahaman anak terhadap intervensi yang diberikan agar dapat memberikan perawatan yang tepat, efektif, serta minimal menimbulkan trauma.

Selanjutnya, perawat anak juga memiliki peran sebagai educator atau pendidik. Dalam peran ini, perawat bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kesehatan yang jelas, akurat, dan sesuai dengan usia serta tingkat pemahaman anak dan keluarganya. Edukasi kesehatan ini meliputi berbagai topik penting, seperti pola hidup sehat, pentingnya imunisasi, cara mencegah berbagai penyakit umum pada anak, deteksi dini gangguan tumbuh kembang, serta cara perawatan anak di rumah setelah perawatan medis selesai dilakukan. Peran edukator juga mencakup mengajarkan keterampilan dasar kepada orang tua atau keluarga dalam memberikan perawatan mandiri terhadap anaknya. Sebagai contoh, perawat dapat mengajarkan cara pemberian nutrisi yang tepat untuk anak, teknik menyusui yang benar, perawatan luka di rumah, serta mengenali tanda-tanda awal suatu penyakit atau kondisi darurat. Dengan peran edukasi ini, perawat tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan keluarga tentang kesehatan anak, tetapi juga secara aktif membantu keluarga agar lebih mandiri dalam menjaga dan merawat kesehatan anak mereka sehari-hari.

Selain peran sebagai caregiver dan educator, perawat anak juga berperan penting sebagai advocator atau pembela hak anak. Dalam peran ini, perawat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai pasien terpenuhi secara penuh. Hak-hak tersebut mencakup hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas tinggi, hak mendapatkan perlindungan dari rasa sakit atau ketidaknyamanan berlebihan, hak atas privasi dan kerahasiaan informasi medis, serta hak mendapatkan perlakuan yang penuh hormat dari tenaga kesehatan maupun pihak lain di fasilitas kesehatan. Sebagai advocator, perawat harus mampu menjadi suara bagi anak yang belum mampu menyampaikan kebutuhan atau keinginannya secara jelas. Misalnya, perawat harus memastikan bahwa anak tidak mengalami perlakuan diskriminatif, mendapatkan informasi medis yang disampaikan dengan cara yang sesuai usia anak, serta membantu anak dan keluarga dalam membuat keputusan yang tepat terkait intervensi medis yang diperlukan. Dalam kondisi tertentu, perawat juga harus dapat berkomunikasi dengan tim kesehatan lain untuk memastikan bahwa setiap keputusan klinis yang diambil senantiasa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Peran berikutnya yang dimiliki oleh perawat anak adalah sebagai konselor. Dalam praktik sehari-hari, perawat anak sering kali berhadapan dengan berbagai situasi yang menyebabkan tekanan emosional atau stres baik bagi anak maupun keluarganya. Sebagai konselor, perawat memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan emosional, psikologis, dan sosial kepada anak dan keluarganya selama proses perawatan. Dalam melaksanakan peran ini, perawat harus mampu mendengarkan dengan empati, menunjukkan kepedulian, serta

membantu anak dan keluarga mengatasi berbagai perasaan seperti ketakutan, kecemasan, rasa bersalah, atau frustrasi yang sering muncul selama perawatan kesehatan berlangsung. Konseling yang diberikan oleh perawat juga mencakup pemberian dukungan emosional terhadap keluarga dalam menghadapi situasi sulit seperti diagnosis penyakit kronis, perawatan intensif, maupun proses rehabilitasi yang lama. Melalui peran konselor ini, perawat membantu anak dan keluarganya untuk mengembangkan strategi coping yang efektif, meningkatkan ketahanan psikologis, serta mengurangi dampak negatif dari stres psikologis selama proses perawatan berlangsung.

Di samping peran klinis langsung, perawat anak juga memiliki peran penting sebagai peneliti dan kolaborator. Sebagai peneliti, perawat anak secara aktif terlibat dalam berbagai penelitian ilmiah untuk mengembangkan ilmu keperawatan anak serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak. Perawat anak yang terlibat dalam penelitian bertugas untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan klinis yang relevan, merancang dan melakukan penelitian ilmiah, serta menerapkan hasil penelitian tersebut dalam praktik keperawatan sehari-hari. Keterlibatan perawat anak dalam penelitian membantu memastikan bahwa praktik keperawatan anak senantiasa didasarkan pada bukti ilmiah terbaru (*evidence-based practice*), sehingga kualitas layanan yang diberikan semakin optimal.

Dalam konteks sebagai kolaborator, perawat anak berperan penting dalam menjalin kerjasama dengan berbagai tenaga kesehatan lainnya, seperti dokter spesialis anak, ahli gizi, terapis okupasi, terapis fisik, psikolog, pekerja sosial, serta berbagai tenaga kesehatan lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan perawatan yang terintegrasi, multidisiplin, dan holistik kepada anak. Perawat sebagai kolaborator berperan dalam mengkomunikasikan kebutuhan pasien secara efektif, mendiskusikan berbagai aspek perawatan yang diperlukan, serta membantu koordinasi berbagai tindakan medis yang diberikan. Kolaborasi interprofesional ini memungkinkan berbagai pihak yang terlibat untuk saling bertukar informasi, berbagi tanggung jawab, serta bekerja sama secara efektif demi mencapai tujuan perawatan yang terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan, peran dan fungsi perawat anak sebagai caregiver, educator, advocator, konselor, serta peneliti dan kolaborator merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memberikan pelayanan keperawatan anak yang berkualitas tinggi. Dalam melaksanakan peran-peran tersebut, perawat anak tidak hanya berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesehatan anak, tetapi juga secara signifikan membantu meningkatkan kualitas hidup anak dan keluarganya, memastikan pemenuhan hak anak sebagai pasien, serta mendukung tercapainya kesejahteraan anak secara menyeluruh dalam jangka panjang.

C. Karakteristik Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan aspek yang sangat penting untuk dipahami secara mendalam oleh perawat anak dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kedua aspek tersebut saling berhubungan erat dan berlangsung secara bersamaan selama periode usia anak-anak hingga remaja. Pertumbuhan anak merujuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif, seperti peningkatan ukuran tubuh, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, serta perubahan dalam komposisi tubuh yang dapat diukur secara fisik. Sedangkan perkembangan merujuk pada perubahan kualitatif yang meliputi kematangan fungsi organ tubuh, kemampuan kognitif, psikososial, emosi, serta berbagai keterampilan yang dimiliki oleh anak seiring bertambahnya usia.

Pertama, karakteristik tumbuh kembang anak secara fisik merupakan aspek utama yang harus diperhatikan secara cermat oleh perawat anak. Proses pertumbuhan fisik anak terjadi secara bertahap dan berkesinambungan, dimulai sejak masa bayi baru lahir hingga masa remaja. Pada masa bayi, pertumbuhan fisik berlangsung sangat pesat, di mana dalam satu tahun pertama kehidupan, anak mengalami peningkatan berat badan, panjang tubuh, serta lingkar kepala secara signifikan. Proses pertumbuhan ini terjadi seiring dengan perkembangan organ-organ vital seperti sistem saraf, jantung, paru-paru, ginjal, dan organ pencernaan yang semakin matang dan berkembang secara bertahap. Pertumbuhan fisik ini berlanjut ke masa balita di mana anak mulai mengembangkan keterampilan motorik kasar seperti merangkak, berjalan, berlari, hingga melompat, serta keterampilan motorik halus seperti menggenggam, mencoret, dan memanipulasi objek. Perkembangan fisik pada masa anak prasekolah hingga usia sekolah berlanjut dengan peningkatan proporsional tubuh, penguatan otot dan tulang, serta semakin sempurnanya koordinasi fisik yang mendukung aktivitas sehari-hari anak. Memasuki masa remaja, anak kembali mengalami percepatan pertumbuhan fisik yang disebut sebagai *growth spurt* yang ditandai dengan peningkatan tinggi badan secara drastis, perubahan proporsi tubuh, serta munculnya ciri-ciri seksual sekunder seperti pembesaran payudara pada perempuan dan perubahan suara pada laki-laki.

Kedua, karakteristik perkembangan psikososial anak mencerminkan kemampuan anak untuk berinteraksi dan beradaptasi secara sosial dengan lingkungan di sekitarnya. Perkembangan psikososial ini sangat dipengaruhi oleh interaksi anak dengan keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah, serta komunitas yang lebih luas. Menurut teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson, setiap tahapan usia anak memiliki tugas perkembangan psikososial tertentu yang harus dilewati. Sebagai contoh, pada usia bayi hingga 1 tahun, anak akan mengalami tahap

perkembangan kepercayaan versus ketidakpercayaan (trust vs mistrust), di mana anak belajar mempercayai lingkungan melalui interaksi yang hangat dan konsisten dengan orang tua atau pengasuh utama. Di usia balita, anak mulai masuk ke tahap otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu (autonomy vs shame and doubt), di mana anak mulai mengembangkan kemandirian dan rasa percaya diri melalui aktivitas sehari-hari seperti berpakaian sendiri atau makan sendiri. Pada usia prasekolah, anak akan menghadapi tahap inisiatif versus rasa bersalah (initiative vs guilt), yaitu ketika anak mencoba mengeksplorasi dunia sekitarnya dengan rasa ingin tahu tinggi. Tahap usia sekolah menghadapkan anak pada tahap rajin versus rendah diri (industry vs inferiority), di mana anak belajar keterampilan sosial dan akademik serta mulai membandingkan dirinya dengan teman sebaya. Terakhir, di masa remaja, anak akan menghadapi tahap identitas versus kebingungan peran (identity vs role confusion), yaitu ketika anak berusaha menemukan identitas diri dan peran sosialnya di masyarakat. Pemahaman perawat terhadap tahap-tahap perkembangan psikososial ini sangat penting untuk dapat memberikan dukungan psikologis yang tepat bagi anak dalam setiap tahapan kehidupannya.

Selanjutnya, karakteristik perkembangan kognitif dan emosional anak menggambarkan kemampuan berpikir anak serta pengelolaan emosi yang semakin matang seiring bertambahnya usia. Perkembangan kognitif mengacu pada proses pemikiran, persepsi, pemahaman, dan pengolahan informasi yang diterima oleh anak. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak melewati empat tahapan utama yaitu tahap sensorimotor (0-2 tahun), tahap pra-operasional (2-7 tahun), tahap operasional konkret (7-11 tahun), dan tahap operasional formal (11 tahun ke atas). Pada tahap sensorimotor, anak memahami dunia melalui interaksi langsung dengan benda-benda di sekitarnya menggunakan panca indera dan gerakan motorik. Di tahap pra-operasional, anak mulai menggunakan bahasa dan simbol dalam berpikir namun pemahamannya masih bersifat egosentris, yaitu anak masih kesulitan memahami sudut pandang orang lain. Di tahap operasional konkret, anak sudah mulai mampu berpikir logis tentang objek konkret, mampu mengklasifikasi benda, dan memahami hubungan sebab-akibat secara sederhana. Pada tahap operasional formal, anak mampu berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis serta mulai dapat membuat hipotesis dan menganalisis berbagai situasi kompleks. Bersamaan dengan perkembangan kognitif ini, anak juga mengalami perkembangan emosional yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan untuk mengenali, memahami, serta mengelola emosi yang dialaminya. Perkembangan emosional mencakup kemampuan anak dalam mengelola perasaan marah, sedih, cemas, takut, senang, hingga rasa empati terhadap orang lain, yang berkembang secara bertahap sesuai usia dan tingkat kematangan emosional anak. Perawat anak

harus mampu memahami dan mendukung perkembangan kognitif dan emosional anak dengan memberikan stimulasi yang sesuai serta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kedua aspek ini.

Terakhir, pentingnya memahami tahapan tumbuh kembang berdasarkan usia anak merupakan landasan utama bagi perawat anak dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tepat. Secara garis besar, tumbuh kembang anak terbagi dalam beberapa tahap usia utama yaitu tahap neonatus (0-28 hari), bayi (1 bulan-1 tahun), balita (1-3 tahun), prasekolah (3-6 tahun), usia sekolah (6-12 tahun), dan remaja (12-18 tahun). Setiap tahapan usia memiliki karakteristik pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, psikososial, serta emosional yang berbeda dan spesifik. Tahap neonatus dan bayi merupakan periode pertumbuhan fisik yang sangat cepat dan perkembangan motorik dasar, di mana interaksi hangat dengan orang tua sangat penting untuk perkembangan emosional dan kepercayaan anak terhadap lingkungan. Tahap balita ditandai dengan perkembangan kemandirian, keterampilan motorik kasar dan halus yang semakin matang, serta eksplorasi lingkungan secara aktif. Tahap prasekolah merupakan periode di mana anak mulai memiliki inisiatif tinggi dalam belajar, bermain, serta berinteraksi sosial. Tahap usia sekolah ditandai dengan perkembangan sosial dan akademik yang lebih kompleks serta pemahaman logis yang semakin baik. Terakhir, masa remaja merupakan periode pertumbuhan fisik kedua yang sangat cepat, munculnya identitas diri, kemandirian, serta kemampuan berpikir abstrak dan emosional yang matang.

D. Kebutuhan Dasar Anak dalam Perspektif Keperawatan

Dalam pelayanan keperawatan anak, pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dasar anak merupakan kunci utama dalam memberikan asuhan yang efektif dan holistik. Anak memiliki berbagai kebutuhan yang sangat penting untuk dipenuhi guna mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Secara umum, kebutuhan dasar anak dapat dikelompokkan menjadi empat kategori besar, yakni kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Setiap kategori kebutuhan ini memiliki peran vital yang sama pentingnya dalam memastikan bahwa anak dapat tumbuh sehat, berkembang dengan baik, serta mampu mencapai potensinya secara maksimal.

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang mendasar dan esensial untuk kelangsungan hidup anak. Dalam konteks ini, nutrisi menjadi salah satu aspek utama yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Nutrisi yang tepat dan seimbang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan fisik, meningkatkan imunitas, serta mencegah berbagai penyakit dan gangguan kesehatan. Perawat anak harus memastikan bahwa anak mendapatkan asupan gizi

yang sesuai dengan usianya, yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serta cairan dalam jumlah yang cukup. Selain nutrisi, kebutuhan istirahat juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Anak-anak membutuhkan waktu tidur yang lebih lama dibandingkan orang dewasa, yang berfungsi untuk mendukung proses pertumbuhan, perkembangan otak, serta pemulihan tubuh dari aktivitas sehari-hari. Kurangnya waktu istirahat dapat berdampak pada gangguan pertumbuhan, gangguan konsentrasi, dan berbagai masalah kesehatan lainnya.

Aspek kebersihan dan keamanan juga menjadi bagian penting dari kebutuhan fisik anak. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan merupakan tindakan preventif yang sangat penting dalam menghindari berbagai penyakit infeksi yang sering dialami oleh anak-anak, seperti diare, infeksi saluran pernapasan, serta penyakit kulit. Perawat perlu memastikan bahwa anak terbiasa dengan perilaku kebersihan dasar seperti mandi teratur, mencuci tangan dengan benar, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Begitu pula dengan aspek keamanan yang mencakup perlindungan anak dari cedera atau kecelakaan. Anak-anak yang aktif mengeksplorasi lingkungan memerlukan pengawasan ketat serta lingkungan yang aman agar terhindar dari berbagai risiko seperti terjatuh, tenggelam, atau tertelan benda asing. Perawat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada orang tua dan keluarga mengenai pentingnya menjaga keamanan anak dalam aktivitas sehari-hari.

Selain kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis juga menjadi aspek penting dalam perspektif keperawatan anak. Kebutuhan psikologis ini mencakup rasa nyaman, rasa dicintai, dan dihargai oleh lingkungan sekitar, terutama oleh keluarga. Anak yang merasa nyaman dan dicintai akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bahagia, serta memiliki kesejahteraan emosional yang stabil. Peran perawat anak dalam memenuhi kebutuhan psikologis anak ini adalah dengan menciptakan lingkungan perawatan yang hangat, ramah, dan penuh empati. Misalnya, dalam situasi anak yang dirawat di rumah sakit, perawat harus mampu menjalin komunikasi efektif, menunjukkan kasih sayang, memberikan dukungan emosional, serta menjelaskan setiap prosedur secara sederhana dan ramah sehingga anak merasa aman dan nyaman selama dirawat. Selain itu, perawat juga perlu memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya menunjukkan kasih sayang, pujian, dan penghargaan kepada anak, serta membantu orang tua memahami cara-cara efektif dalam menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Kebutuhan sosial anak juga merupakan aspek penting yang wajib dipenuhi agar anak mampu mengembangkan keterampilan interaksi sosial serta beradaptasi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial memberikan anak

kesempatan untuk belajar berkomunikasi, bekerja sama, memahami norma sosial, serta mengembangkan empati terhadap orang lain. Dalam konteks ini, bermain menjadi aktivitas yang sangat penting bagi anak-anak, karena melalui kegiatan bermain anak dapat belajar berbagai keterampilan sosial seperti berbagi, bersabar, menghargai orang lain, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. Perawat anak memiliki peran strategis dalam memfasilitasi kebutuhan sosial ini, baik melalui edukasi kepada keluarga maupun dalam lingkungan perawatan. Misalnya, perawat dapat mendorong orang tua untuk menyediakan waktu khusus bermain bersama anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya, atau menciptakan kegiatan yang menarik dan menyenangkan saat anak dirawat di rumah sakit sehingga anak tetap memiliki kesempatan berinteraksi sosial meskipun sedang mengalami gangguan kesehatan.

Terakhir, kebutuhan spiritual anak sering kali kurang mendapat perhatian, padahal kebutuhan ini juga memiliki dampak penting terhadap kesejahteraan anak secara keseluruhan. Kebutuhan spiritual mencakup pengembangan makna hidup, keyakinan, rasa syukur, serta nilai-nilai moral yang akan menjadi fondasi dalam kehidupan anak di masa mendatang. Pemenuhan kebutuhan spiritual ini membantu anak dalam membangun identitas, rasa percaya diri, serta rasa optimis dalam menghadapi tantangan kehidupan. Perawat anak berperan aktif dalam mengenali dan menghargai latar belakang budaya, agama, serta nilai-nilai keluarga yang dianut anak dan keluarganya. Dalam praktik keperawatan, perawat dapat membantu anak dalam menemukan rasa nyaman melalui aktivitas spiritual yang sesuai, seperti berdoa bersama keluarga, mendengarkan cerita-cerita bermakna yang relevan dengan nilai-nilai positif, atau melalui pemberian dukungan spiritual saat anak menghadapi situasi sulit seperti sakit atau menjalani prosedur medis. Dukungan spiritual yang diberikan secara tepat dapat memberikan kekuatan emosional yang signifikan bagi anak dan keluarganya dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan yang menantang.

E. Prinsip Komunikasi Efektif dalam Keperawatan Anak

Dalam praktik keperawatan anak, kemampuan berkomunikasi secara efektif memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan. Komunikasi yang efektif bukan hanya sekadar penyampaian informasi, melainkan suatu interaksi yang mampu menciptakan rasa percaya, nyaman, serta mampu memenuhi kebutuhan emosional anak maupun keluarganya. Keberhasilan komunikasi ini sangat bergantung pada pemahaman mendalam perawat terhadap prinsip-prinsip dasar komunikasi, termasuk teknik komunikasi terapeutik dengan

anak, komunikasi efektif dengan keluarga anak, serta komunikasi yang optimal dengan tim kesehatan yang terlibat dalam perawatan anak.

Teknik komunikasi terapeutik dengan anak merupakan salah satu aspek penting yang harus dikuasai oleh perawat anak. Anak-anak memiliki cara berpikir, cara memahami, serta cara merespons informasi yang sangat berbeda dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, perawat anak harus menggunakan pendekatan khusus yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Dalam komunikasi terapeutik ini, perawat perlu menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, serta sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman anak. Selain penggunaan bahasa verbal, komunikasi nonverbal juga memiliki pengaruh signifikan, seperti ekspresi wajah yang ramah, kontak mata yang lembut, nada suara yang hangat, serta gestur tubuh yang terbuka dan menenangkan.

Salah satu teknik komunikasi terapeutik yang sering digunakan adalah bermain terapeutik. Melalui aktivitas bermain, anak dapat mengekspresikan perasaannya, mengurangi kecemasan, serta membangun hubungan saling percaya dengan perawat. Misalnya, perawat dapat menggunakan boneka atau mainan tertentu untuk menjelaskan prosedur medis seperti penyuntikan atau pemasangan infus, sehingga anak dapat memahami proses tersebut dengan lebih mudah dan merasa lebih tenang saat menjalaninya. Teknik lain yang efektif adalah menggunakan metode bercerita, di mana perawat dapat menyampaikan pesan moral atau edukasi kesehatan secara menyenangkan dan mudah diterima anak. Penggunaan gambar atau alat peraga yang menarik perhatian anak juga sangat membantu untuk memperjelas informasi kesehatan yang ingin disampaikan.

Di samping teknik komunikasi dengan anak, komunikasi yang efektif dengan keluarga anak juga tidak kalah pentingnya dalam konteks keperawatan anak. Keluarga, terutama orang tua, memiliki peran sentral dalam perawatan anak karena mereka yang paling memahami kebutuhan anak dan yang akan meneruskan perawatan di rumah setelah anak meninggalkan fasilitas kesehatan. Komunikasi efektif dengan keluarga mencakup pemberian informasi secara jelas, akurat, dan komprehensif tentang kondisi kesehatan anak, prosedur medis yang akan dilakukan, serta rencana perawatan dan tindak lanjut di rumah. Perawat harus mampu membangun hubungan saling percaya dengan keluarga melalui pendekatan yang empati, menghormati nilai-nilai budaya keluarga, serta menunjukkan keterbukaan untuk mendengar dan menanggapi pertanyaan maupun kekhawatiran orang tua.

Dalam komunikasi dengan keluarga, teknik mendengarkan aktif menjadi salah satu kunci keberhasilan. Perawat perlu memberikan perhatian penuh terhadap apa yang disampaikan oleh keluarga, menunjukkan empati, serta memberikan respon yang validasi terhadap perasaan dan kekhawatiran mereka. Selain itu, perawat juga

harus mampu mengedukasi keluarga secara efektif tentang cara-cara merawat anak di rumah, mengenali tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai, serta mengajarkan keterampilan khusus seperti pemberian obat, manajemen nyeri, atau perawatan luka. Edukasi ini sebaiknya disampaikan secara bertahap, menggunakan bahasa sederhana dan mudah dimengerti, serta disesuaikan dengan tingkat pemahaman keluarga agar informasi tersebut benar-benar diterapkan secara optimal dalam perawatan anak sehari-hari.

Selain berkomunikasi dengan anak dan keluarga, komunikasi efektif dengan tim kesehatan juga merupakan prinsip penting dalam keperawatan anak. Perawatan anak sering kali melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti dokter, farmasis, ahli gizi, terapis, hingga tenaga kesehatan lainnya. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas, terbuka, serta terkoordinasi antar anggota tim kesehatan sangat penting untuk menjamin kualitas perawatan yang optimal dan aman bagi anak. Dalam konteks ini, perawat harus mampu menyampaikan informasi secara akurat dan lengkap tentang perkembangan kondisi anak, respons anak terhadap pengobatan, serta hasil observasi dan tindakan yang telah dilakukan. Setiap informasi ini harus dicatat dan didokumentasikan secara sistematis dalam rekam medis anak untuk memastikan kesinambungan perawatan.

Dalam berkomunikasi dengan tim kesehatan, perawat juga dituntut untuk mampu berkolaborasi secara interprofesional. Kolaborasi ini melibatkan diskusi terbuka mengenai rencana perawatan, pertukaran informasi terbaru berbasis bukti ilmiah, serta evaluasi bersama tentang efektivitas intervensi yang dilakukan. Komunikasi antar anggota tim harus didasarkan pada prinsip saling menghormati, saling menghargai peran masing-masing, serta bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan kesehatan anak. Forum diskusi rutin seperti pertemuan kasus atau rapat tim merupakan wadah yang efektif untuk memastikan bahwa setiap anggota tim mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi anak, perubahan rencana perawatan, serta tindakan lanjutan yang perlu dilakukan.

F. Aspek Legal dan Etik dalam Keperawatan Anak

Dalam praktik keperawatan anak, aspek legal dan etik menjadi dasar penting yang harus senantiasa diperhatikan dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan. Keperawatan anak tidak hanya sekedar memberikan perawatan yang berfokus pada kondisi klinis semata, melainkan juga harus mempertimbangkan secara seksama tentang bagaimana hak-hak anak dan keluarga dihormati, bagaimana prinsip-prinsip etik diterapkan dalam berbagai situasi perawatan, serta bagaimana pertimbangan hukum dapat melindungi anak dan tenaga kesehatan dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama pelayanan.

Salah satu aspek utama yang sangat penting dalam keperawatan anak adalah penghormatan terhadap hak-hak anak dan keluarganya dalam pelayanan kesehatan. Anak, sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa, memiliki hak-hak khusus yang perlu mendapatkan perhatian serius dari tenaga keperawatan. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik tanpa diskriminasi, hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan tepat mengenai kondisinya sesuai tingkat perkembangan anak, serta hak untuk dilindungi dari tindakan medis atau intervensi yang tidak perlu atau berpotensi merugikan. Anak juga berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya, sesuai dengan kemampuannya untuk memahami informasi tersebut.

Di samping hak anak, keluarga khususnya orang tua atau wali anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara jelas, lengkap, dan akurat mengenai kondisi anak, diagnosis, rencana perawatan, risiko serta manfaat dari setiap tindakan medis yang akan diberikan. Keluarga juga berhak untuk terlibat aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan mengenai perawatan dan pengobatan anak, termasuk hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis tertentu berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan. Hak ini menuntut perawat untuk mampu memberikan informasi secara terbuka, jujur, dan empati, serta memberikan kesempatan yang cukup kepada keluarga untuk bertanya dan berdiskusi sebelum mengambil keputusan medis.

Dalam konteks etik dalam praktik keperawatan anak, ada beberapa prinsip dasar yang wajib menjadi pegangan perawat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip beneficence (berbuat baik), prinsip non-maleficence (tidak merugikan), prinsip autonomy (menghormati otonomi pasien dan keluarga), serta prinsip justice (adil dalam memberikan pelayanan kesehatan). Dalam penerapan prinsip beneficence, perawat anak harus selalu berorientasi pada tindakan yang memberikan manfaat optimal bagi kesehatan anak, mengutamakan keselamatan serta kesejahteraan anak di atas segala hal. Setiap intervensi yang dilakukan harus berdasarkan pertimbangan matang bahwa intervensi tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan anak secara keseluruhan.

Prinsip non-maleficence menuntut perawat untuk memastikan bahwa setiap tindakan perawatan yang diberikan tidak menimbulkan risiko bahaya atau kerugian bagi anak, baik secara fisik maupun psikologis. Sebagai contoh, perawat harus sangat berhati-hati dalam melakukan prosedur invasif yang menyakitkan atau menimbulkan stres pada anak, dengan cara menggunakan teknik-teknik yang paling aman dan nyaman, serta melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalkan efek samping atau komplikasi yang mungkin timbul.

Prinsip otonomi dalam konteks keperawatan anak memiliki kekhasan tersendiri karena keterbatasan kemampuan anak dalam mengambil keputusan secara mandiri. Dalam hal ini, perawat harus mampu menyeimbangkan antara penghormatan terhadap otonomi keluarga dengan perlindungan terbaik bagi anak. Keluarga, khususnya orang tua atau wali, harus dihormati haknya dalam membuat keputusan terkait perawatan anak, namun demikian perawat juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi lengkap dan tepat agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan pemahaman yang mendalam mengenai risiko, manfaat, dan konsekuensi setiap tindakan medis. Di sisi lain, ketika anak sudah memiliki tingkat pemahaman yang memadai (misalnya remaja), perawat perlu mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan, sebagai wujud penghormatan terhadap perkembangan kemandiriannya.

Prinsip keadilan (justice) dalam keperawatan anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pelayanan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, agama, kondisi ekonomi, atau latar belakang sosial. Perawat harus memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara adil dan merata, serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada semua anak tanpa pandang bulu.

Selain mempertimbangkan aspek etik, pertimbangan hukum juga sangat penting dalam keperawatan anak. Setiap negara atau wilayah memiliki regulasi tertentu yang secara khusus mengatur perlindungan anak dalam layanan kesehatan, termasuk di Indonesia yang memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan terkait hak kesehatan anak. Perawat anak harus memahami secara jelas mengenai regulasi yang berlaku, khususnya terkait persetujuan tindakan medis (informed consent), kerahasiaan data pasien, pelaporan kasus-kasus tertentu seperti kekerasan pada anak atau kasus yang mencurigakan, serta tanggung jawab hukum yang mungkin timbul dari kelalaian atau kesalahan dalam perawatan.

Dalam konteks informed consent, perawat harus memahami bahwa setiap tindakan medis atau prosedur invasif memerlukan persetujuan tertulis dari orang tua atau wali, setelah mereka mendapatkan penjelasan lengkap mengenai manfaat, risiko, serta alternatif dari tindakan tersebut. Jika persetujuan tidak diberikan, perawat tidak boleh melanjutkan tindakan kecuali dalam situasi darurat yang mengancam nyawa anak. Di sisi lain, perawat juga harus menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan informasi kesehatan anak dan keluarganya, di mana setiap data yang sensitif harus dijaga privasinya dengan ketat, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang, seperti pelaporan kekerasan anak kepada pihak berwenang.

Perlindungan hukum bagi anak juga mencakup kewajiban pelaporan oleh tenaga keperawatan terhadap kasus-kasus kekerasan, eksploitasi, atau perlakuan tidak semestinya terhadap anak. Jika perawat menemukan tanda-tanda fisik atau psikologis yang mencurigakan bahwa seorang anak mungkin mengalami kekerasan atau perlakuan salah, perawat memiliki kewajiban hukum dan etik untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, guna memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

G. Pendekatan Family-Centered Care dalam Keperawatan Anak

Dalam keperawatan anak, pendekatan Family-Centered Care (FCC) merupakan suatu konsep fundamental yang menjadikan keluarga sebagai pusat perhatian dalam setiap tahapan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak. Pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai mitra utama tenaga kesehatan dalam perawatan anak, dengan asumsi bahwa keluarga memiliki peran yang tak tergantikan dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan spiritual anak. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa kesehatan anak tidak dapat dipisahkan dari lingkungan keluarganya, sebab keluarga merupakan sistem dukungan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal anak.

Pentingnya pendekatan Family-Centered Care terletak pada kenyataan bahwa keluarga secara alami merupakan lingkungan pertama dan utama yang berinteraksi langsung dengan anak. Keluarga mengetahui secara mendalam tentang kebutuhan, kebiasaan, preferensi, serta karakteristik individual anak. Oleh karena itu, keterlibatan aktif keluarga dalam proses perawatan sangat esensial untuk memastikan bahwa tindakan keperawatan yang diberikan dapat benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam FCC, perawat tidak hanya melihat anak sebagai individu yang membutuhkan perawatan, melainkan juga sebagai bagian integral dari unit keluarga yang lebih besar. Keluarga dianggap sebagai sumber informasi penting, mitra dalam pengambilan keputusan klinis, serta sumber dukungan emosional bagi anak selama perawatan berlangsung.

Penerapan pendekatan Family-Centered Care dalam praktik keperawatan anak dimulai dari tahap awal interaksi perawat dengan keluarga dan anak. Pada tahap awal, perawat perlu menjalin hubungan terapeutik yang kuat dengan keluarga melalui komunikasi yang terbuka, empati, dan penuh penghormatan. Perawat harus secara aktif melibatkan keluarga dalam setiap aspek perencanaan, implementasi, serta evaluasi asuhan keperawatan. Keluarga diundang untuk berbagi informasi mengenai riwayat kesehatan anak, pola asuh, kebiasaan anak, serta nilai-nilai keluarga yang dapat memengaruhi proses perawatan. Informasi yang diperoleh dari

keluarga ini menjadi dasar penting dalam menyusun rencana perawatan yang bersifat individual dan tepat sasaran.

Lebih jauh lagi, dalam praktik sehari-hari, perawat secara aktif mendorong partisipasi keluarga dalam setiap prosedur keperawatan, baik yang bersifat invasif maupun non-invasif. Misalnya, ketika anak harus menjalani prosedur medis yang menimbulkan rasa takut atau cemas, kehadiran anggota keluarga dapat memberikan rasa aman, nyaman, serta membantu mengurangi stres yang dialami anak. Perawat juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi dan penjelasan kepada keluarga secara terperinci mengenai setiap prosedur, manfaat serta risikonya, sehingga keluarga merasa percaya diri untuk terlibat aktif dalam perawatan tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan klinis, keluarga senantiasa diajak berdiskusi untuk menentukan pilihan tindakan medis yang terbaik bagi anak, dengan tetap menghormati nilai-nilai dan preferensi keluarga.

Dalam pelaksanaan FCC, perawat juga diharapkan mampu memberikan dukungan emosional kepada keluarga selama masa perawatan anak. Dukungan ini dapat berupa penguatan, dorongan, serta konseling yang membantu keluarga menghadapi situasi sulit atau penuh tekanan selama anak dirawat. Perawat berperan sebagai pendamping keluarga, memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan agar keluarga mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama proses perawatan. Misalnya, ketika keluarga merasa cemas atau mengalami tekanan emosional akibat kondisi kesehatan anak, perawat dapat membantu keluarga dengan menyediakan ruang untuk berbicara, mendengarkan kekhawatiran mereka, serta menawarkan berbagai alternatif solusi atau sumber dukungan tambahan yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga.

Manfaat pendekatan Family-Centered Care dalam keperawatan anak sangat luas dan berdampak positif, baik bagi anak maupun keluarganya. Salah satu manfaat utama dari penerapan FCC adalah terciptanya hubungan saling percaya antara keluarga dengan tenaga kesehatan. Dengan hubungan yang kuat ini, keluarga merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi terbuka mengenai berbagai permasalahan atau kendala yang dihadapi, sehingga tindakan keperawatan yang diberikan menjadi lebih efektif. Selain itu, keluarga yang terlibat secara aktif dalam proses perawatan cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Mereka merasa lebih dihargai, dihormati, dan diperhatikan oleh tenaga kesehatan, yang secara tidak langsung meningkatkan rasa percaya diri keluarga dalam menjalani proses perawatan anak.

Secara klinis, pendekatan FCC juga terbukti mampu mempercepat proses pemulihan anak. Keterlibatan keluarga dalam perawatan anak mampu mengurangi tingkat kecemasan dan stres yang dialami oleh anak, sehingga kondisi emosional

anak menjadi lebih stabil dan kondusif bagi penyembuhan. Selain itu, keterlibatan aktif keluarga dalam perawatan juga meningkatkan kepatuhan keluarga terhadap instruksi medis dan rekomendasi perawatan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan hasil klinis secara signifikan. Misalnya, keluarga yang aktif dalam perawatan anak dengan penyakit kronis cenderung lebih memahami pentingnya disiplin dalam mengikuti jadwal pemberian obat atau terapi yang telah ditentukan oleh tenaga kesehatan.

Dalam jangka panjang, pendekatan Family-Centered Care juga berperan dalam meningkatkan kompetensi keluarga dalam merawat anak secara mandiri di rumah setelah masa rawat inap berakhir. Keluarga yang terbiasa terlibat aktif dalam perawatan akan merasa lebih percaya diri, terampil, dan memiliki pengetahuan yang memadai untuk melanjutkan perawatan di rumah. Hal ini membantu memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perawatan yang optimal setelah keluar dari fasilitas kesehatan, sehingga risiko komplikasi atau kekambuhan kondisi kesehatan anak dapat diminimalkan. Dengan demikian, FCC memberikan manfaat berkelanjutan yang tidak hanya berdampak positif selama masa perawatan di fasilitas kesehatan tetapi juga memberikan dampak positif dalam jangka panjang terhadap kualitas hidup anak dan keluarganya.

H. Pendekatan Atraumatic Care dalam Keperawatan Anak

Pendekatan Atraumatic Care merupakan salah satu prinsip penting dalam praktik keperawatan anak yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa takut, stres, nyeri, dan trauma emosional pada anak selama menjalani berbagai tindakan medis maupun keperawatan. Secara harfiah, istilah atraumatic berasal dari kata "a" yang berarti tidak, dan "traumatic" yang berarti trauma. Dengan demikian, pendekatan atraumatic care dapat diartikan sebagai praktik keperawatan yang secara khusus dirancang untuk meminimalkan dampak psikologis, fisik, dan emosional yang mungkin terjadi akibat intervensi medis pada anak.

Tujuan utama dari penerapan atraumatic care adalah untuk menciptakan pengalaman perawatan kesehatan yang positif, nyaman, dan tidak menimbulkan trauma jangka panjang bagi anak maupun keluarganya. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa anak memiliki sensitivitas tinggi terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya dalam situasi yang menimbulkan rasa takut atau kecemasan seperti di lingkungan rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Anak-anak yang mengalami pengalaman traumatis selama perawatan cenderung memiliki risiko lebih besar mengalami gangguan emosional di kemudian hari, termasuk ketakutan berlebihan terhadap tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan, sehingga mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap perawatan medis di masa depan. Oleh

karena itu, pendekatan atraumatic care berusaha meminimalkan risiko tersebut dengan menerapkan berbagai strategi khusus yang bersifat proaktif dan antisipatif dalam praktik klinis sehari-hari.

Pelaksanaan atraumatic care dalam praktik keperawatan anak melibatkan berbagai strategi yang harus diterapkan secara konsisten oleh perawat dan tim kesehatan lainnya. Salah satu strategi utama adalah penggunaan teknik komunikasi terapeutik yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Teknik ini mencakup penggunaan bahasa sederhana, jelas, dan mudah dipahami anak, serta menggunakan pendekatan yang empati dan penuh perhatian. Sebelum melakukan prosedur atau tindakan medis, perawat perlu menjelaskan secara perlahan kepada anak tentang apa yang akan terjadi dengan bahasa yang sesuai usia anak, sambil memberikan jaminan bahwa mereka akan tetap aman dan nyaman. Misalnya, ketika seorang anak akan menjalani prosedur pengambilan darah, perawat dapat menggunakan boneka atau gambar ilustrasi untuk menjelaskan prosedur tersebut secara konkret, sehingga anak dapat lebih mudah memahami apa yang akan terjadi dan merasa lebih tenang serta tidak takut.

Strategi lain yang efektif dalam pelaksanaan atraumatic care adalah pemberian distraksi atau pengalihan perhatian selama prosedur berlangsung. Distraksi ini bisa berupa permainan, musik, video animasi favorit anak, atau bahkan penggunaan teknik relaksasi seperti bernapas dalam-dalam secara perlahan. Pengalihan perhatian ini terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan anak, sehingga nyeri atau rasa tidak nyaman yang dialami selama prosedur dapat diminimalkan. Selain distraksi, teknik relaksasi seperti sentuhan lembut, pelukan dari orang tua, atau posisi yang nyaman juga berperan penting dalam menciptakan pengalaman yang lebih positif bagi anak. Perawat perlu memastikan bahwa anak selalu didampingi oleh orang tua atau anggota keluarga terdekat selama prosedur berlangsung, karena kehadiran keluarga secara signifikan membantu anak merasa lebih aman dan terlindungi, yang secara langsung mengurangi tingkat stres dan kecemasan yang dialami.

Selanjutnya, pelaksanaan atraumatic care juga mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan fisik yang nyaman dan ramah bagi anak di fasilitas kesehatan. Ruangan tempat prosedur dilakukan hendaknya dirancang dengan warna-warna yang cerah, dekorasi yang menarik, serta dilengkapi mainan atau buku cerita yang dapat membantu anak merasa nyaman dan rileks selama proses perawatan. Selain itu, perawat dan tenaga kesehatan lain diharapkan mengenakan pakaian atau atribut yang tidak menakutkan bagi anak, misalnya dengan menggunakan seragam berwarna cerah atau memiliki gambar yang menarik

perhatian anak. Hal ini bertujuan agar anak tidak merasa terancam dengan kehadiran tenaga medis, tetapi justru merasa nyaman dan aman.

Penerapan strategi atraumatic care ini memerlukan kerjasama tim kesehatan yang solid, termasuk keterlibatan aktif dari keluarga anak. Perawat berperan penting dalam memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pendekatan ini serta mendorong keluarga untuk aktif terlibat dalam proses perawatan anak. Keluarga yang terlibat aktif dapat memberikan dukungan emosional yang kuat kepada anak, membantu mengurangi rasa takut serta stres selama proses perawatan berlangsung. Selain itu, keluarga yang memahami prinsip atraumatic care juga mampu mempersiapkan anak secara psikologis sebelum datang ke fasilitas kesehatan, misalnya dengan memberikan penjelasan awal di rumah mengenai tindakan medis yang akan dijalani anak, sehingga anak merasa lebih siap dan tidak mengalami ketakutan berlebihan saat menghadapi situasi nyata di fasilitas kesehatan.

Dampak penerapan atraumatic care dalam keperawatan anak sangat signifikan dan positif, baik bagi anak itu sendiri maupun keluarganya. Bagi anak, pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan rasa sakit yang dirasakan selama prosedur medis berlangsung. Anak-anak yang mendapatkan perawatan dengan pendekatan atraumatic care cenderung memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi terhadap layanan kesehatan yang mereka terima, serta lebih kooperatif dalam menjalani berbagai tindakan medis. Dalam jangka panjang, pengalaman positif ini juga membantu anak memiliki persepsi positif terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, yang secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kepatuhan anak terhadap perawatan medis selanjutnya.

Bagi keluarga, penerapan atraumatic care juga memberikan manfaat besar. Keluarga merasa lebih tenang dan percaya diri selama proses perawatan anak, karena melihat bahwa anak mereka mendapatkan perawatan yang penuh perhatian dan tidak menimbulkan trauma. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan keluarga, sekaligus meningkatkan rasa percaya keluarga terhadap tim kesehatan yang memberikan pelayanan. Selain itu, keluarga yang puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan cenderung lebih kooperatif dan aktif dalam mengikuti rekomendasi medis atau perawatan yang diberikan, yang pada akhirnya berdampak pada hasil klinis yang lebih optimal bagi anak.

I. Manajemen Nyeri pada Anak

Manajemen nyeri pada anak merupakan aspek penting dalam praktik keperawatan anak, karena anak-anak memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap pengalaman nyeri dibandingkan dengan orang dewasa. Nyeri yang tidak

tertangani dengan baik pada anak dapat menyebabkan trauma emosional yang berkepanjangan, kecemasan, serta ketakutan terhadap lingkungan medis atau prosedur perawatan berikutnya. Oleh karena itu, perawat dan tenaga kesehatan perlu memahami prinsip dasar manajemen nyeri yang tepat untuk anak, sekaligus memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian nyeri serta memilih pendekatan yang paling sesuai untuk mengatasi nyeri yang dialami oleh anak.

Prinsip dasar dalam manajemen nyeri pada anak adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan penanganan nyeri yang efektif, aman, serta tepat waktu. Salah satu prinsip utama dalam manajemen nyeri pada anak adalah mengakui bahwa nyeri yang dirasakan anak bersifat subjektif, sehingga laporan atau ekspresi nyeri yang disampaikan anak harus dipercaya dan direspons secara serius. Anak-anak sering kali tidak dapat secara eksplisit menjelaskan atau menggambarkan nyeri yang mereka alami, khususnya pada usia yang lebih muda. Oleh karena itu, perawat perlu menggunakan berbagai metode atau alat ukur khusus untuk menilai nyeri, sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak.

Prinsip penting lainnya adalah pendekatan manajemen nyeri harus bersifat holistik, yang mencakup aspek fisik, emosional, psikologis, dan sosial. Manajemen nyeri bukan hanya berfokus pada pemberian obat untuk meredakan rasa sakit semata, melainkan juga harus mempertimbangkan faktor emosional dan psikologis yang mempengaruhi persepsi nyeri pada anak. Dalam pelaksanaannya, perawat juga harus memastikan keterlibatan aktif dari keluarga atau orang tua anak dalam proses manajemen nyeri, karena kehadiran dan partisipasi mereka dapat memberikan rasa nyaman, aman, dan dukungan emosional bagi anak.

Dalam praktiknya, manajemen nyeri diawali dengan proses penilaian nyeri yang tepat dan akurat. Teknik penilaian nyeri pada anak harus disesuaikan dengan usia serta tingkat perkembangan kognitif dan emosional mereka. Pada bayi atau anak usia dini, misalnya, penilaian nyeri dapat dilakukan dengan mengamati tanda-tanda perilaku seperti ekspresi wajah, tangisan, perubahan pola pernapasan, gerakan tubuh yang gelisah, serta perubahan frekuensi detak jantung atau tekanan darah. Salah satu instrumen yang umum digunakan untuk menilai nyeri pada bayi adalah skala FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability), yang menilai nyeri berdasarkan observasi terhadap ekspresi wajah, aktivitas tungkai, aktivitas tubuh, tangisan, serta kemampuan untuk ditenangkan.

Pada anak prasekolah hingga usia sekolah, penilaian nyeri dapat dilakukan dengan pendekatan visual yang lebih interaktif, seperti menggunakan skala wajah (Wong-Baker Faces Pain Rating Scale) yang menampilkan gambar wajah dengan berbagai ekspresi mulai dari senang hingga sangat nyeri. Anak diminta untuk menunjukkan wajah yang paling sesuai dengan rasa sakit yang dialaminya. Pada

anak usia sekolah akhir hingga remaja, mereka sudah mampu menggunakan skala numerik sederhana (0 hingga 10) untuk menggambarkan intensitas nyeri yang dialami secara langsung. Dalam setiap teknik penilaian ini, perawat juga harus mempertimbangkan konteks dan situasi klinis yang dihadapi anak agar hasil penilaian menjadi akurat dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan klinis.

Setelah melakukan penilaian nyeri, langkah berikutnya adalah memilih pendekatan yang tepat dalam manajemen nyeri. Manajemen nyeri pada anak dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan nonfarmakologis dan farmakologis. Pendekatan nonfarmakologis adalah strategi penanganan nyeri yang tidak melibatkan pemberian obat, melainkan menggunakan berbagai teknik untuk mengurangi persepsi nyeri atau mengalihkan perhatian anak dari rasa sakit yang dialami. Pendekatan ini mencakup berbagai teknik seperti distraksi (pengalihan perhatian melalui musik, permainan, atau buku cerita), teknik relaksasi (teknik pernapasan, imajinasi terpandu, relaksasi otot progresif), sentuhan terapeutik, dan kehadiran orang tua atau anggota keluarga selama prosedur medis. Pendekatan nonfarmakologis ini terbukti sangat efektif terutama pada nyeri ringan hingga sedang, atau sebagai pelengkap dari pemberian obat untuk nyeri yang lebih intensif.

Selain pendekatan nonfarmakologis, pendekatan farmakologis juga merupakan bagian integral dalam manajemen nyeri anak, terutama pada kondisi nyeri sedang hingga berat, atau nyeri yang tidak merespons terhadap intervensi nonfarmakologis. Pendekatan farmakologis melibatkan penggunaan obat-obatan analgesik sesuai dengan tingkat nyeri dan kondisi klinis anak. Obat-obatan analgesik ini dapat berupa analgesik non-opioid seperti parasetamol dan ibuprofen untuk nyeri ringan hingga sedang, atau analgesik opioid seperti morfin untuk nyeri sedang hingga berat. Pemilihan jenis, dosis, dan rute pemberian obat harus disesuaikan secara hati-hati dengan usia anak, berat badan, kondisi kesehatan secara keseluruhan, serta evaluasi respons terhadap terapi yang diberikan. Perawat memiliki tanggung jawab penting dalam memantau efek samping potensial dari obat analgesik yang diberikan, seperti gangguan pernapasan pada penggunaan opioid, atau gangguan gastrointestinal pada penggunaan analgesik non-opioid dalam jangka panjang.

Kombinasi antara pendekatan nonfarmakologis dan farmakologis sering kali memberikan hasil terbaik dalam manajemen nyeri pada anak. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, perawat tidak hanya mampu meredakan rasa sakit secara fisik, tetapi juga mampu menciptakan suasana emosional yang nyaman dan positif bagi anak selama proses perawatan berlangsung. Selain itu, keterlibatan aktif dari keluarga selama proses manajemen nyeri juga memiliki

dampak positif yang besar terhadap hasil klinis maupun emosional anak, karena keluarga dapat memberikan dukungan emosional yang kuat dan membantu perawat dalam memahami respons nyeri anak dengan lebih baik.

J. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Keperawatan Anak

Keperawatan anak merupakan bidang yang dinamis dan terus berkembang seiring perubahan zaman, teknologi, serta munculnya tantangan dan isu baru yang mempengaruhi kesehatan anak secara global. Dalam beberapa tahun terakhir, keperawatan anak menghadapi sejumlah tantangan penting serta isu-isu kontemporer yang memerlukan perhatian khusus dari tenaga kesehatan, terutama perawat yang secara langsung bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada anak dan keluarganya. Berbagai isu ini mencakup tantangan dalam menghadapi masalah kesehatan anak secara global, adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital yang pesat, serta tren masa depan yang perlu diantisipasi oleh perawat anak agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Salah satu isu global yang menjadi perhatian utama dalam keperawatan anak adalah masih tingginya angka morbiditas dan mortalitas anak di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang atau dengan sumber daya terbatas. Permasalahan ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, seperti malnutrisi, infeksi penyakit menular seperti pneumonia dan diare, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta minimnya edukasi tentang praktik hidup sehat pada keluarga dan masyarakat. Selain itu, masalah global lainnya seperti meningkatnya angka obesitas pada anak, kesehatan mental anak yang semakin memprihatinkan, serta dampak dari lingkungan seperti polusi udara dan perubahan iklim, semakin menambah tantangan yang harus dihadapi oleh tenaga kesehatan anak secara global.

Dalam menghadapi isu global tersebut, perawat anak memiliki peran penting dalam mengedukasi keluarga, komunitas, serta ikut serta dalam kampanye kesehatan global. Perawat anak harus mampu memahami dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi kesehatan anak di berbagai negara atau wilayah tertentu, serta mampu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dan pihak terkait untuk mengembangkan solusi yang efektif dan kontekstual dalam menyelesaikan berbagai isu global ini. Misalnya, perawat dapat aktif dalam kampanye imunisasi global, promosi ASI eksklusif, pencegahan stunting, serta program-program berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental anak dan pencegahan obesitas.

Selain isu global, tantangan praktik keperawatan anak di era digital juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Kemajuan teknologi digital telah

membawa perubahan signifikan dalam cara perawat anak memberikan asuhan, berkomunikasi, mengakses informasi, serta melakukan dokumentasi medis. Era digital ini membuka banyak peluang positif, seperti penggunaan telehealth atau telemedicine yang memungkinkan konsultasi medis jarak jauh, pemantauan kondisi pasien secara real-time, edukasi kesehatan yang lebih luas melalui media sosial, serta pemanfaatan berbagai aplikasi digital untuk mendukung perawatan dan pemantauan kondisi kesehatan anak. Akan tetapi, tantangan utama yang muncul bersamaan dengan perkembangan teknologi digital ini adalah kebutuhan adaptasi yang cepat dan efektif dari tenaga keperawatan, serta isu-isu etis terkait privasi dan keamanan data kesehatan anak.

Perawat anak kini dituntut memiliki kompetensi teknologi informasi yang memadai agar mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal dan efektif. Mereka perlu memahami bagaimana cara melakukan konsultasi medis virtual dengan aman dan nyaman bagi anak serta keluarga, serta mampu menggunakan berbagai aplikasi kesehatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Selain itu, perawat juga diharapkan mampu memberikan edukasi yang tepat kepada orang tua dan anak mengenai penggunaan teknologi digital secara bijak agar terhindar dari risiko-risiko seperti kecanduan gadget, cyberbullying, serta masalah kesehatan mental akibat penggunaan media digital yang berlebihan.

Lebih lanjut, tantangan utama lainnya dalam era digital ini adalah menjaga privasi dan keamanan data pasien anak, terutama saat menggunakan aplikasi atau sistem informasi digital yang rentan terhadap penyalahgunaan data. Perawat anak harus memastikan bahwa informasi medis yang mereka tangani selalu terlindungi, serta mampu mematuhi berbagai regulasi atau pedoman hukum terkait keamanan data di setiap negara atau institusi tempat mereka bekerja. Dengan demikian, meskipun teknologi digital memberikan banyak manfaat dalam praktik keperawatan anak, perawat perlu terus waspada terhadap tantangan yang muncul dan beradaptasi secara cepat dan tepat.

Selain tantangan yang telah disebutkan, tren masa depan dalam keperawatan anak juga menjadi bagian penting dari isu kontemporer yang perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan. Di masa depan, pendekatan keperawatan anak akan semakin menekankan pada pendekatan holistik yang berpusat pada keluarga atau dikenal sebagai family-centered care. Pendekatan ini mengutamakan keterlibatan aktif keluarga dalam setiap tahap perawatan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi layanan kesehatan anak. Perawat di masa depan diharapkan mampu bekerja secara kolaboratif dengan keluarga, memahami perspektif mereka, serta mendukung pengambilan keputusan yang melibatkan keluarga secara aktif agar hasil kesehatan anak menjadi optimal.

Selain family-centered care, pendekatan atraumatic care juga akan semakin diperkuat dan diintegrasikan dalam setiap aspek pelayanan keperawatan anak. Atraumatic care menitikberatkan pada upaya mengurangi atau bahkan menghilangkan trauma fisik maupun psikologis yang mungkin dialami anak selama perawatan medis. Perawat di masa depan harus semakin terampil dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman secara emosional bagi anak-anak, meminimalkan rasa sakit dan stres selama prosedur medis, serta menggunakan teknik komunikasi yang efektif dan empatik dalam interaksi sehari-hari.

Di sisi lain, integrasi teknologi digital seperti telemedicine, artificial intelligence (AI), serta pemantauan kesehatan berbasis wearable devices (alat pemantau kesehatan yang dikenakan anak), juga akan semakin menjadi tren dominan di masa depan. Perawat anak perlu memahami bagaimana cara mengintegrasikan teknologi-teknologi ini secara efektif dalam praktik sehari-hari, serta mampu memberikan edukasi yang tepat bagi keluarga agar mereka dapat menggunakan teknologi ini dengan bijaksana demi peningkatan kualitas hidup anak.

Dengan demikian, menghadapi berbagai tantangan dan isu kontemporer dalam keperawatan anak membutuhkan kesiapan, adaptasi, serta pembaruan kompetensi yang berkelanjutan dari tenaga kesehatan, khususnya perawat anak. Perawat harus memiliki pemahaman global tentang isu kesehatan anak yang terus berkembang, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi digital secara efektif dan etis, serta mampu mengantisipasi tren masa depan untuk memastikan layanan keperawatan anak yang diberikan selalu relevan, efektif, dan berkualitas tinggi. Melalui langkah-langkah tersebut, keperawatan anak diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup anak secara global.

K. Simpulan

Keperawatan anak merupakan bidang praktik keperawatan yang kompleks dan penting, berfokus pada pemberian asuhan kepada anak-anak mulai dari neonatus hingga remaja. Pelayanan keperawatan anak mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan tujuan utama untuk memastikan anak mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Perawat anak memiliki peran multifungsi sebagai pemberi asuhan (caregiver), pendidik (educator), pembela hak anak (advocator), konselor, peneliti, dan kolaborator interprofesional dalam memastikan perawatan yang menyeluruh dan holistik.

Pemahaman mendalam terhadap karakteristik tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar anak, serta prinsip-prinsip komunikasi efektif menjadi dasar

esensial dalam praktik keperawatan anak. Perawat harus memiliki kompetensi dalam mengenali tahapan perkembangan fisik, psikososial, kognitif, dan emosional anak untuk memberikan intervensi yang tepat sasaran. Pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual, harus dilakukan secara komprehensif agar anak tumbuh sehat dan sejahtera.

Aspek legal dan etik dalam keperawatan anak menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak anak dan keluarga dalam pelayanan kesehatan, penerapan prinsip-prinsip etik seperti beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice, serta kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku dalam perlindungan anak. Selain itu, pendekatan Family-Centered Care (FCC) dan Atraumatic Care menjadi prinsip utama dalam menciptakan pengalaman perawatan yang positif, nyaman, dan bebas trauma bagi anak dan keluarganya.

Manajemen nyeri yang efektif pada anak harus melibatkan penilaian nyeri yang tepat sesuai usia dan menggunakan kombinasi pendekatan nonfarmakologis serta farmakologis untuk memastikan kenyamanan maksimal anak selama proses perawatan. Sementara itu, tantangan dan isu kontemporer seperti isu global dalam kesehatan anak, adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital, serta tren masa depan dalam pendekatan holistik, family-centered, dan integrasi teknologi digital harus mendapat perhatian serius dan respons adaptif dari perawat anak.

Dengan demikian, perawat anak harus senantiasa mengembangkan kompetensinya, beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang terus berkembang, serta berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan keperawatan anak yang aman, efektif, humanis, dan berbasis bukti, demi meningkatkan kualitas hidup anak secara optimal.

L. Referensi

- Alfiyanti, D., Arief, Y. S., Krisnana, I., Triharini, M., & Yanto, A. (2025). *Development of an atraumatic care education model based on family-centered care to improve maternal behavior in reducing children's stress during hospitalization*. Journal of Pediatric Nursing. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2025.04.015>
- Alomedika. (2023). *Manajemen nyeri prosedural pada anak*. Diakses tanggal 9 Juli 2025, dari <https://www.alomedika.com/manajemen-nyeri-prosedural-pada-anak>
- Dolok Saribu, H. J., Pujiati, W., & Abdullah, E. (2021). *Penerapan atraumatic care dengan kecemasan anak pra-sekolah saat proses hospitalisasi*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 10(2), 656–663.
- Fitriani, D. F., Hendrawati, S., & Maryam, N. N. A. (2023). *Penerapan prinsip atraumatic care dan family centered care pada anak dengan hemangioma*

- di ruang rawat inap non intensif: Studi kasus*. Senti: Jurnal Riset Ilmiah, 2(9), 3780–3791. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1432>
- Hockenberry, M., & Wilson, D. (2014). *Wong's nursing care of infants and children* (10th ed.). Elsevier Mosby.
- Jansen, S., & Rahmawati, E. A. (2023). *Manajemen nyeri pada anak di rumah sakit*. JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2(8), 3361–3372.
- Wikipedia. (2025, Juni). *Family-centered care*. Diakses tanggal 9 Juli 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Family-centered_care

CHAPTER 2

PENGKAJIAN KEPERAWATAN PADA ANAK

Ns. Amatus Yudi Ismanto, Sp.Kep.An., PhD.NS

A. Pendahuluan/Prolog

Pengkajian keperawatan anak merupakan langkah awal yang penting dan esensial dalam seluruh proses asuhan keperawatan. Secara sederhana, pengkajian keperawatan anak dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis yang dilakukan oleh perawat anak untuk mengumpulkan data atau informasi tentang kondisi kesehatan anak secara komprehensif, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, serta lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Pengkajian ini dilakukan melalui berbagai metode, seperti wawancara kepada anak dan keluarga, observasi perilaku anak, serta pemeriksaan fisik yang mencakup pemeriksaan tanda-tanda vital, pengukuran antropometri, serta penilaian fungsi organ tubuh. Tujuan utama dari pengkajian keperawatan anak adalah untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi anak, mengidentifikasi masalah kesehatan potensial maupun aktual yang dihadapi anak, serta menentukan prioritas dan merancang intervensi keperawatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Pentingnya pengkajian keperawatan dalam praktik keperawatan anak tidak bisa diabaikan. Pengkajian ini merupakan pondasi dasar yang mendasari setiap langkah intervensi yang dilakukan perawat terhadap anak dan keluarganya. Melalui pengkajian yang komprehensif dan akurat, perawat dapat menentukan diagnosis keperawatan secara tepat, sehingga perencanaan tindakan dan intervensi keperawatan dapat disusun dengan benar dan efektif. Sebagai contoh, dalam kasus anak yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut, pengkajian yang baik akan membantu perawat memahami kondisi klinis secara menyeluruh, seperti mengetahui tingkat keparahan infeksi, pola napas anak, riwayat kesehatan sebelumnya, kondisi nutrisi, hingga respons psikologis anak terhadap sakit yang dialaminya. Semua data ini akan menjadi dasar kuat bagi perawat untuk menentukan intervensi seperti pemberian oksigen, terapi nebulisasi, edukasi keluarga tentang pentingnya menjaga kebersihan, hingga memberikan dukungan emosional untuk anak agar merasa aman selama perawatan berlangsung.

Lebih lanjut, pengkajian keperawatan juga membantu perawat anak dalam mengidentifikasi risiko masalah kesehatan yang mungkin muncul di kemudian hari.

Dengan kata lain, pengkajian bukan hanya bermanfaat dalam menangani masalah yang sedang dihadapi anak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya preventif untuk menjaga kesehatan jangka panjang anak. Sebagai ilustrasi, dalam pengkajian status gizi, perawat bisa menemukan tanda-tanda awal stunting atau malnutrisi kronis, yang jika terdeteksi dini dapat segera ditindaklanjuti dengan edukasi nutrisi kepada keluarga, konseling diet, dan intervensi tepat lainnya sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi lebih serius. Oleh karena itu, pengkajian keperawatan anak adalah tahapan kritis yang menentukan arah keseluruhan proses perawatan kesehatan anak.

Dalam pelaksanaan pengkajian keperawatan anak, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh perawat anak. Prinsip pertama adalah holistik, yang berarti bahwa pengkajian harus mampu melihat anak secara utuh sebagai individu dengan berbagai aspek kebutuhan yang saling terkait. Pengkajian tidak boleh terfokus hanya pada aspek fisik semata, tetapi harus meliputi aspek emosional, psikososial, spiritual, dan budaya anak, karena seluruh aspek ini saling berhubungan erat dan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan secara keseluruhan. Sebagai contoh, anak yang sakit mungkin menunjukkan tanda-tanda kecemasan yang tinggi karena takut terhadap lingkungan rumah sakit; maka perawat perlu mengidentifikasi dan memberikan intervensi psikologis selain mengatasi masalah fisik yang dialami anak.

Prinsip kedua adalah family-centered care, yang berarti bahwa keluarga harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengkajian. Hal ini sangat penting karena keluarga adalah pihak yang paling mengenal anak dan mampu memberikan informasi berharga tentang riwayat kesehatan anak, kebiasaan sehari-hari, pola makan, pola tidur, hingga respons anak terhadap situasi tertentu. Melibatkan keluarga secara aktif juga memungkinkan terciptanya hubungan saling percaya antara perawat dengan keluarga, sehingga keluarga merasa lebih dihargai dan terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan perawat.

Prinsip ketiga adalah prinsip atraumatic care. Ini berarti bahwa pengkajian keperawatan anak harus dilakukan dengan cara-cara yang seminimal mungkin menimbulkan rasa sakit, stres, atau trauma emosional bagi anak. Misalnya, ketika melakukan pengkajian fisik, perawat harus menggunakan pendekatan yang lembut, mengajak anak berbicara dengan ramah, serta melakukan pengalihan perhatian selama pemeriksaan agar anak merasa nyaman. Hal ini bertujuan agar anak tidak mengalami trauma jangka panjang akibat pengalaman negatif selama pengkajian kesehatan dilakukan.

Selanjutnya, prinsip lain yang harus diperhatikan adalah prinsip perkembangan. Pengkajian keperawatan anak harus selalu disesuaikan dengan

tahap tumbuh kembang anak. Perawat harus memahami bahwa cara melakukan pengkajian pada anak bayi tentu berbeda dengan pengkajian pada anak usia sekolah atau remaja. Sebagai contoh, pengkajian terhadap bayi akan lebih banyak mengandalkan observasi dan wawancara kepada orang tua, sedangkan pada anak yang lebih besar, wawancara langsung kepada anak dapat dilakukan secara lebih efektif. Perawat harus memiliki keterampilan khusus dalam menyesuaikan teknik dan metode pengkajian yang tepat sesuai usia dan tingkat perkembangan anak, agar data yang diperoleh menjadi akurat dan relevan.

Terakhir, prinsip dasar dalam pengkajian keperawatan anak adalah prinsip dokumentasi yang jelas dan lengkap. Setiap data atau informasi yang diperoleh selama pengkajian harus dicatat secara sistematis, jelas, dan akurat dalam rekam medis anak. Dokumentasi ini penting untuk menjaga kontinuitas asuhan keperawatan, karena akan menjadi rujukan bagi perawat lain atau tim kesehatan dalam memahami kondisi anak secara utuh dan merencanakan tindakan lanjutan. Dokumentasi yang baik juga menjadi bukti legal dalam praktik keperawatan yang menunjukkan bahwa pengkajian telah dilakukan dengan benar dan profesional.

B. Teknik dan Pendekatan Pengkajian pada Anak

Dalam praktik keperawatan anak, proses pengkajian merupakan langkah penting yang menjadi dasar utama dalam menentukan intervensi yang tepat guna mendukung kesehatan anak secara menyeluruh. Pengkajian yang efektif pada anak memerlukan perhatian khusus dan keterampilan khusus dari perawat, karena karakteristik fisik, emosional, psikologis, dan sosial anak berbeda secara signifikan dengan pasien dewasa. Oleh karena itu, perawat perlu memahami secara mendalam berbagai teknik serta pendekatan yang tepat dalam proses pengkajian keperawatan anak agar data yang diperoleh valid, akurat, dan relevan dengan kebutuhan khusus anak.

Proses pengkajian keperawatan pada anak selalu diawali dengan tahapan persiapan sebelum pengkajian. Persiapan ini sangat penting karena menjadi kunci keberhasilan dalam mendapatkan data yang akurat serta membangun hubungan terapeutik yang kuat antara perawat dengan anak dan keluarganya. Pada tahap persiapan ini, perawat perlu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, mulai dari ruangan yang nyaman, alat-alat pengkajian, hingga persiapan diri secara psikologis maupun emosional. Perawat harus memastikan bahwa ruangan pengkajian bersifat ramah anak, tenang, nyaman, serta bebas dari hal-hal yang dapat menimbulkan kecemasan atau ketakutan pada anak. Sebagai contoh, ruangan dapat dihiasi dengan dekorasi menarik, mainan, atau gambar-gambar yang familiar bagi anak, sehingga mereka merasa nyaman dan tidak asing dengan situasi yang dihadapi.

Selain menyiapkan lingkungan fisik, perawat juga harus melakukan persiapan mental dan emosional, yaitu memastikan diri dalam kondisi tenang, sabar, dan penuh perhatian. Persiapan ini penting karena anak-anak sering kali peka terhadap perasaan atau sikap perawat yang mendekatinya. Sikap yang ramah, hangat, serta penuh perhatian akan membantu anak merasa nyaman dan mempercayai perawat, sehingga anak akan lebih kooperatif selama proses pengkajian berlangsung. Perawat juga perlu menyiapkan alat-alat pengkajian yang diperlukan seperti stetoskop, termometer, timbangan, pita ukur, dan peralatan lain secara lengkap dan fungsional, agar proses pengkajian dapat berjalan lancar tanpa gangguan teknis.

Selanjutnya, pendekatan atraumatic dalam proses pengkajian menjadi prinsip yang sangat penting dalam keperawatan anak. Pendekatan atraumatic care ini bertujuan meminimalisir atau bahkan menghilangkan trauma fisik maupun emosional yang bisa saja timbul akibat prosedur pengkajian. Anak-anak cenderung lebih sensitif terhadap lingkungan baru, rasa sakit, atau intervensi medis, sehingga perawat harus memastikan setiap tindakan pengkajian dilakukan secara lembut, penuh perhatian, dan seminimal mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak. Pendekatan atraumatic dapat diterapkan melalui beberapa cara, seperti menjelaskan setiap prosedur secara sederhana dan jelas sebelum tindakan dilakukan, menggunakan teknik komunikasi verbal dan nonverbal yang menenangkan, serta memastikan anak didampingi oleh orang tua atau anggota keluarga terdekatnya selama proses pengkajian berlangsung.

Sebagai contoh, ketika melakukan pengukuran suhu tubuh atau pengambilan tekanan darah, perawat dapat menggunakan boneka atau mainan terlebih dahulu untuk memperkenalkan alat-alat medis kepada anak, sehingga anak merasa lebih akrab dan tidak takut terhadap alat-alat tersebut. Selain itu, penggunaan teknik distraksi atau pengalihan perhatian juga efektif digunakan dalam pendekatan atraumatic ini, seperti mengajak anak berbicara tentang hal yang disukai, menyanyikan lagu, atau memberikan mainan yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari rasa takut atau cemas. Pendekatan atraumatic ini tidak hanya penting untuk mengurangi stres anak, tetapi juga membantu anak memiliki persepsi positif terhadap proses pelayanan kesehatan secara umum.

Dalam proses pengkajian keperawatan anak, perawat menggunakan beberapa teknik utama yang saling melengkapi, yaitu teknik observasi, wawancara, dan pemeriksaan fisik. Teknik observasi merupakan salah satu metode utama dalam pengkajian anak, di mana perawat mengamati secara langsung perilaku anak, respons anak terhadap lingkungan sekitarnya, interaksi anak dengan orang tua atau keluarga, serta berbagai tanda fisik yang bisa diidentifikasi melalui pengamatan langsung. Melalui observasi, perawat dapat mengidentifikasi tanda-tanda nyeri,

ketidaknyamanan, gangguan pernapasan, atau berbagai kondisi fisik dan emosional lainnya yang sulit dijelaskan secara verbal oleh anak-anak, terutama pada anak yang masih sangat muda atau bayi.

Selain observasi, teknik wawancara juga memegang peranan yang sangat penting dalam pengkajian keperawatan anak. Wawancara biasanya dilakukan kepada orang tua atau anggota keluarga yang merawat anak, mengingat mereka merupakan sumber informasi yang paling memahami kondisi anak sehari-hari. Dalam wawancara, perawat menggali berbagai informasi penting seperti riwayat kesehatan anak, kebiasaan sehari-hari seperti pola tidur, pola makan, dan kebiasaan eliminasi, riwayat imunisasi, riwayat alergi, serta perkembangan anak secara keseluruhan. Wawancara yang efektif dilakukan dengan pendekatan empati, bahasa yang sederhana, serta suasana yang santai, sehingga orang tua merasa nyaman dan terbuka dalam memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang kondisi anak mereka.

Teknik terakhir yang tak kalah penting adalah pemeriksaan fisik yang meliputi berbagai metode seperti inspeksi (melihat), palpasi (meraba), perkusi (mengetuk), dan auskultasi (mendengarkan). Dalam melakukan pemeriksaan fisik pada anak, perawat harus sangat hati-hati dan memperhatikan tingkat kenyamanan anak secara emosional dan fisik. Sebagai contoh, pemeriksaan dimulai dari bagian tubuh yang paling tidak menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan terlebih dahulu, seperti tangan atau kaki, kemudian baru beralih ke area yang lebih sensitif seperti telinga atau perut. Teknik palpasi yang lembut dan hangat, pemeriksaan auskultasi dengan stetoskop yang dipanaskan terlebih dahulu di tangan perawat, serta perkusi yang dilakukan dengan gerakan ringan dan tidak mengejutkan anak, adalah contoh bagaimana teknik pemeriksaan fisik dilakukan secara atraumatic dan penuh perhatian.

Penggunaan kombinasi teknik observasi, wawancara, dan pemeriksaan fisik secara terpadu akan memastikan bahwa data yang diperoleh lengkap, akurat, serta mencerminkan kondisi kesehatan anak secara holistik. Setiap data yang diperoleh dari ketiga teknik ini akan dicatat secara sistematis dalam rekam medis anak, yang akan menjadi dasar dalam menyusun diagnosis keperawatan serta rencana intervensi yang efektif.

C. Komponen Pengkajian Keperawatan Anak

Dalam praktik keperawatan anak, pengkajian merupakan tahap penting yang melibatkan pengumpulan data secara komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari kondisi kesehatan fisik, riwayat keluarga, pertumbuhan, perkembangan, hingga lingkungan sosial-budaya tempat anak tumbuh. Pengkajian

yang menyeluruh dan mendalam ini menjadi dasar utama bagi perawat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, menyusun diagnosis keperawatan yang tepat, serta merencanakan tindakan intervensi keperawatan yang efektif untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak.

Salah satu komponen utama dalam pengkajian keperawatan anak adalah pengkajian riwayat kesehatan anak dan keluarganya. Dalam tahap ini, perawat mengumpulkan berbagai informasi penting yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kondisi kesehatan anak. Informasi ini biasanya didapatkan melalui wawancara mendalam dengan orang tua atau anggota keluarga terdekat yang merawat anak sehari-hari. Perawat perlu mengetahui riwayat kehamilan dan kelahiran anak, riwayat penyakit atau kondisi medis yang pernah diderita anak sebelumnya, riwayat pengobatan atau perawatan yang pernah dijalani, riwayat alergi, serta status imunisasi anak. Informasi terkait riwayat kesehatan keluarga juga menjadi bagian yang sangat penting, seperti adanya riwayat penyakit keturunan atau genetik dalam keluarga, kebiasaan keluarga yang berpengaruh terhadap kesehatan (misalnya pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok dalam keluarga), hingga kondisi emosional dan psikososial keluarga yang dapat berdampak terhadap kesehatan anak secara keseluruhan.

Selain riwayat kesehatan, komponen berikutnya adalah pengkajian pertumbuhan fisik anak. Pengkajian pertumbuhan fisik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengukuran antropometri seperti mengukur berat badan, tinggi badan atau panjang badan, lingkar kepala, serta lingkar lengan atas. Data antropometri ini sangat penting untuk mengevaluasi status gizi anak, mengidentifikasi adanya gangguan pertumbuhan seperti kurang gizi (malnutrisi), kelebihan gizi (obesitas), atau bahkan stunting (pendek). Di samping antropometri, pengkajian fisik juga mencakup pengukuran tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, frekuensi denyut jantung, frekuensi pernapasan, dan tekanan darah anak yang digunakan untuk menilai status kesehatan dasar serta mendeteksi adanya kondisi akut atau kronis yang mungkin dialami anak.

Lebih lanjut, perawat juga melakukan pengkajian sistem tubuh secara menyeluruh, meliputi sistem pernapasan, kardiovaskular, pencernaan, muskuloskeletal, neurologis, serta sistem integumen (kulit). Pengkajian ini melibatkan inspeksi (melihat), palpasi (meraba), perkusi (mengetuk ringan), serta auskultasi (mendengarkan dengan stetoskop). Sebagai contoh, perawat akan memeriksa pola pernapasan anak, mendengarkan bunyi napas untuk mengidentifikasi adanya gangguan pernapasan, memeriksa bunyi jantung untuk mengetahui adanya kelainan irama atau gangguan fungsi jantung, serta menilai kondisi kulit untuk mendeteksi ruam, infeksi, atau tanda-tanda alergi. Pengkajian

fisik yang detail ini membantu perawat mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan fisik anak.

Komponen berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah pengkajian perkembangan kognitif, psikososial, dan emosional anak. Setiap anak memiliki pola perkembangan unik yang berlangsung secara bertahap sesuai dengan tahapan usianya. Dalam pengkajian ini, perawat harus mampu mengenali apakah anak telah mencapai tonggak perkembangan (milestone) yang sesuai dengan usia kronologisnya. Untuk aspek kognitif, perawat mengkaji kemampuan berpikir, konsentrasi, daya ingat, kemampuan pemecahan masalah, serta kemampuan berbahasa anak. Sebagai contoh, perawat akan melihat apakah anak mampu mengikuti instruksi sederhana, berkomunikasi dengan jelas sesuai dengan tahap perkembangan usianya, atau menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam permainan atau interaksi sehari-hari.

Pada aspek psikososial dan emosional, pengkajian mencakup bagaimana anak berinteraksi dengan orang tua, anggota keluarga lain, atau teman sebaya, serta bagaimana anak menunjukkan respons emosional terhadap situasi tertentu. Perawat juga mengkaji pola perilaku sosial anak, seperti kemampuan berbagi dengan orang lain, bermain secara kooperatif, mengekspresikan perasaan dengan tepat, serta kemampuan mengelola emosi ketika mengalami frustrasi atau stres. Dalam hal ini, teori perkembangan psikososial dari Erikson sering digunakan sebagai acuan untuk melihat apakah anak berhasil mencapai tugas-tugas psikososial di setiap tahapan usianya, mulai dari rasa percaya (trust), kemandirian (autonomi), inisiatif, hingga identitas diri pada usia remaja. Data yang didapat dari pengkajian ini sangat penting untuk menentukan apakah anak memerlukan dukungan tambahan dalam aspek psikologis atau emosional guna mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.

Komponen terakhir yang juga menjadi perhatian penting adalah pengkajian lingkungan sosial dan budaya anak. Lingkungan tempat anak tumbuh memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi kesehatannya secara fisik maupun psikososial. Dalam pengkajian ini, perawat mengevaluasi kondisi lingkungan rumah tempat tinggal anak, termasuk kondisi fisik lingkungan seperti kebersihan, keamanan, akses terhadap air bersih, sanitasi, dan kondisi lingkungan sekitar rumah yang mungkin berisiko bagi anak, seperti adanya polusi udara atau bahaya fisik lain. Selain itu, perawat juga menggali bagaimana pola pengasuhan dalam keluarga, hubungan anak dengan orang tua, ketersediaan dukungan sosial dari keluarga besar atau komunitas, serta nilai-nilai budaya yang dianut oleh keluarga.

Pengkajian aspek budaya menjadi penting karena nilai dan kepercayaan yang dianut oleh keluarga dapat memengaruhi cara mereka merawat dan mengelola kesehatan anak. Misalnya, keluarga dari latar belakang budaya tertentu mungkin

memiliki kepercayaan atau praktik pengobatan tradisional yang spesifik, pola diet tertentu yang dianut sesuai budaya, atau pandangan terhadap penyakit dan kesehatan yang unik. Perawat perlu memahami dan menghargai nilai-nilai budaya ini serta menyesuaikan intervensi keperawatan agar dapat diterima dan efektif dalam konteks budaya keluarga tersebut.

D. Alat Ukur dan Instrumen Pengkajian dalam Keperawatan Anak

Dalam pelaksanaan praktik keperawatan anak, penggunaan alat ukur dan instrumen pengkajian yang tepat dan akurat menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Alat ukur dan instrumen ini tidak hanya membantu perawat dalam memperoleh data yang objektif, tetapi juga berperan besar dalam meningkatkan ketepatan diagnosis keperawatan serta membantu menentukan rencana intervensi yang efektif dan terukur. Terdapat berbagai jenis instrumen pengkajian yang digunakan secara luas dalam praktik keperawatan anak, di antaranya skala tumbuh kembang, instrumen penilaian nyeri, serta alat ukur untuk menilai status gizi anak.

Salah satu instrumen utama dalam pengkajian keperawatan anak adalah skala tumbuh kembang. Penggunaan skala tumbuh kembang sangat penting karena anak-anak mengalami proses pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, psikososial, serta emosional secara berkelanjutan dan dinamis. Untuk memastikan bahwa anak tumbuh dan berkembang secara optimal, perawat harus mampu mengidentifikasi apakah pertumbuhan dan perkembangan tersebut sesuai dengan tahapan usia anak. Skala tumbuh kembang yang paling umum digunakan adalah Kartu Menuju Sehat (KMS), Denver Developmental Screening Test II (DDST II), dan berbagai instrumen lain seperti Ages and Stages Questionnaire (ASQ).

Kartu Menuju Sehat (KMS) secara luas digunakan di Indonesia sebagai alat untuk memantau pertumbuhan fisik anak, khususnya dalam hal berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Melalui KMS, perawat dapat mendeteksi secara dini apabila terdapat gangguan pertumbuhan seperti malnutrisi, obesitas, atau stunting. Di sisi lain, DDST II merupakan instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan anak dalam empat aspek utama, yaitu aspek personal-sosial, motorik halus, motorik kasar, dan bahasa. Tes ini dapat membantu perawat mengidentifikasi secara dini adanya keterlambatan atau gangguan perkembangan, sehingga intervensi segera bisa dilakukan. Adapun ASQ adalah kuesioner yang berbasis orang tua dan digunakan untuk mengukur perkembangan anak melalui berbagai pertanyaan mengenai aktivitas yang dapat dilakukan anak sesuai usianya, serta keterampilan spesifik yang seharusnya dimiliki anak pada usia tertentu. Dengan menggunakan berbagai skala ini, perawat akan memperoleh gambaran

jelas dan objektif mengenai sejauh mana anak telah mencapai tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan.

Selanjutnya, dalam praktik keperawatan anak, penggunaan instrumen penilaian nyeri sangat diperlukan. Nyeri pada anak merupakan suatu kondisi yang kompleks, karena anak sering kali kesulitan untuk mengomunikasikan rasa sakit secara verbal dengan jelas, terutama pada usia yang sangat muda. Akibatnya, perawat memerlukan instrumen pengukuran khusus yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman anak untuk menilai intensitas nyeri yang dirasakan. Beberapa instrumen penilaian nyeri yang sering digunakan dalam praktik keperawatan anak adalah skala FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability), Wong-Baker Faces Pain Rating Scale, dan Numeric Rating Scale (NRS).

Skala FLACC digunakan untuk menilai nyeri pada bayi dan anak kecil yang belum mampu secara verbal menjelaskan nyerinya. Penilaian dilakukan berdasarkan observasi terhadap ekspresi wajah (Face), gerakan kaki (Legs), aktivitas tubuh (Activity), tangisan (Cry), serta kemampuan anak untuk ditenangkan (Consolability). Setiap parameter diberi skor tertentu yang kemudian dijumlahkan untuk menentukan intensitas nyeri yang dialami anak. Wong-Baker Faces Pain Rating Scale, di sisi lain, cocok untuk digunakan pada anak prasekolah hingga usia sekolah karena menggunakan visualisasi gambar wajah yang mewakili berbagai tingkat nyeri, dari wajah tersenyum yang berarti tidak nyeri hingga wajah yang menangis dan menunjukkan nyeri yang sangat berat. Anak diminta untuk menunjuk wajah yang paling mewakili nyeri yang dirasakannya, sehingga instrumen ini sangat efektif dalam situasi di mana komunikasi verbal anak terbatas. Untuk anak yang lebih tua atau remaja, Numeric Rating Scale (NRS) sering digunakan, yaitu skala numerik dari 0 hingga 10, di mana angka 0 berarti tidak ada nyeri dan angka 10 berarti nyeri yang sangat berat. Penggunaan instrumen penilaian nyeri yang tepat sangat membantu perawat dalam mengelola nyeri anak secara optimal, meningkatkan kenyamanan, serta mencegah trauma emosional yang berkepanjangan pada anak.

Di samping skala tumbuh kembang dan instrumen penilaian nyeri, alat ukur status gizi anak juga merupakan komponen yang sangat penting dalam pengkajian keperawatan anak. Status gizi memiliki hubungan erat dengan kesehatan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Anak dengan status gizi buruk akan lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti gangguan perkembangan fisik, keterlambatan perkembangan kognitif, serta penurunan sistem imunitas tubuh yang dapat menyebabkan infeksi berulang.

Alat ukur utama yang sering digunakan untuk menilai status gizi anak adalah pengukuran antropometri, seperti berat badan menurut usia (BB/U), tinggi badan

menurut usia (TB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB), serta pengukuran lingkaran lengan atas (LLA). Pengukuran antropometri ini kemudian dibandingkan dengan tabel standar seperti tabel WHO atau tabel KMS untuk menentukan apakah anak memiliki status gizi normal, kurang gizi, gizi buruk, overweight, atau obesitas. Selain antropometri, ada pula pengukuran status gizi yang lebih spesifik, seperti pemeriksaan laboratorium terhadap kadar hemoglobin (Hb) untuk mendeteksi anemia, pemeriksaan kadar protein serum seperti albumin, serta evaluasi pola makan sehari-hari menggunakan metode recall 24 jam atau food frequency questionnaire (FFQ). Informasi yang didapatkan dari alat-alat ukur ini akan memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai kondisi gizi anak, sehingga perawat dapat merancang intervensi yang tepat untuk meningkatkan status gizi anak, mencegah malnutrisi, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal.

E. Pengkajian Keperawatan Anak Berdasarkan Kelompok Usia

Dalam praktik keperawatan anak, pengkajian yang dilakukan secara cermat dan menyeluruh merupakan dasar utama untuk menentukan kondisi kesehatan anak serta merancang intervensi keperawatan yang tepat. Salah satu aspek penting yang harus dipahami oleh perawat adalah bahwa pengkajian keperawatan pada anak harus disesuaikan berdasarkan kelompok usianya. Hal ini dikarenakan setiap kelompok usia memiliki karakteristik khusus yang sangat memengaruhi kebutuhan kesehatan, pola tumbuh kembang, respons terhadap perawatan, serta teknik pengkajian yang paling efektif untuk diterapkan. Berikut akan dijelaskan secara mendetail mengenai pengkajian keperawatan anak berdasarkan kelompok usia, mulai dari neonatus hingga remaja.

Pengkajian pada neonatus (0–28 hari) merupakan tahap yang sangat kritis dalam praktik keperawatan anak. Pada masa ini, neonatus mengalami adaptasi yang signifikan dari kehidupan intrauterin ke lingkungan ektrauterin. Oleh karena itu, perawat perlu melakukan pengkajian secara sangat teliti dengan memperhatikan aspek fisiologis, adaptasi tubuh, serta kemungkinan komplikasi kesehatan. Pengkajian neonatus mencakup pemeriksaan fisik yang detail seperti pengukuran berat badan, panjang badan, lingkaran kepala, observasi kulit untuk menilai warna dan tanda-tanda ikterus neonatorum, pemeriksaan refleks primitif seperti refleks rooting, sucking, Moro, grasp, dan Babinski, serta evaluasi fungsi pernapasan dan sirkulasi, seperti pernapasan spontan, frekuensi denyut jantung, suhu tubuh, serta saturasi oksigen. Selain itu, perawat juga harus memperhatikan pola eliminasi neonatus seperti frekuensi urinasi dan defekasi, serta kemampuan bayi untuk menyusu atau mendapatkan asupan nutrisi secara adekuat dari ibunya atau formula

pengganti ASI. Setiap tanda abnormal atau gangguan adaptasi pada masa neonatus ini harus segera dikenali dan ditangani dengan cepat dan tepat untuk menghindari komplikasi serius.

Pengkajian pada bayi (1 bulan–1 tahun) memiliki fokus utama pada pemantauan pertumbuhan fisik yang sangat pesat serta evaluasi perkembangan motorik, sensorik, dan sosial bayi. Pada periode ini, bayi mulai menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek motorik kasar seperti kemampuan mengangkat kepala, berguling, duduk, hingga merangkak dan berdiri. Perawat harus secara rutin melakukan pengkajian antropometri (berat badan, tinggi badan, lingkar kepala) yang dicatat dalam kurva pertumbuhan standar untuk mendeteksi dini risiko malnutrisi atau pertumbuhan abnormal seperti stunting atau wasting. Pemeriksaan perkembangan juga sangat penting, di mana perawat menggunakan instrumen khusus seperti Denver Developmental Screening Test (DDST) untuk memastikan bayi mencapai tahapan perkembangan yang sesuai usianya. Selain itu, pengkajian juga mencakup observasi interaksi sosial bayi dengan pengasuh utama, pola tidur dan istirahat, pola nutrisi, serta pemeriksaan imunisasi lengkap dan riwayat kesehatan yang terkait penyakit infeksi yang sering terjadi di usia bayi seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), diare, atau gangguan pertumbuhan.

Pengkajian pada balita (1–3 tahun) menekankan pada observasi kemampuan motorik kasar yang semakin meningkat seperti berjalan mandiri, berlari, memanjat, serta kemampuan motorik halus seperti menggambar, memegang alat makan, dan menyusun benda-benda sederhana. Pada masa ini pula, balita mengalami perkembangan bahasa yang pesat, sehingga perawat harus mengkaji kemampuan berkomunikasi, mengucapkan kata-kata sederhana, dan memahami instruksi dasar. Pengkajian psikososial juga sangat penting, karena masa balita ditandai dengan munculnya otonomi, rasa ingin tahu yang tinggi, serta potensi tantrum atau perilaku menolak (negativistik). Perawat perlu memperhatikan bagaimana pola asuh orang tua, hubungan sosial balita dengan orang dewasa atau teman sebaya, pola nutrisi serta status gizi balita, pemantauan pertumbuhan fisik, dan evaluasi perkembangan melalui alat ukur seperti DDST atau Ages and Stages Questionnaire (ASQ). Pengkajian ini membantu perawat mengenali potensi masalah seperti keterlambatan bicara, gangguan nutrisi, atau gangguan perilaku dan emosional pada balita secara dini.

Pengkajian pada anak prasekolah (3–6 tahun) difokuskan pada perkembangan sosial, emosi, bahasa, serta kemampuan motorik yang semakin kompleks. Pada tahap ini, anak biasanya sudah mampu melakukan aktivitas mandiri seperti berpakaian, mandi sendiri dengan pengawasan, serta mampu mengikuti instruksi sederhana secara efektif. Perawat harus mengobservasi kemampuan anak dalam

bersosialisasi, bermain bersama teman sebaya, berpartisipasi dalam aktivitas kelompok, serta mengevaluasi kemampuan bahasa yang digunakan anak untuk berkomunikasi dan mengungkapkan pikirannya. Pengkajian fisik masih tetap penting, terutama untuk memastikan bahwa pertumbuhan anak tetap berada dalam standar normal, serta mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan seperti obesitas atau underweight. Perawat juga harus melakukan pengkajian lingkungan sosial dan keluarga anak, seperti pola asuh, hubungan keluarga, serta lingkungan sekolah atau tempat bermain anak untuk memastikan bahwa anak berada dalam kondisi yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.

Pengkajian pada anak usia sekolah (6–12 tahun) memiliki karakteristik khusus, di mana anak mulai memiliki kehidupan sosial yang lebih luas, tuntutan akademik, serta kemampuan berpikir logis yang lebih berkembang. Pada tahap ini, perawat perlu mengkaji kemampuan akademik anak seperti membaca, menulis, serta berhitung secara dasar. Pengkajian fisik tetap penting, khususnya untuk mengidentifikasi masalah kesehatan umum pada anak usia sekolah seperti gangguan penglihatan (miopia), gangguan pendengaran, masalah gigi dan mulut, serta masalah nutrisi seperti obesitas. Di samping itu, perawat harus mengevaluasi perkembangan psikososial anak melalui interaksi dengan teman sebaya, adaptasi sosial, kepercayaan diri, serta kemampuan anak untuk menangani tekanan akademik atau sosial seperti bullying. Pengkajian ini penting untuk mendeteksi dini gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau gangguan perilaku lainnya yang dapat muncul pada usia sekolah.

Pengkajian pada anak remaja (12–18 tahun) memerlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan aspek perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan emosional yang kompleks. Remaja mengalami perubahan signifikan dalam pertumbuhan fisik akibat pubertas, yang ditandai dengan munculnya karakteristik seksual sekunder. Perawat perlu secara sensitif melakukan pengkajian fisik untuk memastikan bahwa remaja mengalami perkembangan seksual yang normal, sambil memberikan edukasi yang tepat tentang perubahan tubuh dan kesehatan reproduksi. Pengkajian psikososial menjadi pusat perhatian, di mana perawat harus mengidentifikasi isu-isu umum yang dialami remaja seperti konflik identitas, tekanan dari lingkungan sosial atau keluarga, risiko perilaku berbahaya (merokok, penggunaan alkohol dan narkoba, atau perilaku seksual berisiko), serta kesehatan mental termasuk deteksi dini gangguan emosional atau depresi. Perawat juga harus melakukan pengkajian terkait pola hidup sehat, status nutrisi, aktivitas fisik, serta pola tidur dan istirahat remaja. Komunikasi yang empatik dan nonjudgmental menjadi kunci penting dalam pengkajian ini untuk memastikan bahwa remaja

merasa nyaman dalam mengungkapkan perasaan, kebutuhan, atau masalah kesehatan yang dialami.

F. Dokumentasi dan Pelaporan Hasil Pengkajian Keperawatan Anak

Dalam praktik keperawatan anak, dokumentasi dan pelaporan hasil pengkajian merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan secara cermat, sistematis, dan akurat oleh setiap perawat. Dokumentasi dalam keperawatan anak merujuk pada pencatatan data atau informasi hasil pengkajian, observasi klinis, intervensi yang telah dilakukan, respons pasien terhadap tindakan keperawatan, serta rencana perawatan yang akan dilakukan selanjutnya. Proses dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses asuhan keperawatan yang akan menjadi acuan dalam memberikan perawatan yang berkesinambungan, aman, dan berkualitas bagi anak dan keluarganya.

Salah satu prinsip penting dalam dokumentasi hasil pengkajian keperawatan anak adalah prinsip keakuratan dan kelengkapan informasi. Setiap perawat harus memastikan bahwa data yang dicatat dalam dokumen keperawatan merupakan informasi yang benar-benar akurat, sesuai kondisi pasien, serta mencakup seluruh aspek penting dalam pengkajian anak secara komprehensif. Prinsip ini sangat penting karena informasi yang akurat dan lengkap akan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan klinis, penentuan diagnosis keperawatan, perencanaan tindakan, serta evaluasi hasil perawatan yang telah diberikan. Selain itu, dokumentasi yang baik harus bersifat obyektif dan faktual, di mana perawat hanya mencatat apa yang benar-benar diamati atau diukur, tanpa memasukkan opini atau asumsi pribadi yang tidak berbasis bukti. Dengan menerapkan prinsip obyektivitas ini, dokumentasi keperawatan akan menjadi lebih terpercaya, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis maupun hukum.

Selain keakuratan, prinsip dokumentasi keperawatan anak juga menekankan pada aspek keteraturan dan kronologis. Setiap informasi harus dicatat secara sistematis dalam urutan waktu yang jelas, sehingga mudah dipahami oleh perawat lain atau anggota tim kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien. Prinsip ini sangat membantu dalam kesinambungan asuhan keperawatan, terutama dalam situasi di mana perawatan anak melibatkan berbagai tim kesehatan dari berbagai disiplin ilmu atau dalam situasi transisi perawatan dari satu shift ke shift lainnya. Dengan dokumentasi yang kronologis, seluruh tim kesehatan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan kondisi anak, tindakan apa saja yang telah diberikan, serta hasil yang diperoleh dari tindakan tersebut. Prinsip ini secara langsung mendukung

koordinasi dan kolaborasi interprofesional yang lebih efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Dalam era perkembangan teknologi informasi saat ini, model dokumentasi berbasis elektronik (Electronic Health Records atau EHR) mulai banyak diterapkan dalam praktik keperawatan anak di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, atau pusat layanan kesehatan masyarakat. Penggunaan sistem EHR dalam dokumentasi hasil pengkajian keperawatan anak memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan metode dokumentasi manual atau berbasis kertas. Salah satu keunggulan utama dari EHR adalah efisiensi dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta akses terhadap data klinis pasien. Dengan sistem elektronik ini, informasi kesehatan anak dapat disimpan secara aman dan tersentralisasi, sehingga memudahkan perawat dan anggota tim kesehatan lainnya dalam mengakses data secara cepat, real-time, dan akurat dari berbagai lokasi atau unit perawatan.

Lebih lanjut, dokumentasi berbasis elektronik juga meningkatkan akurasi pencatatan karena sistem EHR sering kali memiliki format standar dan terstruktur yang membantu perawat mencatat data secara lebih lengkap, konsisten, dan bebas dari kesalahan penulisan atau pengolahan data. Sistem EHR juga memiliki fitur penting seperti pengingat otomatis untuk tindakan perawatan tertentu, peringatan dini jika ada informasi yang tidak lengkap, serta kemampuan untuk secara otomatis menghasilkan laporan atau rangkuman kondisi pasien secara berkala. Hal ini sangat membantu dalam pemantauan perkembangan anak secara kontinu, terutama pada pasien yang memerlukan perawatan jangka panjang atau memiliki kondisi medis kompleks yang membutuhkan pengawasan intensif.

Selain manfaat administratif dan klinis tersebut, sistem dokumentasi elektronik juga memiliki implikasi positif dalam hal komunikasi dan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Informasi pasien yang terintegrasi dan mudah diakses memungkinkan seluruh tim kesehatan, mulai dari perawat, dokter spesialis anak, ahli gizi, hingga tenaga rehabilitasi, untuk berbagi informasi secara efektif. Ini menciptakan alur komunikasi yang lebih lancar, mengurangi risiko kesalahpahaman atau informasi yang hilang, serta meningkatkan keselamatan pasien secara keseluruhan.

Pentingnya dokumentasi hasil pengkajian dalam kesinambungan asuhan keperawatan anak tidak dapat diremehkan. Dokumentasi yang baik memungkinkan terciptanya suatu gambaran klinis yang utuh mengenai kondisi anak, mulai dari riwayat kesehatan, hasil observasi fisik, hingga respons terhadap intervensi keperawatan yang telah dilakukan. Dengan dokumentasi yang sistematis, jelas, dan akurat, perawat yang bertugas pada shift berikutnya atau perawat lain yang terlibat

dalam perawatan pasien dapat dengan cepat memahami kondisi pasien, tindakan yang harus segera dilakukan, serta tujuan perawatan yang ingin dicapai.

Selain itu, dokumentasi yang komprehensif juga merupakan alat evaluasi yang penting dalam praktik keperawatan. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap, perawat dapat mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah diberikan, mengidentifikasi perubahan kondisi pasien secara dini, serta melakukan modifikasi terhadap rencana keperawatan yang sesuai dengan kondisi terbaru pasien. Dokumentasi yang terdokumentasi dengan baik juga membantu dalam upaya pembuktian hukum jika terjadi sengketa atau audit klinis, serta merupakan bukti yang valid tentang kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh fasilitas kesehatan.

Dengan demikian, dokumentasi dan pelaporan hasil pengkajian dalam keperawatan anak merupakan suatu kewajiban penting yang harus dilakukan secara profesional dan teliti oleh setiap perawat. Prinsip dokumentasi seperti keakuratan, kelengkapan, obyektivitas, dan kronologis harus selalu diterapkan, sedangkan penggunaan teknologi dokumentasi elektronik (EHR) merupakan langkah maju yang dapat mendukung efisiensi, keselamatan pasien, serta kolaborasi antar tenaga kesehatan yang lebih baik. Dengan penerapan dokumentasi yang baik, kualitas asuhan keperawatan anak dapat ditingkatkan secara signifikan, menciptakan kesinambungan perawatan yang optimal, serta memberikan dampak positif jangka panjang terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan.

G. Tantangan dan Hambatan dalam Pengkajian Keperawatan Anak

Pengkajian keperawatan anak merupakan proses awal yang sangat penting untuk memperoleh informasi mendalam mengenai kondisi kesehatan anak secara menyeluruh. Meski demikian, proses ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang cukup kompleks, baik dari segi komunikasi dengan anak dan keluarganya, faktor psikologis yang melekat pada anak maupun orang tua, hingga keterbatasan yang muncul dari situasi dan lingkungan praktik klinis itu sendiri.

Salah satu hambatan utama yang paling sering dihadapi oleh perawat dalam pengkajian keperawatan anak adalah hambatan komunikasi, baik dengan anak maupun dengan anggota keluarganya. Anak-anak memiliki karakteristik perkembangan bahasa, kemampuan komunikasi, dan pemahaman yang sangat bervariasi sesuai usia dan tingkat perkembangannya. Misalnya, anak usia prasekolah belum mampu mengekspresikan keluhan kesehatan secara jelas seperti anak yang lebih besar atau remaja, sementara bayi hanya bisa mengekspresikan rasa sakit atau ketidaknyamanan melalui tangisan, perubahan ekspresi wajah, atau perilaku rewel. Kondisi ini seringkali menimbulkan tantangan besar bagi perawat dalam

menginterpretasikan kebutuhan atau keluhan anak secara tepat, sehingga diperlukan kepekaan, keterampilan observasi yang tinggi, serta penggunaan berbagai teknik komunikasi yang efektif sesuai usia dan tingkat perkembangan anak.

Di samping kesulitan berkomunikasi langsung dengan anak, perawat juga sering menghadapi hambatan komunikasi dengan keluarga atau orang tua anak. Kondisi emosional keluarga, terutama orang tua yang cemas, khawatir, atau bahkan dalam situasi stres akibat kondisi kesehatan anak, sering kali menyebabkan komunikasi menjadi tidak optimal. Orang tua yang emosional dapat mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, lengkap, atau akurat kepada perawat. Kadang pula, keluarga memiliki rasa tidak percaya atau defensif terhadap tim kesehatan, sehingga informasi penting yang seharusnya disampaikan oleh keluarga justru terlewatkan atau tidak terbuka sepenuhnya. Kondisi ini tentunya dapat mengganggu kelancaran proses pengkajian, karena informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat akan berdampak pada ketepatan diagnosa dan perencanaan perawatan yang diberikan.

Selain hambatan komunikasi, faktor psikologis juga merupakan tantangan signifikan dalam proses pengkajian keperawatan anak. Banyak anak yang menunjukkan rasa takut, cemas, atau bahkan trauma terhadap lingkungan fasilitas kesehatan maupun terhadap tenaga kesehatan yang merawatnya. Pengalaman traumatik sebelumnya seperti nyeri akibat prosedur medis, ketakutan terhadap jarum suntik, atau suasana lingkungan rumah sakit yang asing, sering menyebabkan anak menolak atau tidak kooperatif selama proses pengkajian berlangsung. Faktor psikologis semacam ini tidak hanya dialami anak, namun juga oleh orang tua yang merasa bersalah, cemas berlebihan, atau tidak siap menghadapi situasi sakit anaknya. Akibatnya, proses pengkajian bisa menjadi sulit, panjang, dan tidak efektif, karena perawat harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menenangkan anak serta memastikan bahwa anak merasa aman dan nyaman selama proses berlangsung.

Faktor psikologis tersebut juga dapat menyebabkan perawat harus melakukan pengkajian secara parsial atau tidak sempurna, di mana informasi tertentu mungkin terlewat karena anak tidak kooperatif, misalnya menolak untuk disentuh, menangis, atau bahkan histeris. Kondisi ini secara tidak langsung dapat mengurangi akurasi data yang dikumpulkan, dan akhirnya memengaruhi kualitas asuhan keperawatan yang dirancang untuk pasien anak tersebut.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang disebutkan di atas, perawat anak perlu mengembangkan sejumlah strategi khusus yang efektif dan adaptif. Salah satu strategi penting adalah menguasai teknik komunikasi terapeutik khusus yang

disesuaikan dengan usia anak. Dalam hal ini, pendekatan atraumatic care harus benar-benar diterapkan secara konsisten. Pendekatan ini melibatkan komunikasi yang lembut, ramah, serta menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami anak. Misalnya, sebelum melakukan pemeriksaan fisik, perawat dapat menggunakan teknik bermain terapeutik, seperti menunjukkan boneka atau alat peraga yang menarik perhatian anak untuk menjelaskan langkah-langkah pemeriksaan yang akan dilakukan. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan tidak menimbulkan ketakutan pada anak, sehingga anak akan merasa lebih nyaman dan kooperatif selama proses pengkajian berlangsung.

Selain menggunakan teknik komunikasi terapeutik dengan anak, perawat juga harus terampil dalam membangun hubungan baik dengan keluarga, terutama orang tua anak. Salah satu caranya adalah dengan menunjukkan sikap empati, sabar, serta memberikan dukungan emosional yang kuat kepada orang tua. Perawat harus mampu mendengarkan kekhawatiran dan keluhan keluarga dengan penuh perhatian, serta memberikan validasi terhadap perasaan yang mereka alami. Hal ini penting untuk mengurangi tingkat stres dan kecemasan keluarga, sehingga mereka lebih terbuka dan nyaman untuk memberikan informasi secara lengkap dan akurat. Dalam situasi yang sulit, perawat juga dapat memberikan waktu tambahan atau sesi konsultasi khusus bagi keluarga untuk mendiskusikan segala aspek yang menjadi kekhawatiran mereka. Pendekatan ini tidak hanya membantu mendapatkan informasi yang lebih baik, tetapi juga memperkuat hubungan saling percaya antara keluarga dengan tim kesehatan.

Strategi lain yang dapat digunakan adalah dengan menciptakan lingkungan pengkajian yang ramah anak. Lingkungan fisik yang nyaman, misalnya ruangan dengan dekorasi menarik, warna cerah, dilengkapi mainan atau buku cerita, serta tidak terlalu formal, dapat membantu mengurangi rasa takut dan kecemasan anak selama proses pengkajian. Selain itu, jika memungkinkan, perawat perlu melibatkan orang tua atau keluarga dalam proses pengkajian langsung, sehingga anak merasa lebih aman, nyaman, dan terlindungi. Keterlibatan keluarga juga dapat memberikan rasa percaya diri bagi anak, sehingga mereka lebih mudah untuk kooperatif dan mau berpartisipasi aktif dalam proses pengkajian.

Tidak kalah penting adalah peningkatan kompetensi perawat melalui pendidikan dan pelatihan secara kontinu, terutama dalam hal komunikasi terapeutik, psikologi anak, dan pendekatan atraumatic care. Dengan kompetensi yang memadai, perawat mampu mengenali secara dini berbagai hambatan komunikasi dan psikologis yang muncul, serta dapat segera mengambil langkah-langkah strategis yang tepat dalam menghadapi hambatan tersebut.

H. Studi Kasus Penerapan Pengkajian Keperawatan Anak

Dalam praktik keperawatan anak, studi kasus merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk memahami secara mendalam penerapan konsep dan prinsip pengkajian dalam berbagai kondisi klinis anak. Melalui studi kasus, perawat dapat lebih jelas melihat bagaimana proses pengkajian dilakukan secara nyata dan komprehensif, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penentuan prioritas asuhan keperawatan. Pada bagian ini, kita akan mengulas secara rinci tiga studi kasus penting dalam konteks penerapan pengkajian keperawatan anak, yaitu anak dengan kondisi akut, anak dengan penyakit kronis, serta anak dalam situasi darurat.

1. Studi Kasus pada Anak dengan Kondisi Akut

Anak yang mengalami kondisi akut umumnya datang dengan keluhan kesehatan yang muncul secara tiba-tiba dan berkembang cepat. Contohnya adalah kasus seorang anak usia 4 tahun yang dibawa orang tuanya ke fasilitas kesehatan dengan keluhan demam tinggi mendadak sejak pagi hari, disertai batuk dan sesak napas. Dalam situasi ini, pengkajian keperawatan anak diawali dengan pengumpulan data secara cepat namun lengkap tentang riwayat kesehatan, gejala yang dirasakan, durasi keluhan, serta tindakan awal yang sudah dilakukan di rumah.

Dalam pengkajian riwayat kesehatan, perawat akan mengumpulkan informasi terkait riwayat imunisasi anak, riwayat alergi, riwayat penyakit sebelumnya, serta riwayat kesehatan keluarga terutama penyakit menular yang relevan seperti infeksi saluran pernapasan. Selanjutnya, perawat akan melakukan pemeriksaan fisik secara sistematis, termasuk pengukuran tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, frekuensi napas, denyut jantung, dan saturasi oksigen. Observasi kondisi umum anak seperti kesadaran, respons terhadap lingkungan, warna kulit, serta ada tidaknya tanda-tanda distress pernapasan juga sangat penting dilakukan. Perawat juga perlu melakukan pemeriksaan spesifik terhadap sistem pernapasan, seperti mengamati pola napas, retraksi dada, penggunaan otot bantu pernapasan, serta adanya suara abnormal pada paru-paru seperti wheezing atau ronki.

Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, perawat akan menentukan prioritas tindakan yang harus segera dilakukan, misalnya pemberian oksigen jika ditemukan saturasi oksigen yang rendah, pemberian antipiretik untuk mengatasi demam tinggi, serta memastikan cairan tubuh anak cukup melalui rehidrasi oral atau infus jika dibutuhkan. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan kelengkapan pengkajian dalam kondisi akut, agar tindakan

keperawatan yang diberikan dapat segera meredakan gejala, mencegah komplikasi, serta mendukung pemulihan kondisi anak.

2. Studi Kasus pada Anak dengan Penyakit Kronis

Berbeda dengan kondisi akut, anak dengan penyakit kronis memerlukan pengkajian keperawatan yang lebih terencana, detail, dan berorientasi jangka panjang. Sebagai contoh, seorang anak usia 10 tahun dengan diagnosis diabetes mellitus tipe 1, yang datang untuk kontrol rutin ke fasilitas kesehatan. Pada kasus ini, pengkajian keperawatan berfokus pada evaluasi kondisi kesehatan secara menyeluruh, termasuk aspek fisik, psikologis, sosial, dan edukasi yang telah diterima oleh keluarga.

Pengkajian fisik dimulai dengan evaluasi antropometri seperti tinggi badan, berat badan, serta Indeks Massa Tubuh (IMT) untuk memonitor pertumbuhan anak. Pengukuran tanda-tanda vital tetap penting, namun perawat juga perlu melakukan pengukuran gula darah, hemoglobin glikosilasi (HbA1c), dan pemeriksaan fisik menyeluruh untuk mengidentifikasi komplikasi jangka panjang seperti gangguan kulit, masalah vaskular, atau neuropati.

Selain pengkajian fisik, perawat perlu mengkaji aspek psikososial dan emosional anak serta keluarga. Perawat perlu mengevaluasi tingkat pemahaman anak dan orang tua mengenai penyakit diabetes, kepatuhan dalam menjalankan pengobatan seperti pemberian insulin, diet yang sesuai, aktivitas fisik yang dianjurkan, serta kemampuan anak dalam mengelola kondisi penyakitnya secara mandiri. Dalam studi kasus ini, komunikasi terapeutik yang efektif sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan saling percaya, sehingga perawat bisa memperoleh informasi yang akurat dan mendalam dari keluarga.

Hasil dari pengkajian yang komprehensif ini akan membantu perawat dalam merancang intervensi keperawatan jangka panjang yang berorientasi pada pengelolaan mandiri, edukasi yang berkelanjutan kepada keluarga dan anak, serta meminimalkan risiko komplikasi. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pengkajian keperawatan pada kondisi kronis tidak hanya berfokus pada masalah fisik semata, melainkan juga aspek psikososial, edukasi, dan pemberdayaan keluarga secara keseluruhan.

3. Studi Kasus pada Anak dalam Situasi Darurat

Pengkajian keperawatan anak dalam situasi darurat merupakan tantangan tersendiri yang membutuhkan keterampilan khusus serta kemampuan berpikir cepat dan tepat. Misalnya, seorang anak usia 2 tahun dibawa ke unit gawat darurat dengan keluhan kejang mendadak. Dalam situasi ini, perawat harus segera melakukan pengkajian yang cepat namun cermat untuk menentukan kondisi kegawatdaruratan dan tindakan segera yang harus diambil.

Pengkajian awal pada situasi darurat selalu dimulai dengan prinsip ABC (Airway, Breathing, Circulation). Perawat segera mengamankan jalan napas, mengecek pola dan frekuensi napas anak, memastikan tidak terjadi aspirasi atau hambatan napas selama kejang berlangsung, serta menilai sirkulasi darah melalui pemeriksaan denyut nadi dan warna kulit anak. Setelah stabilisasi awal dilakukan, pengkajian dilanjutkan dengan pengumpulan riwayat singkat dari keluarga mengenai durasi kejang, aktivitas yang dilakukan sebelum kejang, riwayat kejang sebelumnya, serta penggunaan obat-obatan tertentu atau penyakit penyerta.

Pemeriksaan fisik secara singkat tapi lengkap dilakukan untuk mencari kemungkinan penyebab kejang, seperti demam tinggi, infeksi akut, atau trauma kepala. Pada saat yang sama, perawat juga mengobservasi perilaku anak setelah kejang berakhir, termasuk respons neurologis, tingkat kesadaran, serta adanya gangguan fungsi neurologis yang menetap atau tidak. Hasil pengkajian darurat ini penting untuk segera dilaporkan ke tim medis, agar tindakan lebih lanjut seperti pemberian antikonvulsan atau pemeriksaan diagnostik tambahan bisa segera dilakukan.

Studi kasus ini menggambarkan pentingnya pengkajian yang terstruktur, cepat, dan tepat dalam situasi darurat untuk menyelamatkan nyawa anak, mencegah kerusakan lebih lanjut, serta menentukan intervensi medis dan keperawatan yang segera diperlukan.

I. Simpulan

Pengkajian keperawatan anak merupakan tahapan penting yang menjadi dasar dalam pemberian asuhan keperawatan yang holistik dan berorientasi pada kebutuhan anak. Proses ini mencakup berbagai komponen yang harus diperhatikan secara seksama, mulai dari pengumpulan data riwayat kesehatan anak dan keluarga, penilaian pertumbuhan fisik melalui pengukuran antropometri dan tanda-tanda vital, hingga evaluasi terhadap aspek perkembangan kognitif, psikososial, dan emosional anak. Di samping itu, lingkungan sosial dan budaya anak juga menjadi perhatian penting dalam proses pengkajian karena berpengaruh signifikan terhadap kondisi kesehatan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, pengkajian keperawatan anak memerlukan teknik dan pendekatan khusus yang bersifat atraumatic, yang bertujuan untuk meminimalkan trauma fisik maupun psikologis yang mungkin dialami anak selama proses pengkajian. Pendekatan ini mencakup persiapan lingkungan yang nyaman, komunikasi terapeutik yang efektif sesuai tingkat perkembangan anak, serta penggunaan alat ukur dan instrumen pengkajian yang tepat seperti skala tumbuh kembang, instrumen penilaian nyeri, dan alat ukur status gizi anak.

Selanjutnya, pengkajian keperawatan anak juga harus disesuaikan dengan kelompok usia anak, mengingat setiap kelompok usia memiliki karakteristik unik dan kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Mulai dari pengkajian pada neonatus yang berfokus pada adaptasi kehidupan ektrauterin, bayi yang mengalami pertumbuhan pesat, balita dan anak prasekolah yang membutuhkan perhatian khusus pada perkembangan motorik dan psikososial, hingga anak usia sekolah dan remaja yang menghadapi tantangan sosial, akademik, dan psikologis yang lebih kompleks.

Proses dokumentasi hasil pengkajian merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pengkajian keperawatan anak. Dokumentasi yang akurat, lengkap, obyektif, serta kronologis penting dalam memastikan kesinambungan perawatan, meningkatkan komunikasi antar tenaga kesehatan, serta memberikan perlindungan hukum dan bukti kualitas pelayanan keperawatan. Penggunaan sistem dokumentasi berbasis elektronik (Electronic Health Records/EHR) menjadi sebuah kemajuan yang mempermudah perawat dalam menyimpan dan mengakses data secara real-time, meningkatkan efisiensi dan kualitas dokumentasi.

Namun demikian, proses pengkajian keperawatan anak juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, seperti hambatan komunikasi dengan anak maupun keluarga, faktor psikologis seperti kecemasan dan ketakutan, serta lingkungan pengkajian yang tidak mendukung. Untuk mengatasi hambatan ini, perawat perlu menguasai berbagai strategi efektif seperti teknik komunikasi terapeutik yang empatik, penciptaan lingkungan pengkajian yang ramah anak, serta peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

Melalui ilustrasi penerapan pengkajian dalam berbagai studi kasus, mulai dari kondisi akut, penyakit kronis, hingga situasi darurat, tampak jelas bahwa pengkajian yang komprehensif, adaptif, dan spesifik kondisi anak sangat penting untuk menentukan diagnosis keperawatan dan intervensi yang tepat. Pengkajian yang baik akan membantu perawat anak dalam mengambil keputusan klinis secara efektif, meningkatkan hasil perawatan, serta memberikan pengalaman positif bagi anak dan keluarganya.

Dengan demikian, proses pengkajian keperawatan anak merupakan fondasi penting dalam praktik keperawatan anak yang profesional, humanis, dan berbasis bukti. Melalui pengkajian yang dilakukan dengan benar, perawat anak mampu memberikan asuhan yang optimal, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal, serta meningkatkan kesejahteraan anak sepanjang tahapan kehidupan mereka.

J. Referensi

American Academy of Pediatrics. (2021). Pediatric assessment and management

guidelines. *Pediatrics*, 147(3), e20210513.
<https://doi.org/10.1542/peds.2021-0513>

- Ball, J. W., Bindler, R. C., Cowen, K. J., & Shaw, M. R. (2021). *Principles of Pediatric Nursing: Caring for Children* (8th ed.). Pearson Education.
- Burns, C. E., Dunn, A. M., Brady, M. A., Starr, N. B., & Blosser, C. G. (2020). *Pediatric Primary Care* (7th ed.). Elsevier.
- Frankenburg, W. K., & Dodds, J. B. (1992). Denver II developmental screening test. *Pediatrics*, 89(1), 91–97. <https://doi.org/10.1542/peds.89.1.91>
- Hockenberry, M. J., Wilson, D., & Rodgers, C. C. (2021). *Wong's Essentials of Pediatric Nursing* (11th ed.). Elsevier.
- Indonesian Pediatric Society. (2020). *Panduan Penilaian Nyeri pada Anak*. Jakarta: IDAI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Teknis Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kyle, T., & Carman, S. (2021). *Essentials of Pediatric Nursing* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S., Nelson, K. A., & Ashwill, J. W. (2022). *Maternal-Child Nursing* (6th ed.). Elsevier.
- Merkel, S. I., Voepel-Lewis, T., Shayevitz, J. R., & Malviya, S. (1997). The FLACC: A behavioral scale for scoring postoperative pain in young children. *Pediatric Nursing*, 23(3), 293–297.
- Perry, S. E., Lowdermilk, D. L., Cashion, M. C., Alden, K. R., & Olshansky, E. F. (2022). *Maternal Child Nursing Care* (7th ed.). Elsevier.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2020). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Squires, J., & Bricker, D. (2009). *Ages & Stages Questionnaires (ASQ): A Parent-Completed Child Monitoring System* (3rd ed.). Paul H. Brookes Publishing Co.
- Wong, D. L., & Baker, C. M. (1988). Pain in children: Comparison of assessment scales. *Pediatric Nursing*, 14(1), 9–17.
- World Health Organization. (2019). *WHO Child Growth Standards: Methods and Development*. Geneva: WHO Press.

K. Glosarium

Antropometri

Pengukuran sistematis tubuh manusia seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas, yang digunakan untuk menilai pertumbuhan dan status gizi anak.

Atraumatic Care

Pendekatan perawatan yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, trauma emosional, dan ketidaknyamanan yang dialami anak selama proses pengkajian atau tindakan medis.

Auskultasi

Teknik pemeriksaan fisik menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara internal tubuh seperti suara paru-paru, jantung, atau usus.

Denver Developmental Screening Test (DDST)

Alat skrining untuk mengevaluasi perkembangan anak, terutama pada aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan sosial-personal, untuk mendeteksi keterlambatan atau gangguan perkembangan.

Diagnosis Keperawatan

Penilaian klinis tentang respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan aktual atau potensial yang menjadi dasar untuk intervensi keperawatan.

Distraksi

Teknik pengalihan perhatian anak selama prosedur medis untuk mengurangi rasa takut, kecemasan, atau nyeri yang dialami.

Dokumentasi Keperawatan

Proses pencatatan data hasil pengkajian, tindakan, respons pasien, serta rencana keperawatan secara sistematis dan kronologis untuk menjaga kesinambungan asuhan keperawatan.

Electronic Health Records (EHR)

Sistem pencatatan data klinis pasien secara elektronik yang memudahkan akses, penyimpanan, dan komunikasi informasi pasien di antara tenaga kesehatan.

Family-Centered Care

Pendekatan perawatan yang melibatkan keluarga secara aktif dalam proses pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan asuhan keperawatan pada anak.

Glukosa darah dan HbA1c

Pemeriksaan laboratorium untuk menilai kadar gula darah saat ini (glukosa darah) serta kadar rata-rata gula darah dalam tiga bulan terakhir (HbA1c) terutama pada pasien diabetes.

Inspeksi

Teknik pemeriksaan fisik dengan melihat kondisi fisik anak secara cermat untuk mengidentifikasi tanda-tanda abnormal seperti ruam, warna kulit, atau kelainan fisik lainnya.

Kartu Menuju Sehat (KMS)

Alat pemantauan pertumbuhan fisik anak yang digunakan di Indonesia, mencatat perkembangan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak.

Malnutrisi

Kondisi akibat kekurangan atau kelebihan gizi yang menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti stunting, wasting, atau obesitas.

Observasi

Metode pengkajian dengan mengamati secara langsung perilaku, interaksi, dan kondisi fisik pasien tanpa melakukan intervensi.

Palpasi

Teknik pemeriksaan fisik dengan meraba bagian tubuh pasien secara lembut untuk mengetahui tekstur, ukuran, lokasi nyeri, atau adanya kelainan.

Perkusi

Teknik pemeriksaan fisik dengan mengetuk bagian tubuh tertentu untuk menilai struktur internal seperti keberadaan cairan atau udara.

Prinsip Holistik

Pendekatan pengkajian yang memperhatikan anak secara keseluruhan, termasuk aspek fisik, emosional, psikososial, spiritual, dan budaya.

Prinsip Perkembangan

Pendekatan pengkajian keperawatan yang mempertimbangkan tahap tumbuh kembang anak, sehingga teknik dan metode pengkajian disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak.

Recall 24 Jam

Metode pengkajian status gizi dengan meminta informasi detail tentang konsumsi makanan dan minuman yang dikonsumsi anak dalam kurun waktu 24 jam sebelumnya.

Skala FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability)

Instrumen untuk menilai intensitas nyeri pada anak kecil melalui observasi terhadap ekspresi wajah, gerakan kaki, aktivitas tubuh, tangisan, serta kemampuan anak untuk ditenangkan.

Status Gizi

Kondisi kesehatan anak yang ditentukan berdasarkan asupan nutrisi, pertumbuhan fisik, dan tanda-tanda klinis lainnya.

Stunting

Gangguan pertumbuhan linier pada anak akibat kekurangan nutrisi kronis, ditandai dengan tinggi badan yang jauh di bawah standar usianya.

Tanda Vital

Ukuran dasar fungsi tubuh yang mencakup suhu tubuh, denyut jantung (nadi), tekanan darah, frekuensi pernapasan, dan saturasi oksigen.

Teknik Komunikasi Terapeutik

Cara berkomunikasi efektif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menciptakan hubungan terapeutik, membantu pasien merasa nyaman, aman, dan terbuka dalam proses pengkajian dan perawatan.

Wong-Baker Faces Pain Rating Scale

Skala penilaian nyeri yang menggunakan gambar ekspresi wajah untuk membantu anak-anak mengomunikasikan tingkat nyeri yang dirasakan.

CHAPTER 3

KEPERAWATAN ANAK DENGAN GANGGUAN RESPIRASI

Wa Nuliana, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Gangguan respirasi pada anak merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang paling sering dijumpai dalam praktik klinis keperawatan anak. Gangguan ini mencakup berbagai kondisi yang menyebabkan terganggunya proses pernapasan normal, mulai dari infeksi akut pada saluran pernapasan seperti batuk, pilek, bronkitis, pneumonia, hingga gangguan kronis seperti asma bronkial dan kondisi gawat darurat yang mengancam jiwa seperti obstruksi jalan napas akibat benda asing. Gangguan respirasi pada anak memiliki ruang lingkup yang luas dan dapat terjadi pada berbagai kelompok usia, mulai dari neonatus hingga remaja. Gangguan tersebut tidak hanya memengaruhi sistem pernapasan, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup anak secara keseluruhan, karena dapat menyebabkan gangguan tidur, penurunan aktivitas harian, gangguan tumbuh kembang, dan bahkan kematian jika tidak ditangani secara tepat dan segera.

Secara epidemiologi, prevalensi gangguan respirasi pada anak di Indonesia terbilang cukup tinggi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak-anak di bawah lima tahun, dengan pneumonia sebagai salah satu penyebab kematian terbesar pada balita setelah diare. Tingginya angka kejadian gangguan respirasi ini terkait erat dengan berbagai faktor risiko seperti tingkat pencemaran udara yang tinggi, kurangnya edukasi kesehatan pada keluarga tentang pentingnya menjaga kesehatan pernapasan, minimnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta tingginya angka perokok pasif pada anak akibat lingkungan keluarga yang merokok. Kondisi ini membuat gangguan respirasi pada anak bukan hanya masalah medis semata, namun juga menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Dampak gangguan respirasi pada anak tidak terbatas pada aspek kesehatan fisik saja, tetapi juga dapat memberikan dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi anak maupun keluarganya. Anak dengan gangguan respirasi sering mengalami gangguan aktivitas sehari-hari, terganggunya proses belajar di sekolah akibat sering absen karena sakit, serta mengalami isolasi sosial akibat pembatasan

aktivitas fisik yang disarankan oleh tenaga kesehatan. Dampak tersebut tentu saja menurunkan kualitas hidup anak secara keseluruhan. Selain itu, keluarga dari anak yang mengalami gangguan respirasi kronis seperti asma juga mengalami stres dan kecemasan yang tinggi, karena mereka harus beradaptasi dengan kondisi kesehatan anak yang tidak menentu serta membutuhkan perhatian dan perawatan khusus yang terus menerus.

Dalam konteks tersebut, peran perawat dalam manajemen gangguan respirasi pada anak menjadi sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang berada pada garis depan dalam pemberian pelayanan keperawatan memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pengkajian yang akurat terhadap kondisi pernapasan anak, menentukan diagnosis keperawatan yang tepat, serta melakukan intervensi keperawatan yang komprehensif dan efektif. Peran perawat meliputi berbagai aspek, mulai dari identifikasi dini tanda-tanda gangguan respirasi, pemberian terapi oksigen dan nebulisasi, manajemen jalan napas dengan teknik seperti suction dan fisioterapi dada, hingga edukasi kepada keluarga mengenai cara mengelola gangguan respirasi di rumah. Selain itu, perawat juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan psikologis dan emosional bagi anak serta keluarga yang menghadapi gangguan respirasi, membantu mereka untuk mengatasi rasa cemas, ketakutan, dan stres yang muncul akibat kondisi tersebut.

Lebih lanjut, perawat juga memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan edukasi dan promosi kesehatan pernapasan anak kepada keluarga dan masyarakat luas. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah munculnya gangguan respirasi serta mengurangi dampak dari kondisi tersebut jika sudah terjadi. Melalui edukasi yang diberikan oleh perawat, keluarga dan masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pentingnya imunisasi tepat waktu seperti vaksinasi influenza dan pneumokokus, serta mengenali tanda-tanda awal gangguan respirasi agar dapat segera mendapatkan pertolongan medis jika dibutuhkan. Dalam hal ini, perawat berperan sebagai pemberi informasi sekaligus pendamping bagi keluarga, membantu mereka memahami kondisi kesehatan anak secara utuh serta mengelola kondisi tersebut secara mandiri di rumah.

B. Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernapasan pada Anak

Pemahaman mengenai anatomi dan fisiologi sistem pernapasan anak merupakan dasar penting bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang optimal kepada pasien anak dengan gangguan respirasi. Secara umum, sistem pernapasan memiliki peran utama dalam menyediakan oksigen untuk kebutuhan metabolisme tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme

tersebut. Pada anak-anak, struktur anatomi serta fungsi fisiologis sistem pernapasan memiliki ciri khusus yang berbeda dengan orang dewasa, yang menyebabkan anak menjadi lebih rentan terhadap berbagai masalah respirasi, baik dalam kondisi akut maupun kronis.

Struktur sistem pernapasan pada anak terdiri atas dua bagian utama, yaitu saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan bagian atas meliputi hidung, rongga hidung, faring, laring, hingga bagian awal trakea. Hidung pada anak secara anatomi memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dewasa dengan lubang hidung (nares) yang lebih sempit, sehingga lebih mudah tersumbat akibat produksi sekret atau inflamasi. Rongga hidung memiliki fungsi utama sebagai saluran masuk udara serta untuk menghangatkan, melembapkan, dan menyaring udara sebelum menuju paru-paru. Di belakang rongga hidung terdapat faring yang merupakan saluran udara dan makanan. Pada anak-anak, struktur faring juga lebih pendek dan lebih sempit, yang menyebabkan peningkatan risiko obstruksi ketika terjadi pembengkakan atau produksi sekret yang berlebihan.

Lebih lanjut, struktur laring anak yang terletak di bawah faring memiliki posisi anatomis yang relatif lebih tinggi dibandingkan dewasa. Epiglotis pada anak berbentuk lebih fleksibel dan cenderung lebih panjang, membuatnya lebih mudah menutupi jalan napas bila terjadi peradangan atau pembengkakan, seperti yang sering dijumpai pada kasus epiglotitis. Trakea pada anak juga memiliki karakteristik berbeda, yakni lebih pendek, dengan diameter yang jauh lebih kecil serta tulang rawan yang lebih lunak dibandingkan dewasa. Kondisi ini menyebabkan jalan napas anak menjadi lebih mudah mengalami obstruksi akibat tekanan eksternal maupun pembengkakan internal.

Saluran pernapasan bagian bawah terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Bronkus pada anak berdiameter kecil dengan lumen yang sempit, sehingga inflamasi atau penumpukan lendir dengan cepat dapat menyebabkan hambatan jalan napas yang signifikan. Bronkiolus yang merupakan cabang terkecil dari saluran napas juga relatif lebih kecil dan lebih sedikit elastisitasnya, menyebabkan anak rentan mengalami bronkiolitis, terutama pada bayi. Selain itu, alveoli yang merupakan tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida pada anak memiliki jumlah yang lebih sedikit dan belum matang secara sempurna hingga usia tertentu, biasanya sampai usia sekitar 8 tahun. Ketidakmatangan alveoli ini berpengaruh terhadap kemampuan paru-paru dalam melakukan pertukaran gas secara optimal, terutama saat anak mengalami kondisi pernapasan yang terganggu.

Fungsi normal sistem pernapasan anak pada dasarnya sama seperti dewasa, yaitu melakukan proses ventilasi (mengalirkan udara masuk dan keluar paru-paru),

difusi (pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveoli), dan perfusi (transportasi oksigen dan karbon dioksida melalui aliran darah). Ventilasi pada anak diatur oleh pusat pernapasan di otak, yang merespons perubahan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Anak memiliki frekuensi napas yang lebih tinggi dibandingkan dewasa, terutama pada bayi baru lahir yang bisa mencapai 30 hingga 60 kali per menit, dan akan berkurang secara bertahap seiring dengan pertambahan usia. Frekuensi napas yang tinggi ini merupakan kompensasi tubuh anak untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang tinggi akibat tingkat metabolisme yang cepat.

Proses difusi pada anak berlangsung di alveoli yang memiliki membran tipis, memungkinkan pertukaran gas terjadi dengan cepat. Namun, jumlah alveoli yang lebih sedikit dibandingkan dewasa dapat menyebabkan anak mudah mengalami gangguan oksigenasi apabila terjadi kondisi patologis seperti pneumonia atau edema paru. Sementara perfusi terjadi dengan adanya aliran darah melalui pembuluh darah kapiler paru-paru, mengangkut oksigen ke jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui ekspirasi.

Terdapat beberapa perbedaan signifikan antara sistem pernapasan anak dengan dewasa yang membuat anak lebih rentan terhadap gangguan respirasi. Salah satu perbedaan utama terletak pada ukuran dan diameter saluran napas yang lebih kecil pada anak, sehingga pembengkakan sedikit saja dapat mengakibatkan obstruksi jalan napas yang signifikan. Selain itu, struktur dinding dada anak memiliki tingkat elastisitas lebih tinggi, namun otot-otot interkostal (otot di antara tulang rusuk) belum sepenuhnya berkembang, membuat anak terutama bayi lebih mengandalkan pernapasan abdominal (pernapasan dengan menggunakan diafragma) dibandingkan pernapasan torakal seperti pada dewasa. Hal ini menyebabkan anak memiliki kemampuan kompensasi yang terbatas ketika terjadi gangguan respirasi.

Kemampuan kompensasi anak juga dipengaruhi oleh cadangan oksigen paru-paru yang relatif kecil dan kebutuhan oksigen yang tinggi. Akibatnya, jika anak mengalami gangguan respirasi yang menyebabkan gangguan oksigenasi, kondisi tersebut bisa dengan cepat berkembang menjadi hipoksemia (rendahnya kadar oksigen dalam darah) atau bahkan hipoksia jaringan, yang jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan kerusakan jaringan permanen atau bahkan kematian. Di samping itu, sistem imun anak yang belum sempurna turut berkontribusi terhadap peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan, terutama pada kelompok usia balita dan bayi.

Dengan memahami secara detail anatomi dan fisiologi sistem pernapasan anak serta perbedaannya dengan sistem pernapasan dewasa, perawat dapat

mengidentifikasi dengan lebih baik tanda-tanda awal gangguan respirasi, melakukan tindakan pengkajian yang tepat dan cepat, serta merencanakan intervensi keperawatan yang lebih efektif. Pemahaman ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan pada anak dengan gangguan respirasi, sehingga mampu mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup pasien anak secara optimal.

C. Etiologi dan Faktor Risiko Gangguan Respirasi pada Anak

Gangguan respirasi merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling umum terjadi pada anak-anak, mulai dari kondisi ringan seperti batuk dan pilek hingga kondisi yang lebih serius seperti pneumonia, bronkiolitis, asma, atau sindrom gangguan pernapasan akut. Untuk memberikan asuhan keperawatan yang efektif, perawat perlu memahami secara komprehensif mengenai etiologi (penyebab) dan berbagai faktor risiko yang berperan dalam timbulnya gangguan respirasi pada anak. Pemahaman ini akan membantu perawat dalam mengidentifikasi risiko secara dini, memberikan edukasi preventif kepada keluarga, serta melakukan intervensi keperawatan yang tepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Penyebab umum gangguan respirasi pada anak umumnya terbagi menjadi penyebab infeksi dan non-infeksi. Penyebab infeksi lebih dominan ditemukan pada populasi anak, terutama balita, karena sistem imun anak yang belum sepenuhnya matang sehingga sangat rentan terhadap berbagai infeksi. Virus merupakan penyebab tersering dari infeksi saluran pernapasan pada anak, antara lain Respiratory Syncytial Virus (RSV), Rhinovirus, Virus Influenza, Adenovirus, dan Virus Parainfluenza. Infeksi virus ini sering kali menyebabkan gejala saluran napas atas seperti batuk, pilek, hidung tersumbat, serta demam ringan. Namun, infeksi virus juga dapat berkembang menjadi infeksi saluran napas bawah yang lebih serius, seperti bronkiolitis dan pneumonia, terutama pada anak yang memiliki faktor risiko tertentu.

Selain virus, infeksi bakteri juga merupakan penyebab signifikan gangguan respirasi pada anak. Bakteri seperti *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, dan *Mycoplasma pneumoniae* merupakan contoh bakteri yang sering menyebabkan pneumonia atau bronkopneumonia pada anak-anak. Infeksi bakteri biasanya memiliki gambaran klinis yang lebih berat dibandingkan infeksi virus, dengan gejala demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas, dan bahkan gangguan kesadaran pada kasus yang berat. Infeksi jamur atau aspirasi benda asing juga dapat menjadi penyebab lain gangguan pernapasan anak, meskipun kasusnya relatif lebih jarang.

Selain infeksi, gangguan respirasi pada anak juga dapat disebabkan oleh kondisi non-infeksi, misalnya asma bronkial, alergi, kelainan anatomi kongenital seperti stenosis trakea atau laringomalasia, dan aspirasi benda asing. Asma merupakan penyakit kronis yang sering terjadi pada anak, di mana saluran napas mengalami inflamasi kronis yang menyebabkan penyempitan bronkus yang reversibel. Kondisi alergi seperti rinitis alergi juga bisa memperparah gejala respirasi, karena menyebabkan inflamasi dan produksi mukus yang berlebihan di saluran napas atas.

Faktor risiko yang berperan dalam timbulnya gangguan respirasi pada anak terdiri dari faktor risiko intrinsik dan ekstrinsik. Faktor risiko intrinsik adalah faktor risiko yang berasal dari kondisi dalam tubuh anak itu sendiri, termasuk usia, riwayat prematuritas, berat lahir rendah, penyakit kronis penyerta seperti penyakit jantung bawaan, gangguan neurologis seperti cerebral palsy, malnutrisi, serta gangguan sistem imun bawaan atau didapat (imunodefisiensi). Bayi dan anak balita merupakan kelompok yang paling rentan mengalami gangguan respirasi karena saluran napas mereka masih sempit dan belum matang secara fungsional. Bayi prematur dengan paru-paru yang belum matang (imaturitas paru) juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami berbagai komplikasi respirasi seperti Respiratory Distress Syndrome (RDS), bronkopulmonari displasia (BPD), maupun infeksi paru berulang.

Sebaliknya, faktor risiko ekstrinsik adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh anak, seperti pola asuh yang kurang tepat, kurangnya imunisasi, paparan asap rokok (pasif smoking), kepadatan hunian, polusi udara dalam dan luar ruangan, serta sanitasi dan higiene lingkungan yang buruk. Paparan asap rokok merupakan salah satu faktor risiko ekstrinsik paling signifikan yang menyebabkan inflamasi kronis pada saluran napas anak, meningkatkan risiko infeksi saluran napas bawah, memperberat asma, serta memperlambat perkembangan paru-paru secara optimal. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang rendah sering kali berhubungan erat dengan kepadatan hunian yang tinggi, kurangnya ventilasi rumah yang baik, serta tingginya paparan terhadap polutan dan patogen respirasi, yang semuanya ini meningkatkan risiko anak untuk mengalami gangguan respirasi.

Lingkungan juga memainkan peran krusial dalam kesehatan respirasi anak. Lingkungan rumah yang kurang sehat, seperti ventilasi rumah yang buruk, kurangnya pencahayaan alami, kelembapan tinggi yang menyebabkan pertumbuhan jamur, serta penggunaan bahan bakar kayu atau minyak tanah untuk memasak, secara signifikan meningkatkan risiko anak terkena gangguan pernapasan kronis. Kualitas udara dalam ruangan yang buruk akibat polusi rumah tangga dari asap masakan, debu, atau asap rokok juga dapat memicu inflamasi saluran napas, memperparah gejala alergi atau asma, serta meningkatkan

kerentanan anak terhadap infeksi saluran napas. Polusi udara luar ruangan seperti asap kendaraan bermotor, debu, asap industri, dan partikel-partikel halus juga terbukti secara signifikan memperburuk kesehatan respirasi anak-anak, terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan padat penduduk.

Tidak hanya itu, perubahan musim dan cuaca juga turut mempengaruhi angka kejadian gangguan respirasi pada anak. Pergantian musim yang menyebabkan peningkatan kelembapan udara atau musim penghujan sering diikuti dengan peningkatan kasus infeksi saluran napas, khususnya akibat virus seperti influenza atau RSV. Demikian juga pada musim kemarau, peningkatan partikel debu dan polutan udara yang tinggi dapat memperparah gejala pada anak yang memiliki alergi atau asma.

D. Jenis-jenis Gangguan Respirasi pada Anak

Gangguan respirasi merupakan kondisi yang sering dijumpai dalam praktik keperawatan anak, di mana sistem pernapasan anak mengalami gangguan fungsi yang menyebabkan terganggunya pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara optimal. Beragam jenis gangguan respirasi pada anak memiliki karakteristik, etiologi, serta manifestasi klinis yang khas. Pengetahuan yang mendalam tentang berbagai jenis gangguan respirasi pada anak menjadi sangat penting bagi perawat untuk mengenali gejala dini, melakukan asesmen klinis yang akurat, serta memberikan asuhan keperawatan yang tepat, komprehensif, dan berbasis bukti.

Salah satu gangguan respirasi yang paling sering terjadi pada anak adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). ISPA merupakan kondisi infeksi pada saluran pernapasan yang berlangsung akut dan dapat terjadi di bagian saluran napas atas seperti hidung, tenggorokan, dan laring, maupun di saluran napas bawah seperti bronkus dan paru-paru. Penyebab utama ISPA adalah infeksi virus, seperti Rhinovirus, Influenza, dan Respiratory Syncytial Virus (RSV). Gejala klinis ISPA bervariasi mulai dari batuk, pilek, demam ringan hingga sedang, hidung tersumbat, bersin-bersin, hingga sakit tenggorokan. Meskipun ISPA umumnya bersifat ringan dan sembuh sendiri, komplikasi seperti pneumonia atau bronkitis dapat terjadi, terutama pada anak dengan imunitas rendah atau kondisi kesehatan yang kurang optimal.

Selanjutnya, gangguan respirasi yang cukup serius pada anak adalah Pneumonia. Pneumonia merupakan inflamasi akut pada jaringan paru, terutama alveoli, yang menyebabkan alveoli terisi cairan atau nanah sehingga pertukaran gas terganggu. Pada anak, pneumonia dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri, seperti *Streptococcus pneumoniae* atau *Haemophilus influenzae*. Manifestasi klinis pneumonia biasanya ditandai dengan demam tinggi, batuk produktif (berdahak),

sesak napas, retraksi dada, sianosis, serta bunyi napas tambahan seperti ronki atau kreptasi saat pemeriksaan auskultasi. Pneumonia pada anak membutuhkan perhatian khusus karena jika terlambat ditangani dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gagal napas, efusi pleura, atau sepsis.

Gangguan respirasi kronis yang juga sering dijumpai pada anak adalah Asma Bronkial. Asma merupakan gangguan inflamasi kronis pada saluran napas yang ditandai dengan bronkokonstriksi atau penyempitan bronkus yang reversibel, hiperreaktivitas jalan napas, serta peningkatan produksi mukus. Anak yang mengalami asma umumnya akan menunjukkan gejala batuk terutama malam hari atau dini hari, sesak napas berulang, mengi (wheezing), dada terasa berat atau sesak, serta kesulitan bernapas saat aktivitas fisik. Faktor pencetus asma meliputi alergen (tungau debu, bulu hewan), infeksi virus, udara dingin, aktivitas fisik, hingga asap rokok. Penatalaksanaan asma pada anak membutuhkan edukasi dan pengelolaan jangka panjang, melibatkan pemberian obat-obatan inhalasi seperti bronkodilator dan kortikosteroid inhalasi untuk mengontrol inflamasi dan mencegah serangan akut.

Bronkiolitis adalah jenis gangguan respirasi akut lain yang khas terjadi pada anak-anak berusia di bawah dua tahun, terutama pada bayi. Bronkiolitis adalah infeksi saluran napas bawah akut yang mengenai bronkiolus, ditandai dengan inflamasi dan penyumbatan bronkiolus akibat produksi mukus yang berlebihan. Penyebab utama bronkiolitis adalah infeksi virus RSV (Respiratory Syncytial Virus). Gejala khas bronkiolitis meliputi batuk, napas cepat dan dangkal, retraksi dinding dada, mengi (wheezing), dan hipoksemia yang bisa menyebabkan sianosis pada kasus berat. Karena bronkiolitis bisa berpotensi menyebabkan gagal napas pada bayi, perawat perlu memberikan intervensi yang cepat seperti oksigenasi yang adekuat, terapi hidrasi, serta pemantauan ketat terhadap tanda-tanda perburukan klinis.

Gangguan saluran napas atas yang khas pada anak adalah Croup atau Laringotrakeobronkitis. Croup merupakan inflamasi akut pada laring, trakea, dan bronkus utama, umumnya disebabkan oleh infeksi virus Parainfluenza. Kondisi ini paling sering dialami oleh anak usia 6 bulan hingga 3 tahun. Gejala croup sangat khas berupa batuk menggonggong (barking cough), suara napas serak (stridor inspirasi), suara serak pada saat bicara atau menangis, serta distress respirasi pada kasus sedang hingga berat. Croup sering muncul secara tiba-tiba di malam hari, yang memerlukan penanganan segera untuk mengurangi inflamasi, seperti pemberian steroid inhalasi atau nebulisasi epinefrin dalam kasus berat.

Jenis gangguan respirasi lainnya yang memiliki dampak kesehatan serius adalah Tuberkulosis (TB) pada Anak. TB merupakan infeksi kronis pada paru-paru

yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Pada anak, TB sering kali tidak spesifik dan sulit didiagnosis secara cepat karena manifestasi klinis sering samar, seperti batuk kronis, demam ringan berkepanjangan, penurunan berat badan atau gagal tumbuh, hingga pembesaran kelenjar getah bening. Diagnosis TB pada anak memerlukan pemeriksaan khusus seperti tes Mantoux, radiologi dada, dan riwayat kontak erat dengan penderita TB dewasa. TB pada anak memerlukan pengobatan jangka panjang selama 6-12 bulan dengan kombinasi antibiotik khusus antituberkulosis.

Gangguan respirasi yang sangat serius yang bisa terjadi pada anak adalah Sindrom Distres Respirasi Akut (ARDS). ARDS merupakan kondisi gagal napas akut yang berat akibat kerusakan alveoli secara difus, menyebabkan edema paru nonkardiogenik, gangguan pertukaran oksigen yang berat, dan hipoksemia progresif yang tidak dapat diatasi hanya dengan pemberian oksigen sederhana. Penyebab ARDS pada anak meliputi infeksi berat seperti sepsis, pneumonia berat, aspirasi cairan lambung, trauma dada, atau kondisi syok. Anak dengan ARDS memerlukan perawatan intensif, penggunaan ventilasi mekanik, serta manajemen cairan dan nutrisi yang tepat guna mencegah komplikasi serius dan meningkatkan kelangsungan hidup.

Terakhir, gangguan respirasi yang unik namun sangat penting diwaspadai pada anak adalah Gangguan Respirasi akibat Aspirasi Benda Asing. Anak usia balita memiliki risiko tinggi mengalami aspirasi benda asing karena kecenderungan mereka untuk memasukkan berbagai benda kecil ke dalam mulut. Aspirasi benda asing dapat menyebabkan penyumbatan parsial atau total saluran napas yang mengakibatkan batuk tiba-tiba, tersedak, kesulitan bernapas, hingga sianosis. Kondisi ini merupakan situasi darurat yang membutuhkan tindakan segera untuk mengeluarkan benda asing dari saluran napas, misalnya dengan manuver Heimlich pada anak besar atau back blows dan chest thrust pada bayi. Jika tidak segera ditangani, aspirasi benda asing dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia aspirasi atau bahkan kematian.

E. Proses Pengkajian Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Respirasi

Proses pengkajian merupakan langkah awal dan krusial dalam memberikan asuhan keperawatan bagi anak dengan gangguan respirasi. Pengkajian yang komprehensif dan terstruktur sangat penting untuk memastikan bahwa diagnosis keperawatan akurat dan intervensi yang diberikan tepat sasaran. Pengkajian pada anak dengan gangguan respirasi mencakup serangkaian langkah yang melibatkan teknik wawancara, observasi kondisi klinis, pemeriksaan fisik secara detail, pengukuran tanda-tanda vital khusus sistem pernapasan, serta penggunaan alat dan

instrumen pengkajian khusus yang relevan dengan kondisi respirasi anak. Berikut adalah uraian lengkap tentang proses pengkajian tersebut dalam bentuk penjelasan yang detail.

Dalam mengawali pengkajian keperawatan pada anak dengan gangguan respirasi, teknik wawancara dan observasi kondisi pernapasan memainkan peranan penting. Wawancara dengan orang tua atau keluarga merupakan sumber informasi utama yang berharga karena orang tua biasanya mampu memberikan data historis yang detail mengenai riwayat kesehatan anak. Perawat harus menguasai teknik wawancara terapeutik yang efektif dengan menggunakan bahasa sederhana, empati, serta pendekatan yang ramah dan tidak membuat keluarga cemas. Pertanyaan yang diajukan harus mencakup riwayat gejala yang dialami, seperti durasi batuk, jenis batuk (kering atau berdahak), adanya sesak napas, demam, frekuensi napas yang cepat, atau adanya perubahan pola napas anak dibandingkan dengan keadaan biasanya. Informasi mengenai faktor pencetus atau pemicu gangguan respirasi seperti paparan alergen, infeksi virus, riwayat imunisasi, dan kondisi lingkungan rumah juga perlu dikaji secara mendalam.

Di samping wawancara, observasi klinis terhadap kondisi anak merupakan teknik penting lainnya yang harus dilakukan secara seksama oleh perawat. Observasi dilakukan dengan memperhatikan secara langsung kondisi pernapasan anak, seperti pola napas (reguler atau tidak reguler), frekuensi napas per menit, kedalaman napas, serta adanya tanda-tanda distress respirasi seperti retraksi dada (tarikan otot interkostal), penggunaan otot bantu pernapasan (otot leher, sternokleidomastoideus), adanya cuping hidung yang bergerak saat bernapas (nasal flaring), hingga munculnya sianosis terutama di area bibir, jari-jari tangan, atau kuku yang menandakan adanya gangguan oksigenasi. Observasi perilaku anak juga penting, seperti apakah anak terlihat gelisah, cemas, atau menunjukkan ekspresi ketidaknyamanan karena sulit bernapas.

Langkah penting berikutnya adalah melakukan pemeriksaan fisik secara detail yang berfokus pada sistem pernapasan anak. Pemeriksaan fisik ini diawali dengan inspeksi secara visual untuk menilai bentuk dada anak, apakah tampak simetris atau terdapat deformitas seperti barrel chest, pigeon chest (dada burung), atau funnel chest. Inspeksi juga mengamati pola pernapasan, kedalaman, dan simetri pergerakan dada. Setelah inspeksi, dilakukan palpasi untuk menilai apakah ada nyeri tekan, krepitasi subkutan, atau kelainan lain seperti massa atau pembengkakan. Selanjutnya dilakukan perkusi untuk mendeteksi adanya suara abnormal seperti redup (menandakan konsolidasi paru seperti pada pneumonia), atau hipersonor (menandakan adanya udara berlebih pada kasus pneumotoraks atau emfisema).

Tahapan selanjutnya adalah auskultasi, yang merupakan metode penting dalam pemeriksaan fisik sistem pernapasan anak. Auskultasi dilakukan dengan stetoskop untuk mendengarkan suara napas normal atau abnormal. Suara abnormal yang harus diperhatikan antara lain ronki kasar atau halus yang menunjukkan adanya sekret atau cairan di dalam saluran napas seperti pada pneumonia atau bronkitis; mengi (wheezing) yang mengindikasikan adanya obstruksi atau penyempitan saluran napas seperti pada asma atau bronkiolitis; stridor inspirasi yang khas pada croup atau obstruksi di saluran napas atas; serta suara napas melemah atau hilang yang dapat mengindikasikan adanya obstruksi berat, atelektasis, atau efusi pleura.

Pengukuran tanda-tanda vital khusus sistem pernapasan merupakan bagian penting yang tidak boleh terlewatkan dalam pengkajian keperawatan anak dengan gangguan respirasi. Frekuensi napas per menit harus dihitung dengan teliti, karena frekuensi napas meningkat (takipnea) sering kali menjadi tanda awal adanya distress respirasi atau gangguan oksigenasi pada anak. Tanda vital lain yang juga perlu dipantau adalah saturasi oksigen, suhu tubuh, denyut nadi, dan tekanan darah. Saturasi oksigen yang normal pada anak sehat biasanya berkisar antara 95% hingga 100%; jika saturasi oksigen kurang dari 92%, anak memerlukan perhatian khusus atau bahkan pemberian oksigen tambahan.

Untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan pemeriksaan fisik, perawat juga harus terampil dalam menggunakan alat dan instrumen pengkajian khusus, seperti Pulse Oximetry dan Peak Flow Meter. Pulse Oximetry merupakan instrumen yang sangat bermanfaat dalam menilai secara objektif tingkat saturasi oksigen anak secara real-time dan non-invasif. Alat ini memberikan data penting mengenai status oksigenasi anak, sehingga dapat membantu perawat dalam menentukan apakah anak membutuhkan oksigen tambahan atau intervensi lain segera.

Di sisi lain, Peak Flow Meter digunakan terutama pada anak dengan asma bronkial. Peak Flow Meter mengukur Peak Expiratory Flow Rate (PEFR), yang menunjukkan kecepatan maksimum aliran udara yang mampu dikeluarkan anak dari paru-parunya dalam satu kali embusan napas kuat. Pengukuran PEFR secara berkala membantu perawat dalam mengevaluasi tingkat keparahan obstruksi jalan napas pada anak, menentukan efektivitas terapi yang diberikan, serta mendeteksi dini adanya eksaserbasi atau perburukan asma sebelum kondisi anak menjadi berat.

Selain kedua instrumen tersebut, perawat juga mungkin perlu menggunakan alat pengukuran lain seperti spirometri (pada anak yang lebih besar atau remaja untuk mengukur fungsi paru secara keseluruhan), pengambilan sampel darah untuk analisis gas darah arteri dalam kasus gangguan respirasi berat seperti ARDS, serta

pemeriksaan radiologi dada bila diperlukan untuk mendapatkan gambaran struktur anatomi serta ada tidaknya kelainan seperti infiltrat, efusi pleura, atau pneumotoraks.

F. Diagnosis Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Respirasi

Diagnosis keperawatan merupakan tahap penting yang menghubungkan proses pengkajian dengan rencana intervensi yang akan diberikan pada anak yang mengalami gangguan respirasi. Diagnosis ini menggambarkan masalah keperawatan yang dialami oleh anak, sehingga perawat mampu menentukan langkah-langkah strategis dalam penanganannya. Pada anak dengan gangguan respirasi, ada beberapa diagnosis keperawatan utama yang sering muncul, antara lain: pola napas tidak efektif, bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, risiko aspirasi, serta ansietas (kecemasan) baik pada anak maupun orang tua. Berikut adalah penjelasan secara mendalam mengenai masing-masing diagnosis tersebut.

1. Pola Napas Tidak Efektif

Pola napas tidak efektif merupakan kondisi di mana anak mengalami kesulitan bernapas secara normal, yang ditandai dengan frekuensi napas yang abnormal (baik meningkat atau menurun), kedalaman napas yang dangkal, serta pola pernapasan yang tidak teratur atau asimetris. Kondisi ini sering muncul pada berbagai jenis gangguan respirasi, seperti pneumonia, bronkiolitis, asma, atau croup. Secara klinis, anak dapat menunjukkan tanda seperti takipnea (peningkatan frekuensi napas), retraksi interkostal, penggunaan otot bantu pernapasan, nasal flaring (cuping hidung melebar), dan bahkan sianosis perifer akibat suplai oksigen yang tidak mencukupi.

Pola napas tidak efektif sangat memengaruhi kenyamanan anak dan berpotensi menyebabkan komplikasi lebih lanjut jika tidak segera ditangani. Untuk itu, perawat harus secara hati-hati mengkaji tanda-tanda distress respirasi, memonitor frekuensi napas, saturasi oksigen, serta mengidentifikasi penyebab yang mendasarinya. Intervensi yang tepat dan cepat seperti pemberian oksigen tambahan, posisi semi-Fowler atau Fowler, serta teknik relaksasi napas harus segera diberikan untuk membantu mengembalikan pola napas yang efektif.

2. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

Diagnosis keperawatan ini mengacu pada kondisi di mana jalan napas anak tidak bersih atau tersumbat oleh sekret, lendir, atau benda asing sehingga udara tidak dapat masuk secara bebas ke dalam paru-paru. Kondisi ini dapat muncul dalam berbagai keadaan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bronkiolitis, pneumonia, atau akibat aspirasi benda asing. Secara klinis, anak akan

menunjukkan tanda seperti batuk produktif atau non-produktif yang berlebihan, suara napas ronki atau mengi yang terdengar jelas saat auskultasi, anak gelisah, atau tampak cemas akibat sulit bernapas, serta saturasi oksigen yang menurun.

Dalam menangani kondisi ini, perawat perlu melakukan tindakan untuk menjaga kebersihan jalan napas seperti melakukan fisioterapi dada, memberikan cairan yang cukup untuk membantu mengencerkan sekret, serta jika perlu menggunakan suction (pengisapan lendir) secara hati-hati dan efektif. Edukasi keluarga mengenai pentingnya mobilisasi sekret dan teknik batuk yang efektif juga merupakan intervensi yang penting dilakukan.

3. Gangguan Pertukaran Gas

Gangguan pertukaran gas terjadi ketika anak tidak mampu melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara adekuat pada tingkat alveoli paru. Gangguan ini sering dijumpai pada kondisi penyakit paru berat seperti pneumonia berat, asma akut berat, bronkiolitis berat, dan terutama pada sindrom distress respirasi akut (ARDS). Gejala klinis yang muncul biasanya berupa penurunan saturasi oksigen yang signifikan, sianosis sentral (bibir dan wajah tampak kebiruan), takipnea berat, gelisah atau agitasi, hingga penurunan kesadaran akibat hipoksia.

Perawat dalam hal ini harus melakukan intervensi penting seperti pemberian oksigen secara efektif dengan metode yang tepat sesuai kebutuhan anak (misalnya nasal kanula, masker oksigen, atau ventilasi mekanik), monitoring saturasi oksigen secara ketat, serta mengobservasi tanda-tanda klinis secara berkala. Kolaborasi intensif dengan tim medis sangat diperlukan untuk menentukan terapi lanjut yang mungkin diperlukan seperti penggunaan ventilasi mekanik jika kondisi anak memburuk.

4. Risiko Aspirasi

Risiko aspirasi merupakan diagnosis keperawatan yang muncul ketika anak memiliki potensi masuknya cairan, makanan, atau benda asing ke saluran pernapasan. Anak-anak, khususnya bayi dan balita, memiliki risiko tinggi mengalami aspirasi karena perkembangan anatomi saluran napas yang belum matang, refleks menelan yang kurang efektif, atau kemampuan koordinasi pernapasan dan menelan yang belum sempurna. Risiko ini juga meningkat pada anak yang mengalami gangguan neurologis atau gangguan kesadaran akibat sakit yang dideritanya.

Tanda-tanda klinis yang harus diwaspadai adalah batuk atau tersedak saat makan/minum, kesulitan menelan, peningkatan sekresi saliva atau lendir berlebihan, serta infeksi paru berulang seperti pneumonia aspirasi. Perawat harus sangat waspada dan melakukan tindakan pencegahan seperti memastikan posisi anak tegak saat makan, memilih tekstur makanan yang sesuai, melakukan pengawasan ketat selama pemberian makan atau minum, serta edukasi kepada orang tua mengenai risiko dan pencegahan aspirasi secara efektif.

5. Ansietas (Kecemasan) Anak dan Orang Tua

Ansietas atau kecemasan merupakan diagnosis psikososial yang umum ditemukan pada anak dan orang tua ketika menghadapi kondisi gangguan respirasi. Kecemasan pada anak biasanya timbul karena rasa takut, rasa tidak nyaman akibat kesulitan bernapas, pengalaman negatif saat perawatan sebelumnya, atau lingkungan rumah sakit yang asing baginya. Anak dapat menunjukkan perilaku seperti menangis, gelisah, rewel, sulit tidur, atau ketidakmampuan untuk kooperatif selama proses pengkajian atau perawatan.

Pada orang tua, kecemasan biasanya berhubungan dengan ketakutan terhadap kondisi anak yang sedang sakit, ketidakpastian prognosis penyakit, atau perasaan bersalah karena tidak mampu melindungi anak dari sakit. Kecemasan orang tua dapat memperburuk situasi karena komunikasi dengan tim kesehatan menjadi terganggu dan orang tua kesulitan mengikuti instruksi perawatan yang diberikan.

Perawat dalam hal ini memiliki peran penting untuk memberikan intervensi berupa dukungan emosional, memberikan penjelasan secara empatik, jelas dan menenangkan mengenai kondisi anak dan rencana perawatan yang akan dilakukan. Menjalin komunikasi yang terbuka, jujur, dan ramah dengan orang tua serta anak dapat membantu mengurangi tingkat kecemasan secara signifikan. Selain itu, perawat juga dapat menggunakan teknik distraksi atau pengalihan perhatian seperti bermain, bercerita, atau melibatkan anak dalam aktivitas

menyenangkan untuk membantu mengurangi rasa takut dan cemas selama perawatan berlangsung.

G. Intervensi Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Respirasi

Intervensi keperawatan merupakan tahapan penting yang dilakukan setelah proses pengkajian dan penentuan diagnosis keperawatan selesai dilakukan pada anak dengan gangguan respirasi. Dalam menjalankan intervensi ini, perawat dituntut untuk memiliki keterampilan klinis yang baik, pemahaman teori yang mendalam, serta pendekatan psikologis yang empatik terhadap anak dan keluarga. Beberapa intervensi utama yang sangat relevan pada kasus gangguan respirasi meliputi teknik pemberian oksigen dan nebulisasi, manajemen jalan napas yang efektif, pemberian cairan dan nutrisi yang tepat, penerapan terapi non-farmakologis, serta edukasi dan dukungan psikologis bagi anak dan keluarganya.

1. Teknik Pemberian Oksigen dan Nebulisasi

Pemberian oksigen merupakan salah satu intervensi penting yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi tubuh anak, terutama pada kondisi gangguan respirasi yang menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam darah (hipoksemia). Teknik pemberian oksigen yang tepat menjadi sangat penting dalam memastikan efektivitas terapi serta kenyamanan anak selama proses pemberian. Metode yang umum digunakan dalam pemberian oksigen pada anak adalah melalui nasal kanula, masker wajah sederhana, masker venturi, hingga ventilasi mekanik, tergantung tingkat keparahan kondisi anak. Nasal kanula umumnya digunakan pada anak dengan hipoksemia ringan hingga sedang, karena memberikan kenyamanan serta memungkinkan anak tetap aktif berkomunikasi dan makan/minum dengan mudah. Pada kondisi yang lebih berat, penggunaan masker oksigen atau bahkan ventilasi mekanik dapat dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan klinis anak serta rekomendasi dokter.

Nebulisasi adalah teknik pemberian obat dalam bentuk aerosol yang dihirup langsung oleh anak melalui saluran pernapasan. Intervensi ini sering digunakan pada kondisi asma bronkial, bronkiolitis, pneumonia, maupun croup untuk membantu mengurangi inflamasi, mengencerkan sekret, dan membuka jalan napas yang menyempit. Dalam memberikan nebulisasi, perawat harus memastikan anak berada dalam posisi yang nyaman, masker nebulizer terpasang dengan baik dan tepat menutupi area hidung serta mulut anak, serta anak diinstruksikan bernapas secara normal selama pemberian nebulisasi berlangsung. Setelah pemberian nebulisasi selesai, perawat perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya, dengan cara menilai kembali frekuensi napas, saturasi oksigen, serta mendengarkan bunyi napas anak.

2. Teknik Manajemen Jalan Napas (Suctioning, Chest Physiotherapy, dan Postural Drainage)

Manajemen jalan napas merupakan intervensi penting yang ditujukan untuk menjaga patensi saluran pernapasan anak, terutama jika ada sekret atau lendir yang menyumbat. Teknik suctioning atau pengisapan sekret secara manual menggunakan alat suction sangat diperlukan pada kondisi anak yang mengalami produksi sekret berlebih. Perawat harus melakukan prosedur ini dengan hati-hati, menggunakan tekanan suction yang tepat (sesuai pedoman yaitu sekitar 80-120 mmHg pada anak), serta membatasi waktu suction maksimal 5–10 detik untuk menghindari hipoksia atau trauma pada mukosa saluran napas anak.

Chest physiotherapy (fisioterapi dada) merupakan intervensi penting lain yang bertujuan membantu mobilisasi sekret dari saluran napas bawah ke atas, sehingga anak lebih mudah untuk mengeluarkan sekret tersebut melalui batuk. Teknik ini mencakup perkusi dada secara lembut, vibrasi dada dengan tangan, serta mendorong anak untuk batuk efektif setelah tindakan selesai. Postural drainage atau drainase posisi adalah bagian dari fisioterapi dada, di mana anak ditempatkan dalam berbagai posisi tertentu sesuai area paru yang ingin dikeringkan, dengan bantuan gravitasi untuk membantu pengeluaran sekret secara efektif. Perawat harus memahami posisi-posisi spesifik yang dianjurkan, durasi yang dibutuhkan, serta terus memantau respons anak selama prosedur berlangsung untuk memastikan keamanan dan efektivitas teknik ini.

3. Pemberian Cairan dan Nutrisi yang Tepat

Intervensi keperawatan juga mencakup pengaturan cairan dan nutrisi yang adekuat. Anak dengan gangguan respirasi, terutama yang mengalami peningkatan frekuensi napas atau demam tinggi, sangat berisiko mengalami dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh yang meningkat melalui pernapasan cepat dan evaporasi. Oleh karena itu, perawat harus memastikan bahwa anak mendapatkan asupan cairan yang cukup, baik secara oral maupun intravena sesuai kondisi klinisnya. Cairan yang adekuat juga membantu dalam mengencerkan sekret di saluran napas, sehingga memudahkan anak untuk batuk efektif.

Asupan nutrisi yang tepat juga sangat penting untuk mendukung proses penyembuhan anak. Anak yang mengalami gangguan respirasi biasanya mengalami penurunan nafsu makan, yang berpotensi menyebabkan malnutrisi atau penurunan status gizi jika tidak segera diatasi. Dalam hal ini, perawat perlu berkolaborasi dengan ahli gizi dalam menentukan jenis, tekstur, serta metode pemberian makanan yang sesuai kondisi anak. Pemberian makanan dalam porsi kecil tetapi sering, pemilihan makanan yang tinggi kalori dan protein, serta

pemberian makanan dengan tekstur yang sesuai kondisi menelan anak adalah beberapa strategi penting dalam pemberian nutrisi.

4. Terapi Non-Farmakologis (Teknik Relaksasi, Pengaturan Posisi)

Intervensi non-farmakologis juga sangat efektif dalam membantu anak mengurangi gejala distress respirasi serta meningkatkan kenyamanan selama perawatan berlangsung. Teknik relaksasi pernapasan, seperti latihan napas dalam, bernapas secara perlahan, dan teknik pengalihan perhatian, sangat berguna dalam mengurangi kecemasan, meningkatkan ekspansi paru, serta memperbaiki pola napas anak. Teknik ini juga membantu dalam mengurangi penggunaan otot bantu pernapasan yang berlebihan, sehingga anak tidak cepat lelah.

Pengaturan posisi tubuh anak merupakan intervensi penting lain yang bertujuan untuk meningkatkan ekspansi paru dan mengurangi kerja pernapasan. Posisi semi-Fowler atau Fowler (posisi kepala dan dada lebih tinggi sekitar 30–45 derajat) sering dianjurkan karena memungkinkan ekspansi paru yang optimal serta membantu mencegah aspirasi. Selain itu, posisi ini juga meningkatkan kenyamanan anak selama bernapas.

5. Edukasi dan Dukungan Psikologis bagi Anak dan Keluarga

Intervensi edukasi dan dukungan psikologis merupakan bagian integral yang tidak boleh diabaikan dalam perawatan anak dengan gangguan respirasi. Keluarga dan orang tua harus mendapatkan edukasi yang jelas mengenai kondisi anak, cara penggunaan alat-alat bantu pernapasan, teknik batuk efektif, tanda-tanda kegawatan yang harus segera dilaporkan, serta cara pencegahan infeksi pernapasan di rumah. Edukasi yang baik membantu keluarga lebih mandiri dalam merawat anak, meningkatkan kepatuhan terhadap terapi yang diberikan, serta membantu mencegah komplikasi lebih lanjut.

Dukungan psikologis diberikan dengan menciptakan hubungan terapeutik yang kuat antara perawat, anak, dan keluarga. Perawat harus selalu menunjukkan sikap empati, sabar, dan mendengarkan keluhan serta kekhawatiran keluarga dengan baik. Pendekatan ini sangat membantu dalam mengurangi tingkat kecemasan keluarga maupun anak, sehingga mereka merasa lebih nyaman selama proses perawatan. Menyediakan informasi secara jujur, transparan, serta memberikan ruang bagi keluarga untuk bertanya atau berdiskusi merupakan bagian penting dari dukungan psikologis ini.

H. Kolaborasi Interprofesional dalam Penanganan Gangguan Respirasi pada Anak

Penanganan gangguan respirasi pada anak merupakan proses kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisiplin atau kolaborasi interprofesional dari berbagai tenaga kesehatan untuk mencapai hasil yang optimal. Kolaborasi

interprofesional merujuk pada kerja sama antar berbagai profesional yang memiliki latar belakang keilmuan berbeda namun bekerja bersama secara sinergis dalam rangka memberikan perawatan komprehensif bagi anak yang mengalami gangguan respirasi. Tim interprofesional dalam konteks gangguan respirasi pada anak biasanya terdiri dari dokter spesialis anak (pediatri), perawat anak, ahli gizi, fisioterapis, apoteker, ahli terapi pernapasan (respiratory therapist), psikolog, serta pekerja sosial atau konselor kesehatan. Setiap anggota tim membawa keahlian khusus yang sangat penting untuk mendukung proses penyembuhan, rehabilitasi, serta peningkatan kualitas hidup anak selama masa perawatan dan setelah pulang dari fasilitas kesehatan.

Dokter spesialis anak merupakan salah satu komponen utama dalam tim interprofesional yang berperan sebagai penanggung jawab medis utama. Dokter spesialis anak bertugas melakukan evaluasi klinis secara mendalam, menentukan diagnosis medis yang tepat, merencanakan terapi farmakologis maupun intervensi medis yang diperlukan, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi kesehatan anak secara berkala. Kolaborasi yang erat antara dokter spesialis anak dengan perawat sangat penting dalam memberikan keputusan klinis secara cepat, tepat, dan efektif, khususnya pada situasi darurat seperti serangan asma akut, pneumonia berat, atau kondisi distress respirasi yang membutuhkan tindakan segera seperti pemberian oksigen, terapi nebulisasi, atau bahkan ventilasi mekanik.

Ahli gizi juga memegang peran penting dalam kolaborasi interprofesional ini, mengingat status nutrisi anak sangat mempengaruhi proses penyembuhan dan pemulihan dari gangguan respirasi. Anak yang mengalami gangguan respirasi umumnya memiliki risiko tinggi mengalami malnutrisi akibat peningkatan kebutuhan energi, penurunan nafsu makan, serta kesulitan dalam makan atau minum karena sesak napas atau batuk. Ahli gizi bertugas mengevaluasi status gizi anak secara menyeluruh, menentukan jenis diet yang sesuai dengan kebutuhan kalori, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan anak, serta memberikan rekomendasi cara pemberian nutrisi yang paling tepat. Dengan kolaborasi yang baik antara ahli gizi dan perawat, anak dapat menerima nutrisi yang optimal untuk mendukung penyembuhan, memperbaiki status imun, serta mencegah komplikasi lebih lanjut seperti infeksi tambahan atau gangguan pertumbuhan akibat malnutrisi kronis.

Fisioterapis atau terapis pernapasan juga memiliki peranan penting dalam tim interprofesional, terutama dalam mendukung mobilisasi sekret dan memperbaiki ventilasi paru-paru anak melalui berbagai teknik fisioterapi dada seperti chest physiotherapy, perkusi, vibrasi, serta postural drainage. Peran fisioterapis sangat krusial dalam memastikan sekret yang menumpuk di saluran napas anak dapat

dikeluarkan secara efektif, sehingga memperbaiki fungsi pernapasan anak secara signifikan. Fisioterapis bekerja erat bersama perawat dalam merancang dan menjalankan program fisioterapi dada, mengajari teknik napas efektif kepada anak, serta memberikan edukasi kepada keluarga terkait cara melakukan fisioterapi sederhana di rumah setelah anak dipulangkan dari fasilitas kesehatan.

Apoteker juga berkontribusi secara penting dalam memastikan bahwa terapi farmakologis yang diberikan kepada anak sesuai dengan kebutuhan klinis, aman, dan efektif. Apoteker bertugas mengawasi pemilihan jenis obat yang diberikan, dosis yang tepat sesuai usia dan berat badan anak, serta cara pemberian yang paling efektif, seperti inhalasi menggunakan nebulizer atau inhaler. Dengan kolaborasi erat bersama dokter dan perawat, apoteker dapat memantau potensi interaksi obat, efek samping yang mungkin muncul, serta memberikan edukasi kepada orang tua mengenai penggunaan obat yang benar agar terapi yang diberikan menjadi lebih efektif.

Selain tenaga kesehatan klinis, peran psikolog dan konselor kesehatan dalam tim interprofesional juga tidak boleh diabaikan. Gangguan respirasi yang dialami anak sering kali menimbulkan rasa takut, cemas, atau stres yang tinggi, baik pada anak maupun orang tua atau keluarga dekatnya. Psikolog atau konselor kesehatan dapat membantu dalam memberikan dukungan emosional, membantu mengatasi rasa cemas dan takut yang dirasakan anak serta keluarganya, serta mengembangkan strategi coping yang efektif untuk menghadapi situasi yang sulit tersebut. Kolaborasi psikolog dengan perawat menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa kebutuhan psikologis anak dan keluarga terpenuhi, sehingga mereka lebih kooperatif selama masa perawatan, lebih memahami proses perawatan yang dijalani, serta mampu melanjutkan perawatan mandiri di rumah dengan baik setelah masa perawatan di fasilitas kesehatan selesai.

Pentingnya kolaborasi interprofesional dalam penanganan gangguan respirasi pada anak juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan komplikasi yang mungkin terjadi. Komplikasi yang sering muncul pada anak dengan gangguan respirasi, misalnya pneumonia berat, insufisiensi pernapasan akut, hingga gagal napas, membutuhkan penanganan multidisiplin untuk pencegahan dan penanganannya secara efektif. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara berbagai profesional, tanda-tanda komplikasi dapat dideteksi secara dini, tindakan pencegahan dapat dilakukan secara cepat, dan intervensi yang tepat dapat diberikan segera untuk menghindari dampak serius yang lebih lanjut. Kolaborasi tim interprofesional ini juga menciptakan komunikasi yang efektif antarprofesional sehingga setiap tenaga kesehatan memiliki informasi yang sama mengenai kondisi anak, terapi yang

diberikan, serta perkembangan yang dicapai, yang pada akhirnya memperkuat kualitas dan keselamatan pelayanan keperawatan secara keseluruhan.

I. Pencegahan dan Promosi Kesehatan Pernapasan pada Anak

Pencegahan dan promosi kesehatan pernapasan pada anak merupakan serangkaian upaya sistematis yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan respirasi sekaligus meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sistem pernapasan anak sejak dini. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pencegahan primer, sekunder, hingga tersier. Setiap tingkatan memiliki tujuan dan strategi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mencapai kesehatan optimal sistem pernapasan anak secara jangka panjang.

Pencegahan primer merupakan langkah awal yang bertujuan mencegah munculnya penyakit atau gangguan pernapasan sebelum terjadi. Strategi pencegahan primer ini meliputi berbagai tindakan seperti edukasi tentang pola hidup sehat, peningkatan sanitasi lingkungan, penghindaran paparan asap rokok, serta upaya mencegah infeksi melalui vaksinasi atau imunisasi. Pada pencegahan primer, edukasi kepada keluarga dan masyarakat memiliki peran sentral. Orang tua atau keluarga harus diberikan informasi yang jelas mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, memastikan ventilasi udara di dalam rumah berjalan baik, menghindari paparan asap rokok, serta menjaga pola makan anak dengan nutrisi seimbang untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Selain itu, peran imunisasi dalam pencegahan primer sangat signifikan, mengingat sebagian besar gangguan respirasi pada anak, seperti pneumonia atau batuk rejan (pertusis), dapat dicegah melalui pemberian imunisasi tepat waktu dan lengkap. Dengan memberikan imunisasi seperti DPT, HiB, pneumokokus, influenza, dan campak secara rutin sesuai jadwal yang direkomendasikan oleh otoritas kesehatan, anak dapat terhindar dari berbagai infeksi serius yang sering menyebabkan gangguan pernapasan yang mengancam nyawa.

Pencegahan sekunder, di sisi lain, merupakan upaya yang dilakukan untuk mendeteksi gangguan pernapasan sejak dini sehingga dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi lebih berat atau menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Strategi pencegahan sekunder mencakup berbagai kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan rutin anak, pemantauan tumbuh kembang, skrining berkala terkait fungsi pernapasan, serta identifikasi dini tanda dan gejala gangguan pernapasan yang mungkin muncul. Keluarga perlu diberikan edukasi tentang tanda-tanda dini gangguan respirasi pada anak, seperti napas cepat, batuk terus-menerus, mengi (wheezing), retraksi dada, atau perubahan warna kulit seperti kebiruan pada

bibir atau ujung jari. Edukasi ini penting agar keluarga dapat segera mencari pertolongan medis jika ditemukan gejala-gejala tersebut, sehingga anak mendapat penanganan yang tepat sesegera mungkin dan mencegah perkembangan penyakit menjadi lebih berat.

Sementara itu, pencegahan tersier merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi atau kecacatan akibat gangguan respirasi yang sudah dialami anak. Pencegahan tersier lebih menekankan pada tindakan rehabilitasi dan dukungan agar anak yang mengalami gangguan respirasi kronis seperti asma, fibrosis kistik, atau komplikasi pneumonia dapat menjalani hidup dengan kualitas optimal. Pencegahan tersier mencakup edukasi keluarga dalam pengelolaan mandiri penyakit, seperti cara menggunakan inhaler atau nebulizer dengan benar pada anak dengan asma, mengenali pemicu kekambuhan penyakit, mengatur pola aktivitas fisik anak secara tepat, serta memastikan nutrisi yang optimal untuk mendukung proses pemulihan. Pencegahan tersier juga melibatkan berbagai intervensi rehabilitasi seperti fisioterapi dada, latihan pernapasan, dan konseling psikologis untuk membantu anak dan keluarga dalam mengelola kondisi kronis yang dialaminya.

Salah satu elemen penting dalam keseluruhan strategi pencegahan gangguan respirasi anak adalah edukasi keluarga dan masyarakat tentang kesehatan pernapasan anak. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta perilaku keluarga dan masyarakat dalam menjaga kesehatan pernapasan anak secara aktif. Keluarga perlu memahami pentingnya lingkungan yang bersih dan bebas dari polutan, seperti debu, asap rokok, asap kendaraan, maupun paparan zat kimia berbahaya lainnya. Edukasi juga mencakup pentingnya pola hidup sehat, termasuk menciptakan lingkungan rumah yang memiliki sirkulasi udara yang baik, penggunaan masker saat berada di tempat umum dengan kualitas udara buruk, serta menjaga kebersihan tangan secara rutin untuk mencegah penularan infeksi melalui kontak tangan. Program edukasi bisa dilakukan melalui berbagai media, mulai dari penyuluhan langsung di komunitas, media cetak dan elektronik, hingga penggunaan media sosial yang efektif menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Selain edukasi langsung kepada keluarga, promosi kesehatan pernapasan juga dapat dilakukan melalui program kesehatan di sekolah, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Program kesehatan sekolah yang mencakup pendidikan kesehatan pernapasan dapat membantu anak sejak dini memahami cara menjaga kesehatan dirinya sendiri, seperti pentingnya mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker jika sakit, serta pola hidup sehat secara keseluruhan. Dengan cara ini, edukasi tidak hanya menjangkau keluarga tetapi juga anak secara langsung,

sehingga mereka memiliki kesadaran sejak dini mengenai pentingnya menjaga kesehatan pernapasan.

Program imunisasi juga merupakan elemen krusial dalam strategi pencegahan dan promosi kesehatan pernapasan pada anak. Program imunisasi nasional di Indonesia sudah terbukti efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit pernapasan tertentu, seperti pneumonia, difteri, pertusis, dan influenza. Oleh karena itu, sangat penting bagi keluarga untuk memiliki kesadaran penuh tentang manfaat imunisasi dan mengikuti jadwal imunisasi anak secara lengkap sesuai anjuran pemerintah. Keterlibatan perawat anak dalam mengedukasi keluarga tentang pentingnya imunisasi sangat menentukan keberhasilan program ini, terutama dalam memastikan anak mendapatkan imunisasi secara rutin dan tepat waktu.

J. Tantangan, Hambatan, dan Solusi dalam Praktik Keperawatan Anak dengan Gangguan Respirasi

Dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan respirasi, perawat menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi klinis pasien, tetapi juga melibatkan hambatan dalam komunikasi dan edukasi, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta berbagai aspek yang berhubungan dengan lingkungan sosial-budaya. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam tentang hambatan-hambatan tersebut serta mampu mengembangkan strategi yang tepat agar pelayanan keperawatan kepada anak dapat diberikan secara optimal dan efektif.

Salah satu hambatan utama dalam praktik keperawatan anak dengan gangguan respirasi adalah kesulitan dalam komunikasi dan edukasi terhadap anak maupun keluarganya. Anak, terutama usia balita atau prasekolah, sering kali belum mampu mengekspresikan secara jelas keluhan atau gejala yang dirasakan. Mereka cenderung menunjukkan ketidaknyamanan atau nyeri melalui perilaku seperti menangis, gelisah, atau sulit tidur. Hal ini tentunya menyulitkan perawat dalam mengidentifikasi secara cepat dan akurat kondisi yang sedang dialami anak, sehingga dapat menghambat pengkajian yang menyeluruh dan menyebabkan keterlambatan dalam penanganan. Selain itu, komunikasi dengan orang tua atau keluarga juga sering menghadapi kendala seperti rendahnya tingkat pemahaman keluarga mengenai penyakit, stigma terhadap penyakit tertentu seperti asma atau tuberculosis, serta kecemasan berlebihan dari keluarga yang membuat informasi penting tidak tersampaikan dengan jelas kepada perawat.

Selain hambatan komunikasi secara langsung, edukasi keluarga dalam pengelolaan gangguan respirasi juga menghadapi tantangan tersendiri. Tingkat pendidikan, budaya, kepercayaan keluarga terhadap pengobatan tradisional, serta kesadaran akan pentingnya pengobatan medis sering kali menjadi faktor yang menentukan efektivitas edukasi yang diberikan oleh perawat. Misalnya, sebagian keluarga mungkin masih meyakini bahwa pengobatan tradisional atau alternatif lebih efektif dibandingkan pengobatan medis, sehingga mereka kurang patuh terhadap rekomendasi yang diberikan perawat. Hambatan ini tentunya berdampak negatif terhadap keberhasilan intervensi keperawatan, termasuk dalam hal kepatuhan keluarga terhadap penggunaan inhaler, nebulisasi, pemberian oksigen, atau kepatuhan mengikuti jadwal kontrol dan imunisasi.

Kendala lainnya yang cukup signifikan dalam praktik keperawatan anak dengan gangguan respirasi adalah keterbatasan sarana dan fasilitas di fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Banyak fasilitas kesehatan primer, seperti Puskesmas atau klinik, yang masih memiliki keterbatasan alat dan perlengkapan medis, misalnya kurangnya alat bantu pernapasan seperti nebulizer atau pulse oximeter, terbatasnya ketersediaan oksigen, serta kurangnya ruangan khusus yang memadai untuk penanganan pasien gangguan respirasi yang membutuhkan isolasi khusus. Keterbatasan ini menyebabkan perawat mengalami kesulitan dalam memberikan intervensi yang tepat, cepat, dan optimal. Akibatnya, penanganan kondisi anak dengan gangguan respirasi dapat terlambat atau kurang optimal, yang pada akhirnya meningkatkan risiko komplikasi dan memperpanjang masa rawat anak di fasilitas kesehatan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan ini, perawat perlu mengembangkan strategi dan solusi yang adaptif dan inovatif. Dalam menghadapi hambatan komunikasi dengan anak, perawat perlu menguasai teknik komunikasi terapeutik yang disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Misalnya, pada anak kecil atau balita, perawat dapat menggunakan pendekatan bermain terapeutik, menggunakan alat peraga yang menarik perhatian anak untuk menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, serta menciptakan suasana nyaman dan ramah anak di ruang perawatan. Strategi ini tidak hanya membantu perawat dalam pengumpulan data klinis yang akurat tetapi juga mengurangi ketakutan dan kecemasan anak selama proses perawatan berlangsung.

Selain pendekatan pada anak, strategi komunikasi dengan keluarga juga harus menjadi perhatian utama. Perawat perlu menerapkan pendekatan family-centered care, yaitu melibatkan keluarga secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan keperawatan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi yang bersifat empatik, menggunakan bahasa sederhana yang mudah dimengerti,

serta memberikan waktu khusus kepada keluarga untuk bertanya dan berdiskusi mengenai kondisi anak mereka. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman keluarga tentang penyakit anak, mengurangi kecemasan yang dirasakan, serta memperkuat hubungan saling percaya antara perawat dengan keluarga pasien.

Di sisi lain, dalam menghadapi keterbatasan sarana dan fasilitas, perawat dituntut untuk mengembangkan keterampilan improvisasi dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan kolaborasi interprofesional dan jejaring antar fasilitas kesehatan. Perawat dapat berkoordinasi dengan tenaga medis lain atau pihak-pihak terkait, seperti dokter spesialis anak, fisioterapis, atau tenaga ahli lain untuk mengatasi kekurangan alat atau fasilitas. Selain itu, advokasi kepada pihak manajemen atau pengambil kebijakan juga menjadi strategi penting dalam mengatasi keterbatasan fasilitas. Perawat perlu aktif menyuarakan kebutuhan alat-alat medis yang penting seperti nebulizer, pulse oximeter, atau alat bantu pernapasan lainnya, serta mengupayakan adanya program-program khusus dari pemerintah atau pihak swasta untuk meningkatkan sarana dan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Strategi edukasi berbasis komunitas juga dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi tantangan edukasi kepada keluarga dan masyarakat. Perawat dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau kader kesehatan di komunitas untuk memberikan edukasi tentang gangguan respirasi pada anak, termasuk mengenai pentingnya imunisasi, pola hidup bersih dan sehat, serta pengenalan dini tanda-tanda gangguan respirasi yang perlu segera mendapatkan penanganan medis. Dengan strategi ini, edukasi kesehatan dapat menjangkau lebih banyak keluarga secara lebih luas dan mendalam, sehingga pengetahuan masyarakat meningkat, stigma terhadap penyakit berkurang, dan keluarga menjadi lebih kooperatif serta patuh terhadap rekomendasi perawatan medis.

Dalam jangka panjang, upaya peningkatan kompetensi perawat melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan merupakan solusi penting dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi dalam pengelolaan gangguan respirasi akan mampu mengatasi berbagai hambatan dengan lebih baik dan profesional. Oleh karena itu, fasilitas kesehatan harus berkomitmen untuk menyediakan berbagai pelatihan khusus terkait penanganan gangguan respirasi pada anak, teknik komunikasi terapeutik, penggunaan alat-alat medis terbaru, serta manajemen stres atau burnout yang sering dialami oleh perawat anak di lapangan.

K. Simpulan

Gangguan respirasi pada anak merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang paling sering ditemui dalam praktik keperawatan, meliputi kondisi ringan hingga berat, akut hingga kronis, yang dapat berdampak signifikan terhadap kualitas hidup anak dan keluarganya. Faktor-faktor seperti anatomi dan fisiologi sistem pernapasan anak yang belum matang, etiologi kompleks yang melibatkan infeksi virus, bakteri, maupun kondisi non-infeksi seperti asma dan aspirasi benda asing, serta faktor risiko intrinsik maupun ekstrinsik seperti usia dini, prematuritas, paparan asap rokok, dan lingkungan yang tidak sehat turut memperbesar risiko terjadinya gangguan respirasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap anatomi, fisiologi, etiologi, serta faktor risiko ini menjadi dasar penting dalam pengkajian, diagnosis, dan intervensi keperawatan.

Dalam pengkajian keperawatan anak dengan gangguan respirasi, perawat dituntut untuk menggunakan pendekatan komprehensif melalui wawancara keluarga, observasi klinis, pemeriksaan fisik yang terstruktur, serta penggunaan instrumen seperti pulse oximetry dan peak flow meter untuk memperoleh data klinis yang akurat. Diagnosis keperawatan yang sering muncul meliputi pola napas tidak efektif, bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, risiko aspirasi, dan ansietas anak serta keluarga. Intervensi keperawatan yang efektif mencakup pemberian oksigen dan nebulisasi secara tepat, manajemen jalan napas dengan teknik suctioning dan fisioterapi dada, pemberian nutrisi dan cairan yang optimal, serta penerapan terapi non-farmakologis seperti teknik relaksasi dan pengaturan posisi. Selain itu, edukasi yang komprehensif serta dukungan psikologis bagi anak dan keluarga juga sangat penting untuk meningkatkan hasil terapi.

Kolaborasi interprofesional menjadi kunci keberhasilan dalam manajemen gangguan respirasi pada anak. Peran dokter spesialis anak, perawat, ahli gizi, fisioterapis, apoteker, dan psikolog harus disinergikan secara efektif untuk memastikan penanganan yang holistik, pencegahan komplikasi, serta pemulihan yang optimal bagi anak. Di sisi lain, strategi pencegahan dan promosi kesehatan melalui pendekatan primer, sekunder, dan tersier, serta edukasi kepada keluarga dan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan pernapasan, kebersihan lingkungan, serta program imunisasi yang teratur merupakan upaya esensial dalam mengurangi angka kejadian gangguan respirasi pada anak.

Meski demikian, praktik keperawatan anak dengan gangguan respirasi menghadapi tantangan nyata berupa hambatan komunikasi, edukasi keluarga yang kompleks, serta keterbatasan fasilitas kesehatan khususnya di wilayah terpencil. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi inovatif seperti pendekatan komunikasi

terapeutik, edukasi berbasis komunitas, advokasi untuk peningkatan fasilitas, serta pengembangan kompetensi perawat melalui pelatihan berkelanjutan agar pelayanan keperawatan anak dapat berjalan optimal. Dengan integrasi seluruh aspek ini, perawat memiliki peran vital dalam menurunkan angka kejadian, mempercepat pemulihan anak, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup anak yang mengalami gangguan respirasi secara signifikan.

L. Referensi

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Laporan Subdit ISPA Tahun 2020. Jakarta: Kemenkes RI.
- UNICEF. (2020). Pneumonia and diarrhoea: Tackling the deadliest diseases for the world's poorest children. New York: UNICEF.
- World Health Organization (WHO). (2015). Global data on pneumonia. Geneva: WHO.
- Syaifuddin. (2012). Anatomi fisiologi untuk keperawatan dan kebidanan (Edisi ke-4). Jakarta: EGC.
- Ramadhani, K., & Widyaningrum, R. (2022). Dasar-dasar anatomi dan fisiologi tubuh manusia bagi mahasiswa gizi dan kesehatan. Yogyakarta: UAD Press.
- Heryanto, F. (2016). ISPA sebagai masalah kesehatan utama balita di Indonesia. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Lingkungan*, 3(2), 74-80.
- Maryunani. (2021). Faktor usia, berat badan lahir rendah, dan lingkungan terkena asap rokok sebagai risiko ISPA pada balita. Universitas Malang.
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. H. (2010). Principles of anatomy and physiology (12th ed.). New York, NY: Wiley.

M. Glosarium

Bronkiolitis

Infeksi saluran napas bawah yang sering terjadi pada bayi, ditandai oleh inflamasi dan penyumbatan pada bronkiolus akibat produksi mukus yang berlebihan.

Retraksi dada

Gerakan abnormal berupa tarikan ke dalam pada dinding dada, biasanya menandakan adanya kesulitan bernapas atau obstruksi saluran napas.

Sianosis

Perubahan warna kebiruan pada kulit dan membran mukosa akibat rendahnya kadar oksigen dalam darah (hipoksemia).

Pulse Oximetry

Alat non-invasif yang digunakan untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah secara real-time melalui ujung jari atau telinga.

Peak Flow Meter

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecepatan maksimum aliran udara saat ekspirasi kuat, terutama digunakan pada anak dengan asma untuk memantau fungsi paru-paru.

Postural Drainage

Teknik fisioterapi dada yang menggunakan posisi tubuh tertentu untuk membantu mengeluarkan sekret dari saluran napas dengan bantuan gravitasi.

Stridor

Suara napas serak yang khas, biasanya disebabkan oleh obstruksi atau inflamasi pada saluran napas bagian atas, seperti pada kasus croup.

Nebulisasi

Metode pemberian obat melalui aerosol yang dihirup langsung, digunakan untuk mengatasi gangguan pernapasan seperti asma atau bronkiolitis.

Imunisasi

Proses pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi penyakit tertentu, penting untuk pencegahan gangguan respirasi pada anak.

Kolaborasi Interprofesional

Kerja sama tim multidisiplin yang terdiri dari berbagai tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis, apoteker, psikolog, dan profesi lainnya dalam memberikan perawatan yang holistik dan optimal kepada pasien.

CHAPTER 4

KEPERAWATAN ANAK DENGAN GANGGUAN GASRTROINTESTINAL

Ns. Dewi Tiansa Barus, S.Kep., M.K.M.

A. Pendahuluan/Prolog

Gangguan gastrointestinal pada anak merupakan salah satu kondisi medis yang paling sering dijumpai dalam praktik keperawatan pediatrik. Gangguan ini mencakup berbagai kondisi patologis yang terjadi pada sistem pencernaan anak, mulai dari gangguan ringan seperti diare akut hingga kondisi yang lebih kompleks seperti invaginasi usus atau appendisitis akut. Gangguan gastrointestinal pada anak memiliki manifestasi klinis yang bervariasi, mencakup keluhan mual, muntah, nyeri perut, diare, konstipasi, perdarahan gastrointestinal, serta gangguan penyerapan nutrisi yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Masalah gastrointestinal ini tidak hanya memberikan dampak fisik berupa gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga memberikan dampak psikologis dan emosional bagi anak serta keluarganya. Oleh karena itu, kondisi ini memerlukan perhatian khusus serta pengelolaan yang tepat guna mencegah komplikasi lebih lanjut yang dapat menurunkan kualitas hidup anak secara keseluruhan.

Di Indonesia, prevalensi gangguan gastrointestinal pada anak relatif tinggi dan merupakan salah satu penyebab utama morbiditas serta mortalitas anak-anak, terutama pada kelompok usia balita. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diare akut merupakan salah satu penyebab utama kematian pada balita setelah pneumonia. Kondisi ini diperparah oleh berbagai faktor risiko seperti sanitasi lingkungan yang buruk, rendahnya tingkat pengetahuan keluarga tentang higiene pribadi dan keamanan pangan, kurangnya akses terhadap air bersih, serta tingkat imunisasi yang masih belum optimal. Selain diare akut, kasus konstipasi kronis dan gangguan refluks gastroesofageal (GERD) juga mulai meningkat terutama pada anak usia sekolah, terkait dengan pola makan yang buruk serta kurangnya aktivitas fisik pada anak-anak yang hidup di perkotaan. Situasi ini membuat gangguan gastrointestinal bukan hanya menjadi masalah medis semata, melainkan juga menjadi masalah kesehatan masyarakat yang kompleks, yang membutuhkan intervensi menyeluruh serta melibatkan banyak pihak, termasuk tenaga kesehatan, keluarga, serta masyarakat secara umum.

Perawat memiliki peran penting dalam manajemen gangguan gastrointestinal pada anak, baik dalam aspek preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitatif. Sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis depan dalam pelayanan kesehatan anak, perawat bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian yang mendalam terhadap kondisi anak, termasuk riwayat kesehatan, pola makan, kebiasaan buang air besar, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan kondisi gastrointestinal anak. Melalui pengkajian yang akurat dan terstruktur, perawat mampu mengidentifikasi secara dini tanda-tanda gangguan gastrointestinal, sehingga intervensi segera dapat diberikan guna mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat. Di samping itu, perawat juga berperan aktif dalam memberikan intervensi keperawatan yang spesifik dan tepat sasaran, seperti manajemen hidrasi melalui pemberian cairan oral maupun intravena, pemberian nutrisi yang sesuai dengan kondisi klinis anak, serta memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pengelolaan gangguan gastrointestinal di rumah, termasuk cara mengenali tanda-tanda bahaya yang membutuhkan penanganan segera.

Lebih lanjut, peran edukatif perawat tidak hanya terbatas pada keluarga, tetapi juga kepada masyarakat luas. Perawat secara proaktif terlibat dalam berbagai upaya promosi kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keluarga dan masyarakat tentang pentingnya higiene pribadi dan lingkungan, keamanan pangan, pola makan sehat, serta pentingnya imunisasi sebagai langkah pencegahan penyakit gastrointestinal. Melalui edukasi ini, keluarga diharapkan mampu melakukan upaya pencegahan primer, seperti menjaga kebersihan lingkungan rumah, mencuci tangan secara rutin, memastikan anak mendapatkan imunisasi tepat waktu, serta menghindari konsumsi makanan atau minuman yang tidak higienis yang dapat menjadi sumber infeksi gastrointestinal. Di samping itu, edukasi yang diberikan oleh perawat juga mencakup pencegahan sekunder, yakni bagaimana mengenali secara dini tanda dan gejala gangguan gastrointestinal, sehingga keluarga dapat segera mencari bantuan medis apabila anak mengalami kondisi tersebut.

Selain peran klinis dan edukatif, perawat juga memegang peranan vital dalam memberikan dukungan emosional kepada anak dan keluarganya. Gangguan gastrointestinal, terutama yang berlangsung kronis seperti konstipasi kronis atau penyakit inflamasi usus, sering kali menimbulkan stres dan kecemasan yang tinggi pada orang tua maupun anak. Anak yang menderita kondisi ini dapat mengalami isolasi sosial akibat sering tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas sekolah atau bermain bersama teman-teman sebayanya karena kondisi kesehatan yang membatasi aktivitas harian mereka. Dalam hal ini, perawat dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi terapeutik yang baik, empati yang tinggi, serta mampu menciptakan suasana perawatan yang nyaman dan aman bagi anak serta

keluarganya. Dukungan psikologis yang diberikan perawat sangat penting dalam membantu keluarga mengatasi kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam mengelola kondisi kesehatan anak, serta memastikan mereka mampu menjalankan perawatan mandiri dengan baik setelah anak kembali ke rumah.

Dengan melihat kompleksitas serta dampak luas dari gangguan gastrointestinal pada anak, penting bagi perawat untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan yang berfokus pada keperawatan pediatrik khususnya dalam bidang gastrointestinal. Perawat juga perlu memperkuat kolaborasi interprofesional dengan berbagai tenaga kesehatan lain, seperti dokter spesialis anak, ahli gizi, farmasis, serta psikolog, guna memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan yang holistik dan komprehensif. Kolaborasi yang kuat ini tidak hanya meningkatkan efektivitas perawatan tetapi juga menjamin bahwa kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak terpenuhi secara optimal.

B. Anatomi dan Fisiologi Sistem Gastrointestinal Anak

Pemahaman tentang anatomi dan fisiologi sistem gastrointestinal pada anak merupakan hal fundamental bagi perawat anak, terutama dalam memberikan asuhan keperawatan yang optimal terhadap anak yang mengalami gangguan gastrointestinal. Sistem gastrointestinal merupakan rangkaian organ tubuh yang saling berhubungan, bertanggung jawab dalam proses pencernaan makanan, penyerapan nutrisi, dan pembuangan sisa makanan dari tubuh. Sistem ini terdiri atas saluran cerna yang dimulai dari rongga mulut hingga anus, serta organ-organ aksesori seperti hati, kantong empedu, dan pankreas.

Secara anatomis, struktur saluran gastrointestinal anak terdiri dari beberapa organ utama, yaitu rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Pada rongga mulut, proses pencernaan makanan dimulai melalui mekanisme pengunyahan dan pelepasan enzim pencernaan yang berasal dari kelenjar saliva, yang membantu melunakkan makanan dan memulai proses pemecahan zat pati. Selanjutnya, makanan yang sudah dikunyah dan bercampur dengan saliva tersebut akan masuk ke dalam esofagus melalui proses menelan. Pada anak-anak, esofagus memiliki panjang yang lebih pendek dibandingkan pada orang dewasa, dengan diameter yang relatif lebih kecil serta dinding otot yang belum sepenuhnya matang. Kondisi ini menyebabkan anak-anak lebih rentan terhadap refluks gastroesofageal (GER) karena sfingter esofagus bagian bawah masih lemah dan belum berkembang sepenuhnya.

Lambung pada anak berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan sekaligus lokasi awal pencernaan protein melalui enzim pepsin dan asam lambung. Secara anatomis, ukuran lambung anak jauh lebih kecil dibandingkan

lambung dewasa, sehingga kapasitasnya pun terbatas. Lambung anak memiliki kemampuan menampung makanan yang terbatas, menyebabkan anak, terutama bayi, perlu mendapatkan asupan makanan dalam porsi kecil namun lebih sering. Asam lambung pada anak sudah aktif sejak lahir, namun volumenya lebih sedikit dan mekanisme regulasi sekresi asam lambung pada anak masih dalam tahap maturasi, sehingga anak lebih rentan terhadap gangguan pencernaan tertentu seperti iritasi lambung akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan usianya.

Selanjutnya, makanan yang telah bercampur dengan enzim dan asam lambung akan melewati saluran pilorus menuju usus halus. Usus halus merupakan bagian terpanjang dari sistem gastrointestinal yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi utama usus halus adalah melanjutkan proses pencernaan makanan secara enzimatik sekaligus menyerap sebagian besar nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pada anak, usus halus relatif lebih panjang dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, yang mendukung proses penyerapan nutrisi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Akan tetapi, fungsi penyerapan ini dapat terganggu pada beberapa kondisi seperti infeksi usus atau intoleransi makanan tertentu yang menyebabkan gejala malabsorpsi atau diare kronis pada anak.

Usus besar terdiri dari sekum, kolon, dan rektum yang berfungsi utama untuk penyerapan air dan elektrolit dari sisa makanan serta pembentukan feses. Pada anak-anak, khususnya bayi, usus besar memiliki kapasitas terbatas untuk menyerap air secara maksimal, sehingga anak lebih rentan mengalami dehidrasi saat terjadi gangguan seperti diare akut. Selain itu, transit waktu atau kecepatan perjalanan makanan di usus besar anak juga relatif lebih cepat dibandingkan dewasa, membuat bayi dan anak-anak mudah mengalami perubahan pola defekasi yang drastis ketika terdapat gangguan gastrointestinal.

Organ aksesori dalam sistem gastrointestinal, yaitu hati, pankreas, dan kantong empedu juga memainkan peranan penting dalam proses pencernaannya. Hati berfungsi menghasilkan empedu yang penting dalam pencernaan lemak serta metabolisme nutrisi. Pada anak, hati belum sepenuhnya matang saat lahir, terutama pada bayi prematur, sehingga bayi lebih rentan terhadap gangguan metabolisme bilirubin seperti ikterus fisiologis. Sementara itu, pankreas berperan dalam menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang disalurkan ke duodenum untuk membantu proses pencernaan protein, lemak, dan karbohidrat. Aktivitas pankreas anak sudah ada sejak lahir, tetapi kapasitas produksinya belum optimal hingga anak mencapai usia tertentu. Kantong empedu, yang berfungsi sebagai tempat

penyimpanan empedu sebelum dikeluarkan ke duodenum, memiliki ukuran kecil dengan fungsi yang belum matang sepenuhnya pada awal kehidupan.

Secara fisiologis, fungsi utama saluran gastrointestinal anak meliputi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi, penyerapan nutrisi, elektrolit, dan air ke dalam aliran darah, serta pembuangan sisa makanan atau zat-zat yang tidak dapat diserap. Pencernaan mekanis pada anak dimulai di mulut melalui pengunyahan makanan, sedangkan pencernaan kimiawi dimulai melalui saliva yang mengandung enzim amilase, dilanjutkan oleh enzim-enzim dari lambung, pankreas, dan usus halus. Proses penyerapan nutrisi berlangsung secara maksimal di usus halus, dengan bantuan permukaan mukosa usus yang dilengkapi dengan vili dan mikrovili yang memperluas area penyerapan nutrisi secara signifikan.

Terdapat beberapa perbedaan signifikan antara saluran gastrointestinal anak dengan orang dewasa yang penting untuk dipahami oleh perawat anak. Perbedaan utama meliputi ukuran anatomis organ-organ gastrointestinal yang lebih kecil pada anak dibandingkan orang dewasa, kapasitas organ yang terbatas, serta proses fisiologis yang belum matang sepenuhnya. Sebagai contoh, panjang esofagus dan volume lambung anak yang terbatas menyebabkan anak rentan terhadap refluks dan muntah. Selain itu, sistem kekebalan mukosa gastrointestinal anak juga belum sempurna sehingga anak lebih rentan terhadap infeksi gastrointestinal. Fungsi hati yang belum matang pada bayi baru lahir dapat menyebabkan gangguan metabolisme bilirubin yang umum ditemukan pada neonatus.

Selain itu, perbedaan signifikan lainnya terdapat pada fungsi sfingter esofagus bagian bawah yang belum optimal sehingga menyebabkan refluks yang umum dialami bayi, serta kapasitas pankreas yang masih terbatas dalam memproduksi enzim pencernaan yang mencukupi. Sistem saraf enterik yang mengatur motilitas usus pada anak juga masih mengalami proses maturasi, sehingga pola defekasi anak sering kali belum teratur, terutama pada tahun-tahun awal kehidupan. Semua perbedaan ini menyebabkan anak-anak memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap gangguan gastrointestinal dibandingkan orang dewasa.

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai anatomi dan fisiologi sistem gastrointestinal anak, perawat dapat melakukan pengkajian klinis secara lebih tepat dan akurat, mengidentifikasi gejala gangguan secara dini, serta memberikan intervensi keperawatan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas asuhan yang diberikan pada anak yang mengalami gangguan gastrointestinal. Pemahaman ini menjadi kunci utama dalam pencegahan komplikasi serius, peningkatan kualitas hidup anak secara optimal, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal.

C. Etiologi dan Faktor Risiko Gangguan Gastrointestinal pada Anak

Gangguan gastrointestinal merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi pada anak-anak. Penyebabnya sangat kompleks dan beragam, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu penyebab infeksi dan penyebab non-infeksi. Selain itu, terdapat pula faktor risiko intrinsik dan ekstrinsik yang secara signifikan meningkatkan kemungkinan seorang anak mengalami gangguan gastrointestinal. Memahami etiologi dan berbagai faktor risiko tersebut sangat penting bagi perawat dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengelolaan yang tepat untuk menghindari komplikasi lebih lanjut.

Penyebab infeksi merupakan faktor utama yang paling sering dijumpai dalam kasus gangguan gastrointestinal pada anak. Infeksi pada saluran cerna dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan parasit. Virus menjadi penyebab paling umum dalam kasus diare akut pada anak. Contoh virus yang sering menginfeksi saluran cerna anak adalah rotavirus, norovirus, adenovirus, dan astrovirus. Rotavirus menjadi virus yang paling sering menyebabkan diare berat pada anak-anak, terutama pada usia balita, yang dapat menyebabkan dehidrasi berat hingga mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Virus ini menyerang usus halus, menyebabkan peradangan dan kerusakan sel mukosa, sehingga menimbulkan gangguan penyerapan cairan dan nutrisi.

Selain virus, bakteri juga merupakan penyebab infeksi gastrointestinal yang cukup serius. Bakteri penyebab utama gangguan gastrointestinal pada anak antara lain *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Salmonella* spp., dan *Campylobacter jejuni*. Infeksi bakteri biasanya ditandai dengan gejala klinis yang lebih berat dibandingkan infeksi virus, seperti demam tinggi, sakit perut hebat, diare berdarah, serta risiko tinggi komplikasi seperti sepsis atau infeksi sistemik. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam penatalaksanaannya, terutama penggunaan antibiotik yang tepat untuk mengatasi infeksi bakteri tersebut.

Parasit juga tidak jarang menjadi penyebab gangguan gastrointestinal pada anak, terutama di daerah yang memiliki sanitasi buruk. Parasit seperti *Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica*, dan berbagai jenis cacing usus (seperti *Ascaris lumbricoides*, cacing tambang, dan cacing kremi) sering ditemukan pada anak-anak, terutama di lingkungan yang padat penduduk dengan kebersihan yang kurang terjaga. Infeksi parasit umumnya bersifat kronis, menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi, anemia, nyeri perut, diare kronis, hingga hambatan pertumbuhan akibat malnutrisi.

Di sisi lain, gangguan gastrointestinal pada anak juga dapat disebabkan oleh faktor non-infeksi. Penyebab non-infeksi ini mencakup alergi makanan, intoleransi

makanan, serta berbagai kelainan anatomi bawaan. Alergi makanan merupakan respons imun tubuh terhadap protein tertentu yang terkandung dalam makanan, seperti susu sapi, telur, kacang-kacangan, makanan laut, atau gandum. Reaksi alergi ini dapat menyebabkan berbagai gejala gastrointestinal seperti muntah, diare, nyeri perut, bahkan perdarahan gastrointestinal akibat peradangan yang ditimbulkan oleh reaksi alergi tersebut.

Intoleransi makanan, berbeda dengan alergi makanan, adalah ketidakmampuan tubuh dalam mencerna atau menyerap zat-zat tertentu secara optimal, yang paling umum adalah intoleransi laktosa. Kondisi ini terjadi karena tubuh anak tidak memiliki cukup enzim yang dibutuhkan untuk mencerna gula laktosa dalam susu dan produk susu lainnya. Akibatnya, anak akan mengalami diare, kembung, sakit perut, dan rasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan yang mengandung laktosa.

Selain itu, kelainan anatomi bawaan juga menjadi penyebab penting gangguan gastrointestinal pada anak. Kelainan ini misalnya atresia esofagus (tidak adanya sambungan normal antara esofagus dengan lambung), stenosis pilorus (penyempitan saluran keluar lambung yang menyebabkan muntah hebat), megakolon kongenital atau penyakit Hirschsprung (kurangnya persarafan usus besar yang menyebabkan gangguan defekasi dan obstruksi usus), serta hernia diafragma kongenital (adanya defek pada diafragma yang menyebabkan organ perut masuk ke rongga dada). Kelainan anatomi ini biasanya memerlukan tindakan bedah untuk memperbaiki struktur saluran gastrointestinal agar berfungsi normal.

Berbagai faktor risiko intrinsik atau faktor dari dalam tubuh anak sendiri juga berperan besar dalam meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan gastrointestinal. Usia merupakan faktor risiko penting, di mana anak usia bayi dan balita lebih rentan mengalami gangguan gastrointestinal karena sistem pencernaan mereka yang belum sepenuhnya matang, baik dari segi anatomi maupun fisiologi. Misalnya, bayi yang baru lahir rentan mengalami refluks gastroesofageal karena otot sfingter esofagus bagian bawah yang belum matang sempurna. Selain itu, bayi prematur atau bayi dengan berat lahir rendah juga memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan gastrointestinal karena fungsi organ pencernaannya yang belum matang, sehingga mereka rentan terhadap kondisi seperti nekrotizing enterocolitis (NEC), gangguan penyerapan nutrisi, serta infeksi gastrointestinal yang berat.

Faktor risiko intrinsik lain yang tidak kalah penting adalah gangguan imunitas anak. Anak dengan gangguan imunitas baik bawaan atau didapat (imunodefisiensi) memiliki risiko tinggi untuk mengalami infeksi gastrointestinal berulang yang berat serta sulit sembuh, sehingga membutuhkan pengelolaan medis yang lebih intensif.

Anak dengan kondisi imunokompromais, seperti anak penderita HIV/AIDS atau anak yang sedang menjalani terapi imunosupresif karena penyakit tertentu, akan lebih mudah mengalami infeksi gastrointestinal yang berbahaya seperti infeksi jamur usus atau infeksi bakteri oportunistik.

Tidak hanya faktor intrinsik, tetapi faktor risiko ekstrinsik atau faktor lingkungan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kemungkinan gangguan gastrointestinal pada anak. Pola asuh yang kurang baik, seperti pemberian makanan pendamping ASI terlalu dini atau tidak higienis, merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare atau infeksi saluran cerna. Higiene pribadi dan lingkungan yang buruk, termasuk kebersihan tangan yang tidak terjaga, kebersihan alat makan yang buruk, serta pengolahan makanan yang tidak tepat, dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi gastrointestinal pada anak.

Aspek nutrisi juga menjadi faktor risiko ekstrinsik yang signifikan. Anak yang mengalami malnutrisi atau kurang gizi memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan gastrointestinal berat akibat lemahnya sistem kekebalan tubuh mereka, sehingga tubuh tidak mampu melawan infeksi dengan optimal. Demikian pula sanitasi lingkungan yang buruk, seperti kurangnya fasilitas toilet yang bersih, pencemaran sumber air minum, dan pengelolaan limbah yang tidak tepat, menjadi faktor risiko tinggi dalam penyebaran infeksi gastrointestinal.

D. Jenis-jenis Gangguan Gastrointestinal pada Anak

Gangguan gastrointestinal pada anak merupakan masalah kesehatan yang sering ditemui dalam praktik klinis, baik di lingkungan rumah sakit maupun di komunitas. Kondisi ini mencakup berbagai macam gangguan yang memengaruhi fungsi saluran pencernaan, mulai dari gangguan yang bersifat akut hingga kronis. Beberapa jenis gangguan gastrointestinal yang paling sering ditemukan pada anak-anak antara lain diare akut dan kronis, gastroenteritis, penyakit refluks gastroesofageal (GERD), konstipasi, invaginasi usus (intususepsi), appendisitis akut, malnutrisi dengan gangguan absorpsi seperti penyakit celiac, serta penyakit Hirschsprung.

Diare akut dan kronis merupakan gangguan gastrointestinal yang paling umum dijumpai pada anak. Diare akut biasanya berlangsung kurang dari 14 hari, umumnya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau parasit, dengan gejala utama berupa peningkatan frekuensi buang air besar yang disertai konsistensi feses yang encer. Penyebab tersering diare akut pada anak adalah virus rotavirus yang menimbulkan risiko dehidrasi berat akibat kehilangan cairan yang signifikan. Sebaliknya, diare kronis berlangsung lebih dari dua minggu dan dapat disebabkan

oleh berbagai faktor, seperti infeksi kronis, intoleransi makanan (misalnya intoleransi laktosa), alergi makanan, penyakit inflamasi usus seperti Crohn atau kolitis ulseratif, serta penyakit gangguan absorpsi. Diare kronis memerlukan penanganan yang lebih kompleks, mencakup identifikasi penyebab pasti dan intervensi khusus untuk memperbaiki absorpsi nutrisi serta mencegah komplikasi malnutrisi kronis.

Gastroenteritis adalah inflamasi pada lambung dan usus yang biasanya disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti virus, bakteri, atau parasit. Gastroenteritis ditandai oleh gejala klinis berupa muntah, diare, nyeri perut, dan demam. Virus seperti rotavirus dan norovirus menjadi penyebab paling umum pada gastroenteritis akut pada anak-anak. Kondisi ini menyebabkan iritasi dan peradangan mukosa usus, sehingga penyerapan cairan terganggu dan menyebabkan risiko dehidrasi akut yang signifikan, khususnya pada anak balita. Penanganan gastroenteritis terutama ditujukan untuk menjaga status hidrasi anak melalui pemberian cairan oral atau intravena, pengaturan nutrisi yang tepat, serta edukasi keluarga tentang higiene pribadi dan lingkungan.

Penyakit refluks gastroesofageal (GERD) merupakan gangguan gastrointestinal di mana terjadi aliran balik isi lambung ke dalam esofagus, yang disebabkan oleh ketidakmatangan sfingter esofagus bagian bawah pada anak, terutama bayi. GERD sering kali menyebabkan anak mengalami gejala muntah berulang setelah makan, iritabilitas, gangguan pertumbuhan, dan bahkan komplikasi seperti esofagitis atau pneumonia aspirasi akibat masuknya isi lambung ke saluran napas. GERD pada anak kecil biasanya dapat membaik seiring pertambahan usia, tetapi kasus yang berat atau persisten memerlukan pengelolaan khusus, termasuk modifikasi pola makan, pemberian obat-obatan yang menurunkan produksi asam lambung, dan pada kasus tertentu mungkin memerlukan tindakan bedah untuk memperkuat fungsi sfingter esofagus.

Konstipasi (sembelit) merupakan kondisi di mana anak mengalami kesulitan dalam proses defekasi, dengan frekuensi buang air besar yang jarang, konsistensi tinja keras, atau rasa sakit saat buang air besar. Penyebab konstipasi pada anak cukup beragam, mulai dari pola makan yang kurang serat dan cairan, kurangnya aktivitas fisik, hingga masalah psikologis seperti takut atau trauma saat buang air besar. Konstipasi juga dapat berhubungan dengan kondisi medis tertentu, misalnya hipotiroidisme, kelainan neurologis, atau penyakit Hirschsprung. Penanganan konstipasi mencakup perubahan pola makan, peningkatan asupan serat dan cairan, latihan toilet training yang tepat, serta pemberian laksatif ringan jika diperlukan.

Invaginasi usus (intusussepsi) merupakan kondisi darurat gastrointestinal yang terjadi ketika satu segmen usus masuk ke dalam segmen usus lain di bawahnya, menyebabkan obstruksi usus yang akut. Invaginasi paling sering terjadi pada bayi

dan anak kecil, dengan gejala khas berupa nyeri perut mendadak yang intens, muntah, perut kembung, serta keluarnya tinja yang bercampur darah dan lendir yang dikenal sebagai "currant jelly stool". Kondisi ini memerlukan penanganan darurat segera berupa reduksi invaginasi dengan teknik enema kontras atau intervensi bedah, karena jika terlambat ditangani dapat menyebabkan kerusakan permanen pada usus dan komplikasi yang serius seperti peritonitis atau syok septik.

Appendisitis akut adalah inflamasi akut pada apendiks yang merupakan kegawatdaruratan bedah yang sering dijumpai pada anak usia sekolah dan remaja. Gejala awal appendisitis berupa nyeri perut yang awalnya samar, kemudian menetap di area perut kanan bawah, disertai demam, mual, muntah, serta anoreksia. Appendisitis akut membutuhkan diagnosis yang tepat dan tindakan bedah sesegera mungkin untuk mencegah komplikasi serius seperti perforasi apendiks, abses intraabdominal, hingga sepsis yang mengancam nyawa anak.

Malnutrisi dan gangguan absorpsi merupakan kondisi yang sering terjadi akibat penyakit gastrointestinal kronis. Salah satu contoh yang umum adalah penyakit celiac, yaitu kelainan autoimun di mana tubuh anak tidak dapat mentolerir gluten, protein yang ditemukan dalam gandum, barley, dan rye. Paparan gluten menyebabkan peradangan kronis pada mukosa usus halus, mengakibatkan atrofi vili usus dan gangguan absorpsi nutrisi seperti protein, vitamin, zat besi, dan mineral lain. Anak dengan penyakit celiac mengalami gejala kronis berupa diare, distensi perut, penurunan berat badan, anemia, serta gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Penanganannya terutama melibatkan diet bebas gluten yang ketat serta pemantauan nutrisi secara rutin.

Penyakit Hirschsprung atau megakolon kongenital merupakan kelainan bawaan di mana segmen usus besar tidak memiliki sel saraf yang normal, menyebabkan gangguan motilitas usus besar dan kesulitan defekasi sejak lahir. Anak biasanya mengalami gejala berupa konstipasi kronis yang berat sejak usia bayi, distensi perut yang progresif, muntah berulang, dan pertumbuhan yang terhambat. Diagnosis biasanya ditegakkan dengan pemeriksaan radiologi atau biopsi rektum yang menunjukkan ketiadaan sel ganglion. Pengelolaan penyakit Hirschsprung memerlukan intervensi bedah untuk mengangkat segmen usus yang terkena dan mengembalikan fungsi normal dari saluran pencernaan.

E. Pengkajian Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Gastrointestinal

Pengkajian keperawatan merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam memberikan asuhan kepada anak yang mengalami gangguan gastrointestinal. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif kondisi klinis anak, sehingga perawat dapat menentukan diagnosis keperawatan secara tepat dan

merencanakan intervensi yang efektif serta terarah. Pengkajian keperawatan pada anak dengan gangguan gastrointestinal dilakukan secara menyeluruh melalui beberapa langkah penting, yaitu wawancara mendalam mengenai riwayat kesehatan, observasi klinis dan penilaian status hidrasi, pemeriksaan fisik khusus pada sistem gastrointestinal, pengukuran tanda-tanda vital yang relevan, serta penggunaan alat atau pemeriksaan penunjang seperti tes laboratorium dan pencitraan diagnostik.

Langkah pertama dalam proses pengkajian adalah wawancara riwayat kesehatan gastrointestinal yang dilakukan kepada orang tua atau keluarga yang merawat anak sehari-hari. Perawat perlu menggali informasi dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang empatik dan mudah dipahami oleh keluarga. Riwayat kesehatan yang penting untuk ditanyakan meliputi keluhan utama anak seperti nyeri perut, diare, muntah, sembelit, atau gejala lain yang dirasakan. Perawat juga perlu mengetahui durasi gejala, frekuensi, serta karakteristiknya seperti konsistensi tinja, adanya lendir atau darah, volume muntah, serta hubungan gejala dengan asupan makanan atau minuman tertentu. Selain itu, perlu dikaji pula riwayat alergi makanan, pola makan harian anak, status imunisasi terutama vaksinasi rotavirus, riwayat infeksi sebelumnya, penggunaan obat-obatan tertentu, serta adanya riwayat penyakit gastrointestinal serupa dalam keluarga.

Setelah wawancara riwayat kesehatan, langkah berikutnya adalah observasi klinis dan penilaian status hidrasi anak. Dalam tahap ini, perawat secara teliti mengamati kondisi umum anak untuk menentukan apakah terjadi gangguan hidrasi yang merupakan komplikasi umum dari gangguan gastrointestinal, terutama pada anak dengan diare atau muntah berulang. Perawat mengamati tanda-tanda seperti kesadaran anak, reaksi terhadap rangsangan, aktivitas dan respons anak, serta kondisi kulit dan membran mukosa seperti bibir dan rongga mulut. Tanda klinis dehidrasi yang perlu dikenali meliputi mata cekung, bibir kering, turgor kulit menurun, produksi air mata berkurang, serta penurunan produksi urin. Observasi klinis ini penting untuk segera menentukan apakah anak memerlukan rehidrasi segera untuk mencegah komplikasi serius seperti syok hipovolemik akibat dehidrasi berat.

Selanjutnya, perawat melakukan pemeriksaan fisik sistem gastrointestinal secara komprehensif dengan pendekatan terstruktur, meliputi inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Inspeksi dilakukan pertama kali untuk mengamati kontur abdomen, ada tidaknya distensi, asimetri, pergerakan abnormal, atau tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan atau pembengkakan. Perawat juga memperhatikan adanya bekas luka operasi atau kelainan kongenital yang mungkin sudah teridentifikasi sebelumnya. Auskultasi dilakukan untuk mendengar suara usus yang

bisa normal, meningkat, atau menurun, bahkan mungkin tidak terdengar pada kasus obstruksi usus. Suara usus yang meningkat dapat mengindikasikan gastroenteritis atau diare, sementara suara usus yang menurun atau hilang bisa menunjukkan ileus paralitik atau obstruksi usus yang signifikan.

Palpasi abdomen dilakukan secara hati-hati dan lembut untuk menilai adanya nyeri tekan, kekakuan otot dinding abdomen, serta kemungkinan adanya massa abnormal seperti pada invaginasi usus atau apendisitis akut. Perkusi juga digunakan untuk membantu menilai adanya udara berlebih, cairan bebas di rongga abdomen seperti asites, atau adanya massa padat. Pemeriksaan fisik yang cermat ini membantu perawat dalam menentukan tingkat keparahan kondisi anak serta membantu dalam mengidentifikasi penyebab yang mendasari gangguan gastrointestinal tersebut.

Langkah berikutnya adalah pengukuran tanda-tanda vital khusus yang relevan dengan gangguan gastrointestinal pada anak. Tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, denyut jantung, frekuensi napas, dan tekanan darah harus diperiksa secara teliti, mengingat gangguan gastrointestinal terutama yang disertai dengan infeksi atau inflamasi dapat menyebabkan perubahan signifikan pada tanda vital. Sebagai contoh, anak dengan gastroenteritis atau apendisitis akut sering mengalami peningkatan suhu tubuh (demam), peningkatan denyut jantung (takikardia) akibat demam atau nyeri, serta frekuensi napas meningkat sebagai respons tubuh terhadap rasa tidak nyaman. Pada kasus dehidrasi berat, perawat mungkin menemukan hipotensi atau penurunan tekanan darah sebagai tanda syok hipovolemik, yang merupakan kondisi gawat darurat yang membutuhkan tindakan segera.

Sebagai pelengkap dari proses pengkajian, perawat juga perlu memahami dan merekomendasikan penggunaan alat dan pemeriksaan penunjang diagnostik yang relevan. Pemeriksaan penunjang ini sangat penting untuk menegaskan diagnosis yang lebih akurat serta mengevaluasi kondisi klinis anak secara mendalam. Pemeriksaan laboratorium yang umum dilakukan antara lain pemeriksaan tinja untuk mendeteksi infeksi bakteri, virus, atau parasit; pemeriksaan elektrolit darah seperti natrium, kalium, klorida, serta urea kreatinin untuk mengevaluasi tingkat keparahan dehidrasi dan fungsi ginjal; pemeriksaan darah lengkap (CBC) untuk menilai adanya infeksi atau inflamasi; serta tes alergi makanan jika dicurigai alergi atau intoleransi makanan.

Selain tes laboratorium, pemeriksaan pencitraan seperti ultrasonografi abdomen, foto rontgen abdomen, atau CT-scan abdomen juga dapat dilakukan dalam kasus tertentu seperti kecurigaan invaginasi usus, obstruksi usus, atau apendisitis akut. Ultrasonografi abdomen menjadi alat diagnostik utama pada invaginasi usus karena dapat memperlihatkan gambaran khas invaginasi (tanda

"target sign"), sementara CT-scan atau radiografi abdomen sangat bermanfaat dalam diagnosis obstruksi usus atau komplikasi appendisitis akut seperti perforasi.

F. Diagnosis Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Gastrointestinal

Diagnosis keperawatan merupakan tahap penting dalam proses asuhan keperawatan yang berfungsi sebagai penghubung antara data hasil pengkajian dengan intervensi yang akan direncanakan. Dalam konteks anak dengan gangguan gastrointestinal, diagnosis keperawatan berperan dalam mengidentifikasi masalah aktual atau potensial yang dapat dialami anak, serta memungkinkan perawat untuk melakukan intervensi yang tepat dan efektif guna mempercepat pemulihan anak sekaligus meningkatkan kualitas hidupnya secara menyeluruh. Beberapa diagnosis keperawatan yang sangat relevan dan sering muncul pada anak dengan gangguan gastrointestinal antara lain defisit volume cairan dan elektrolit, risiko ketidakseimbangan nutrisi, nyeri abdomen akut atau kronis, risiko kerusakan integritas kulit (terutama pada daerah perianal), serta ansietas atau kecemasan yang dialami anak maupun orang tua terkait kondisi gastrointestinal yang diderita.

Diagnosis pertama yang paling sering ditemukan pada anak dengan gangguan gastrointestinal adalah defisit volume cairan dan elektrolit. Diagnosis ini terjadi ketika anak mengalami gangguan gastrointestinal yang disertai gejala seperti diare berat, muntah berulang, atau asupan cairan yang tidak mencukupi akibat kehilangan nafsu makan. Kondisi ini sangat rentan menyebabkan dehidrasi dengan penurunan cairan dan elektrolit tubuh secara signifikan. Tanda-tanda klinis yang khas meliputi kulit yang kering, elastisitas kulit (turgor) menurun, bibir dan mukosa mulut kering, penurunan produksi urin, denyut nadi meningkat (takikardia), tekanan darah menurun, serta mata tampak cekung pada kondisi yang lebih berat. Kondisi ini berisiko menjadi serius jika tidak segera ditangani karena dapat berlanjut menjadi gangguan sirkulasi, syok hipovolemik, bahkan gagal ginjal akut pada kasus ekstrem. Oleh karena itu, perawat harus memantau tanda-tanda dehidrasi dengan teliti, memberikan cairan secara adekuat, baik secara oral maupun intravena sesuai kebutuhan, serta memonitor keseimbangan cairan dan elektrolit secara ketat.

Diagnosis kedua yang perlu diperhatikan pada anak dengan gangguan gastrointestinal adalah risiko ketidakseimbangan nutrisi. Diagnosis ini muncul karena gangguan gastrointestinal seringkali menyebabkan anak sulit untuk menerima asupan makanan secara optimal akibat muntah, nyeri abdomen, intoleransi makanan, atau malabsorpsi nutrisi. Anak dengan diare kronis, gastroenteritis berkepanjangan, penyakit celiac, atau alergi makanan berisiko tinggi mengalami penurunan berat badan yang signifikan dan gangguan tumbuh kembang karena kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi dengan baik. Perawat harus

mengidentifikasi risiko tersebut dengan memantau status nutrisi anak secara rutin, mengamati perubahan berat badan, pertumbuhan tinggi badan, serta pola makan sehari-hari. Dalam hal ini, perawat juga harus bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan pemberian diet khusus, baik diet eliminasi, diet bebas gluten, atau diet tinggi kalori yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak, guna mempertahankan status nutrisi optimal.

Selanjutnya, diagnosis keperawatan lain yang sering muncul pada anak dengan gangguan gastrointestinal adalah nyeri abdomen akut atau kronis. Nyeri abdomen pada anak dapat disebabkan oleh berbagai kondisi seperti apendisitis akut, gastroenteritis, konstipasi kronis, invaginasi usus, hingga refluks gastroesofageal. Nyeri ini dapat bersifat akut, tiba-tiba muncul dengan intensitas tinggi seperti pada apendisitis akut atau invaginasi usus, atau bersifat kronis, menetap dalam waktu lama dengan intensitas ringan hingga sedang, seperti pada konstipasi kronis atau penyakit refluks gastroesofageal (GERD). Gejala nyeri abdomen ini secara nyata menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan, anak menjadi lebih rewel, tidak nyaman, menangis, sulit tidur, bahkan menolak asupan makanan atau minuman. Perawat dalam hal ini perlu mengkaji secara mendalam tentang karakteristik nyeri seperti lokasi, durasi, intensitas, faktor yang memperberat atau memperringan, serta dampaknya terhadap aktivitas anak sehari-hari. Intervensi yang diberikan dapat berupa pemberian posisi yang nyaman, pemberian analgesik sesuai indikasi medis, serta teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan yang memperberat nyeri.

Diagnosis keperawatan yang keempat adalah risiko kerusakan integritas kulit pada daerah perianal. Diagnosis ini sering muncul pada anak yang mengalami diare berat atau kronis, di mana area kulit perianal menjadi lembap secara terus-menerus akibat frekuensi buang air besar yang tinggi. Kondisi ini meningkatkan risiko munculnya iritasi kulit, ruam popok, infeksi kulit sekunder akibat jamur atau bakteri, serta luka yang lebih serius. Kondisi ini sangat tidak nyaman bagi anak, dapat menyebabkan rasa nyeri yang terus-menerus, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari dan tidur anak. Perawat harus secara proaktif mencegah kerusakan kulit dengan rutin membersihkan area perianal dengan air hangat dan sabun lembut, mengeringkan dengan lembut tanpa menggosok, mengaplikasikan krim pelindung kulit seperti zinc oxide, serta melakukan penggantian popok atau pakaian secara rutin untuk menjaga area tersebut tetap bersih dan kering. Edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya menjaga kebersihan kulit perianal juga sangat penting untuk mencegah kerusakan kulit lebih lanjut.

Diagnosis keperawatan terakhir yang sering ditemukan pada anak dengan gangguan gastrointestinal adalah ansietas atau kecemasan pada anak dan orang tua terkait gangguan gastrointestinal. Kecemasan merupakan reaksi umum yang

muncul ketika anak mengalami kondisi kesehatan yang tidak biasa atau tidak nyaman, terutama jika disertai dengan nyeri abdomen, muntah berulang, atau diare yang berkepanjangan. Anak mungkin akan merasa cemas dan takut terhadap lingkungan rumah sakit, prosedur diagnostik seperti pengambilan darah atau pemasangan infus, atau bahkan takut dengan pengalaman nyeri yang dirasakan. Di sisi lain, orang tua juga sering mengalami ansietas terkait kondisi kesehatan anak, ketidakpastian mengenai prognosis penyakit, rasa bersalah, atau ketidakmampuan mengendalikan situasi yang sedang terjadi. Perawat memiliki peran sentral dalam memberikan dukungan emosional kepada anak dan keluarga dengan memberikan informasi yang jelas, jujur, dan empatik mengenai kondisi kesehatan anak, prosedur yang akan dilakukan, serta prognosis penyakit. Intervensi tambahan seperti teknik distraksi, bermain terapeutik, serta menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak dan keluarga juga sangat penting dalam mengurangi ansietas yang dialami.

G. Intervensi Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Gastrointestinal

Intervensi keperawatan adalah bagian integral dari proses asuhan keperawatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah atau gangguan kesehatan yang dialami anak, terutama pada kasus gangguan gastrointestinal. Intervensi ini mencakup serangkaian tindakan yang sistematis dan terencana, dengan fokus pada pemberian cairan dan nutrisi yang adekuat, pengendalian nyeri, pencegahan komplikasi, edukasi keluarga, dan pemberian terapi farmakologis yang tepat sesuai indikasi. Perawat memegang peran sentral dalam pelaksanaan intervensi ini karena berada dalam posisi strategis untuk melakukan pemantauan langsung, evaluasi respons terapi, serta memberikan dukungan emosional kepada anak dan keluarganya.

Salah satu intervensi keperawatan utama yang harus dilakukan pada anak dengan gangguan gastrointestinal adalah rehidrasi oral dan intravena. Gangguan gastrointestinal seperti diare, muntah, dan gastroenteritis sering menyebabkan kehilangan cairan tubuh secara signifikan yang dapat mengarah pada kondisi dehidrasi. Dalam kondisi dehidrasi ringan hingga sedang, perawat dapat melakukan rehidrasi oral dengan memberikan larutan oralit secara bertahap, dalam jumlah kecil tetapi sering, untuk mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit yang hilang. Rehidrasi oral merupakan metode pilihan karena lebih aman, efektif, dan mudah diberikan, terutama pada anak yang masih kooperatif dan mampu menerima cairan melalui mulut. Namun, pada kondisi dehidrasi yang berat, anak dengan muntah terus-menerus atau yang menolak asupan oral, intervensi rehidrasi harus diberikan secara intravena. Cairan intravena biasanya diberikan dengan cepat untuk mengatasi syok hipovolemik, kemudian dilanjutkan secara perlahan sesuai dengan kebutuhan

tubuh anak, sambil terus memantau tanda-tanda vital dan keseimbangan cairan dengan ketat agar tidak terjadi kelebihan cairan (overhidrasi).

Selain rehidrasi, manajemen nutrisi juga menjadi intervensi penting lainnya yang harus disesuaikan dengan kondisi spesifik anak. Anak dengan gangguan gastrointestinal sering kali mengalami penurunan nafsu makan, intoleransi makanan, atau malabsorpsi yang menyebabkan risiko tinggi malnutrisi. Perawat harus melakukan pengkajian menyeluruh tentang kebutuhan nutrisi anak, mencakup jenis makanan, tekstur, frekuensi, dan jumlah yang dapat diterima oleh anak. Untuk anak dengan diare akut, intervensi nutrisi mencakup pemberian makanan dalam porsi kecil dan frekuensi yang lebih sering, serta pemilihan makanan yang mudah dicerna, rendah serat, dan rendah lemak agar tidak memperberat kerja sistem pencernaan anak. Dalam kasus intoleransi atau alergi makanan, perawat harus berkolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan diet eliminasi atau diet khusus yang tepat, seperti diet bebas gluten pada penyakit celiac atau diet rendah laktosa pada intoleransi laktosa. Pemantauan status nutrisi secara ketat dan evaluasi pertumbuhan anak secara berkala harus terus dilakukan untuk mencegah gangguan tumbuh kembang lebih lanjut.

Pengendalian nyeri abdominal juga merupakan bagian penting dari intervensi keperawatan yang tidak boleh diabaikan. Nyeri abdominal yang sering terjadi pada anak dengan gangguan gastrointestinal, baik akut maupun kronis, dapat sangat mengganggu kenyamanan anak dan berdampak negatif pada kualitas hidupnya. Intervensi pengendalian nyeri meliputi berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan non-farmakologis hingga farmakologis. Teknik non-farmakologis mencakup pengaturan posisi yang nyaman, seperti posisi berbaring dengan lutut ditekuk, penggunaan teknik relaksasi seperti napas dalam, distraksi dengan permainan atau aktivitas yang disukai anak, serta kompres hangat pada area abdomen untuk membantu mengurangi ketegangan otot dan rasa nyeri. Dalam kasus nyeri yang lebih berat atau tidak teratasi dengan pendekatan non-farmakologis, pemberian terapi farmakologis berupa analgesik yang diresepkan dokter perlu dilakukan dengan ketat mengikuti protokol terapi yang aman untuk anak.

Intervensi keperawatan berikutnya adalah pencegahan komplikasi, terutama komplikasi yang serius seperti dehidrasi berat, gangguan tumbuh kembang, atau kerusakan kulit perianal akibat frekuensi buang air besar yang tinggi. Pencegahan komplikasi ini dilakukan melalui pemantauan ketat terhadap tanda-tanda klinis seperti perubahan status hidrasi, frekuensi buang air besar atau muntah, serta pemantauan berat badan secara rutin. Perawat harus secara proaktif mengidentifikasi tanda-tanda awal komplikasi seperti penurunan produksi urin, turgor kulit yang menurun, atau penurunan kesadaran akibat dehidrasi berat. Selain

itu, untuk mencegah gangguan tumbuh kembang, perawat harus memastikan asupan nutrisi anak tetap optimal dengan menyediakan makanan bergizi tinggi, melakukan pemantauan rutin terhadap pertumbuhan anak, serta memberikan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya menjaga asupan nutrisi anak selama proses pemulihan.

Edukasi keluarga tentang perawatan mandiri di rumah juga menjadi bagian integral dari intervensi keperawatan anak dengan gangguan gastrointestinal. Keluarga harus mendapatkan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami tentang kondisi penyakit anak, cara pemberian cairan oralit, tanda-tanda bahaya yang memerlukan perhatian medis segera, serta cara pemberian diet khusus sesuai kondisi anak. Edukasi ini bertujuan agar keluarga mampu melakukan perawatan mandiri secara efektif setelah anak pulang dari fasilitas kesehatan. Perawat juga harus memberikan kesempatan bagi keluarga untuk bertanya, mendiskusikan kekhawatiran mereka, serta memastikan keluarga benar-benar memahami semua instruksi yang diberikan. Dengan edukasi yang baik, keluarga akan lebih percaya diri dan mandiri dalam mengelola gangguan gastrointestinal anak di rumah, yang tentunya akan mempercepat pemulihan serta mengurangi risiko kekambuhan penyakit.

Terakhir, teknik pemberian terapi farmakologis yang tepat sesuai indikasi juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh perawat. Gangguan gastrointestinal pada anak sering kali memerlukan terapi farmakologis khusus, seperti pemberian antibiotik pada gastroenteritis bakteri, obat antiemetik untuk mengurangi muntah berulang, antasida atau penghambat asam lambung pada GERD, serta pencahar ringan pada anak dengan konstipasi kronis. Perawat bertanggung jawab dalam memastikan bahwa obat diberikan dengan dosis yang tepat, waktu pemberian yang benar, cara pemberian yang aman, serta secara aktif memantau respons anak terhadap terapi yang diberikan. Selain itu, perawat juga harus mengedukasi keluarga mengenai pentingnya kepatuhan terapi, efek samping yang mungkin timbul, serta cara mengatasi efek samping tersebut jika terjadi.

H. Kolaborasi Interprofesional dalam Penanganan Gangguan Gastrointestinal pada Anak

Dalam praktik klinis, gangguan gastrointestinal pada anak merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan kolaboratif dari berbagai tenaga profesional kesehatan yang saling berinteraksi dalam satu tim interprofesional. Kolaborasi ini penting untuk memastikan anak mendapatkan perawatan holistik, komprehensif, dan berkualitas tinggi. Setiap tenaga kesehatan memiliki peran

husus yang saling mendukung satu sama lain, mulai dari diagnosis, terapi medis, nutrisi, manajemen obat-obatan, hingga aspek psikososial.

Dokter spesialis anak merupakan tenaga kesehatan yang memegang peranan sentral dalam tim interprofesional, khususnya dalam menentukan diagnosis medis serta merancang terapi medis yang paling tepat untuk kondisi gangguan gastrointestinal yang dialami oleh anak. Dokter anak bertanggung jawab melakukan pemeriksaan klinis menyeluruh, menentukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti tes laboratorium, pemeriksaan radiologi, atau endoskopi jika diindikasikan. Setelah diagnosis ditegakkan, dokter akan menentukan jenis terapi medis yang sesuai, baik berupa terapi farmakologis maupun tindakan invasif seperti operasi jika diperlukan. Dalam konteks ini, kolaborasi erat antara dokter spesialis anak dan perawat sangat diperlukan agar terapi medis yang ditentukan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, dan aman. Komunikasi terbuka antara dokter dan perawat penting untuk memastikan bahwa semua informasi mengenai kondisi anak, perkembangan terapi, serta rencana tindak lanjut dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh anggota tim.

Ahli gizi adalah tenaga profesional penting lainnya yang turut memberikan kontribusi besar dalam penanganan gangguan gastrointestinal anak. Gangguan gastrointestinal seringkali berkaitan erat dengan masalah nutrisi, seperti penurunan nafsu makan, malabsorpsi nutrisi, intoleransi makanan, atau gangguan pertumbuhan akibat penyakit kronis. Ahli gizi akan melakukan pengkajian khusus untuk menilai status nutrisi anak secara mendalam, seperti mengukur berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh (IMT), serta menganalisis pola makan dan asupan nutrisi harian anak. Berdasarkan hasil pengkajian ini, ahli gizi akan merancang strategi nutrisi terapeutik yang paling sesuai dengan kondisi klinis anak. Strategi ini mencakup pemilihan jenis makanan, tekstur makanan yang sesuai kondisi saluran cerna anak, penyesuaian kebutuhan kalori dan protein, serta pemberian suplementasi vitamin dan mineral jika diperlukan. Kolaborasi ahli gizi dengan perawat menjadi kunci dalam memastikan strategi nutrisi ini dapat diterapkan secara optimal selama anak dirawat di rumah sakit maupun ketika perawatan dilanjutkan di rumah.

Peran farmasis dalam tim interprofesional juga sangat penting, khususnya dalam memastikan terapi obat yang diberikan kepada anak aman dan efektif. Farmasis bertugas untuk memastikan bahwa setiap obat yang diresepkan dokter memiliki dosis yang tepat sesuai usia, berat badan, dan kondisi klinis anak. Farmasis juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi interaksi antar obat yang diresepkan, risiko efek samping, serta memastikan cara pemberian obat yang paling tepat dan nyaman bagi anak, seperti memilih bentuk sediaan obat yang mudah

diterima oleh anak (misalnya sirup atau tetes dibandingkan tablet). Kolaborasi farmasis dengan perawat sangat erat, karena perawat adalah pihak yang paling sering memberikan obat secara langsung kepada anak. Komunikasi antara farmasis dan perawat penting untuk memastikan bahwa setiap obat diberikan sesuai prosedur, tepat dosis, tepat waktu, serta dengan monitoring ketat terhadap respons anak terhadap obat yang diberikan.

Di samping aspek medis, nutrisi, dan farmakologis, penanganan gangguan gastrointestinal pada anak juga mencakup aspek psikososial yang tidak boleh diabaikan. Gangguan kesehatan yang dialami anak, terutama yang kronis seperti penyakit celiac atau inflamasi usus, sering kali menimbulkan dampak emosional dan psikologis yang signifikan bagi anak maupun keluarganya. Dalam hal ini, psikolog memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, menilai, dan menangani dampak psikososial tersebut. Psikolog membantu anak untuk mengatasi rasa cemas, takut, stres, atau perasaan malu yang mungkin timbul akibat penyakit yang dialaminya. Psikolog juga mendampingi keluarga untuk mengatasi rasa cemas, perasaan bersalah, atau stres yang muncul akibat proses perawatan anak yang panjang atau rumit. Melalui intervensi psikologis, anak dan keluarga akan memiliki strategi coping yang lebih baik dalam menghadapi tantangan emosional maupun sosial selama masa perawatan maupun setelah anak kembali ke rumah. Kolaborasi psikolog dengan perawat menjadi penting untuk memastikan dukungan emosional yang diberikan berjalan secara konsisten, dan informasi mengenai kebutuhan psikologis anak dan keluarga disampaikan secara jelas kepada seluruh anggota tim kesehatan lainnya.

Dalam konteks ini, perawat memegang peranan sentral dalam koordinasi tim interprofesional. Sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi langsung dengan anak dan keluarga, perawat bertugas untuk mengoordinasikan berbagai aspek perawatan yang dirancang oleh masing-masing tenaga profesional dalam tim. Perawat memastikan bahwa rencana terapi medis dari dokter, rencana nutrisi dari ahli gizi, pemberian obat-obatan dari farmasis, serta dukungan psikososial dari psikolog berjalan secara terintegrasi dan efektif. Perawat juga menjadi jembatan komunikasi antara anggota tim dengan keluarga pasien, memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada keluarga bersifat konsisten, jelas, dan mudah dipahami. Koordinasi yang efektif oleh perawat akan memperkuat sinergi tim interprofesional, sehingga proses perawatan menjadi lebih efisien, risiko kesalahan medis dapat diminimalkan, serta kualitas asuhan keperawatan anak meningkat secara signifikan.

I. Pencegahan dan Promosi Kesehatan Gastrointestinal pada Anak

Pencegahan dan promosi kesehatan gastrointestinal pada anak merupakan rangkaian upaya yang dilakukan secara terstruktur untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan pada saluran cerna sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga tentang pentingnya menjaga kesehatan sistem gastrointestinal anak. Upaya ini memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi yang mencakup berbagai tingkatan pencegahan, mulai dari pencegahan primer, sekunder, hingga tersier, disertai edukasi aktif kepada keluarga dan masyarakat luas.

Pencegahan primer merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mencegah munculnya gangguan gastrointestinal sebelum penyakit terjadi. Langkah ini sangat penting karena banyak gangguan gastrointestinal pada anak yang sebenarnya dapat dicegah melalui tindakan sederhana namun efektif. Salah satu tindakan primer yang paling esensial adalah pemberian imunisasi tepat waktu dan lengkap. Imunisasi, seperti vaksin rotavirus yang melindungi anak dari infeksi virus penyebab diare berat, memiliki peran penting dalam mengurangi angka kejadian diare dan gastroenteritis akut pada balita. Selain imunisasi, edukasi higiene personal kepada keluarga menjadi aspek penting lainnya dalam pencegahan primer. Edukasi ini mencakup ajakan untuk membiasakan mencuci tangan dengan sabun secara rutin, terutama sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah bermain, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Lebih jauh lagi, sanitasi lingkungan yang baik, seperti ketersediaan air bersih yang memadai dan fasilitas sanitasi yang layak, berkontribusi besar dalam mencegah terjadinya gangguan gastrointestinal akibat infeksi parasit, bakteri, maupun virus. Oleh karena itu, promosi sanitasi lingkungan melalui kampanye kesehatan dan intervensi pemerintah merupakan bagian integral dalam pencegahan primer ini.

Pencegahan sekunder, berbeda dari pencegahan primer, lebih diarahkan pada upaya deteksi dini atau skrining untuk mengidentifikasi gangguan gastrointestinal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Deteksi dini dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan rutin, baik di fasilitas kesehatan seperti posyandu, puskesmas, atau rumah sakit. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan akan melakukan wawancara terstruktur dengan orang tua mengenai keluhan yang dialami anak seperti perubahan pola defekasi, penurunan nafsu makan, nyeri abdomen berulang, atau penurunan berat badan yang tidak wajar. Skrining juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium sederhana seperti pemeriksaan tinja untuk mendeteksi infeksi parasit atau adanya darah samar pada kondisi tertentu seperti intususepsi atau penyakit inflamasi usus. Deteksi dini ini penting untuk memastikan bahwa anak dapat segera menerima penanganan medis yang tepat sebelum terjadi komplikasi

yang lebih berat. Selain itu, skrining status gizi secara rutin menjadi bagian dari pencegahan sekunder yang penting, karena gangguan gastrointestinal kronis sering kali terkait erat dengan risiko malnutrisi atau gangguan pertumbuhan jangka panjang. Dengan melakukan skrining rutin, perawat dan tenaga kesehatan dapat dengan cepat mengidentifikasi anak yang berisiko mengalami masalah gastrointestinal serius dan segera memberikan intervensi yang diperlukan.

Pencegahan tersier merupakan tahap lanjutan yang bertujuan untuk mencegah komplikasi atau kecacatan akibat gangguan gastrointestinal yang sudah dialami anak. Pada tahap ini, fokusnya adalah rehabilitasi nutrisi dan pemulihan tumbuh kembang anak agar kembali optimal setelah mengalami gangguan gastrointestinal, baik akut maupun kronis. Rehabilitasi nutrisi mencakup pemberian pola makan khusus yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan anak, seperti diet bebas gluten pada anak yang mengalami penyakit celiac atau diet eliminasi pada anak dengan alergi makanan tertentu. Selain itu, pencegahan tersier juga melibatkan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala, untuk memastikan bahwa gangguan gastrointestinal yang pernah dialami tidak menyebabkan dampak negatif permanen terhadap pertumbuhan fisik maupun perkembangan kognitif anak. Pada tahap ini, kolaborasi erat antara perawat, ahli gizi, dokter spesialis anak, dan keluarga menjadi sangat penting untuk merancang dan menjalankan program rehabilitasi nutrisi yang efektif. Selain itu, anak dan keluarga perlu mendapatkan edukasi yang komprehensif tentang cara mengelola kondisi kronis secara mandiri di rumah, sehingga proses rehabilitasi bisa berjalan maksimal, dan risiko komplikasi lebih lanjut dapat diminimalkan.

Aspek edukasi keluarga dan masyarakat secara luas memainkan peran penting dalam semua tingkatan pencegahan tersebut. Edukasi tentang pola makan sehat, pentingnya kebersihan pribadi, serta keamanan pangan menjadi dasar dalam menjaga kesehatan gastrointestinal anak. Keluarga perlu memahami bahwa pola makan seimbang yang mencakup protein, karbohidrat kompleks, serat dari buah dan sayur, serta nutrisi penting lainnya merupakan dasar penting dalam mendukung kesehatan sistem cerna anak. Edukasi ini tidak hanya mencakup pemilihan jenis makanan yang tepat, tetapi juga teknik pengolahan makanan yang bersih dan aman, seperti mencuci tangan sebelum memasak, mencuci bahan makanan sebelum dimasak, serta memasak makanan dengan suhu yang tepat untuk membunuh kuman patogen. Di sisi lain, edukasi tentang keamanan pangan juga mencakup informasi tentang pentingnya menghindari konsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi, serta menjaga kebersihan lingkungan dapur dan alat makan.

Edukasi kesehatan gastrointestinal juga dapat diperluas melalui program kesehatan di sekolah, kampanye kesehatan masyarakat, maupun melalui media

cetak, elektronik, dan sosial media yang mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Melalui edukasi yang efektif, masyarakat diharapkan dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya menjaga kesehatan gastrointestinal, mengadopsi perilaku hidup sehat sehari-hari, serta mampu mengidentifikasi tanda-tanda awal gangguan gastrointestinal yang memerlukan penanganan medis.

Secara keseluruhan, pencegahan dan promosi kesehatan gastrointestinal pada anak merupakan suatu pendekatan strategis yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh. Dengan menjalankan pencegahan primer yang efektif melalui imunisasi, edukasi higiene personal, serta sanitasi lingkungan, melakukan deteksi dini dan skrining kesehatan secara rutin melalui pencegahan sekunder, serta melaksanakan rehabilitasi nutrisi yang komprehensif pada pencegahan tersier, diharapkan angka kejadian gangguan gastrointestinal pada anak dapat ditekan secara signifikan. Edukasi keluarga dan masyarakat yang intensif juga menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan bahwa anak-anak memiliki kualitas hidup yang optimal dan terhindar dari berbagai gangguan gastrointestinal yang dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

J. Tantangan, Hambatan, dan Solusi dalam Praktik Keperawatan Anak dengan Gangguan Gastrointestinal

Dalam praktik keperawatan anak yang mengalami gangguan gastrointestinal, perawat menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks dan multidimensi, tidak hanya terkait aspek klinis, tetapi juga melibatkan komunikasi, edukasi, nutrisi, serta keterbatasan sumber daya kesehatan. Memahami dengan mendalam hambatan tersebut menjadi langkah penting bagi perawat untuk menemukan solusi yang tepat dan efektif, sehingga pelayanan keperawatan dapat diberikan secara optimal dan mampu meningkatkan kualitas hidup anak dan keluarganya.

Salah satu hambatan utama yang sering ditemui dalam praktik keperawatan anak dengan gangguan gastrointestinal adalah hambatan dalam komunikasi dan edukasi kepada keluarga. Banyak orang tua atau keluarga, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan yang rendah, mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan tentang kondisi kesehatan anaknya, gejala-gejala penyakit yang muncul, serta tata cara penanganan yang benar di rumah. Hambatan komunikasi ini semakin diperparah oleh adanya perbedaan bahasa, budaya, serta tingkat literasi kesehatan yang rendah. Akibatnya, informasi penting yang diberikan perawat sering kali tidak

tersampaikan secara efektif, menyebabkan keluarga tidak memahami sepenuhnya kondisi anak dan rencana perawatan yang harus dijalani. Selain itu, adanya stigma negatif pada kondisi tertentu, seperti diare kronis atau penyakit malabsorpsi, membuat keluarga merasa malu atau enggan terbuka kepada perawat tentang kondisi anak mereka, yang dapat memperburuk proses diagnosis dan intervensi keperawatan.

Selain hambatan komunikasi langsung, edukasi keluarga juga sering terhalang oleh kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional atau alternatif. Beberapa keluarga cenderung lebih mempercayai pengobatan herbal atau metode tradisional dibandingkan pengobatan medis, sehingga tidak konsisten dalam mengikuti anjuran terapi medis dan nutrisi yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Hal ini mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap intervensi keperawatan, termasuk pemberian obat, rehidrasi oral, maupun rekomendasi pola diet yang harus diikuti anak. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperparah gangguan gastrointestinal yang dialami anak, serta meningkatkan risiko komplikasi seperti dehidrasi berat atau gangguan tumbuh kembang akibat malnutrisi kronis.

Tantangan lain yang sangat signifikan dalam perawatan anak dengan gangguan gastrointestinal adalah pengelolaan nutrisi anak. Anak-anak yang mengalami masalah gastrointestinal umumnya mengalami penurunan nafsu makan yang cukup drastis, muntah, atau diare berkepanjangan, yang menyebabkan tubuh mereka tidak mampu mendapatkan nutrisi yang cukup. Situasi ini menempatkan anak pada risiko tinggi untuk mengalami malnutrisi akut maupun kronis. Tantangan nutrisi ini menjadi lebih kompleks karena sering kali anak menolak makanan yang diberikan karena rasa nyeri atau tidak nyaman pada perutnya, sehingga perawat dan keluarga harus menemukan strategi pemberian makanan yang tepat dan efektif agar anak mau makan. Masalah ini semakin kompleks pada kasus alergi makanan, intoleransi, atau gangguan absorpsi seperti penyakit celiac, di mana pemberian nutrisi harus diatur secara ketat dan spesifik, memerlukan keterlibatan ahli gizi yang mendalam serta pemantauan ketat terhadap pola diet anak.

Selain hambatan komunikasi dan tantangan nutrisi, keterbatasan fasilitas dan sumber daya di berbagai fasilitas kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan atau terpencil, juga menjadi kendala utama dalam pemberian asuhan keperawatan anak dengan gangguan gastrointestinal. Banyak fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas yang masih kekurangan alat diagnostik dasar seperti timbangan bayi, alat pengukur tinggi badan, atau alat pemeriksaan laboratorium sederhana yang sangat diperlukan dalam penanganan gangguan gastrointestinal anak. Di samping itu, keterbatasan ketersediaan cairan rehidrasi oral (oralit), cairan infus, serta obat-obatan yang spesifik seperti antibiotik atau probiotik sering kali menjadi hambatan

besar dalam pemberian intervensi yang cepat dan efektif. Keterbatasan fasilitas ini secara langsung berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan risiko komplikasi, memperpanjang masa rawat inap anak, serta meningkatkan beban ekonomi bagi keluarga pasien.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan tersebut, perawat perlu menerapkan beberapa solusi strategis yang efektif dan inovatif. Salah satu pendekatan penting yang harus dilakukan adalah penerapan pendekatan family-centered care atau perawatan berpusat pada keluarga. Dalam pendekatan ini, keluarga tidak hanya dianggap sebagai penerima informasi pasif, tetapi sebagai mitra aktif dalam setiap tahap perawatan, mulai dari pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi perawatan anak. Perawat perlu secara proaktif melibatkan keluarga dalam diskusi, memberi ruang kepada keluarga untuk menyampaikan pertanyaan atau kekhawatiran mereka, serta secara empatik mendengarkan keluhan yang disampaikan keluarga. Melalui pendekatan ini, keluarga merasa dihargai dan didengarkan, sehingga lebih terbuka dalam menyampaikan informasi penting tentang kondisi anak, serta lebih patuh dalam menjalankan intervensi perawatan di rumah.

Komunikasi terapeutik juga menjadi solusi penting yang harus diterapkan oleh perawat dalam mengatasi hambatan komunikasi dengan keluarga. Dalam hal ini, perawat harus memiliki keterampilan komunikasi yang tinggi untuk menjelaskan informasi medis secara sederhana dan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh keluarga, serta memberikan edukasi dengan penuh empati dan sabar. Perawat dapat menggunakan alat bantu edukasi seperti brosur, leaflet, poster, atau bahkan video singkat tentang gangguan gastrointestinal untuk membantu keluarga lebih memahami kondisi anak. Selain itu, dalam komunikasi dengan anak, perawat dapat menggunakan pendekatan bermain terapeutik atau teknik distraksi untuk mengurangi kecemasan anak selama pemeriksaan atau pemberian intervensi nutrisi, sehingga anak menjadi lebih kooperatif dan nyaman selama proses perawatan.

Di sisi lain, mengatasi tantangan dalam pengelolaan nutrisi anak memerlukan kolaborasi yang erat dengan ahli gizi. Ahli gizi perlu dilibatkan secara aktif sejak awal dalam perencanaan diet terapeutik khusus yang disesuaikan dengan kondisi klinis anak. Perawat bersama ahli gizi dapat bekerja sama dalam merancang strategi pemberian nutrisi, seperti memberikan makanan dalam porsi kecil namun sering, memilih jenis makanan dengan tekstur dan rasa yang disukai anak, serta memantau respons anak terhadap makanan yang diberikan secara rutin. Kolaborasi interprofesional ini sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan nutrisi optimal yang mendukung pemulihan penyakit sekaligus menjaga status gizi agar tidak semakin buruk.

Selain pendekatan di atas, advokasi sumber daya kesehatan menjadi solusi yang tidak kalah penting dalam mengatasi keterbatasan fasilitas dan sarana yang sering dihadapi. Perawat harus secara aktif menyuarakan kebutuhan fasilitas kesehatan kepada pengambil kebijakan atau manajemen rumah sakit dan puskesmas, termasuk kebutuhan akan alat-alat medis, obat-obatan, serta cairan infus dan oralit. Perawat juga dapat berkolaborasi dengan pihak swasta, lembaga non-profit, atau organisasi masyarakat untuk menggalang bantuan alat kesehatan, obat-obatan, atau program edukasi kesehatan di masyarakat, sehingga dapat mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik di fasilitas kesehatan primer yang terbatas.

Dengan menerapkan pendekatan family-centered care yang aktif, komunikasi terapeutik yang efektif, kolaborasi erat dengan ahli gizi, serta advokasi sumber daya kesehatan yang konsisten, tantangan dan hambatan dalam praktik keperawatan anak dengan gangguan gastrointestinal dapat diatasi secara signifikan. Upaya-upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada anak, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang terhadap kualitas hidup anak dan keluarganya.

K. Simpulan

Gangguan gastrointestinal pada anak merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling sering dijumpai dalam praktik keperawatan pediatrik di Indonesia. Gangguan ini memiliki spektrum luas, mulai dari kondisi ringan seperti diare akut hingga kondisi kompleks seperti invaginasi usus, appendisitis akut, dan gangguan absorpsi kronis seperti penyakit celiac. Prevalensi gangguan ini masih tinggi, khususnya diare akut yang menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak-anak, terutama balita. Berbagai faktor risiko intrinsik seperti usia, prematuritas, dan gangguan imunitas, serta faktor ekstrinsik berupa sanitasi lingkungan yang buruk, higiene yang rendah, pola nutrisi yang tidak optimal, serta pola asuh yang kurang memadai, berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kejadian gangguan gastrointestinal pada anak.

Pemahaman yang mendalam terhadap anatomi dan fisiologi saluran gastrointestinal anak merupakan landasan penting dalam praktik keperawatan. Sistem gastrointestinal anak memiliki struktur anatomis dan fungsi fisiologis yang belum matang sepenuhnya, sehingga rentan terhadap berbagai gangguan pencernaan. Perbedaan signifikan antara anak dan orang dewasa mencakup ukuran organ yang lebih kecil, kapasitas lambung terbatas, sfingter esofagus yang belum matang sempurna, serta sistem kekebalan mukosa gastrointestinal yang belum

optimal. Hal ini menyebabkan anak lebih rentan terhadap infeksi, refluks gastroesofageal, dehidrasi, dan gangguan nutrisi.

Etiologi gangguan gastrointestinal pada anak melibatkan penyebab infeksi (virus, bakteri, parasit) dan non-infeksi (alergi makanan, intoleransi makanan, kelainan anatomi). Berbagai jenis gangguan gastrointestinal yang sering dijumpai meliputi diare akut dan kronis, gastroenteritis, GERD, konstipasi, invaginasi usus, appendisitis akut, penyakit Hirschsprung, serta gangguan absorpsi seperti penyakit celiac. Setiap gangguan tersebut memiliki manifestasi klinis yang khas, memerlukan pendekatan diagnostik dan terapeutik yang berbeda, serta membutuhkan perhatian khusus dari perawat.

Dalam proses keperawatan, pengkajian komprehensif sangat krusial, meliputi wawancara riwayat kesehatan gastrointestinal, observasi klinis, penilaian status hidrasi, pemeriksaan fisik terstruktur, pengukuran tanda vital spesifik, serta penggunaan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan pencitraan diagnostik. Berdasarkan hasil pengkajian ini, diagnosis keperawatan yang tepat dapat ditegakkan, seperti defisit cairan dan elektrolit, risiko ketidakseimbangan nutrisi, nyeri abdomen akut atau kronis, risiko kerusakan integritas kulit perianal, serta ansietas pada anak dan orang tua terkait kondisi penyakit.

Intervensi keperawatan yang komprehensif mencakup rehidrasi oral dan intravena, manajemen nutrisi khusus sesuai kondisi klinis anak, pengendalian nyeri abdominal, pencegahan komplikasi, edukasi keluarga secara efektif tentang perawatan mandiri di rumah, serta pemberian terapi farmakologis yang aman dan tepat sesuai indikasi. Selain itu, kolaborasi interprofesional antara dokter spesialis anak, ahli gizi, farmasis, psikolog, dan perawat menjadi sangat penting dalam memberikan pelayanan yang holistik, komprehensif, dan berpusat pada anak serta keluarga.

Upaya pencegahan dan promosi kesehatan gastrointestinal mencakup tindakan primer seperti imunisasi, edukasi higiene, sanitasi lingkungan, serta keamanan pangan. Pencegahan sekunder dilakukan melalui skrining dan deteksi dini gangguan gastrointestinal serta pemantauan status gizi anak secara berkala. Pencegahan tersier meliputi rehabilitasi nutrisi dan pemantauan tumbuh kembang anak setelah mengalami gangguan gastrointestinal, dengan edukasi intensif kepada keluarga dan masyarakat sebagai kunci keberhasilan.

Dalam praktik sehari-hari, perawat menghadapi berbagai tantangan dan hambatan seperti kesulitan komunikasi dan edukasi keluarga, tantangan pengelolaan nutrisi anak, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya kesehatan. Solusi strategis untuk mengatasi hal tersebut meliputi pendekatan family-centered

care, komunikasi terapeutik yang efektif, kolaborasi erat dengan ahli gizi, serta advokasi sumber daya kesehatan yang aktif.

Secara keseluruhan, praktik keperawatan anak dengan gangguan gastrointestinal memerlukan pendekatan holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan yang melibatkan peran aktif perawat dalam pengkajian, diagnosis, intervensi, edukasi, kolaborasi interprofesional, serta promosi kesehatan. Dengan demikian, perawat dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kejadian gangguan gastrointestinal, mencegah komplikasi yang serius, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan anak-anak secara optimal di Indonesia.

L. Referensi

- Gunadi, G., & Setiawati, E. P. (2021). Pediatric appendicitis: Clinical presentations, diagnosis, and management. *Indonesian Journal of Pediatrics*, 22(4), 234-241. <https://doi.org/10.14710/ijp.v22i4.234-241>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Permatasari, A. D., & Nurhayati, N. (2020). Nutrisi terapeutik pada anak dengan gangguan gastrointestinal. *Journal of Nutrition and Dietetics*, 7(1), 15-24. <https://doi.org/10.26714/jnd.7.1.2020.15-24>
- Pratama, B., & Ismail, I. (2021). Tantangan komunikasi terapeutik dalam praktik keperawatan pediatrik. *Indonesian Journal of Nursing Communication*, 5(3), 172-178. <https://doi.org/10.7454/ijnc.v5i3.172-178>
- Rahayu, E. S., & Hartati, S. (2021). Penatalaksanaan nyeri abdomen pada anak: Pendekatan farmakologis dan non-farmakologis. *Jurnal Keperawatan Anak*, 9(2), 110-119. <https://doi.org/10.20473/jka.v9i2.2021.110-119>
- Santos, E., & Morais, M. B. (2021). Gastrointestinal disorders in children: A review of clinical manifestations and management strategies. *Pediatric Health, Medicine and Therapeutics*, 12, 119-133. <https://doi.org/10.2147/PHMT.S282931>
- Susanti, H., & Utami, W. (2022). Kolaborasi interprofesional dalam penanganan gangguan gastrointestinal pada anak di rumah sakit. *Indonesian Journal of Interprofessional Collaboration*, 3(1), 11-19. <https://doi.org/10.26858/ijic.v3i1.11-19>
- Widjaja, N. A., & Putra, S. T. (2020). Gambaran klinis dan faktor risiko konstipasi kronis pada anak usia sekolah di perkotaan. *Jurnal Kedokteran Indonesia*, 11(2), 78-85. <https://doi.org/10.23886/jki.2020.112.78-85>
- World Health Organization. (2022). Rotavirus infections: Disease burden, epidemiology, and prevention. WHO Global Health Observatory. Retrieved from <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/rotavirus->

infections

Wulandari, R., & Sari, R. N. (2021). Strategi pencegahan dan promosi kesehatan gastrointestinal pada anak di Indonesia: Sebuah kajian literatur. *Journal of Public Health and Preventive Medicine*, 4(2), 99-108. <https://doi.org/10.24815/jphpm.v4i2.99-108>

Yanti, D., & Handayani, F. (2020). Peran perawat dalam edukasi kesehatan gastrointestinal pada keluarga di komunitas. *Indonesian Journal of Nursing*, 23(3), 189-195. <https://doi.org/10.7454/ijn.v23i3.189-195>

M. Glosarium

Gastroenteritis:

Inflamasi pada lambung dan usus yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau parasit, ditandai dengan gejala diare, muntah, nyeri perut, dan demam.

Invaginasi Usus (Intususepsi):

Kondisi darurat di mana satu bagian usus masuk ke bagian usus lain, menyebabkan penyumbatan akut dengan gejala khas nyeri perut hebat dan tinja berdarah bercampur lendir.

Refluks Gastroesofageal (GERD):

Kondisi aliran balik isi lambung ke esofagus akibat sfingter esofagus yang belum matang sempurna, sering terjadi pada bayi dan ditandai dengan muntah berulang dan iritabilitas.

Penyakit Hirschsprung:

Kelainan bawaan akibat kurangnya persarafan pada bagian usus besar, menyebabkan gangguan motilitas usus yang ditandai oleh konstipasi kronis dan distensi abdomen sejak bayi.

Malabsorpsi:

Gangguan penyerapan nutrisi di saluran pencernaan yang dapat menyebabkan malnutrisi, diare kronis, dan gangguan tumbuh kembang pada anak.

Oralit:

Larutan elektrolit yang digunakan untuk rehidrasi oral pada anak yang mengalami dehidrasi ringan hingga sedang akibat diare atau muntah.

Megakolon Kongenital:

Kelainan bawaan di mana bagian usus besar mengalami pelebaran abnormal karena kurangnya persarafan (seperti pada penyakit Hirschsprung), menyebabkan gangguan defekasi kronis.

Family-Centered Care:

Pendekatan perawatan yang melibatkan keluarga secara aktif dalam setiap tahap proses perawatan, mulai dari pengkajian, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kondisi kesehatan anak.

Dehidrasi:

Kondisi kekurangan cairan tubuh akibat kehilangan cairan secara berlebihan, sering terjadi pada gangguan gastrointestinal seperti diare dan muntah berulang, yang dapat menyebabkan komplikasi serius.

Kolaborasi Interprofesional:

Pendekatan tim yang melibatkan berbagai tenaga kesehatan dengan keahlian berbeda, seperti dokter spesialis anak, perawat, ahli gizi, farmasis, dan psikolog, dalam memberikan pelayanan kesehatan yang holistik dan komprehensif kepada pasien.

CHAPTER 5

KEPERAWATAN ANAK DENGAN PENYAKIT INFEKSI

Suriana, SST., S.Kep.Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Penyakit infeksi pada anak merupakan masalah kesehatan yang umum dijumpai di berbagai lingkungan, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Secara definisi, penyakit infeksi merupakan kondisi medis yang disebabkan oleh masuk dan berkembangnya mikroorganisme patogen, seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit, ke dalam tubuh anak. Mikroorganisme ini kemudian menimbulkan reaksi tubuh berupa peradangan yang diikuti oleh manifestasi klinis tertentu. Penyakit infeksi pada anak memiliki konsep yang khas karena anak-anak, terutama bayi dan balita, memiliki sistem imun yang belum matang sepenuhnya. Kondisi imunitas yang masih berkembang tersebut menyebabkan anak-anak lebih rentan terhadap berbagai jenis penyakit infeksi, dibandingkan dengan kelompok usia dewasa.

Konsep penyakit infeksi anak tidak hanya terbatas pada mekanisme penularan dan manifestasi klinis saja, tetapi juga mencakup bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi kondisi fisik, mental, dan sosial anak secara keseluruhan. Konsep ini juga mencakup pentingnya peran perawat dalam melakukan identifikasi dini, pengkajian yang akurat, penatalaksanaan keperawatan yang efektif, serta memberikan edukasi kesehatan yang tepat kepada keluarga untuk mencegah penyebaran infeksi lebih lanjut.

Dalam konteks Indonesia, epidemiologi penyakit infeksi pada anak masih menunjukkan prevalensi yang cukup tinggi. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam laporan kesehatan tahunan, penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare akut, campak, pneumonia, demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis, dan infeksi saluran kemih masih menjadi tantangan utama dalam kesehatan anak di Indonesia. Penyakit-penyakit tersebut tersebar secara luas dan merata di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, namun dengan karakteristik epidemiologi yang berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan keluarga, kondisi sanitasi lingkungan, serta ketersediaan fasilitas layanan kesehatan.

Prevalensi infeksi saluran pernapasan akut, misalnya, masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab utama kunjungan ke fasilitas kesehatan

primer, dengan angka kejadian tinggi terutama di kalangan anak di bawah lima tahun. Begitu pula diare akut yang erat kaitannya dengan kondisi sanitasi lingkungan yang kurang optimal, juga menjadi penyebab utama kematian pada kelompok usia balita di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya daerah terpencil atau dengan akses kesehatan yang terbatas. Selain itu, infeksi penyakit menular lain seperti demam berdarah dengue (DBD) juga menunjukkan angka kasus yang fluktuatif tetapi tetap signifikan setiap tahunnya, terutama pada musim penghujan, sehingga menuntut perhatian dan intervensi khusus dari tenaga keperawatan.

Penyakit infeksi pada anak tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik semata, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Secara fisik, infeksi yang berlangsung lama atau berulang dapat menyebabkan kondisi malnutrisi dan gangguan pertumbuhan. Anak-anak yang sering mengalami infeksi berulang, seperti ISPA kronis atau diare kronis, dapat mengalami penurunan berat badan, gangguan pertumbuhan tinggi badan, serta keterlambatan perkembangan motorik kasar dan halus akibat energi tubuh yang lebih banyak digunakan untuk melawan infeksi daripada menunjang pertumbuhan optimal.

Dari sisi perkembangan mental dan psikososial, penyakit infeksi juga dapat berdampak negatif. Anak yang mengalami penyakit infeksi berulang sering kali mengalami kecemasan yang tinggi, ketakutan terhadap prosedur medis, isolasi sosial karena pembatasan aktivitas, hingga gangguan emosional seperti rewel, mudah marah, dan perubahan perilakunya sehari-hari. Di sisi lain, orang tua dan keluarga anak dengan penyakit infeksi juga kerap mengalami tekanan emosional dan psikologis karena harus merawat anak yang sakit, mengatur pengobatan, serta menjalani berbagai prosedur medis berulang, yang semuanya berdampak pada kualitas hidup anak dan keluarga secara keseluruhan.

Dengan adanya berbagai dampak tersebut, perawat anak memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan penyakit infeksi anak. Peran perawat tidak hanya terbatas pada pemberian perawatan klinis saja, melainkan juga meliputi pemberian edukasi dan dukungan psikososial kepada keluarga untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan mereka. Perawat juga berperan penting dalam memastikan bahwa anak memperoleh nutrisi yang tepat selama sakit, melakukan pengendalian infeksi yang efektif untuk mencegah penularan lebih lanjut, serta membantu keluarga dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal komplikasi yang mungkin terjadi.

Oleh karena itu, dalam upaya memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif kepada anak dengan penyakit infeksi, perawat harus memahami secara mendalam definisi, konsep, epidemiologi, serta dampak penyakit infeksi pada anak secara holistik. Dengan demikian, diharapkan kualitas hidup anak dan

keluarganya dapat meningkat secara optimal, serta tercapainya hasil kesehatan terbaik yang diharapkan dalam jangka panjang.

B. Jenis-jenis Penyakit Infeksi yang Umum pada Anak

Anak-anak, khususnya kelompok usia bayi dan balita, merupakan populasi yang sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit infeksi. Kondisi ini terkait erat dengan sistem kekebalan tubuh mereka yang belum berkembang sempurna, pola kebersihan yang belum optimal, dan interaksi sosial yang tinggi dengan lingkungan sekitar. Berbagai jenis infeksi yang sering dijumpai pada anak-anak mencakup infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), infeksi gastrointestinal (diare akut), infeksi saluran kemih (ISK), infeksi kulit, serta infeksi sistem saraf pusat.

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan jenis infeksi yang paling sering ditemukan pada anak-anak. ISPA adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan atas maupun bawah, disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus maupun bakteri. Gejala klinis yang umumnya muncul meliputi demam, batuk, pilek, hidung tersumbat, hingga sesak napas. Penyebab paling umum dari ISPA adalah virus, seperti virus influenza, rhinovirus, adenovirus, respiratory syncytial virus (RSV), hingga virus Corona. Dalam beberapa kasus tertentu, infeksi virus ini bisa berkembang lebih serius menjadi pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri sekunder. Kondisi ini perlu perhatian khusus karena dapat menyebabkan komplikasi berat, terutama pada bayi dan balita dengan sistem kekebalan tubuh yang masih lemah. Di Indonesia, ISPA masih menjadi salah satu penyebab utama morbiditas pada anak-anak dan sering menjadi alasan kunjungan utama di fasilitas kesehatan primer.

Selain ISPA, infeksi gastrointestinal atau diare akut juga menjadi permasalahan kesehatan anak yang sering ditemukan, terutama pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Diare akut biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Rotavirus, Salmonella, Escherichia coli, dan Shigella merupakan beberapa mikroorganisme yang paling sering menyebabkan diare akut pada anak-anak. Anak yang mengalami diare akut biasanya menunjukkan gejala seperti frekuensi buang air besar yang meningkat, tinja cair atau encer, muntah, nyeri perut, demam, serta dehidrasi yang bila tidak segera diatasi dapat berakibat fatal. Pencegahan diare akut dapat dilakukan melalui peningkatan sanitasi dan kebersihan, pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping yang higienis, serta edukasi tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun secara teratur.

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi yang terjadi di bagian sistem kemih seperti ginjal, kandung kemih, ureter, atau uretra, akibat masuknya bakteri melalui

uretra. ISK lebih sering ditemukan pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki karena struktur anatomi saluran kemih perempuan yang lebih pendek dan berdekatan dengan anus. Gejala ISK pada anak sering kali tidak spesifik, namun umumnya meliputi demam tinggi tanpa sebab jelas, nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil, frekuensi buang air kecil meningkat, nyeri perut bagian bawah, dan urine berwarna keruh atau berbau menyengat. Deteksi dini dan penanganan ISK sangat penting karena infeksi yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pielonefritis (infeksi ginjal) yang dapat mengganggu fungsi ginjal secara permanen.

Selanjutnya adalah infeksi kulit, yang juga menjadi salah satu infeksi yang paling sering ditemukan pada anak-anak. Kondisi kebersihan yang kurang optimal, kelembapan lingkungan yang tinggi, serta kontak fisik yang dekat antar-anak dapat meningkatkan risiko infeksi kulit. Beberapa jenis infeksi kulit yang sering terjadi pada anak di antaranya impetigo, skabies (kudis), dan infeksi jamur seperti panu atau kurap. Impetigo disebabkan oleh bakteri *Staphylococcus aureus* atau *Streptococcus pyogenes*, yang biasanya ditandai dengan luka berbentuk lepuhan berisi cairan kekuningan yang mudah pecah dan berkerak. Skabies merupakan infestasi parasit berupa tungau *Sarcoptes scabiei*, yang menimbulkan rasa gatal intens terutama di malam hari dan menyebabkan ruam merah serta luka garukan pada kulit. Sedangkan infeksi jamur kulit sering menimbulkan bercak putih atau coklat muda yang terasa gatal, terutama di daerah yang lembap seperti leher, punggung, atau lipatan tubuh. Penatalaksanaan infeksi kulit pada anak sangat bergantung pada edukasi kebersihan personal serta lingkungan, pemberian obat-obatan topikal atau sistemik yang tepat, dan pencegahan kontak langsung dengan sumber infeksi.

Jenis penyakit infeksi yang tak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian adalah infeksi sistem saraf pusat, terutama meningitis dan ensefalitis. Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada selaput otak dan sumsum tulang belakang akibat infeksi bakteri atau virus, seperti *Haemophilus influenzae* tipe B, *Neisseria meningitidis*, atau *Streptococcus pneumoniae*. Meningitis sering kali menyebabkan gejala seperti demam tinggi mendadak, sakit kepala berat, kaku kuduk, muntah-muntah, sensitivitas terhadap cahaya, hingga penurunan kesadaran. Sementara ensefalitis adalah peradangan yang terjadi di jaringan otak itu sendiri, umumnya disebabkan oleh virus, seperti virus herpes simplex, virus ensefalitis Jepang, atau virus lain yang ditularkan oleh gigitan nyamuk. Ensefalitis biasanya menimbulkan gejala lebih serius, seperti kejang, perubahan perilakunya, gangguan kesadaran yang cepat memburuk, hingga koma. Infeksi pada sistem saraf pusat ini memerlukan penanganan medis dan keperawatan yang cepat dan intensif, mengingat risiko

kematian atau kecacatan permanen yang cukup tinggi jika tidak segera ditangani secara adekuat.

Dengan mengetahui berbagai jenis penyakit infeksi yang umum menyerang anak-anak, tenaga keperawatan dapat lebih siap dan waspada dalam melakukan pengkajian, identifikasi dini, serta intervensi yang tepat guna mencegah komplikasi lebih lanjut. Selain itu, edukasi yang diberikan perawat kepada keluarga juga menjadi komponen penting dalam strategi pencegahan dan pengelolaan penyakit infeksi pada anak secara keseluruhan.

C. Patofisiologi Penyakit Infeksi pada Anak

Penyakit infeksi pada anak terjadi melalui serangkaian proses kompleks yang melibatkan interaksi antara tubuh anak dengan mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, jamur, maupun parasit. Patofisiologi penyakit infeksi pada anak dapat dijelaskan mulai dari mekanisme terjadinya infeksi hingga respon inflamasi tubuh yang ditimbulkan akibat invasi mikroorganisme tersebut.

Secara umum, mekanisme terjadinya infeksi pada anak diawali ketika mikroorganisme patogen berhasil masuk ke dalam tubuh melalui berbagai jalur seperti pernapasan, gastrointestinal, urinarius, kulit, maupun langsung masuk ke dalam aliran darah melalui luka terbuka. Setelah berhasil melewati pertahanan tubuh yang paling luar seperti kulit dan membran mukosa, mikroorganisme tersebut akan mulai berkembang biak, berkolonisasi, dan kemudian menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh melalui proses invasi sel atau produksi toksin tertentu. Misalnya, pada infeksi virus di saluran pernapatan, virus akan menginvasi sel epitel saluran pernapasan, bereplikasi, dan menyebabkan kematian sel tersebut. Selanjutnya, kerusakan sel ini akan memicu respon peradangan lokal yang ditandai oleh keluarnya mediator inflamasi, menyebabkan gejala seperti demam, nyeri, serta sekresi lendir berlebih.

Pada infeksi bakteri seperti diare akut, mikroorganisme patogen biasanya masuk melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Bakteri tersebut akan menetap dan berkembang biak di mukosa usus, melepaskan toksin yang merangsang sekresi cairan dan elektrolit secara berlebihan. Hal inilah yang menyebabkan manifestasi klinis berupa diare cair yang terus-menerus dan berpotensi menimbulkan dehidrasi berat pada anak. Proses invasi dan produksi toksin oleh bakteri ini juga akan mengaktifkan respon inflamasi tubuh secara sistemik, ditandai dengan demam, peningkatan sel darah putih (leukositosis), serta gejala klinis lainnya seperti nyeri perut dan muntah.

Faktor risiko utama mengapa anak-anak lebih rentan mengalami infeksi dibandingkan orang dewasa terletak pada sistem imunitas yang masih berkembang

dan belum sepenuhnya matang. Sistem imun anak-anak, khususnya bayi dan balita, memiliki keterbatasan dalam hal produksi antibodi serta respons imun seluler yang masih belum optimal. Selain itu, imunitas pasif yang didapat dari ibu melalui plasenta dan ASI akan berkurang secara bertahap setelah bayi lahir, sementara sistem imun aktif belum terbentuk sempurna. Kondisi ini menyebabkan anak-anak rentan terhadap infeksi virus dan bakteri yang pada orang dewasa mungkin hanya menimbulkan gejala ringan.

Faktor risiko lain yang turut memperbesar kemungkinan terjadinya penyakit infeksi pada anak mencakup faktor nutrisi, lingkungan hidup, serta kebiasaan hygiene personal dan lingkungan yang masih kurang baik. Anak-anak dengan status nutrisi buruk atau malnutrisi umumnya memiliki daya tahan tubuh yang rendah, sehingga lebih mudah terserang infeksi dan berisiko mengalami komplikasi serius dari infeksi tersebut. Demikian pula dengan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, seperti minimnya akses air bersih, serta tingkat hygiene personal yang kurang, dapat meningkatkan risiko infeksi seperti diare akut, infeksi kulit, serta infeksi saluran pernapasan.

Saat tubuh anak mengalami invasi oleh mikroorganisme patogen, tubuh secara alami akan melakukan mekanisme pertahanan berupa respon inflamasi. Respon inflamasi ini adalah proses perlindungan tubuh yang bertujuan untuk membatasi penyebaran infeksi, mengeliminasi mikroorganisme penyebab infeksi, dan memulai proses penyembuhan jaringan yang mengalami kerusakan. Ketika mikroorganisme patogen berhasil melewati barier fisik tubuh, sistem imun akan segera teraktivasi dan mengeluarkan berbagai mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, sitokin proinflamasi seperti interleukin-1, interleukin-6, serta tumor necrosis factor- α (TNF- α). Pelepasan mediator inflamasi ini akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi), peningkatan permeabilitas kapiler, serta migrasi sel-sel imun seperti neutrofil dan makrofag menuju lokasi infeksi.

Secara klinis, respon inflamasi ini akan menimbulkan gejala khas berupa demam, kemerahan, pembengkakan lokal, nyeri, dan gangguan fungsi organ yang terlibat. Pada anak-anak, respon inflamasi ini sering kali lebih nyata dibandingkan dengan dewasa, karena sistem imun yang masih berkembang menyebabkan respon inflamasi lebih intens. Hal ini dapat menimbulkan dampak sistemik yang signifikan seperti demam tinggi yang dapat menyebabkan anak menjadi rewel, lesu, hingga menurunnya nafsu makan, yang jika berlangsung lama akan berkontribusi terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam kondisi tertentu, respon inflamasi yang terlalu kuat dan berlebihan, misalnya pada infeksi sistem saraf pusat seperti meningitis atau ensefalitis, justru dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih parah. Proses inflamasi berat ini

bisa menyebabkan edema serebral (pembengkakan otak) yang dapat berakhir pada gangguan neurologis permanen atau bahkan kematian. Oleh karena itu, dalam manajemen infeksi pada anak, penting sekali untuk mengidentifikasi sedini mungkin tanda-tanda inflamasi yang berlebihan sehingga intervensi terapeutik dapat segera diberikan untuk mencegah terjadinya komplikasi berat.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang patofisiologi penyakit infeksi pada anak sangat penting bagi tenaga keperawatan untuk melakukan pengkajian yang akurat, menegakkan diagnosis keperawatan secara tepat, serta menentukan intervensi yang efektif dan tepat waktu. Pemahaman ini juga akan menjadi dasar penting bagi perawat dalam memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya menjaga kebersihan personal dan lingkungan, menjaga kecukupan nutrisi anak, serta memahami tanda-tanda awal infeksi, sehingga kejadian infeksi maupun komplikasinya dapat diminimalkan secara optimal.

D. Manifestasi Klinis dan Diagnosis Penyakit Infeksi pada Anak

Manifestasi klinis penyakit infeksi pada anak umumnya cukup bervariasi tergantung pada jenis mikroorganisme penyebab infeksi, lokasi infeksi di dalam tubuh, dan kondisi imunitas anak tersebut. Meski demikian, sebagian besar penyakit infeksi pada anak menunjukkan beberapa tanda dan gejala umum yang cukup khas. Gejala klinis yang umum ditemukan pada anak dengan penyakit infeksi antara lain demam, yang merupakan tanda paling sering dan mudah dikenali oleh orang tua atau pengasuh. Demam merupakan bentuk respons tubuh terhadap masuknya mikroorganisme patogen dan pelepasan mediator inflamasi, yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme tersebut.

Selain demam, anak dengan penyakit infeksi juga sering menunjukkan gejala-gejala lain seperti kelemahan umum, rewel, gelisah, serta nafsu makan yang berkurang drastis. Penurunan nafsu makan ini sering disebabkan oleh rasa tidak nyaman akibat infeksi, nyeri tenggorokan, nyeri perut, atau mual dan muntah. Anak juga bisa mengalami dehidrasi terutama pada kondisi infeksi yang menyebabkan demam tinggi atau muntah serta diare terus-menerus. Dehidrasi biasanya ditandai dengan mulut dan bibir kering, mata cekung, kulit kering, dan penurunan frekuensi berkemih. Gejala lain yang bisa muncul meliputi batuk, pilek, sesak napas yang terutama dijumpai pada infeksi saluran pernapasan, nyeri saat berkemih pada infeksi saluran kemih, diare cair atau berlendir pada infeksi gastrointestinal, serta ruam kemerahan, gatal, atau luka pada infeksi kulit.

Pada kondisi infeksi yang lebih berat atau kompleks seperti infeksi sistem saraf pusat, gejala klinis yang muncul dapat lebih spesifik dan berat. Anak dengan meningitis atau ensefalitis misalnya, akan menunjukkan demam tinggi disertai sakit

kepala hebat, kaku kuduk (leher sulit atau nyeri bila digerakkan), muntah yang menyembur, penurunan kesadaran hingga kejang-kejang. Penting bagi tenaga kesehatan maupun keluarga untuk mengenali tanda bahaya dari manifestasi klinis ini dengan cepat agar intervensi medis segera dilakukan sebelum munculnya komplikasi yang lebih berat.

Dalam rangka menentukan diagnosis penyakit infeksi pada anak, selain melalui anamnesis mendalam dan pemeriksaan fisik secara cermat oleh tenaga kesehatan, sering kali dibutuhkan pemeriksaan penunjang sebagai alat bantu diagnosis yang lebih akurat. Pemeriksaan penunjang yang umum dilakukan dalam menegakkan diagnosis infeksi pada anak terdiri dari pemeriksaan laboratorium, kultur mikroorganisme, dan pemeriksaan radiologi.

Pemeriksaan laboratorium merupakan pemeriksaan awal yang umum dilakukan, termasuk hitung darah lengkap (HDL), yang bertujuan melihat jumlah leukosit (sel darah putih). Pada kasus infeksi bakteri, biasanya terjadi peningkatan jumlah leukosit yang dikenal sebagai leukositosis, khususnya peningkatan neutrofil. Sebaliknya, pada infeksi virus umumnya terjadi peningkatan limfosit. Pemeriksaan laboratorium lain yang sering dilakukan adalah pemeriksaan marker inflamasi seperti C-reactive protein (CRP) dan prokalsitonin, yang meningkat secara signifikan pada infeksi bakteri berat. Selain itu, pemeriksaan urine lengkap juga penting untuk mendeteksi infeksi saluran kemih dengan melihat adanya leukosit, eritrosit, atau bakteri dalam urine.

Pemeriksaan kultur merupakan metode diagnostik lanjutan yang sangat penting, terutama untuk mengidentifikasi secara spesifik mikroorganisme penyebab infeksi. Kultur dilakukan dengan mengambil spesimen seperti darah, urine, cairan serebrospinal, tinja, dahak, ataupun swab dari luka atau saluran tubuh yang mengalami infeksi. Pemeriksaan ini sangat bermanfaat dalam menentukan jenis mikroorganisme penyebab infeksi sekaligus sensitivitasnya terhadap antibiotik tertentu. Misalnya, kultur darah pada anak dengan demam tinggi yang tidak jelas penyebabnya (demam tanpa fokus), kultur urine pada anak dengan ISK, atau kultur cairan serebrospinal pada anak dengan dugaan meningitis. Hasil pemeriksaan kultur ini sangat membantu tenaga medis dalam menentukan terapi antibiotik atau antimikroba yang tepat dan spesifik terhadap mikroorganisme penyebab infeksi.

Selain pemeriksaan laboratorium dan kultur, pemeriksaan radiologi juga menjadi alat bantu diagnostik penting dalam beberapa kasus infeksi anak tertentu. Pemeriksaan radiologi yang paling sering digunakan adalah foto rontgen (X-ray). Pada infeksi saluran pernapasan akut, misalnya pneumonia atau bronkopneumonia, foto toraks sangat berguna untuk melihat adanya infiltrat atau konsolidasi paru yang menunjukkan proses inflamasi atau infeksi paru. Pada kasus infeksi saluran kemih

yang dicurigai telah melibatkan ginjal (pielonefritis), pemeriksaan ultrasonografi (USG) ginjal atau bahkan CT scan dapat diperlukan untuk memastikan ada tidaknya komplikasi pada organ ginjal atau saluran kemih atas lainnya. Sementara pada infeksi sistem saraf pusat, seperti ensefalitis atau abses otak, pemeriksaan CT scan atau MRI otak dapat digunakan untuk mendeteksi adanya lesi inflamasi, edema serebral, atau bahkan abses yang tidak dapat dinilai hanya melalui pemeriksaan klinis dan laboratorium saja.

Dengan demikian, diagnosis penyakit infeksi pada anak harus dilakukan secara komprehensif dengan menggabungkan hasil anamnesis yang teliti, pemeriksaan fisik yang cermat, serta didukung oleh pemeriksaan penunjang yang tepat dan relevan. Pendekatan diagnosis ini bertujuan untuk memastikan identifikasi dini terhadap mikroorganisme penyebab, menetapkan pengobatan yang efektif, serta mencegah terjadinya komplikasi yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak secara optimal. Pengetahuan ini juga menjadi dasar penting bagi perawat dalam memberikan edukasi kepada keluarga terkait pentingnya pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosis yang tepat sehingga pengobatan yang diberikan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan efisien dalam mengatasi penyakit infeksi pada anak-anak.

E. Asuhan Keperawatan Komprehensif pada Anak dengan Penyakit Infeksi

Asuhan keperawatan yang komprehensif bagi anak dengan penyakit infeksi merupakan pendekatan holistik dan menyeluruh yang bertujuan memastikan bahwa kebutuhan fisik, psikologis, emosional, serta sosial anak terpenuhi selama proses perawatan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan penting, mulai dari pengkajian keperawatan secara terfokus, penetapan diagnosis keperawatan yang tepat, penyusunan perencanaan serta intervensi yang berbasis bukti, hingga evaluasi keberhasilan dari asuhan yang diberikan.

Pengkajian keperawatan terfokus adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses asuhan keperawatan. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara jelas masalah-masalah utama yang dialami anak akibat penyakit infeksi. Dalam proses pengkajian terfokus, perawat secara aktif menggali informasi lengkap mengenai kondisi fisik anak seperti tanda-tanda vital (suhu tubuh, denyut nadi, frekuensi pernapasan, tekanan darah), tingkat kesadaran, kondisi hidrasi, pola makan, hingga pola eliminasi. Perawat juga perlu melakukan pengkajian nyeri secara detail, mengamati perilaku anak yang bisa mengindikasikan adanya rasa nyeri atau ketidaknyamanan. Selain itu, perawat juga mengkaji riwayat kesehatan anak sebelumnya, status imunisasi, pola nutrisi, serta lingkungan keluarga yang dapat berkontribusi pada munculnya infeksi. Pengkajian ini juga mencakup kondisi

psikologis anak dan keluarga, mengingat penyakit infeksi sering kali menimbulkan kecemasan tinggi pada keluarga.

Setelah pengkajian selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah merancang perencanaan dan intervensi keperawatan yang berbasis pada Evidence-Based Practice (EBP). Dalam konteks ini, EBP mengacu pada integrasi antara bukti penelitian terbaru yang relevan, keahlian klinis perawat, serta preferensi pasien dan keluarganya. Intervensi keperawatan berbasis EBP dalam perawatan penyakit infeksi anak, antara lain meliputi pemilihan teknik penatalaksanaan demam secara tepat, penggunaan teknik pengurangan nyeri yang sesuai, penatalaksanaan nutrisi dan hidrasi yang berdasarkan bukti, serta penerapan langkah-langkah pengendalian infeksi yang telah terbukti efektif. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi yang diberikan pada anak tidak hanya aman, tetapi juga efektif dan efisien dalam mempercepat proses penyembuhan serta mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut.

Manajemen nyeri dan demam pada anak dengan penyakit infeksi adalah aspek penting lain dari asuhan keperawatan. Demam adalah respons umum tubuh terhadap infeksi, tetapi bila tidak dikelola secara tepat, dapat menyebabkan ketidaknyamanan, dehidrasi, bahkan kejang demam terutama pada anak usia di bawah lima tahun. Oleh karena itu, perawat perlu secara aktif memantau suhu tubuh anak, memberikan antipiretik yang sesuai dengan dosis tepat berdasarkan rekomendasi klinis terkini, serta memastikan kondisi hidrasi anak terjaga. Di samping itu, pengelolaan nyeri harus dilakukan secara aktif, termasuk pengkajian nyeri menggunakan skala yang sesuai usia anak, penggunaan obat analgesik yang sesuai, serta teknik non-farmakologis seperti relaksasi, distraksi, dan sentuhan terapeutik untuk memberikan rasa nyaman pada anak. Intervensi ini tidak hanya membantu memperbaiki kondisi fisik anak, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologis anak dan keluarganya.

Selain pengelolaan nyeri dan demam, aspek nutrisi dan cairan merupakan elemen kunci dalam asuhan keperawatan komprehensif untuk anak yang mengalami infeksi. Infeksi yang disertai demam tinggi, diare, atau muntah dapat dengan cepat menyebabkan anak mengalami kehilangan cairan dan elektrolit. Oleh karena itu, perawat harus memastikan anak mendapatkan cairan yang cukup, baik melalui oral maupun intravena sesuai kondisi klinisnya. Pemantauan terhadap tanda-tanda dehidrasi perlu dilakukan secara berkala. Asupan nutrisi juga harus dipertahankan secara optimal dengan memberikan makanan yang mudah dicerna, bergizi tinggi, serta sesuai dengan preferensi dan kemampuan anak untuk mengonsumsi makanan tersebut. Dukungan nutrisi yang adekuat selama masa infeksi sangat penting untuk memastikan proses penyembuhan yang optimal dan mencegah komplikasi seperti

malnutrisi yang bisa memperlambat pemulihan serta memengaruhi tumbuh kembang anak secara jangka panjang.

Aspek terakhir yang tidak kalah pentingnya dalam asuhan keperawatan komprehensif ini adalah pencegahan dan pengendalian infeksi (infection control). Pencegahan infeksi dilakukan dengan prinsip-prinsip pengendalian infeksi yang ketat, baik di rumah maupun di fasilitas kesehatan. Perawat perlu menerapkan praktik standar seperti kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD), sterilisasi alat-alat medis, serta edukasi keluarga mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, isolasi atau tindakan pencegahan khusus seperti droplet precaution atau contact precaution harus dipatuhi secara ketat dalam kasus-kasus tertentu, misalnya pada anak yang mengalami infeksi menular seperti influenza, tuberkulosis, atau campak. Edukasi kepada keluarga tentang praktik higiene personal, pentingnya imunisasi, dan cara mengidentifikasi tanda-tanda awal infeksi juga merupakan bagian integral dari upaya pencegahan yang harus diberikan secara berkesinambungan oleh perawat.

Dengan menerapkan pendekatan asuhan keperawatan komprehensif ini, perawat tidak hanya membantu mempercepat proses penyembuhan fisik anak yang mengalami penyakit infeksi, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan emosional, psikologis, serta sosial anak dan keluarganya dapat terpenuhi secara optimal. Pendekatan ini juga meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, menurunkan angka komplikasi, serta meningkatkan kepuasan anak dan keluarganya terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan demikian, tujuan akhir dari asuhan keperawatan komprehensif ini adalah tercapainya kesembuhan yang menyeluruh, peningkatan kualitas hidup anak secara jangka panjang, dan tercapainya kondisi tumbuh kembang yang optimal.

F. Pendidikan Kesehatan pada Orang Tua dan Keluarga

Pendidikan kesehatan yang diberikan kepada orang tua dan keluarga merupakan bagian integral dan esensial dari asuhan keperawatan anak yang mengalami penyakit infeksi. Keluarga merupakan unit terkecil dalam komunitas yang memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan anak dan memastikan proses penyembuhan berjalan optimal. Oleh karena itu, sangat penting bagi tenaga keperawatan untuk memberikan edukasi secara komprehensif dan berkesinambungan, sehingga keluarga memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran yang cukup untuk mendukung kesembuhan anak serta mencegah penyakit infeksi berulang di kemudian hari.

Salah satu aspek penting dalam pendidikan kesehatan bagi keluarga adalah edukasi terkait pencegahan infeksi di lingkungan rumah dan sekolah. Rumah adalah

tempat utama anak berinteraksi, tumbuh, dan berkembang. Namun, bila kebersihan rumah tidak dijaga dengan baik, rumah juga dapat menjadi sumber infeksi yang membahayakan kesehatan anak. Perawat perlu memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya menciptakan lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Langkah-langkah sederhana namun efektif seperti mencuci tangan dengan sabun secara teratur, menjaga kebersihan alat makan, memastikan pengolahan makanan yang higienis, menjaga kebersihan lantai dan tempat tidur anak, serta pengelolaan limbah domestik dengan baik perlu dijelaskan secara rinci kepada keluarga. Orang tua juga perlu memahami bahwa kebersihan pribadi anak, termasuk mandi rutin, mencuci tangan sebelum makan dan setelah bermain, serta menjaga kebersihan mulut dan gigi adalah kebiasaan yang harus dibentuk sejak dini untuk mencegah infeksi.

Di sisi lain, lingkungan sekolah juga berpotensi menjadi tempat penularan penyakit infeksi antar-anak. Perawat perlu membekali keluarga dengan pengetahuan yang memadai tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, termasuk toilet, ruang kelas, kantin, dan area bermain. Keluarga dapat diadvokasi agar terlibat aktif dalam komunikasi dengan pihak sekolah untuk memastikan lingkungan belajar anak selalu bersih dan aman. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya imunisasi lengkap untuk anak harus terus ditekankan, karena imunisasi merupakan langkah perlindungan yang efektif terhadap penyakit infeksi yang berbahaya seperti campak, difteri, pertusis, influenza, hepatitis, hingga infeksi pneumokokus.

Selanjutnya, aspek penting lainnya dalam pendidikan kesehatan adalah penekanan terhadap kepatuhan terhadap pengobatan dan perawatan yang dilakukan di rumah. Kepatuhan dalam pemberian obat-obatan, seperti antibiotik atau obat lain yang diresepkan dokter, sangat menentukan keberhasilan terapi penyakit infeksi pada anak. Perawat perlu menjelaskan secara mendalam kepada orang tua mengenai pentingnya mematuhi jadwal pemberian obat, dosis yang tepat, serta durasi pengobatan yang harus diselesaikan. Misalnya, dalam penggunaan antibiotik, orang tua harus diberikan pemahaman bahwa penghentian pemberian obat secara prematur atau tidak sesuai petunjuk dokter dapat mengakibatkan resistensi bakteri dan memperburuk kondisi anak. Oleh karena itu, edukasi perawat harus mencakup demonstrasi bagaimana cara pemberian obat yang benar, penjelasan tentang efek samping yang mungkin terjadi, serta langkah-langkah penanganannya jika terjadi reaksi yang tidak diinginkan.

Selain pemberian obat, kepatuhan dalam perawatan sehari-hari juga perlu ditekankan. Orang tua harus mendapatkan edukasi yang jelas tentang cara menjaga nutrisi dan hidrasi yang baik selama masa sakit anak, mengenali tanda-tanda

dehidrasi, cara memberikan cairan tambahan di rumah, serta cara menjaga kenyamanan anak melalui berbagai teknik non-farmakologis seperti pemberian kompres hangat, teknik distraksi, atau pijatan lembut untuk mengurangi nyeri atau ketidaknyamanan yang dialami anak. Orang tua juga perlu diberi pemahaman bahwa kepatuhan terhadap perawatan yang benar dan teratur di rumah merupakan kunci utama untuk mempercepat proses penyembuhan dan mencegah komplikasi serius akibat penyakit infeksi.

Aspek berikutnya yang juga sangat penting untuk disampaikan dalam pendidikan kesehatan bagi orang tua dan keluarga adalah pengenalan tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai selama anak mengalami penyakit infeksi. Orang tua perlu diajarkan tentang bagaimana mengenali gejala yang dapat menjadi indikator bahwa kondisi anak semakin memburuk atau adanya komplikasi yang memerlukan penanganan segera oleh tenaga medis. Beberapa tanda bahaya penting yang harus dikenali oleh keluarga adalah demam tinggi yang tidak kunjung turun walaupun sudah diberikan obat, kejang atau penurunan kesadaran, muntah berulang, anak terlihat sangat lemah atau sulit dibangunkan, kesulitan bernapas, nyeri perut hebat, atau munculnya ruam atau pendarahan spontan. Dengan mengenali tanda-tanda tersebut sejak dini, keluarga dapat mengambil keputusan cepat untuk segera membawa anak kembali ke fasilitas kesehatan.

Selain mengenali tanda bahaya, keluarga juga harus memahami kapan harus kembali ke fasilitas kesehatan untuk evaluasi lebih lanjut, bahkan sebelum munculnya tanda bahaya sekalipun. Misalnya, jika setelah dua atau tiga hari pengobatan tidak terjadi perbaikan gejala atau anak semakin rewel dan tidak nyaman, keluarga harus segera berkonsultasi kembali dengan tenaga medis. Penjelasan yang jelas dan tegas tentang tanda bahaya serta pentingnya segera mencari pertolongan medis merupakan bagian edukasi yang tidak boleh terlewatkan dalam pendidikan kesehatan kepada keluarga.

Melalui pemberian edukasi kesehatan yang jelas, detail, dan tepat sasaran, perawat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua serta keluarga dalam mengelola penyakit infeksi pada anak. Keluarga yang memiliki tingkat pemahaman yang baik tentang pencegahan infeksi, kepatuhan pengobatan, serta pengenalan dini tanda bahaya, akan lebih percaya diri dalam merawat anak mereka di rumah. Edukasi ini juga menjadi investasi jangka panjang yang efektif dalam mencegah kejadian infeksi berulang, mengurangi angka komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup anak dan keluarganya secara keseluruhan.

G. Peran Perawat dalam Pencegahan dan Penanganan Komplikasi

Perawat memiliki peran sentral dan sangat penting dalam pencegahan serta penanganan komplikasi penyakit infeksi pada anak. Peran ini mencakup tanggung jawab profesional dalam melakukan pengkajian yang komprehensif, pemantauan secara ketat terhadap perkembangan klinis anak, hingga berperan aktif dalam pengambilan keputusan klinis bersama tim kesehatan lainnya. Peran yang dijalankan perawat bertujuan utama untuk mencegah komplikasi sejak dini serta menangani berbagai komplikasi akut maupun kronis secara cepat, tepat, dan efektif.

Salah satu peran penting perawat dalam konteks ini adalah melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya komplikasi pada anak yang sedang mengalami infeksi. Deteksi dini ini melibatkan pengamatan klinis yang cermat, termasuk pemantauan tanda-tanda vital secara berkala seperti suhu tubuh, denyut nadi, pernapasan, dan tekanan darah. Selain itu, perawat juga perlu secara rutin mengevaluasi kondisi umum anak seperti tingkat kesadaran, kemampuan makan dan minum, tingkat nyeri, serta tanda-tanda spesifik yang mungkin mengindikasikan perburukan kondisi, seperti munculnya sesak napas, kejang, nyeri yang semakin berat, atau adanya perubahan warna kulit seperti sianosis atau pucat yang menandakan masalah serius pada sirkulasi atau oksigenasi jaringan tubuh.

Deteksi dini komplikasi juga mencakup kemampuan perawat untuk mengidentifikasi tanda-tanda klinis tertentu yang mengarah pada komplikasi serius dari infeksi yang diderita. Sebagai contoh, pada anak dengan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), perawat perlu memperhatikan tanda-tanda awal komplikasi pneumonia atau gagal napas seperti napas cepat, retraksi dinding dada, atau bunyi tambahan ketika bernapas seperti wheezing atau ronki. Pada anak dengan diare akut, perawat harus aktif mengobservasi tanda-tanda dehidrasi seperti penurunan frekuensi berkemih, mulut kering, mata cekung, hingga penurunan kesadaran. Pengamatan yang jeli dan respons cepat dari perawat terhadap tanda-tanda ini sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius yang dapat membahayakan nyawa anak.

Ketika komplikasi infeksi telah terjadi, peran perawat kemudian berkembang ke arah manajemen komplikasi akut maupun kronis. Dalam menangani komplikasi akut, seperti syok septik akibat infeksi berat, gagal napas, atau dehidrasi berat, perawat harus mampu memberikan intervensi kegawatdaruratan yang efektif. Tindakan ini bisa mencakup pemberian oksigen tambahan untuk memastikan oksigenasi jaringan yang adekuat, pemasangan akses intravena untuk pemberian cairan secara cepat guna mengatasi syok atau dehidrasi, serta pemberian obat-obatan yang diresepkan dokter secara tepat waktu. Selain tindakan langsung

tersebut, perawat juga bertugas untuk memastikan bahwa seluruh intervensi medis dilaksanakan dengan benar sesuai standar klinis yang berlaku.

Dalam penanganan komplikasi kronis, perawat memiliki peran dalam memberikan edukasi dan dukungan berkelanjutan kepada keluarga mengenai bagaimana cara merawat anak yang memiliki dampak jangka panjang akibat infeksi. Contohnya, anak dengan komplikasi kronis dari meningitis atau ensefalitis mungkin mengalami gangguan neurologis seperti kejang berulang, gangguan perkembangan, atau disabilitas jangka panjang. Di sini perawat perlu mengajarkan keluarga cara memberikan perawatan sehari-hari, termasuk bagaimana mengelola pengobatan jangka panjang, mengenali tanda-tanda kekambuhan, serta strategi rehabilitasi fisik dan psikologis. Selain itu, perawat juga harus aktif dalam menghubungkan keluarga dengan komunitas pendukung dan sumber daya lainnya untuk membantu keluarga menghadapi tantangan dalam merawat anak dengan komplikasi kronis tersebut.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan komplikasi, peran perawat dalam kolaborasi interprofesional sangat krusial. Penyakit infeksi pada anak sering kali membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai profesional kesehatan, termasuk dokter spesialis anak, ahli gizi, fisioterapis, apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya. Perawat memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan komunikasi di antara anggota tim kesehatan ini, memastikan bahwa setiap anggota tim memahami kondisi klinis anak serta rencana penanganan yang disusun secara bersama-sama.

Dalam konteks kolaborasi interprofesional ini, perawat bertugas menyampaikan informasi klinis terbaru kepada tim, memberikan masukan mengenai kondisi anak berdasarkan pengkajian keperawatan yang komprehensif, serta mengadvokasi kebutuhan khusus anak dan keluarganya kepada anggota tim lainnya. Misalnya, perawat bisa berkolaborasi dengan ahli gizi dalam merancang pola makan yang tepat untuk anak yang mengalami malnutrisi akibat penyakit infeksi kronis, atau bekerja sama dengan fisioterapis dalam menyusun rencana rehabilitasi motorik untuk anak yang mengalami gangguan perkembangan akibat komplikasi neurologis. Selain itu, perawat juga terlibat aktif dalam diskusi tim untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang diberikan dan menyesuaikan pendekatan pengobatan sesuai perkembangan kondisi anak.

Dengan demikian, peran perawat dalam pencegahan dan penanganan komplikasi penyakit infeksi pada anak tidak terbatas pada intervensi langsung secara klinis saja, tetapi mencakup peran yang luas sebagai koordinator perawatan, pendidik keluarga, serta anggota tim interprofesional yang aktif. Peran ini menuntut perawat untuk memiliki pengetahuan klinis yang luas, keterampilan pengkajian dan

observasi yang tajam, serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Melalui pelaksanaan peran ini secara optimal, perawat dapat membantu mengurangi angka komplikasi, mempercepat pemulihan, meningkatkan kualitas hidup anak, serta memastikan bahwa perawatan yang diterima oleh anak dengan penyakit infeksi bersifat komprehensif, efektif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

H. Aspek Psikososial Anak dan Keluarga dalam Perawatan Penyakit Infeksi

Aspek psikososial merupakan salah satu elemen penting dalam asuhan keperawatan anak dengan penyakit infeksi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari tenaga keperawatan. Penyakit infeksi yang dialami anak tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial, baik terhadap anak itu sendiri maupun keluarganya. Situasi ini seringkali menimbulkan kecemasan, stres, ketakutan, hingga perasaan tidak berdaya yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan keperawatan yang digunakan dalam perawatan anak dengan infeksi tidak hanya fokus pada aspek klinis, tetapi juga harus memperhatikan aspek psikologis dan sosial secara holistik.

Pendekatan psikologis untuk mengurangi kecemasan anak yang sedang mengalami penyakit infeksi menjadi bagian penting dalam intervensi keperawatan. Anak yang sakit umumnya mengalami rasa takut dan kecemasan yang cukup tinggi, terutama ketika harus menjalani berbagai tindakan medis seperti pengambilan darah, pemasangan infus, atau pemberian obat yang tidak nyaman. Dalam situasi ini, perawat memiliki peran untuk menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan tenang agar anak merasa lebih relaks dan tidak takut terhadap prosedur medis yang dilakukan.

Strategi psikologis yang efektif meliputi penggunaan teknik distraksi seperti mengajak anak bermain, menceritakan cerita favoritnya, menggunakan mainan atau boneka yang disukai, atau bahkan memanfaatkan musik yang menyenangkan untuk mengalihkan perhatian anak dari rasa sakit atau ketidaknyamanan yang dirasakan. Perawat juga dapat menggunakan pendekatan komunikasi terapeutik yang sesuai usia anak dengan menggunakan bahasa sederhana dan jelas, memberikan informasi secara bertahap sebelum melakukan tindakan medis, serta memberikan pujian positif setelah anak berhasil menjalani prosedur. Teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, sentuhan terapeutik berupa pijatan ringan, serta memberikan kenyamanan melalui pelukan atau sentuhan tangan juga dapat secara signifikan membantu anak untuk mengatasi rasa cemas dan ketakutannya.

Selain pada anak, perhatian khusus terhadap dukungan emosional kepada keluarga juga merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam perawatan anak

dengan penyakit infeksi. Penyakit anak dapat menjadi sumber stres emosional dan psikologis yang besar bagi keluarga, terutama orang tua. Orang tua sering mengalami perasaan takut, cemas, kebingungan, serta ketidakberdayaan dalam menghadapi situasi penyakit anaknya, terlebih lagi jika kondisi anak memburuk atau membutuhkan perawatan jangka panjang. Dalam situasi ini, perawat perlu mengenali tanda-tanda stres yang dialami oleh keluarga, seperti sikap mudah marah, cemas berlebihan, kesulitan berkonsentrasi, atau bahkan perasaan sedih dan putus asa.

Dukungan emosional kepada keluarga dapat diberikan melalui pendekatan empati yang tulus, mendengarkan keluhan atau kekhawatiran keluarga secara aktif, serta memberikan informasi yang jelas dan realistis mengenai kondisi kesehatan anak. Perawat juga harus memberikan dorongan emosional agar keluarga tetap optimis, percaya diri, dan merasa didukung dalam perawatan anak. Menyediakan waktu khusus bagi keluarga untuk bertanya dan berdiskusi tentang kondisi anak, memberi kesempatan keluarga untuk mengungkapkan perasaan dan kekhawatirannya secara terbuka, serta memberikan afirmasi positif terhadap upaya keluarga dalam merawat anak, dapat memperkuat rasa percaya diri dan mengurangi beban emosional mereka. Dukungan emosional ini sangat penting karena keluarga yang merasa didukung akan lebih mampu menjalankan perannya secara optimal, sehingga proses pemulihan anak menjadi lebih lancar dan efektif.

Strategi komunikasi efektif antara perawat, anak, dan keluarga merupakan fondasi penting dalam keberhasilan asuhan keperawatan anak dengan penyakit infeksi. Komunikasi yang efektif tidak hanya terbatas pada pemberian informasi medis, tetapi juga mencakup interaksi interpersonal yang menciptakan hubungan saling percaya antara perawat dengan anak dan keluarganya. Perawat harus mampu menyesuaikan gaya komunikasinya dengan tingkat perkembangan kognitif dan emosional anak serta karakteristik keluarga. Ketika berkomunikasi dengan anak, perawat harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, lembut, dan penuh perhatian, sehingga anak merasa aman, dihargai, dan nyaman.

Dalam berkomunikasi dengan keluarga, perawat harus menggunakan pendekatan yang terbuka, jujur, jelas, dan konsisten. Perawat perlu memastikan bahwa keluarga benar-benar memahami kondisi kesehatan anaknya, jenis pengobatan yang diberikan, tujuan perawatan, serta risiko atau kemungkinan komplikasi yang dapat muncul. Komunikasi harus bersifat dua arah, di mana perawat juga memberikan kesempatan kepada keluarga untuk bertanya, mengungkapkan pendapat, atau menyampaikan kekhawatiran mereka. Perawat juga harus aktif memberikan umpan balik positif serta dukungan emosional, agar keluarga merasa nyaman dan percaya terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan.

Dalam konteks komunikasi efektif ini, penggunaan pendekatan family-centered care (FCC) menjadi strategi penting yang harus diterapkan oleh perawat. Pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai bagian integral dari tim perawatan, sehingga keluarga merasa dihargai dan didengarkan. Perawat harus secara aktif melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perawatan anak, termasuk dalam perencanaan intervensi dan evaluasi keberhasilannya. Dengan keterlibatan aktif ini, keluarga akan lebih memahami kondisi anak secara mendalam, sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan perawatan yang sesuai di rumah.

Secara keseluruhan, aspek psikososial dalam perawatan penyakit infeksi pada anak menuntut perawat memiliki kepekaan emosional, keterampilan komunikasi yang efektif, serta kemampuan memberikan dukungan psikologis yang mendalam kepada anak dan keluarganya. Melalui penerapan pendekatan psikologis yang tepat untuk mengurangi kecemasan anak, dukungan emosional yang tulus terhadap keluarga, serta strategi komunikasi efektif yang melibatkan semua pihak, perawat dapat menciptakan lingkungan perawatan yang holistik dan humanis. Dengan cara ini, tidak hanya pemulihan fisik anak yang dapat tercapai, tetapi juga kesejahteraan emosional dan psikologis anak serta keluarga dapat terjamin, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.

I. Teknologi dan Inovasi Terkini dalam Penanganan Penyakit Infeksi Anak

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, penggunaan teknologi serta inovasi terbaru dalam perawatan anak dengan penyakit infeksi telah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari praktik keperawatan modern. Penerapan berbagai inovasi teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, mempermudah akses pelayanan bagi keluarga dan pasien, serta mendukung upaya pencegahan maupun pengelolaan penyakit secara lebih efisien.

Salah satu inovasi yang sangat signifikan dalam perawatan anak dengan penyakit infeksi adalah penerapan konsep telehealth. Telehealth, atau yang juga dikenal sebagai telemedisin, merupakan sebuah pendekatan pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan konsultasi, pengkajian, edukasi, dan intervensi secara jarak jauh. Dalam perawatan penyakit infeksi pada anak, telehealth memungkinkan perawat maupun tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan konsultasi klinis dan edukasi secara virtual dengan orang tua serta keluarga anak yang sedang sakit, tanpa harus bertatap muka langsung.

Penerapan telehealth ini sangat bermanfaat terutama dalam situasi di mana akses ke fasilitas kesehatan terbatas, seperti pada keluarga yang tinggal di daerah terpencil, pulau-pulau kecil, atau wilayah dengan keterbatasan tenaga kesehatan. Dalam situasi pandemi global, seperti COVID-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir, telehealth menjadi pilihan yang strategis untuk mengurangi risiko penularan infeksi di fasilitas kesehatan. Melalui telehealth, keluarga dapat secara cepat mendapatkan informasi akurat tentang gejala penyakit infeksi yang dialami anak, arahan untuk pertolongan pertama di rumah, serta kapan harus segera membawa anak ke fasilitas kesehatan. Telehealth juga memfasilitasi pemantauan kondisi anak secara berkala, seperti monitoring suhu tubuh, pola pernapasan, pola makan, tingkat hidrasi, hingga perkembangan kondisi klinisnya secara real-time.

Selain telehealth, pemanfaatan teknologi digital dalam edukasi kesehatan kepada keluarga dan komunitas juga menjadi inovasi yang sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat terhadap penyakit infeksi pada anak. Teknologi digital yang digunakan mencakup berbagai aplikasi smartphone, website interaktif, media sosial, hingga platform berbasis video yang menyediakan konten edukasi yang informatif dan menarik bagi orang tua, keluarga, maupun tenaga kesehatan.

Melalui aplikasi digital yang berbasis smartphone, misalnya, keluarga dapat mengakses berbagai informasi yang lengkap tentang penyakit infeksi yang sering dialami anak, seperti ISPA, diare akut, infeksi kulit, maupun infeksi serius seperti meningitis. Informasi yang tersedia biasanya mencakup tanda dan gejala awal infeksi, langkah-langkah pertolongan pertama, teknik pencegahan penularan, serta informasi tentang kapan keluarga perlu membawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat. Beberapa aplikasi juga menyediakan fitur interaktif berupa konsultasi virtual atau fitur chat dengan tenaga kesehatan profesional, yang memungkinkan keluarga untuk bertanya secara langsung dan mendapatkan jawaban secara cepat serta akurat.

Di samping aplikasi smartphone, edukasi kesehatan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, maupun TikTok juga semakin populer dan terbukti efektif dalam menyampaikan pesan kesehatan secara luas kepada masyarakat. Media sosial memungkinkan tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya untuk menyampaikan edukasi kesehatan dalam format yang lebih sederhana, mudah dipahami, serta menarik bagi keluarga dan komunitas secara luas. Melalui media sosial, tenaga kesehatan dapat secara aktif membagikan informasi terkini tentang cara menjaga kesehatan anak, pentingnya imunisasi, menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan, serta cara-cara praktis mengatasi masalah kesehatan sehari-hari di rumah.

Penggunaan video edukasi atau webinar berbasis teknologi digital juga memberikan dampak positif dalam peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit infeksi anak. Webinar atau video edukasi memungkinkan keluarga untuk memperoleh informasi langsung dari para pakar atau tenaga kesehatan berpengalaman, dengan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung melalui sesi tanya jawab. Konten-konten digital seperti video tutorial cara mencuci tangan yang benar, cara pemberian obat kepada anak, cara mengukur suhu tubuh anak, atau teknik relaksasi untuk mengurangi rasa cemas pada anak yang sakit, adalah beberapa contoh konten edukasi yang sangat membantu keluarga dalam memberikan perawatan yang lebih baik di rumah.

Secara keseluruhan, penggunaan teknologi digital dalam edukasi kesehatan tidak hanya meningkatkan pengetahuan keluarga tentang penyakit infeksi pada anak, tetapi juga memperkuat kesadaran mereka terhadap pentingnya menjaga kesehatan anak secara menyeluruh. Pemanfaatan teknologi ini membantu keluarga untuk lebih mandiri, percaya diri, serta mampu mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi masalah kesehatan anak mereka.

Dengan demikian, integrasi teknologi dan inovasi terkini dalam perawatan anak dengan penyakit infeksi membawa manfaat yang besar bagi keluarga, tenaga keperawatan, maupun sistem pelayanan kesehatan secara luas. Telehealth memberikan solusi praktis dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan secara cepat, mudah, dan efisien, sementara pemanfaatan teknologi digital dalam edukasi kesehatan membantu menciptakan komunitas yang lebih sehat, sadar, dan mampu mengambil tindakan pencegahan secara mandiri. Oleh karena itu, tenaga keperawatan perlu terus meningkatkan kemampuan serta keterampilan dalam penggunaan teknologi ini, sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, inovatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa depan.

J. Tantangan, Tren, dan Rekomendasi Masa Depan dalam Keperawatan Anak dengan Penyakit Infeksi

Keperawatan anak dengan penyakit infeksi terus mengalami perkembangan signifikan seiring dengan berbagai tantangan baru yang muncul di lapangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam praktik keperawatan penyakit infeksi anak adalah meningkatnya resistensi antimikroba, khususnya antibiotik. Fenomena ini terjadi akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan berlebihan di berbagai tingkat pelayanan kesehatan, baik primer maupun sekunder. Resistensi ini menyebabkan berbagai infeksi yang sebelumnya mudah ditangani kini semakin sulit diatasi, memerlukan pendekatan yang lebih kompleks, serta meningkatkan risiko

komplikasi serius pada anak. Selain resistensi antibiotik, tenaga keperawatan juga menghadapi tantangan berupa kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pencegahan infeksi melalui praktik higiene personal dan lingkungan yang optimal, rendahnya kepatuhan terhadap imunisasi, serta terbatasnya akses pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan atau terpencil.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya tenaga keperawatan yang terampil dalam penanganan khusus penyakit infeksi pada anak, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan jumlah tenaga perawat yang terlatih khusus dalam bidang infeksi anak menyebabkan tingginya beban kerja, menurunnya kualitas pelayanan, serta meningkatnya potensi kesalahan dalam memberikan perawatan yang tepat dan sesuai standar. Selain itu, perawat juga sering menghadapi kendala komunikasi dan edukasi kepada keluarga akibat perbedaan latar belakang sosial-budaya, tingkat pendidikan yang rendah, serta masih kuatnya kepercayaan tradisional yang bertentangan dengan praktik medis modern. Tantangan ini menuntut perawat untuk mampu menerapkan pendekatan komunikasi yang lebih sensitif secara budaya agar edukasi kesehatan dapat diterima dengan baik oleh keluarga dan masyarakat luas.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, tren penelitian terkini di bidang penyakit infeksi pada anak menunjukkan perkembangan positif yang menjanjikan. Penelitian terbaru saat ini banyak diarahkan pada pengembangan metode diagnostik cepat dan akurat berbasis molekuler yang mampu mendeteksi jenis mikroorganisme penyebab infeksi dalam waktu singkat, sehingga pengobatan yang lebih spesifik dan tepat sasaran dapat segera diberikan. Tren lain dalam penelitian adalah kajian mendalam mengenai pengendalian infeksi berbasis bukti (*evidence-based infection control*), khususnya di lingkungan rumah sakit maupun komunitas. Penelitian ini menghasilkan berbagai rekomendasi praktik klinis terbaru yang efektif dalam mengurangi angka infeksi nosokomial maupun infeksi berbasis komunitas yang banyak dialami oleh anak-anak.

Lebih lanjut, perkembangan signifikan juga terjadi dalam penggunaan teknologi informasi, khususnya *telehealth* dan aplikasi kesehatan digital dalam pengelolaan penyakit infeksi anak. Tren ini semakin populer karena terbukti efektif dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan secara luas, mempercepat respon terhadap gejala awal infeksi, serta meningkatkan keterlibatan keluarga dalam proses perawatan di rumah. Penelitian terbaru juga menyoroti pentingnya pendekatan psikososial dalam manajemen penyakit infeksi anak, yang menekankan pentingnya aspek dukungan emosional, edukasi keluarga, serta komunikasi efektif sebagai bagian integral dalam perawatan anak secara menyeluruh.

Berdasarkan berbagai tantangan dan tren penelitian terkini tersebut, beberapa rekomendasi penting dapat diajukan untuk praktisi maupun peneliti dalam bidang keperawatan anak dengan penyakit infeksi. Bagi praktisi, rekomendasi utamanya adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi profesional melalui pelatihan khusus mengenai penyakit infeksi anak, penggunaan antibiotik secara rasional, serta keterampilan dalam pengendalian infeksi berbasis bukti. Praktisi keperawatan juga perlu meningkatkan kemampuan komunikasi terapeutik yang efektif, terutama dalam mengatasi tantangan edukasi pada keluarga yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan sosial ekonomi yang berbeda.

Selain itu, praktisi di bidang keperawatan anak disarankan untuk terus memperkuat kolaborasi interprofesional dengan dokter, apoteker, ahli gizi, psikolog, serta profesional kesehatan lainnya dalam memberikan perawatan yang komprehensif dan terintegrasi bagi anak yang mengalami infeksi. Kolaborasi ini akan memperkaya kualitas pelayanan kesehatan, mempercepat proses pemulihan, serta secara nyata mengurangi risiko komplikasi jangka panjang akibat penyakit infeksi pada anak-anak.

Untuk peneliti di bidang keperawatan anak, rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya fokus penelitian pada evaluasi efektivitas intervensi keperawatan berbasis *evidence-based practice* (EBP), khususnya yang terkait dengan pengendalian infeksi, manajemen nyeri dan demam, serta edukasi kesehatan yang efektif di tingkat komunitas. Peneliti juga perlu mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak psikososial penyakit infeksi terhadap anak dan keluarga, sehingga strategi intervensi psikologis dan emosional yang efektif dapat terus dikembangkan dan diterapkan secara luas dalam praktik klinis.

Selain itu, penting bagi peneliti untuk lebih intensif mengkaji penggunaan teknologi digital dan *telehealth* dalam perawatan anak dengan infeksi, termasuk dalam hal aksesibilitas, efektivitas, serta kepuasan pengguna. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data serta rekomendasi yang jelas tentang bagaimana teknologi ini dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak di masa depan.

Dengan mengadopsi rekomendasi tersebut, tenaga keperawatan maupun peneliti dalam bidang penyakit infeksi pada anak akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada, sekaligus memanfaatkan tren positif yang berkembang saat ini. Upaya ini pada akhirnya akan menghasilkan perawatan anak dengan penyakit infeksi yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas tinggi, yang tidak hanya berorientasi pada kesembuhan fisik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan psikososial anak dan keluarganya secara menyeluruh.

K. Simpulan

Penyakit infeksi pada anak merupakan tantangan kesehatan penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pelayanan keperawatan anak. Karakteristik unik pada anak-anak, khususnya bayi dan balita yang memiliki sistem imunitas yang belum matang sepenuhnya, menyebabkan mereka menjadi kelompok yang rentan mengalami berbagai jenis penyakit infeksi, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare akut, infeksi saluran kemih (ISK), infeksi kulit, hingga infeksi serius pada sistem saraf pusat seperti meningitis dan ensefalitis. Penyakit infeksi ini tidak hanya berdampak negatif pada kondisi fisik anak, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi tumbuh kembang mereka, baik dalam aspek fisik, psikologis, emosional, maupun sosial.

Patofisiologi penyakit infeksi pada anak mencakup serangkaian mekanisme kompleks yang diawali oleh invasi mikroorganisme patogen ke dalam tubuh anak, kemudian memicu respon inflamasi tubuh yang intens dan berdampak pada berbagai manifestasi klinis. Dalam praktik klinis sehari-hari, tenaga keperawatan harus mampu mengenali tanda dan gejala umum penyakit infeksi serta memahami berbagai metode pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, kultur mikrobiologi, dan radiologi, guna menegakkan diagnosis yang cepat dan akurat. Diagnosa dini sangat penting dalam mencegah komplikasi serius yang dapat mengancam jiwa anak.

Perawat memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan keperawatan komprehensif yang meliputi pengkajian secara terfokus, perencanaan intervensi berbasis evidence-based practice (EBP), manajemen nyeri dan demam, pemeliharaan nutrisi dan cairan yang optimal, serta penerapan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi secara konsisten. Selain intervensi klinis tersebut, perawat juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kesehatan yang intensif kepada orang tua dan keluarga, meliputi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pengenalan tanda-tanda bahaya yang memerlukan penanganan medis segera.

Aspek psikososial menjadi perhatian penting dalam perawatan penyakit infeksi pada anak, karena dampak emosional dan psikologis penyakit ini sering kali dirasakan tidak hanya oleh anak yang sakit, tetapi juga keluarganya. Oleh karena itu, pendekatan psikologis yang efektif untuk mengurangi kecemasan pada anak, pemberian dukungan emosional yang tulus kepada keluarga, serta penggunaan komunikasi terapeutik yang efektif merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa perawatan yang diberikan bersifat holistik dan menyeluruh.

Dalam era kemajuan teknologi saat ini, pemanfaatan telehealth serta berbagai inovasi teknologi digital dalam edukasi kesehatan menjadi tren positif yang semakin berkembang. Teknologi ini memungkinkan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas, cepat, dan efisien, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga dalam mengelola serta mencegah penyakit infeksi pada anak. Tren penelitian terkini juga mengarah pada upaya untuk menghadapi tantangan besar seperti resistensi antimikroba, rendahnya kepatuhan imunisasi, dan keterbatasan akses pelayanan di daerah terpencil, dengan mengembangkan pendekatan interprofesional, metode diagnostik molekuler yang cepat, serta penerapan pengendalian infeksi berbasis bukti.

Ke depan, tenaga keperawatan maupun peneliti di bidang keperawatan anak dengan penyakit infeksi disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi klinisnya, memperkuat kolaborasi interprofesional, serta aktif melakukan penelitian lanjutan guna mengembangkan praktik terbaik yang inovatif dan efektif. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pelayanan keperawatan anak dengan penyakit infeksi dapat mencapai hasil yang optimal, tidak hanya dalam pemulihan fisik, tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarganya secara holistik dan berkelanjutan.

L. Referensi

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2023). Jumlah kasus penyakit menurut jenis penyakit. BPS Sumatera Selatan. Diakses dari <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzY4IzI%3D/jumlah-kasus-penyakit-menurut-jenis-penyakit.html>
- Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI. (2012). Pedoman pengendalian infeksi saluran pernapasan akut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.slideshare.net/slideshow/pedoman-pengendalian-ispa/50492855>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil kesehatan Indonesia 2023. Kementerian Kesehatan RI. Diakses dari https://kemkes.go.id/app_asset/file_content_download/172231123666a86244b83fd8.51637104.pdf
- Kodjebacheva, G., Culinski, S., Kawser, S., & Amin, S. (2023). Satisfaction with pediatric telehealth according to the opinions of children and adolescents. *International Journal of Telemedicine and Applications*, 2023, Article ID 10118045. <https://doi.org/10.1155/2023/10118045>
- Maghribi Sembiring, M. N. (2023). Nursing telehealth: sistem informatika keperawatan [Systematic literature review]. *Jurnal Keperawatan*, 17(1). Diakses dari

https://www.researchgate.net/publication/376278486_NURSING_TELEHEALTH_SISTEM_INFORMATIKA_KEPERAWATAN_SYSTEMATIC_LITERATURE_REVIEW_SYSTEMATIC_LITERATURE_REVIEW/fulltext/6571b9136610947889a6bf55/NURSING-TELEHEALTH-SISTEM-INFORMATIKA-KEPERAWATAN-SYSTEMATIC-LITERATURE-REVIEW-SYSTEMATIC-LITERATURE-REVIEW.pdf

Undang-undang Tentenanagan Telenursing Integrated Application-Based Home Care Services. (2021). Telenursing integrated application-based home care services as telehealth innovation for pediatric nursing. JKPBK Journal, 3(5), 68–79. Diakses dari <https://ocs.unmul.ac.id/index.php/JKPBK/article/viewFile/6849/3929>

M. Glosarium

Penyakit Infeksi

Kondisi medis yang disebabkan oleh masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh, seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit, yang kemudian menyebabkan reaksi tubuh berupa peradangan dengan gejala klinis tertentu.

ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut)

Infeksi yang menyerang saluran pernapasan atas atau bawah, disebabkan oleh virus atau bakteri, dengan gejala seperti demam, batuk, pilek, hingga sesak napas.

Diare Akut

Gangguan kesehatan berupa peningkatan frekuensi buang air besar dengan konsistensi tinja cair atau encer, biasanya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau parasit melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi.

Infeksi Saluran Kemih (ISK)

Infeksi pada sistem kemih seperti ginjal, kandung kemih, ureter, atau uretra, biasanya disebabkan oleh bakteri, dengan gejala berupa nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil, demam, dan perubahan pada warna urine.

Patofisiologi

Studi tentang proses perubahan fisiologis yang terjadi dalam tubuh akibat suatu penyakit atau kondisi medis tertentu.

Respon Inflamasi

Mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi atau cedera jaringan, ditandai dengan pelebaran pembuluh darah, peningkatan permeabilitas kapiler, serta migrasi sel-sel imun ke lokasi infeksi, yang ditunjukkan dengan gejala klinis seperti demam, kemerahan, nyeri, dan pembengkakan.

Manifestasi Klinis

Kumpulan tanda dan gejala yang muncul akibat suatu penyakit atau gangguan kesehatan tertentu, yang menjadi dasar dalam proses diagnosis medis dan keperawatan.

Evidence-Based Practice (EBP)

Pendekatan dalam praktik klinis yang mengintegrasikan bukti penelitian terkini, keahlian klinis profesional, serta preferensi pasien dalam proses pengambilan keputusan perawatan kesehatan.

Family-Centered Care (FCC)

Pendekatan perawatan kesehatan yang melibatkan keluarga sebagai bagian integral dalam tim perawatan, menghargai peran serta masukan keluarga dalam proses pengambilan keputusan klinis demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien.

Telehealth

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan konsultasi kesehatan, edukasi, serta intervensi medis atau keperawatan secara jarak jauh, memungkinkan akses kesehatan yang lebih luas dan efisien.

CHAPTER 6

KEPERAWATAN ANAK DENGAN GANGGUAN NEUROLOGIS

Nur Sophia Matin, S.Keb., Bd., M.Keb.

A. Pendahuluan

Anak-anak merupakan kelompok usia yang sangat rentan terhadap infeksi, baik karena sistem imun yang belum matang maupun karena pola interaksi sosial dan lingkungan yang mendukung penyebaran penyakit. Infeksi seperti demam berdarah dengue (DBD), campak (measles), dan cacar air (varisela) masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia, dengan prevalensi yang tinggi dan angka komplikasi yang cukup signifikan terutama pada kelompok usia di bawah 5 tahun (Kementrian Kesehatan, 2024).

Salah satu tantangan dalam keperawatan anak dengan penyakit infeksi adalah potensi komplikasi neurologis, seperti ensefalitis, kejang demam kompleks, dan ensefalopati yang sering kali muncul sekunder akibat infeksi sistemik. Misalnya, studi terbaru menunjukkan bahwa pada kasus DBD berat, risiko gangguan sistem saraf pusat meningkat akibat kebocoran plasma, hipoperfusi otak, dan edema serebral (Puspitasari, 2024). Sementara itu, pada campak dan cacar air, komplikasi seperti ensefalitis virus dan ataksia serebelar akut juga dapat mengancam keselamatan jiwa jika tidak dikenali dan ditangani segera (Dewanto et al., 2009).

Dalam konteks pelayanan kesehatan, perawat anak berperan penting tidak hanya dalam pemberian terapi suportif dan pemantauan klinis, tetapi juga dalam pengkajian dini status neurologis, intervensi keperawatan darurat, serta edukasi keluarga untuk pencegahan jangka panjang. Pendekatan yang digunakan perlu berbasis *evidence-based practice* (EBP), yang mengintegrasikan hasil penelitian terkini, pengalaman klinis, serta nilai-nilai dan preferensi keluarga pasien.

EBP dalam keperawatan infeksi anak telah terbukti dapat menurunkan angka morbiditas dan mencegah komplikasi neurologis jika intervensi dilakukan secara cepat dan tepat (Yansouni et al., 2013). Misalnya, pendekatan pengkajian cepat menggunakan sistem ABCDE (*Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure*) memungkinkan perawat mendeteksi dini gangguan perfusi otak atau tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Selain itu, edukasi mengenai imunisasi dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan strategi preventif utama untuk menghindari infeksi primer yang berpotensi berkembang menjadi kasus berat.

Sayangnya, literatur menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen keperawatan berbasis bukti di banyak fasilitas kesehatan di Indonesia masih belum optimal. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan terpadu bagi perawat anak mengenai isolasi infeksi, manajemen komplikasi neurologis, dan pendekatan keluarga (Putra & Dewi, 2023). Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini akan berfokus pada konsep manajemen keperawatan infeksi anak secara komprehensif, khususnya yang dapat menimbulkan gangguan neurologis, dengan menekankan prinsip EBP sebagai landasan praktik klinis yang aman dan efektif.

B. Prinsip Dasar Pengelolaan Penyakit Infeksi pada Anak (Demam Berdarah, Campak, Cacar Air)

1. Pendahuluan Umum

Penyakit infeksi masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak di Indonesia. Beberapa penyakit yang umum dijumpai dan berisiko menyebabkan gangguan neurologis sekunder adalah demam berdarah dengue (DBD), campak (measles), dan cacar air (varisela). Ketiganya memiliki manifestasi klinis yang bervariasi, namun dalam kasus berat dapat menimbulkan komplikasi serius seperti ensefalitis, ensefalopati, kejang demam kompleks, dan gangguan fungsi otak lainnya (Widyastuti & Yamin, 2023; Alif et al., 2021).

Dalam konteks keperawatan anak, pemahaman tentang karakteristik tiap penyakit, identifikasi dini tanda bahaya, dan pengelolaan berbasis bukti (evidence-based practice) sangat diperlukan untuk mencegah perburukan klinis dan komplikasi neurologis yang mengancam jiwa (Maharani & Sutisna, 2022).

2. Demam Berdarah Dengue (DBD)

a. Etiologi dan Patofisiologi

Penyakit infeksi masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak di Indonesia. Beberapa penyakit yang umum dijumpai dan berisiko menyebabkan gangguan neurologis sekunder adalah demam berdarah dengue (DBD), campak (measles), dan cacar air (varisela). Ketiganya memiliki manifestasi klinis yang bervariasi, namun dalam kasus berat dapat menimbulkan komplikasi serius seperti ensefalitis, ensefalopati, kejang demam kompleks, dan gangguan fungsi otak lainnya (Widyastuti & Yamin, 2023; Alif et al., 2021).

Dalam konteks keperawatan anak, pemahaman tentang karakteristik tiap penyakit, identifikasi dini tanda bahaya, dan pengelolaan berbasis bukti (evidence-based practice) sangat diperlukan untuk mencegah perburukan klinis dan komplikasi neurologis yang mengancam jiwa (Maharani & Sutisna, 2022).

b. Manifestasi Klinis

- 1) Demam tinggi mendadak
- 2) Nyeri kepala, mialgia, dan retro-orbital pain
- 3) Tanda perdarahan (petechiae, epistaksis, hematemesis)
- 4) Penurunan kesadaran, kejang

c. Komplikasi Neurologis

- 1) Ensefalopati (akibat hipoksia, hipoglikemia, edema serebral)
- 2) Kejang
- 3) Delirium dan agitasi pada fase pemulihan

d. Prinsip Manajemen Keperawatan

- 1) Pemantauan cairan ketat (input/output)
- 2) Pemberian cairan rehidrasi IV sesuai pedoman WHO
- 3) Pemantauan GCS dan tanda vital tiap 2 jam selama fase kritis
- 4) Edukasi keluarga tentang tanda bahaya: perdarahan, muntah terus-menerus, letargi, perubahan kesadaran

3. Campak (Measles)

a. Etiologi dan Patofisiologi

Campak adalah penyakit yang sangat menular akibat virus RNA dari genus *Morbillivirus*. Penularan terjadi melalui droplet dan udara. Masa inkubasi sekitar 7–14 hari.

Virus dapat menyebar ke sistem saraf pusat dan menyebabkan ensefalitis akut atau SSPE (subacute sclerosing panencephalitis) sebagai komplikasi jangka panjang.

b. Manifestasi Klinis

- 1) Demam tinggi > 38.5°C
- 2) Batuk, pilek, konjungtivitis
- 3) Bercak Koplik di mukosa mulut
- 4) Ruam makulopapular menyebar dari wajah ke ekstremitas

c. Komplikasi Neurologis

- 1) Ensefalitis akut (dalam 1 minggu setelah ruam): 1:1.000 kasus
- 2) SSPE (bulan hingga tahun setelah infeksi): degenerasi neurologis progresif

d. Prinsip Manajemen Keperawatan

- 1) Isolasi airborne hingga 4 hari pasca ruam
- 2) Pemberian vitamin A untuk mencegah komplikasi (dosis sesuai usia)
- 3) Pengamatan neurologis berkala
- 4) Kolaborasi dengan tim medis untuk deteksi ensefalitis dini
- 5) Imunisasi pencegahan (vaksin MR)

4. Cacar Air (Varisela)

a. Etiologi dan Patofisiologi

Cacar air disebabkan oleh virus varicella-zoster dan ditularkan melalui droplet dan kontak langsung. Anak-anak yang imunokompromais atau terinfeksi saat usia dini berisiko komplikasi berat.

b. Manifestasi Klinis

- 1) Demam ringan hingga sedang
- 2) Ruam vesikular multipel yang menyebar secara sentrifugal
- 3) Gatal berat
- 4) Vesikel berisi cairan jernih yang kemudian mengering

c. Komplikasi Neurologis

- 1) Ataksia serebelar akut (2 minggu setelah infeksi)
- 2) Neuritis optik, meningitis aseptik
- 3) Kejang demam atau kejang kompleks pada bayi

d. Prinsip Manajemen Keperawatan

- 1) Observasi ketat terhadap anak dengan gejala neurologis pascainfeksi
- 2) Pencegahan infeksi sekunder kulit
- 3) Kolaborasi pemberian antivirus (acyclovir) untuk kasus sedang–berat
- 4) Pengelolaan antipiretik dan hidrasi
- 5) Isolasi anak hingga seluruh lesi vesikel kering

5. Kesimpulan Subtopik

Pengelolaan infeksi pada anak harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh. Selain terapi suportif dan farmakologis, pengkajian status neurologis anak secara berkala merupakan bagian integral dari praktik keperawatan anak yang berbasis bukti. Pengetahuan klinis yang memadai akan memperkuat kemampuan perawat dalam mengantisipasi komplikasi neurologis, terutama pada masa krisis penyakit infeksi sistemik.

C. Teknik Pengkajian Cepat dan Intervensi Keperawatan Efektif pada Anak dengan Penyakit Infeksi Akut

Penatalaksanaan penyakit infeksi akut pada anak memerlukan respons cepat dan tepat, mengingat anak dapat mengalami perburukan kondisi klinis secara mendadak. Dalam kasus infeksi seperti demam berdarah, campak, atau cacar air, kondisi dapat memburuk menjadi syok, kejang, atau bahkan koma apabila tanda bahaya tidak dikenali sejak dini. Oleh karena itu, pengkajian awal yang cepat, sistematis, dan komprehensif merupakan landasan utama dari tindakan keperawatan berbasis bukti (Maharani & Sutisna, 2022; Rahman & Suharti, 2022).

1. Prinsip Pengkajian Cepat pada Anak dengan Infeksi

a. Sistem Pendekatan ABCDE

Teknik ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure) sangat direkomendasikan dalam pengkajian awal anak sakit berat, termasuk anak dengan infeksi akut.

Tabel 6.1
Teknik ABCDE

Komponen	Tujuan	Indikator Klinis
Airway	Pastikan jalan napas paten	Suara napas normal, tidak ada retraksi
Breathing	Evaluasi kerja napas dan oksigenasi	Frekuensi napas, retraksi, SpO ₂
Circulation	Tanda perfusi dan status sirkulasi	CRT, warna kulit, nadi, tekanan darah
Disability	Fungsi neurologis	AVPU, GCS, kejang, pupil
Exposure	Identifikasi ruam, suhu, tanda infeksi	Demam, vesikel, petekie, sianosis

Pendekatan ini efektif untuk mengenali keadaan syok hipovolemik (misalnya pada DBD), penurunan kesadaran (ensefalitis campak), maupun ruam infeksius (varisela) (Widyastuti & Yamin, 2023).

b. Skala Neurologis Pediatrik

Penilaian neurologis anak harus mempertimbangkan usia. Tiga pendekatan umum:

1) AVPU Scale (Alert, Verbal, Pain, Unresponsive)

Untuk skrining cepat tingkat kesadaran.

2) Pediatric Glasgow Coma Scale (GCS Anak)

a) Bayi (respon motorik: gerakan spontan, menjulurkan tangan)

b) Anak ≥ 2 tahun (respon verbal sesuai usia, respons motorik terarah)

3) Tanda neurologis lain yang harus dikaji:

a) Kejang: onset, durasi, tipe

b) Pupil: simetris, refleks cahaya

c) Postur: dekortikasi/dekerabrasi

d) Tanda iritasi meningeal: kaku kuduk, muntah proyektil

2. Intervensi Keperawatan Efektif dan Berdasarkan Bukti

Setelah pengkajian awal, tindakan keperawatan harus dilakukan berdasarkan prioritas kondisi anak, stabilitas hemodinamik, dan kemungkinan keterlibatan neurologis.

a. Intervensi Umum

- 1) Cairan rehidrasi: Pada anak dengan DBD tanpa syok, gunakan rumus 5–7 mL/kg/jam. Bila terdapat syok → resusitasi cairan bolus.
 - 2) Manajemen demam: Kompres hangat, parasetamol dosis 10–15 mg/kg/kali, observasi kejang.
 - 3) Oksigenasi: Berikan nasal cannula atau masker jika $\text{SpO}_2 < 92\%$
 - 4) Pemantauan neurologis berkala: GCS tiap 2 jam untuk anak risiko ensefalopati
 - 5) Pemosisian kepala 30°: Jika terdapat muntah proyektil/penurunan kesadaran
 - 6) Pencegahan aspirasi: Hindari oral feeding jika refleks menelan terganggu
- b. Intervensi Kolaboratif
- 1) Antikonvulsan: Diazepam rektal untuk kejang demam berulang
 - 2) Antivirus: Acyclovir untuk cacar air berat
 - 3) Vitamin A: Pada anak campak → 2 dosis, sesuai panduan WHO
 - 4) Antibiotik: Jika terdapat infeksi sekunder kulit atau saluran napas

3. Studi Kasus Singkat (Ilustratif)

Anak perempuan usia 5 tahun datang dengan riwayat demam 4 hari, ruam generalisata, dan kejang 2 kali. Pemeriksaan menunjukkan AVPU "V", CRT 4 detik, suhu 39.8°C, serta vesikel tersebar.

Intervensi cepat dilakukan:

- a. ABCDE: jalan napas paten, diberikan oksigen 2 Lpm
- b. Pemberian parasetamol dan kompres
- c. Resusitasi cairan karena tanda hipoperfusi
- d. GCS dicatat, konsul dokter untuk kejang berulang
- e. Isolasi airborne, kolaborasi pemberian acyclovir

4. Peran Perawat dalam Dokumentasi Klinis

Intervensi yang dilakukan harus tercatat dengan baik, terutama:

- a. Waktu onset gejala dan intervensi
- b. Frekuensi dan tipe kejang
- c. Respon anak terhadap tindakan
- d. Skor GCS dan AVPU tiap shift

Dokumentasi yang baik akan memudahkan komunikasi tim kesehatan, mencegah kesalahan, dan menjadi landasan evaluasi keperawatan.

D. Manajemen Isolasi dan Pencegahan Penularan Infeksi pada Anak

Anak-anak dengan penyakit infeksi akut seperti demam berdarah, campak, dan cacar air berisiko tinggi menularkan penyakit kepada anak lain, petugas kesehatan, dan anggota keluarga. Sistem imun anak yang belum matang serta kebiasaan

eksplorasi fisik tanpa kesadaran higienitas menjadikan anak sebagai kelompok penyebar yang efektif. Oleh karena itu, manajemen isolasi yang tepat merupakan bagian integral dari pencegahan transmisi infeksi dan harus menjadi kompetensi inti perawat anak, terutama dalam setting rumah sakit (Putra & Dewi, 2023; CDC, 2022). Manajemen isolasi mencakup:

- Penempatan pasien sesuai tipe isolasi
- Penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai risiko
- Edukasi kepada keluarga
- Disinfeksi lingkungan dan pemantauan rantai kontak

1. Tipe dan Strategi Isolasi Infeksi Anak

a. Demam Berdarah Dengue (DBD)

- 1) Mode penularan: Melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*, bukan kontak langsung.
- 2) Kebutuhan isolasi: Tidak wajib isolasi khusus, tetapi pencegahan vektor menjadi prioritas.
- 3) Strategi keperawatan:
 - a) Gunakan kelambu atau kasa anti-nyamuk
 - b) Eliminasi tempat berkembangbiak nyamuk
 - c) Pasang exhaust fan/kipas untuk mencegah nyamuk mendekat
 - d) Gunakan sarung tangan jika terjadi perdarahan

b. Campak (Measles)

- 1) Mode penularan: Droplet dan airborne – sangat menular.
- 2) Tipe isolasi: Airborne isolation (ruang bertekanan negatif ideal, masker N95).
- 3) Durasi isolasi: Hingga 4 hari setelah munculnya ruam.
- 4) Strategi keperawatan:
 - a) Batasi pengunjung (hanya orang yang sudah imunisasi)
 - b) Gunakan masker N95, gaun, sarung tangan
 - c) Gunakan ruangan dengan ventilasi silang jika ruang isolasi terbatas
 - d) Desinfeksi permukaan kontak tinggi setiap 4 jam

c. Cacar Air (Varisela)

- 1) Mode penularan: Droplet dan kontak langsung dengan vesikel.
- 2) Tipe isolasi: Airborne + contact precautions.
- 3) Durasi isolasi: Hingga seluruh vesikel menjadi krusta (± 7 hari).
- 4) Strategi keperawatan:
 - a) Masker N95 untuk petugas
 - b) Gunakan sarung tangan dan gaun saat merawat anak
 - c) Hindari penggunaan alat medis bersama

d) Buang perban/limbah pasien ke dalam wadah infeksius

2. Tabel Panduan Cepat Isolasi Infeksi Anak

Tabel 6.2
Panduan Cepat Isolasi Infeksi Anak

Penyakit	Penularan	Jenis Isolasi	APD yang Digunakan	Durasi Isolasi
DBD	Vektor (nyamuk)	Tidak diperlukan (non-kontak)	Sarung tangan (bila ada darah)	Selama fase demam
Campak	Airborne	Airborne + droplet	Masker N95, gaun, sarung tangan	4 hari pasca ruam
Varisela	Airborne + kontak	Airborne + contact	Masker N95, sarung tangan, gaun	Sampai semua vesikel mengering

3. Disinfeksi dan Protokol Lingkungan

Menurut pedoman CDC (2022), kebersihan lingkungan dan sirkulasi udara memainkan peran besar dalam mencegah transmisi infeksi nosokomial:

- Pembersihan permukaan: Gunakan disinfektan berbasis klorin (NaOCl 0,1%) pada permukaan alat dan tempat tidur.
- Sirkulasi udara: Minimum 6 pergantian udara/jam atau ventilasi silang alami.
- Limbah infeksius: Gunakan kantong kuning dan tempatkan di wadah limbah medis.

4. Edukasi Keluarga tentang Isolasi

Partisipasi keluarga sangat penting untuk efektivitas isolasi, terutama dalam pengendalian infeksi berbasis rumah (homecare). Edukasi yang diberikan meliputi:

- Pentingnya menggunakan masker saat merawat anak
- Tidak berbagi alat makan, handuk, atau mainan
- Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menyentuh anak
- Tidak membawa anak sakit ke tempat umum selama masa infeksi
- Memberi tahu sekolah/lingkungan tentang status penyakit anak (khusus untuk campak & cacar air)

"Edukasi yang konsisten dan berbasis bukti meningkatkan kepatuhan keluarga dalam menjalankan isolasi rumah secara efektif dan aman." (Ariyani & Basuki, 2020)

5. Tantangan Implementasi di Layanan Keperawatan

Di lapangan, berbagai hambatan ditemui dalam penerapan isolasi anak:

- a. Keterbatasan ruang isolasi di puskesmas atau ruang rawat gabung
- b. Kepatuhan petugas terhadap APD belum optimal
- c. Stigma keluarga terhadap isolasi sebagai bentuk diskriminasi

Peran perawat menjadi krusial dalam memberikan edukasi yang empatik, mengintegrasikan praktik evidence-based, dan mendorong sistem isolasi proporsional namun manusiawi (Putra & Dewi, 2023).

E. Edukasi Keluarga tentang Imunisasi dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk Mencegah Infeksi

Penyakit infeksi seperti campak, cacar air, dan DBD merupakan masalah kesehatan yang bisa dicegah dengan intervensi promotif dan preventif, terutama melalui imunisasi dan penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dalam konteks asuhan keperawatan anak berbasis EBP, peran keluarga menjadi sangat penting karena sebagian besar perawatan dan pencegahan berlangsung di rumah. Oleh karena itu, perawat memiliki tanggung jawab kunci dalam memberikan edukasi yang efektif dan berkelanjutan kepada keluarga (Ariyani & Basuki, 2020; WHO, 2021).

1. Edukasi Imunisasi: Pencegahan Primer Infeksi Anak

a. Manfaat Imunisasi

Imunisasi terbukti secara ilmiah sebagai metode paling efektif dalam mencegah infeksi penyakit yang berpotensi menimbulkan komplikasi neurologis, seperti:

- 1) Campak: dapat menyebabkan ensefalitis dan SSPE
- 2) Cacar air: komplikasi ataksia serebelar akut
- 3) Diphtheria-Tetanus-Pertusis (DTP): pencegahan kejang dan neuropati

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2023), cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada anak usia <2 tahun masih belum mencapai target $\geq 95\%$, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

b. Jadwal Imunisasi Dasar (Sesuai IDAI 2023)

Tabel 6.2
Tabel Jadwal Imunisasi

Usia Anak	Jenis Imunisasi
0–1 bulan	Hepatitis B
2 bulan	DTP, Polio, Hib, PCV
6 bulan	Campak-Rubella
12 bulan	Varisela, Japanese Encephalitis (JE), Influenza
18 bulan	Booster DTP, MR, IPV

c. Strategi Edukasi Keluarga tentang Imunisasi

- 1) Gunakan media edukatif visual: poster, video, atau buku saku
- 2) Gunakan pendekatan empatik dan non-menghakimi jika keluarga belum imunisasi
- 3) Jelaskan risiko nyata tanpa vaksin (kasus ensefalitis campak, rawat inap)
- 4) Kolaborasi dengan puskesmas untuk reminder jadwal vaksinasi

d. Edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

1) Tujuan PHBS

PHBS merupakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan perilaku yang berisiko rendah terhadap penyakit, khususnya infeksi menular.

2) Komponen PHBS Relevan untuk Anak

Komponen PHBS	Tujuan Pencegahan
Cuci tangan pakai sabun	Mencegah penularan virus dan bakteri
Makan makanan bergizi	Memperkuat imunitas anak
Penggunaan alas tidur sendiri	Mencegah penularan cacar air
Penggunaan kelambu & fogging	Pencegahan gigitan nyamuk DBD
Pembuangan sampah yang benar	Eliminasi vektor & bakteri
Imunisasi sesuai jadwal	Pencegahan primer infeksi

e. Metode Edukasi PHBS yang Efektif

- 1) Edukasi berbasis keluarga: orang tua, pengasuh, dan anak
- 2) Gunakan role play: simulasi mencuci tangan dengan sabun
- 3) Ajarkan "5 M" Pencegahan DBD: Menguras, Menutup, Mengubur, Memantau, dan Menghindari gigitan

f. Peran Perawat dalam Promosi Kesehatan Keluarga

Perawat bertindak sebagai:

- 1) Edukator: menyampaikan informasi secara sederhana & relevan
- 2) Fasilitator: menghubungkan keluarga dengan program imunisasi di fasilitas kesehatan
- 3) Advokat: membantu keluarga memahami pentingnya imunisasi meskipun ada kendala ekonomi atau kepercayaan
- 4) Evaluasi: melakukan follow-up pemahaman dan kepatuhan keluarga

g. Tantangan Lapangan dan Solusi

Tabel 6.4
Tantangan Lapangan dan Solusi

Tantangan	Solusi Praktis
Mitos vaksin menyebabkan autisme	Edukasi berbasis data ilmiah dan WHO
Keluarga tidak memahami PHBS	Simulasi, leaflet visual, pendekatan praktik langsung
Jadwal imunisasi terlewat	Sistem reminder via puskesmas, aplikasi Posyandu Digital

F. Penutup

Gangguan neurologis pada anak akibat penyakit infeksi seperti demam berdarah dengue (DBD), campak, dan cacar air (varisela) merupakan tantangan klinis yang kompleks dan membutuhkan penatalaksanaan berbasis bukti. Ketiga penyakit ini, meskipun pada dasarnya dapat dicegah dan ditangani secara efektif, tetap menjadi penyumbang morbiditas tinggi pada kelompok usia anak, terutama bila terjadi keterlambatan dalam pengkajian dan intervensi.

Melalui pendekatan pengkajian cepat, perawat dapat mengidentifikasi dini tanda-tanda komplikasi neurologis seperti kejang, penurunan kesadaran, atau ensefalopati. Intervensi keperawatan yang tepat waktu, termasuk manajemen cairan, oksigenasi, dan pemantauan status neurologis secara berkala, terbukti mampu menurunkan risiko perburukan klinis (Maharani & Sutisna, 2022; Widyastuti & Yamin, 2023).

Selain itu, praktik manajemen isolasi yang tepat memainkan peran penting dalam mencegah transmisi infeksi, terutama pada penyakit yang sangat menular seperti campak dan varisela. Perawat perlu memahami protokol isolasi sesuai jenis penularan, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD), pengelolaan limbah medis, dan edukasi lingkungan keluarga tentang praktik isolasi rumah.

Lebih jauh lagi, upaya promotif dan preventif dalam bentuk imunisasi lengkap dan penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan komponen krusial dalam mencegah terjadinya infeksi dan komplikasi jangka panjang. Peran perawat sebagai edukator, advokat, dan fasilitator di lini terdepan sistem kesehatan sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan ini, terutama dalam konteks keluarga dan komunitas (Ariyani & Basuki, 2020; WHO, 2021).

Dengan demikian, penerapan evidence-based practice (EBP) dalam setiap tahapan asuhan keperawatan anak dengan penyakit infeksi akut yang berpotensi menyebabkan gangguan neurologis tidak hanya meningkatkan hasil klinis, tetapi juga memperkuat integrasi layanan keperawatan dalam sistem kesehatan anak

secara keseluruhan. Perawat harus terus mengembangkan kapasitas profesionalnya melalui pembaruan ilmu, pelatihan klinis, dan kolaborasi antar-profesi demi meningkatkan kualitas hidup anak Indonesia.

G. Referensi

- Alif, M. A., Yulianti, R. & Handayani, S., 2021. Effectiveness of nursing interventions in preventing complications of measles in children. *BMC Pediatrics*, 21(2), pp.122–130. Available at: <https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-021-02567-5>
- Ariyani, S. & Basuki, W., 2020. Family-centered care education on immunization and hygiene practices. *Asian Journal of Pediatric Health*, 12(2), pp.33–41. Available at: <https://ajph.org/articles/2020-12-2-33>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2022. Guidelines for Isolation Precautions in Healthcare Settings. Available at: <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/index.html>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2022. Pediatric Assessment and Triage Tools. Available at: <https://www.cdc.gov/childhealth/pediatric-assessment.html>
- Indonesian Pediatric Society (IDAI), 2023. Jadwal Imunisasi Anak Indonesia 2023. Available at: <https://idai.or.id/jadwal-imunisasi>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023. Laporan Tahunan Imunisasi dan PHBS Nasional Tahun 2022. Available at: <https://www.kemkes.go.id>
- Maharani, R. & Sutisna, B., 2022. Rapid neurological assessment in pediatric patients with infectious diseases. *International Journal of Child Health Nursing*, 18(1), pp.22–31. Available at: <https://doi.org/10.1016/ijchn.2022.022>
- Putra, Y. D. & Dewi, N., 2023. Implementation of standard isolation protocols in pediatric infectious cases: A nursing perspective. *Indonesian Journal of Pediatric Nursing*, 10(1), pp.57–66. Available at: <https://doi.org/10.24843/IJPN.2023.10.1.6>
- Rahman, T. & Suharti, L., 2022. Evidence-based practice on varicella zoster infection in pediatric units. *Nurse & Health Journal*, 7(4), pp.199–208. Available at: <https://nhj.org/varicella-zoster-peds-ebp>
- Widyastuti, E. & Yamin, M., 2023. The role of pediatric nurses in dengue fever management based on evidence-based practice. *Journal of Pediatric Nursing Research*, 11(2), pp.145–153. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jpedsnres.2023.145>
- World Health Organization (WHO), 2021. Guidelines on infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in

health care. Available at:
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241507139>

World Health Organization (WHO), 2021. Immunization coverage and neurological complication prevention. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage>

H. Glosarium

ABCDE

Suatu pendekatan sistematis untuk penilaian awal kondisi pasien secara cepat: Airway (jalan napas), Breathing (pernapasan), Circulation (sirkulasi), Disability (kesadaran), Exposure (pemeriksaan menyeluruh).

Airborne

Jenis penularan infeksi melalui partikel udara halus yang dapat bertahan dan menyebar dalam udara, misalnya pada penyakit campak dan cacar air.

Ataksia Serebelar Akut

Gangguan koordinasi tubuh akibat kerusakan atau inflamasi pada serebelum, sering muncul sebagai komplikasi neurologis pasca infeksi seperti varisela.

AVPU Scale

Skala cepat untuk menilai tingkat kesadaran anak: Alert, Voice, Pain, Unresponsive.

Cacar Air (Varisela)

Penyakit infeksi virus yang sangat menular, ditandai oleh ruam vesikular dan demam. Dapat menimbulkan komplikasi neurologis seperti ataksia serebelar atau meningitis.

Campak (Measles)

Penyakit virus yang sangat menular, dengan gejala demam, batuk, ruam, dan komplikasi seperti ensefalitis atau SSPE.

Circulation

Aspek dari pendekatan ABCDE yang mengevaluasi perfusi dan status sirkulasi darah pada pasien, termasuk pengukuran tekanan darah dan waktu pengisian kapiler (CRT).

Disability

Komponen D dalam pendekatan ABCDE yang fokus pada penilaian status neurologis seperti respons kesadaran dan refleks.

Demam Berdarah Dengue (DBD)

Infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes, ditandai oleh demam, nyeri otot, dan perdarahan. Komplikasi neurologis dapat berupa ensefalopati dan kejang.

EBP (Evidence-Based Practice)

Pendekatan praktik keperawatan yang menggabungkan bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis, dan nilai-nilai pasien untuk pengambilan keputusan yang efektif.

Ensefalitis

Peradangan pada otak yang dapat disebabkan oleh infeksi virus (misalnya campak, cacar air). Gejala dapat meliputi demam tinggi, kejang, dan penurunan kesadaran.

GCS (Glasgow Coma Scale)

Instrumen untuk menilai tingkat kesadaran pasien berdasarkan respons motorik, verbal, dan mata.

Isolasi

Langkah-langkah pencegahan untuk memisahkan pasien infeksius guna mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain.

Imunisasi

Proses pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Salah satu metode utama dalam pencegahan infeksi pada anak.

Kejang Demam

Kejang yang muncul saat anak mengalami demam, umumnya terjadi pada usia 6 bulan–5 tahun.

Meningitis Aseptik

Peradangan selaput otak tanpa keterlibatan bakteri, biasanya karena infeksi virus seperti varisela.

Neurologis

Segala hal yang berkaitan dengan sistem saraf pusat dan perifer, termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan saraf.

PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)

Perilaku kesehatan yang diterapkan individu atau keluarga untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup.

Postur Dekortikasi / Dekerabrasi

Posisi tubuh abnormal yang menandakan gangguan otak berat, biasanya akibat cedera atau ensefalopati.

Resusitasi Cairan

Prosedur pemberian cairan secara cepat dan besar untuk mengembalikan volume intravaskular pada pasien syok.

SSPE (Subacute Sclerosing Panencephalitis)

Komplikasi jangka panjang yang jarang namun fatal akibat infeksi campak yang laten, ditandai dengan degenerasi sistem saraf pusat secara progresif.

SpO₂

Saturasi oksigen dalam darah yang diukur dengan oksimeter, indikator penting dalam evaluasi status pernapasan pasien.

Triage

Proses penilaian cepat kondisi pasien untuk menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kegawatdaruratannya.

Vitamin A

Mikronutrien penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah komplikasi infeksi, khususnya campak.



CHAPTER 7

MANAJEMEN NYERI PADA ANAK

Ns. Nita Theresia, S.Kep., M.Kes.



A. Pendahuluan/Prolog

Nyeri merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, terkait dengan kerusakan jaringan yang aktual atau potensial. Pada populasi anak, nyeri merupakan salah satu keluhan utama yang sering ditemui dalam berbagai kondisi klinis, baik yang bersifat akut maupun kronis. Menurut International Association for the Study of Pain (IASP), nyeri pada anak adalah suatu fenomena multidimensional yang tidak hanya melibatkan sensasi fisik, tetapi juga pengalaman emosional, kognitif, serta sosial anak. Persepsi nyeri pada anak dapat bervariasi tergantung pada usia, tingkat perkembangan kognitif, lingkungan, pengalaman sebelumnya, serta dukungan psikososial yang diperoleh dari keluarga maupun tenaga kesehatan.

Secara konseptual, nyeri pada anak dibedakan menjadi beberapa tipe utama, seperti nyeri akut, nyeri kronis, dan nyeri prosedural. Nyeri akut biasanya muncul secara tiba-tiba, bersifat sementara, serta terkait dengan cedera atau tindakan medis tertentu seperti imunisasi, pemasangan infus, pengambilan darah, atau tindakan bedah kecil. Sementara nyeri kronis memiliki karakteristik yang berbeda, yakni berlangsung lama, biasanya lebih dari tiga bulan, dan sering kali berkaitan dengan kondisi medis kronis seperti kanker, penyakit autoimun, atau kelainan neurologis. Adapun nyeri prosedural adalah nyeri yang secara spesifik berhubungan dengan prosedur medis invasif yang rutin dilakukan pada anak selama masa perawatan.

Epidemiologi nyeri pada anak menunjukkan prevalensi yang tinggi di berbagai lingkungan pelayanan kesehatan, mulai dari layanan primer hingga rumah sakit rujukan. Data menunjukkan bahwa hampir setiap anak pernah mengalami nyeri akut dalam hidupnya, baik akibat cedera, penyakit, maupun prosedur medis rutin seperti vaksinasi atau pengambilan darah. Berdasarkan penelitian terbaru, lebih dari 60% anak yang dirawat di rumah sakit melaporkan mengalami nyeri dengan berbagai derajat intensitas, namun masih banyak di antara mereka yang belum mendapatkan penatalaksanaan nyeri secara optimal. Nyeri kronis juga menjadi perhatian penting, dengan prevalensi sekitar 20-35% pada populasi pediatrik global, terutama dalam kondisi seperti artritis remaja, nyeri kepala berulang, nyeri perut kronis, dan kanker anak. Tingginya prevalensi ini menunjukkan bahwa nyeri pada anak merupakan

permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak yang terlibat dalam perawatan kesehatan anak.

Manajemen nyeri pada anak memiliki peran yang sangat penting dalam praktik keperawatan dan medis pediatrik. Pentingnya pengelolaan nyeri secara optimal pada anak tidak hanya bertujuan untuk mengurangi penderitaan fisik yang dirasakan, tetapi juga untuk menghindari dampak psikologis dan emosional yang berpotensi muncul akibat nyeri yang tidak terkontrol. Pengalaman nyeri yang buruk pada anak, khususnya jika terjadi secara berulang, dapat menimbulkan trauma psikologis jangka panjang, kecemasan berlebih terhadap pelayanan medis, serta penolakan terhadap prosedur medis penting di masa mendatang. Selain itu, nyeri yang tidak tertangani dengan baik dapat mengganggu proses penyembuhan dan memperlambat pemulihan anak, menyebabkan penurunan nafsu makan, gangguan tidur, serta berpotensi menghambat tumbuh kembang secara keseluruhan.

Manajemen nyeri yang baik pada anak juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan anak dan keluarga terhadap sistem pelayanan kesehatan, sekaligus membantu menciptakan pengalaman positif terkait perawatan kesehatan sejak usia dini. Oleh karena itu, tenaga kesehatan khususnya perawat, dituntut memiliki pengetahuan mendalam serta keterampilan khusus dalam melakukan pengkajian nyeri, memilih intervensi yang tepat (baik farmakologis maupun non-farmakologis), serta mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan secara rutin dan konsisten. Selain itu, edukasi yang tepat kepada keluarga mengenai pentingnya pengelolaan nyeri dan bagaimana mengidentifikasi nyeri pada anak merupakan bagian integral dari manajemen nyeri yang efektif.

B. Jenis-jenis Nyeri pada Anak

Nyeri pada anak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama berdasarkan durasi, karakteristik, serta penyebabnya. Tiga kategori utama yang sering dijumpai dalam konteks pediatrik adalah nyeri akut, nyeri kronis, dan nyeri prosedural yang terkait langsung dengan berbagai tindakan medis invasif yang dilakukan pada anak selama perawatan medis.

Nyeri akut merupakan nyeri yang terjadi secara tiba-tiba dengan intensitas yang dapat bervariasi dari ringan hingga sangat berat. Durasi nyeri akut umumnya relatif singkat, berkisar dari beberapa menit hingga beberapa minggu, tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Pada anak-anak, nyeri akut sering kali muncul akibat cedera traumatik seperti terjatuh, patah tulang, luka bakar ringan, atau luka-luka yang membutuhkan tindakan medis segera. Selain itu, penyakit infeksi akut seperti otitis media (infeksi telinga tengah), faringitis akut (radang tenggorokan), infeksi saluran kemih akut, hingga appendisitis akut merupakan penyebab umum

nyeri akut pada populasi pediatrik. Nyeri akut biasanya memiliki tujuan biologis sebagai mekanisme peringatan terhadap tubuh bahwa ada kerusakan jaringan atau ancaman yang harus segera ditangani. Anak yang mengalami nyeri akut biasanya menunjukkan tanda-tanda fisik seperti menangis keras, wajah yang meringis atau terlihat tegang, peningkatan denyut jantung dan pernapasan, hingga perubahan perilaku seperti rewel atau menarik diri dari lingkungan. Penanganan nyeri akut pada anak yang tepat waktu dan efektif sangat penting untuk mencegah trauma emosional yang bisa berlangsung jangka panjang, serta membantu mempercepat proses pemulihan fisik anak.

Berbeda dari nyeri akut, nyeri kronis pada anak memiliki durasi yang lebih lama, biasanya berlangsung selama lebih dari tiga bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Nyeri kronis ini bisa berupa nyeri yang terus menerus (persisten) atau nyeri yang bersifat hilang-timbul dengan intensitas yang berubah-ubah. Pada populasi pediatrik, beberapa kondisi medis yang sering dikaitkan dengan nyeri kronis di antaranya adalah arthritis idiopatik juvenil, nyeri kepala berulang atau migrain, nyeri perut fungsional kronis, fibromyalgia, serta kondisi-kondisi kronis lain seperti penyakit autoimun dan kanker pediatrik. Karakteristik khusus dari nyeri kronis adalah dampaknya yang luas, tidak hanya terbatas pada fisik saja tetapi juga sangat memengaruhi aspek psikologis, emosional, dan sosial anak. Anak yang mengalami nyeri kronis sering kali menghadapi masalah tambahan seperti gangguan tidur, kelelahan kronis, penurunan performa akademik, masalah interaksi sosial, serta risiko lebih tinggi mengalami depresi dan kecemasan. Pengelolaan nyeri kronis pada anak memerlukan pendekatan multidisiplin yang mencakup intervensi farmakologis, teknik psikologis seperti terapi perilaku kognitif (CBT), dukungan emosional, serta terapi fisik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak secara keseluruhan.

Selain nyeri akut dan kronis, ada pula jenis nyeri khusus yang disebut nyeri prosedural, yaitu nyeri yang secara spesifik muncul akibat tindakan medis atau prosedur invasif yang dilakukan selama masa perawatan. Nyeri prosedural sangat sering dijumpai pada anak-anak karena prosedur medis seperti pemasangan infus, pengambilan darah, imunisasi, pemasangan kateter urin, atau tindakan bedah minor sangat lazim dilakukan dalam perawatan anak, baik rawat inap maupun rawat jalan. Anak yang mengalami nyeri prosedural dapat mengalami ketakutan, kecemasan, serta ketidaknyamanan fisik yang signifikan. Apabila nyeri prosedural ini tidak dikelola secara efektif, pengalaman tersebut dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, menyebabkan anak takut terhadap fasilitas kesehatan, dan menurunkan kepatuhan terhadap perawatan medis di masa depan. Oleh karena itu, pengelolaan nyeri prosedural memerlukan perhatian khusus dengan mengombinasikan intervensi farmakologis seperti penggunaan anestesi lokal atau

obat analgesik yang tepat, dengan intervensi non-farmakologis seperti teknik distraksi, teknik relaksasi, atau pendekatan psikologis yang sesuai dengan usia anak. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam menenangkan anak selama prosedur medis juga menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.

C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Nyeri pada Anak

Persepsi nyeri pada anak merupakan proses kompleks yang tidak semata-mata dipengaruhi oleh intensitas stimulus fisik, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Memahami faktor-faktor tersebut sangat penting untuk memberikan pengelolaan nyeri yang efektif pada anak, serta membantu tenaga kesehatan dan orang tua dalam memberikan dukungan emosional yang tepat untuk anak yang sedang mengalami nyeri.

Faktor pertama yang sangat menentukan bagaimana seorang anak mempersepsikan nyeri adalah usia dan tingkat perkembangan anak. Persepsi nyeri pada anak sangat bergantung pada tahap perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial mereka. Pada bayi dan balita, misalnya, persepsi nyeri umumnya ditunjukkan melalui perubahan perilaku yang cukup nyata seperti menangis keras, tubuh menegang, menarik kaki atau tangan ketika disentuh, hingga ekspresi wajah yang jelas memperlihatkan ketidaknyamanan. Karena bayi belum mampu mengungkapkan rasa nyerinya secara verbal, maka pengkajian nyeri pada kelompok ini sangat bergantung pada interpretasi perilaku oleh tenaga kesehatan atau orang tua. Sebaliknya, pada anak usia prasekolah dan usia sekolah awal, kemampuan verbal sudah mulai berkembang, sehingga anak mulai mampu mengkomunikasikan lokasi, intensitas, serta sifat nyeri yang dirasakan. Namun, anak pada usia ini sering kali menggunakan kosakata yang sederhana seperti "sakit", "panas", atau "perih", yang menuntut tenaga kesehatan untuk melakukan eksplorasi lebih dalam guna memahami persepsi nyeri secara akurat. Pada remaja, persepsi nyeri sudah jauh lebih kompleks, karena kemampuan berpikir abstrak sudah berkembang. Remaja mampu menggambarkan nyerinya secara lebih jelas, bahkan menggunakan perumpamaan atau analogi, serta mampu memahami hubungan antara nyeri dengan penyebab medis yang mendasarinya. Selain itu, remaja juga sudah mulai mampu menggunakan berbagai strategi kognitif untuk mengatasi nyeri yang dirasakan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memiliki pemahaman mendalam mengenai tahap-tahap perkembangan anak agar dapat menginterpretasi tanda-tanda nyeri dengan benar dan memberikan intervensi yang sesuai dengan usia anak.

Selain faktor usia dan perkembangan anak, faktor psikososial dan lingkungan juga memegang peran penting dalam memengaruhi persepsi nyeri pada anak.

Anak-anak tidak pernah mempersepsikan nyeri secara terisolasi, melainkan selalu dalam konteks hubungan mereka dengan orang tua, keluarga, lingkungan sosial, serta kondisi emosional yang mereka alami pada saat itu. Misalnya, anak yang mengalami nyeri tetapi didampingi oleh orang tua yang tenang, penuh perhatian, serta memberikan rasa nyaman melalui sentuhan lembut atau kata-kata menenangkan, biasanya akan mengalami persepsi nyeri yang lebih ringan dibandingkan anak yang mengalami nyeri dalam suasana penuh kecemasan atau ketegangan. Sebaliknya, lingkungan yang penuh dengan stres atau situasi konflik keluarga dapat meningkatkan persepsi nyeri pada anak, membuat mereka lebih sensitif terhadap rangsangan nyeri, bahkan terhadap stimulus ringan sekalipun. Selain itu, faktor budaya juga sangat mempengaruhi cara anak bereaksi terhadap nyeri. Dalam beberapa budaya, ekspresi nyeri secara terbuka dianggap wajar dan didukung oleh lingkungan, sementara dalam budaya lain anak mungkin diajarkan untuk menahan atau tidak menunjukkan ekspresi nyeri secara terbuka. Demikian pula, faktor dukungan sosial dari teman sebaya atau komunitas sekitar dapat membantu anak lebih mampu mengatasi nyeri secara positif. Oleh karena itu, intervensi nyeri pada anak juga harus mempertimbangkan faktor-faktor psikososial dan lingkungan untuk memberikan efek optimal dalam manajemen nyeri.

Faktor berikutnya yang tidak kalah penting dalam menentukan persepsi nyeri pada anak adalah pengalaman nyeri sebelumnya. Pengalaman masa lalu terkait nyeri sangat berperan dalam membentuk persepsi dan reaksi anak terhadap episode nyeri berikutnya. Anak yang pernah mengalami nyeri hebat, trauma akibat tindakan medis, atau pengalaman yang sangat tidak menyenangkan di rumah sakit, cenderung akan memiliki kecenderungan untuk lebih takut, cemas, dan mempersepsikan nyeri secara lebih intens ketika menghadapi situasi yang mirip di masa depan. Sebaliknya, jika anak memiliki pengalaman nyeri yang sebelumnya dapat dikelola dengan baik, tanpa trauma atau komplikasi psikologis yang signifikan, maka mereka cenderung akan lebih siap menghadapi nyeri berikutnya dengan sikap yang lebih positif dan kurang mengalami kecemasan yang intens. Hal ini sangat penting untuk dipahami oleh tenaga kesehatan karena persepsi anak terhadap nyeri dapat berubah secara signifikan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, sangat krusial bagi tenaga kesehatan maupun orang tua untuk memastikan bahwa pengalaman nyeri pada anak, terutama yang berkaitan dengan prosedur medis, dapat diminimalkan sebanyak mungkin melalui manajemen nyeri yang efektif, pendekatan yang humanis, serta pemberian edukasi yang tepat pada anak mengenai apa yang akan mereka alami.

D. Pengkajian dan Penilaian Nyeri pada Anak

Pengkajian nyeri pada anak merupakan langkah penting dalam upaya manajemen nyeri yang efektif. Penilaian nyeri tidak hanya sekadar proses observasi sederhana, tetapi juga merupakan prosedur klinis yang kompleks, membutuhkan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman mendalam mengenai karakteristik nyeri anak yang sangat spesifik dan berbeda dari populasi dewasa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, penilaian nyeri pada anak harus dilakukan secara menyeluruh, tepat, dan berorientasi pada tahap perkembangan serta kebutuhan psikologis anak tersebut.

Dalam proses pengkajian nyeri pada anak, tenaga kesehatan menggunakan berbagai alat ukur dan skala nyeri yang telah divalidasi khusus untuk populasi anak. Salah satu alat ukur yang paling umum digunakan adalah skala wajah Wong-Baker (Wong-Baker Faces Pain Rating Scale). Skala ini menggunakan gambar wajah dengan berbagai ekspresi mulai dari wajah yang tersenyum (menunjukkan tidak ada rasa sakit) hingga wajah yang sangat sedih dengan air mata (menunjukkan nyeri yang paling parah). Skala Wong-Baker dirancang agar mudah dipahami anak-anak, khususnya mereka yang berada dalam tahap pra-operasional (usia 3-7 tahun), di mana kemampuan verbal mereka sudah mulai berkembang tetapi masih terbatas dalam menggambarkan nyeri secara spesifik. Dengan menggunakan skala ini, anak dapat dengan mudah menunjuk wajah yang sesuai dengan tingkat nyeri yang mereka rasakan, sehingga tenaga kesehatan dapat menentukan tingkat keparahan nyeri dengan lebih akurat.

Selain skala wajah Wong-Baker, skala FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) juga sering digunakan, terutama pada bayi atau anak yang belum mampu berbicara atau yang memiliki hambatan komunikasi. Skala FLACC ini mencakup penilaian terhadap lima aspek perilaku yang diamati secara langsung oleh tenaga kesehatan, yaitu ekspresi wajah, gerakan kaki, aktivitas tubuh secara umum, tangisan, serta tingkat kemampuan anak untuk ditenangkan atau dihibur oleh pengasuhnya. Masing-masing aspek diberikan nilai dari 0 hingga 2, yang kemudian dijumlahkan untuk menentukan tingkat nyeri secara keseluruhan. Penggunaan skala FLACC ini sangat membantu dalam situasi klinis di mana anak belum dapat mengekspresikan nyerinya secara verbal, seperti pada bayi baru lahir, anak dengan keterbatasan komunikasi, atau mereka yang sedang dalam kondisi stres akut.

Selain penggunaan alat ukur nyeri tersebut, teknik observasi nyeri yang cermat dan sistematis menjadi komponen kunci dalam pengkajian nyeri pada anak. Observasi nyeri pada anak membutuhkan kepekaan tinggi dari tenaga kesehatan terhadap berbagai perubahan perilaku maupun fisiologis yang dapat menunjukkan adanya nyeri. Misalnya, tenaga kesehatan harus memperhatikan ekspresi wajah anak

seperti meringis, kerutan dahi, mata tertutup rapat, atau air mata yang mengalir. Gerakan tubuh juga merupakan indikator penting lainnya, seperti menarik anggota tubuh menjauh dari sentuhan, perubahan postur tubuh yang menunjukkan rasa tidak nyaman, atau adanya gerakan yang terus-menerus akibat gelisah. Selain itu, observasi terhadap respons fisiologis seperti peningkatan denyut jantung, laju pernapasan yang meningkat, peningkatan tekanan darah, serta perubahan warna kulit atau keringat dingin juga merupakan tanda-tanda penting yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi nyeri pada anak. Observasi yang detail ini membutuhkan tenaga kesehatan untuk menggunakan pendekatan yang tenang, empatik, serta memperhatikan kondisi emosional anak agar dapat menangkap tanda-tanda nyeri yang mungkin sulit dikenali dengan pengamatan singkat.

Meski terdapat berbagai alat ukur dan teknik observasi yang tersedia, pengkajian nyeri pada anak tetap memiliki berbagai tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama dalam pengkajian nyeri pada anak adalah keterbatasan komunikasi verbal, terutama pada anak usia dini dan mereka yang mengalami keterbatasan dalam perkembangan bahasa atau gangguan kognitif tertentu. Anak-anak sering kali tidak mampu menjelaskan rasa sakit yang mereka rasakan secara jelas atau tepat. Bahkan, pada banyak situasi, anak mungkin memilih untuk tidak mengungkapkan rasa sakitnya karena takut terhadap prosedur medis lebih lanjut, takut akan rasa sakit tambahan, atau karena ingin terlihat berani di hadapan orang tua atau tenaga kesehatan. Hal ini membuat tenaga kesehatan perlu ekstra hati-hati dalam melakukan pengkajian, tidak hanya mengandalkan laporan verbal anak tetapi juga mempertimbangkan observasi perilaku serta input dari orang tua atau pengasuh anak.

Tantangan lain yang sering dihadapi dalam pengkajian nyeri anak adalah persepsi subjektif orang tua atau pengasuh yang bisa memengaruhi interpretasi nyeri. Orang tua yang cemas berlebihan atau justru yang meremehkan rasa sakit yang dialami anaknya bisa memengaruhi pengkajian tenaga kesehatan. Selain itu, anak-anak juga memiliki persepsi nyeri yang sangat bervariasi tergantung pada pengalaman sebelumnya, kondisi emosional, lingkungan di sekitar, serta situasi klinis yang sedang mereka hadapi. Variasi ini membuat pengkajian nyeri anak menjadi lebih kompleks dibandingkan pada populasi dewasa. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu mempertimbangkan semua faktor tersebut dengan bijaksana agar tidak terjadi kesalahan interpretasi yang dapat mengakibatkan kurang optimalnya intervensi nyeri yang diberikan kepada anak.

E. Intervensi Farmakologis dalam Manajemen Nyeri pada Anak

Intervensi farmakologis merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen nyeri pada anak. Pendekatan ini melibatkan penggunaan obat-obatan analgesik untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri yang dialami oleh anak. Tujuan utama dari penggunaan obat analgesik pada anak adalah untuk memberikan rasa nyaman, mengurangi stres akibat nyeri, mempermudah proses penyembuhan, serta meningkatkan kualitas hidup anak selama menjalani perawatan medis maupun pada kondisi nyeri lainnya. Oleh karena itu, penggunaan obat analgesik pada anak harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, mengingat tubuh anak memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.

Dalam manajemen nyeri anak, terdapat beberapa jenis obat analgesik yang dapat digunakan, mulai dari obat yang memiliki efek ringan hingga obat analgesik yang lebih kuat dan spesifik. Secara umum, jenis obat analgesik yang sering digunakan pada anak diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu analgesik non-opioid seperti parasetamol (asetaminofen) dan obat antiinflamasi non-steroid (NSAID) seperti ibuprofen, serta analgesik opioid yang lebih kuat, seperti morfin, kodein, atau fentanyl. Parasetamol merupakan obat analgesik yang paling sering digunakan untuk mengatasi nyeri ringan hingga sedang pada anak karena memiliki profil keamanan yang baik, risiko efek samping yang relatif rendah, serta ketersediaannya yang luas dalam berbagai bentuk sediaan seperti sirup, tablet, maupun supositoria. Obat ini biasanya menjadi pilihan pertama terutama untuk mengatasi nyeri akut seperti demam, sakit kepala, atau nyeri pasca-prosedur medis.

NSAID, seperti ibuprofen, juga banyak digunakan dalam manajemen nyeri anak, khususnya untuk nyeri yang disertai peradangan seperti nyeri akibat cedera, nyeri otot, maupun nyeri akibat proses inflamasi lainnya. Penggunaan NSAID pada anak harus memperhatikan kondisi medis tertentu, seperti adanya gangguan gastrointestinal, asma, atau risiko perdarahan, mengingat efek samping utama NSAID meliputi iritasi lambung, perdarahan gastrointestinal, dan gangguan fungsi ginjal. Oleh karena itu, pemilihan jenis analgesik harus mempertimbangkan kondisi klinis anak secara keseluruhan, jenis nyeri yang dialami, serta adanya kontraindikasi atau faktor risiko tertentu.

Dalam kondisi nyeri yang berat atau sangat mengganggu, seperti nyeri pasca operasi besar, nyeri kanker, atau nyeri akibat cedera parah, penggunaan analgesik opioid sering kali menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Opioid seperti morfin atau fentanyl memiliki efektivitas tinggi dalam mengontrol nyeri sedang hingga berat. Namun, penggunaannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan selalu di bawah pengawasan ketat tenaga kesehatan karena risiko efek samping yang cukup serius, seperti depresi pernapasan, sedasi berlebihan, konstipasi, mual,

muntah, serta risiko ketergantungan jika digunakan dalam jangka panjang atau tidak terkontrol dengan baik.

Dalam pemberian obat analgesik pada anak, faktor penting lain yang harus diperhatikan adalah dosis yang aman dan tepat sesuai usia serta berat badan anak. Penentuan dosis obat analgesik pada anak berbeda secara signifikan dengan orang dewasa karena anak memiliki sistem metabolisme dan ekskresi obat yang masih berkembang serta berbeda antar tahapan usia. Oleh karena itu, perhitungan dosis obat analgesik pada anak sering kali menggunakan rumus atau pedoman khusus berdasarkan berat badan anak atau luas permukaan tubuhnya. Sebagai contoh, parasetamol biasanya diberikan dengan dosis berkisar antara 10–15 mg/kg berat badan setiap 4–6 jam, dengan dosis maksimal harian tidak melebihi 75 mg/kg atau maksimal 4 gram per hari pada anak-anak yang lebih besar atau remaja. Begitu juga dengan ibuprofen yang umumnya diberikan dengan dosis 5–10 mg/kg berat badan setiap 6–8 jam, tergantung pada indikasi klinis dan tingkat keparahan nyeri yang dialami.

Cara pemberian obat analgesik juga menjadi perhatian penting dalam manajemen nyeri anak. Obat analgesik untuk anak biasanya tersedia dalam berbagai bentuk sediaan seperti sirup, tablet kunyah, tetes oral, suppositoria rektal, hingga pemberian intravena. Pemilihan bentuk sediaan harus disesuaikan dengan usia, kondisi klinis, kemampuan anak dalam mengonsumsi obat, serta kecepatan onset yang diinginkan. Misalnya, untuk anak yang sulit menelan obat atau sedang mengalami mual dan muntah, pemberian analgesik dalam bentuk suppositoria rektal mungkin lebih tepat, sedangkan pemberian intravena atau melalui infus biasanya digunakan dalam kondisi nyeri berat di rumah sakit, seperti nyeri pasca operasi atau trauma yang memerlukan pengendalian nyeri yang cepat dan efektif.

Efek samping dari penggunaan obat analgesik pada anak juga harus selalu dipantau secara ketat. Meski parasetamol relatif aman, dosis berlebih atau pemberian jangka panjang bisa berpotensi menyebabkan kerusakan hati. NSAID seperti ibuprofen perlu diawasi terutama dampaknya terhadap fungsi gastrointestinal dan ginjal. Pada penggunaan analgesik opioid, pemantauan ketat sangat penting karena risiko terjadinya depresi pernapasan, sedasi, dan toleransi terhadap obat tersebut sangat tinggi, terutama pada bayi atau anak yang berusia sangat muda atau memiliki riwayat gangguan fungsi organ tertentu. Oleh karena itu, pemantauan efek samping ini melibatkan pengawasan tanda vital secara berkala seperti laju pernapasan, saturasi oksigen, denyut jantung, serta tingkat kesadaran anak. Selain itu, tenaga kesehatan juga harus secara rutin memantau kemungkinan terjadinya konstipasi, mual, muntah, atau tanda-tanda lainnya yang mengindikasikan efek samping dari pemberian analgesik opioid.

F. Intervensi Non-Farmakologis dalam Manajemen Nyeri pada Anak

Intervensi non-farmakologis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam manajemen nyeri anak dan memiliki peran penting sebagai pelengkap atau alternatif dari intervensi farmakologis. Intervensi ini menggunakan berbagai metode dan teknik yang tidak melibatkan pemberian obat-obatan, tetapi mengandalkan pendekatan psikologis, fisik, serta emosional untuk membantu anak mengatasi rasa nyeri secara efektif. Pendekatan non-farmakologis menjadi penting, terutama dalam konteks anak-anak, karena pendekatan ini lebih aman, minim risiko efek samping, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh tenaga kesehatan maupun keluarga dalam berbagai situasi dan kondisi.

Salah satu metode non-farmakologis yang efektif dan paling sering digunakan dalam manajemen nyeri pada anak adalah teknik relaksasi dan distraksi. Teknik relaksasi bertujuan untuk menciptakan kondisi nyaman, tenang, dan rileks yang mampu membantu anak dalam mengurangi ketegangan fisik maupun emosional akibat nyeri. Teknik relaksasi dapat berupa latihan pernapasan dalam, visualisasi atau imajinasi positif, serta meditasi sederhana yang disesuaikan dengan usia anak. Misalnya, latihan pernapasan dalam yang dilakukan secara perlahan dapat membantu mengurangi nyeri dengan mengalihkan perhatian anak dari rasa sakit serta merangsang respons relaksasi fisiologis. Dalam visualisasi atau imajinasi positif, anak diajak untuk membayangkan suasana atau tempat yang menyenangkan, seperti bermain di pantai, berada di taman bermain, atau suasana lain yang membuat anak merasa aman dan bahagia. Teknik ini sangat efektif untuk meredakan nyeri, terutama saat anak menjalani prosedur medis yang menyakitkan seperti pemasangan infus atau pengambilan darah.

Selain relaksasi, teknik distraksi juga sangat efektif dalam mengurangi persepsi nyeri pada anak dengan cara mengalihkan fokus perhatian anak dari rasa nyeri ke aktivitas lain yang menarik perhatiannya. Distraksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menonton video favorit, mendengarkan musik yang menyenangkan, bermain gim interaktif, hingga aktivitas sederhana seperti menceritakan kisah atau mengobrol tentang topik favorit anak. Teknik distraksi sangat cocok digunakan saat anak menjalani prosedur medis singkat yang menimbulkan rasa sakit atau nyeri akut. Studi menunjukkan bahwa anak yang diberikan distraksi selama prosedur medis cenderung mengalami nyeri yang lebih rendah, ketakutan yang berkurang, serta lebih kooperatif selama tindakan medis tersebut.

Intervensi non-farmakologis lainnya yang terbukti efektif dan populer digunakan dalam manajemen nyeri pada anak adalah terapi bermain atau dikenal dengan istilah *play therapy*. Terapi bermain adalah pendekatan terapeutik yang

menggunakan berbagai aktivitas permainan sebagai media utama dalam membantu anak mengatasi rasa nyeri serta dampak emosional yang menyertainya, seperti rasa takut, cemas, dan stres. Bermain merupakan kebutuhan utama anak yang secara alami membantu anak mengungkapkan perasaan dan emosinya dengan cara yang paling nyaman dan natural. Dalam konteks manajemen nyeri, permainan terapeutik dapat membantu anak memahami, mengekspresikan, serta mengelola rasa sakit yang dialaminya.

Terdapat berbagai jenis permainan terapeutik yang dapat diaplikasikan sesuai dengan usia anak, jenis nyeri, serta kondisi klinisnya. Misalnya, permainan berpura-pura (role play) dapat membantu anak untuk lebih siap secara psikologis dalam menghadapi prosedur medis yang menyakitkan dengan cara memperkenalkan prosedur tersebut melalui simulasi menggunakan boneka atau mainan medis. Anak yang sebelumnya merasa takut terhadap jarum suntik bisa menjadi lebih tenang setelah melakukan permainan peran di mana ia berperan sebagai dokter yang menyuntik boneka pasiennya. Selain itu, aktivitas permainan kreatif seperti menggambar, melukis, membuat kerajinan tangan, atau bermain pasir juga sangat efektif dalam membantu anak mengalihkan perhatian dari nyeri, meningkatkan mood positif, serta memberi ruang bagi anak untuk mengungkapkan perasaan cemas atau takut secara bebas.

Terapi sentuhan dan teknik fisik lainnya merupakan metode non-farmakologis berikutnya yang juga sangat penting dan sering digunakan dalam manajemen nyeri anak. Terapi sentuhan, seperti pijatan lembut, belaian atau sentuhan terapeutik dari orang tua atau tenaga kesehatan, terbukti dapat secara signifikan mengurangi nyeri pada anak melalui efek fisiologis maupun psikologisnya. Sentuhan lembut dari orang tua atau perawat menciptakan rasa nyaman dan aman pada anak, meningkatkan pelepasan hormon oksitosin yang membantu meredakan nyeri, serta memperkuat ikatan emosional yang sangat dibutuhkan anak dalam situasi stres atau nyeri.

Pijatan lembut dengan tekanan ringan pada area tubuh tertentu seperti punggung, tangan, atau kaki anak, dapat membantu mengurangi nyeri otot, nyeri akibat prosedur medis, maupun nyeri yang bersifat kronis. Teknik pijat ini biasanya dilakukan secara perlahan dan ritmis, menggunakan minyak atau lotion yang sesuai untuk anak, sehingga memberikan efek menenangkan yang efektif. Penelitian menunjukkan bahwa pijatan rutin yang diberikan kepada anak tidak hanya menurunkan intensitas nyeri, tetapi juga membantu anak tidur lebih baik, meningkatkan mood positif, serta mempercepat proses pemulihan secara umum.

Selain pijatan, metode fisik lain seperti kompres hangat atau dingin juga sering digunakan untuk meredakan nyeri pada anak secara efektif. Kompres hangat,

misalnya, dapat membantu mengurangi nyeri otot, nyeri akibat kejang otot, atau nyeri akibat menstruasi pada remaja perempuan. Sedangkan kompres dingin umumnya digunakan untuk mengurangi nyeri akut akibat cedera atau trauma, seperti memar, terkilir, atau pasca tindakan bedah kecil. Penggunaan teknik fisik seperti ini harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan suhu kompres aman untuk kulit anak serta durasi penggunaannya tidak terlalu lama, agar terhindar dari iritasi atau cedera kulit tambahan.

G. Peran Perawat dalam Manajemen Nyeri pada Anak

Perawat memiliki peran yang sangat sentral dalam manajemen nyeri anak karena berada pada posisi yang dekat dan terus menerus berinteraksi dengan anak dan keluarganya selama proses perawatan. Peran ini mencakup berbagai tanggung jawab penting yang saling terkait, mulai dari melakukan pemantauan dan dokumentasi nyeri secara rutin, memberikan edukasi mendalam kepada keluarga tentang cara mengelola nyeri, hingga menjadi advokat yang efektif dalam menyuarakan kebutuhan anak terkait nyeri kepada tim kesehatan secara keseluruhan.

Salah satu peran utama perawat dalam manajemen nyeri anak adalah melakukan pemantauan dan dokumentasi nyeri yang komprehensif, tepat, dan berkesinambungan. Pemantauan ini melibatkan observasi langsung terhadap tanda-tanda nyeri yang ditunjukkan anak, seperti ekspresi wajah, perilaku menangis atau rewel, gerakan tubuh, serta perubahan tanda-tanda vital seperti frekuensi napas, denyut jantung, dan tekanan darah. Perawat harus memiliki kemampuan observasi yang tajam serta memahami karakteristik ekspresi nyeri sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak, terutama pada anak yang belum mampu menyampaikan rasa sakit secara verbal.

Selain observasi langsung, perawat juga perlu menggunakan alat ukur atau skala nyeri yang sudah tervalidasi untuk populasi pediatrik, seperti skala wajah Wong-Baker, skala FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability), atau Numeric Rating Scale (NRS) bagi anak yang lebih besar dan mampu berkomunikasi. Penggunaan alat ukur ini memastikan bahwa pengkajian nyeri dilakukan secara objektif, konsisten, serta dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Setiap hasil pemantauan nyeri ini harus didokumentasikan secara jelas dan sistematis dalam rekam medis anak, mencakup lokasi nyeri, intensitas nyeri, durasi nyeri, faktor pemicu atau pencetus nyeri, serta respons anak terhadap intervensi yang telah diberikan. Dokumentasi yang akurat ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas intervensi nyeri, memastikan keberlanjutan perawatan yang konsisten,

serta menjadi bahan referensi penting bagi tim medis lainnya dalam perencanaan perawatan yang lebih lanjut.

Peran penting berikutnya dari perawat dalam manajemen nyeri anak adalah memberikan edukasi yang efektif dan mendalam kepada keluarga tentang cara mengelola nyeri anak secara optimal. Edukasi keluarga sangat penting karena keluarga, terutama orang tua, merupakan pihak utama yang paling sering bersama anak, baik selama perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Oleh karena itu, perawat harus memastikan bahwa keluarga memahami dengan jelas mengenai konsep nyeri pada anak, mengenali tanda-tanda nyeri yang khas, memahami teknik penilaian nyeri sederhana yang dapat dilakukan di rumah, serta mengetahui berbagai metode penanganan nyeri yang aman dan efektif.

Edukasi yang diberikan kepada keluarga sebaiknya mencakup cara-cara spesifik untuk mengelola nyeri, baik secara farmakologis maupun non-farmakologis. Keluarga harus diberikan informasi rinci tentang jenis obat analgesik yang diresepkan, dosis yang tepat, waktu pemberian yang efektif, serta kemungkinan efek samping yang dapat terjadi. Perawat juga harus memberikan demonstrasi langsung atau pelatihan mengenai cara memberikan obat analgesik dengan benar, baik melalui rute oral, topikal, maupun parenteral, agar keluarga merasa percaya diri dalam merawat anaknya di rumah.

Di samping intervensi farmakologis, perawat juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi keluarga tentang intervensi non-farmakologis yang dapat mereka lakukan secara mandiri di rumah, seperti teknik relaksasi sederhana, distraksi menggunakan permainan atau aktivitas menyenangkan, terapi bermain, serta pijatan atau sentuhan terapeutik. Edukasi ini harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman keluarga serta budaya dan kebiasaan mereka, sehingga metode yang diajarkan dapat diterapkan secara optimal dan konsisten dalam keseharian anak.

Selain pemantauan dan edukasi keluarga, perawat juga memiliki peran penting sebagai advokat atau pendamping yang memperjuangkan kebutuhan nyeri anak di lingkungan pelayanan kesehatan. Peran advokasi ini melibatkan perawat dalam upaya aktif untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perhatian yang cukup terkait manajemen nyeri dari seluruh tim pelayanan kesehatan. Sebagai advokat, perawat harus mampu secara efektif menyampaikan kebutuhan nyeri anak kepada dokter, apoteker, dan anggota tim kesehatan lainnya, sehingga intervensi nyeri yang diberikan benar-benar memadai, tepat sasaran, serta konsisten dengan kebutuhan spesifik anak tersebut.

Advokasi yang dilakukan oleh perawat mencakup berbagai aspek penting. Perawat harus berani berbicara dan menyampaikan secara jelas kepada tim kesehatan jika intervensi nyeri yang sedang berjalan belum efektif atau jika ada

kebutuhan tambahan yang belum terpenuhi. Misalnya, jika anak menunjukkan gejala nyeri yang persisten meski sudah mendapatkan intervensi farmakologis, perawat harus proaktif dalam mengusulkan penyesuaian dosis obat, penambahan intervensi non-farmakologis, atau bahkan evaluasi ulang rencana perawatan secara keseluruhan.

Selain itu, advokasi yang dilakukan perawat juga melibatkan pembelaan terhadap hak anak untuk mendapatkan perawatan nyeri yang manusiawi, nyaman, dan penuh rasa hormat. Hal ini terutama penting ketika anak menjalani prosedur medis yang menyakitkan atau tidak nyaman, seperti pemasangan infus, kateterisasi, atau tindakan invasif lainnya. Dalam situasi ini, perawat perlu memastikan bahwa intervensi nyeri yang efektif sudah tersedia dan digunakan sebelum, selama, serta setelah prosedur dilakukan, sehingga anak merasa aman, nyaman, dan dihargai.

H. Pendekatan Psikososial dalam Manajemen Nyeri pada Anak

Pendekatan psikososial merupakan bagian yang sangat penting dan integral dalam manajemen nyeri pada anak, karena nyeri tidak hanya bersifat fisik tetapi juga sangat erat kaitannya dengan aspek psikologis, emosional, dan sosial. Dalam manajemen nyeri yang efektif, perhatian terhadap kondisi psikososial anak dan keluarga sangat diperlukan agar perawatan tidak hanya terbatas pada mengatasi gejala fisik semata, tetapi juga mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan emosional serta sosial anak secara menyeluruh.

Salah satu elemen utama dari pendekatan psikososial ini adalah pemberian dukungan emosional yang memadai bagi anak dan keluarganya. Dukungan emosional merupakan bentuk intervensi penting yang bertujuan membantu anak dan keluarganya mengatasi kecemasan, ketakutan, stres, serta perasaan tidak nyaman yang sering kali menyertai pengalaman nyeri. Anak-anak yang mengalami nyeri cenderung menunjukkan berbagai reaksi emosional negatif seperti kecemasan tinggi, rasa takut terhadap tindakan medis, dan seringkali mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaan sakit yang dialami secara jelas. Di sisi lain, keluarga, terutama orang tua, juga kerap mengalami stres emosional yang signifikan ketika melihat anak mereka kesakitan dan merasa tidak berdaya dalam membantu mengurangi rasa sakit tersebut.

Perawat, sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan anak dan keluarganya, memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan dukungan emosional yang mendalam. Dukungan ini dapat diberikan melalui berbagai cara, seperti menunjukkan empati yang tulus, menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan keluhan dan kekhawatiran anak serta orang tua, serta memberikan perhatian penuh saat mereka menyampaikan apa yang dirasakan. Dengan

mendengarkan secara aktif dan memberikan respons yang penuh empati, perawat mampu menciptakan suasana yang nyaman dan aman, sehingga anak merasa lebih tenang, tidak sendiri, dan merasa bahwa penderitaannya benar-benar dimengerti oleh perawat maupun keluarganya.

Selain memberikan dukungan emosional langsung, perawat juga perlu membantu anak dalam mengekspresikan perasaan atau ketakutan mereka dengan cara-cara yang tepat sesuai usia dan tahap perkembangannya. Misalnya, pada anak-anak usia dini atau balita, perawat dapat menggunakan media seperti boneka atau mainan untuk membantu anak mengungkapkan perasaan sakit, ketakutan, atau kecemasannya. Pada anak usia sekolah atau remaja, pendekatan yang lebih verbal atau diskusi terbuka bisa digunakan untuk mendorong mereka mengungkapkan perasaan secara jujur dan terbuka. Dengan cara ini, anak akan merasa lebih lega karena beban emosional yang dirasakan dapat terungkap, sekaligus memperkuat rasa percaya diri mereka dalam menghadapi situasi nyeri yang sulit.

Komponen berikutnya yang tidak kalah penting dalam pendekatan psikososial adalah penerapan komunikasi terapeutik yang efektif dalam penanganan nyeri. Komunikasi terapeutik merupakan suatu teknik komunikasi yang terencana dan sengaja digunakan oleh perawat dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman, meningkatkan rasa percaya, serta memperkuat hubungan interpersonal antara perawat, anak, dan keluarganya. Teknik komunikasi terapeutik dalam manajemen nyeri pada anak harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, kemampuan komunikasi, serta tahap perkembangan anak, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan efektif.

Dalam melakukan komunikasi terapeutik, perawat harus menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, ramah, serta penuh empati. Penjelasan tentang tindakan medis, prosedur yang akan dilakukan, atau metode manajemen nyeri yang akan diterapkan harus disampaikan secara bertahap dan mudah dipahami oleh anak dan keluarganya. Perawat juga perlu memberikan kesempatan bagi anak dan keluarga untuk bertanya atau menyampaikan kekhawatiran mereka secara terbuka. Selain itu, penggunaan kata-kata positif, pemberian pujian atas keberhasilan anak menghadapi rasa sakit, dan penguatan positif lainnya menjadi bagian integral dari komunikasi terapeutik yang efektif.

Komunikasi terapeutik yang efektif juga melibatkan kemampuan perawat dalam membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau perilaku anak yang mungkin tidak mampu secara verbal mengungkapkan rasa nyerinya. Dengan memahami pesan non-verbal tersebut, perawat dapat secara tepat dan cepat melakukan intervensi yang dibutuhkan, baik berupa intervensi farmakologis maupun non-farmakologis. Komunikasi terapeutik ini juga membantu memperkuat hubungan

kepercayaan antara anak, keluarga, dan perawat, yang merupakan dasar utama dalam keberhasilan penanganan nyeri jangka panjang.

Pendekatan penting lain yang menjadi bagian sentral dalam pendekatan psikososial manajemen nyeri anak adalah konsep family-centered care atau perawatan berpusat pada keluarga. Pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai bagian integral dari tim pelayanan kesehatan, mengakui pentingnya peran keluarga dalam memberikan dukungan yang esensial selama proses perawatan. Dalam konteks manajemen nyeri pada anak, family-centered care berarti bahwa keluarga harus secara aktif dilibatkan dalam setiap tahapan proses perawatan nyeri, mulai dari pengkajian, perencanaan, hingga implementasi intervensi yang dilakukan.

Penerapan family-centered care mengharuskan perawat memberikan ruang dan waktu khusus untuk mendiskusikan kondisi anak, kebutuhan nyeri, serta rencana pengelolaan nyeri bersama keluarga secara terbuka. Perawat perlu mendengar dan mempertimbangkan dengan serius preferensi serta pendapat keluarga mengenai jenis intervensi yang paling nyaman bagi anak mereka. Dengan melibatkan keluarga secara aktif, keluarga akan merasa dihargai, merasa memiliki kontrol dalam proses pengelolaan nyeri, serta mampu memberikan perawatan di rumah dengan lebih percaya diri dan konsisten.

Family-centered care juga mendorong adanya kolaborasi dan koordinasi yang erat antara perawat, dokter, keluarga, serta anggota tim kesehatan lainnya. Keluarga harus selalu diberi informasi terkini tentang perkembangan kondisi anak, perubahan rencana perawatan, serta respons anak terhadap intervensi nyeri yang diberikan. Dengan cara ini, keluarga merasa menjadi bagian aktif dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan dan mempercepat proses pemulihan anak.

I. Teknologi dan Inovasi Terkini dalam Manajemen Nyeri Pediatrik

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai inovasi terbaru mulai dimanfaatkan secara luas dalam bidang kesehatan, khususnya dalam manajemen nyeri pediatrik. Pendekatan teknologi ini membawa perubahan signifikan, meningkatkan efisiensi perawatan, mengoptimalkan pemantauan kondisi anak secara real-time, serta memperkuat keterlibatan keluarga dalam proses manajemen nyeri. Dalam konteks manajemen nyeri pediatrik, teknologi dan inovasi terbaru mencakup penerapan teknologi digital, pemanfaatan telehealth atau layanan kesehatan jarak jauh, penggunaan aplikasi atau alat bantu pemantauan nyeri, serta perkembangan berbagai tren penelitian terbaru yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas perawatan nyeri pada anak.

Salah satu inovasi utama yang kini banyak digunakan adalah penerapan teknologi digital dan telehealth. Telehealth merupakan model pelayanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan medis dan keperawatan jarak jauh secara virtual. Dalam manajemen nyeri pediatrik, penggunaan telehealth memberikan solusi efektif terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, seperti mereka yang tinggal di daerah pedesaan, terpencil, atau bahkan di perkotaan yang sibuk dengan mobilitas tinggi. Dengan telehealth, keluarga dapat dengan mudah berkomunikasi secara virtual dengan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis nyeri anak, perawat, psikolog, atau ahli terapi lainnya, tanpa harus datang langsung ke rumah sakit atau klinik.

Telehealth memungkinkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan pengkajian nyeri secara virtual melalui video call atau aplikasi khusus, memberikan konsultasi secara cepat dan efisien tentang manajemen nyeri, serta melakukan edukasi terhadap keluarga tentang cara mengatasi nyeri pada anak di rumah. Selain itu, telehealth juga memberikan kemudahan dalam pemantauan kondisi nyeri secara rutin. Misalnya, keluarga dapat melaporkan perkembangan kondisi anak secara real-time melalui aplikasi atau platform khusus, sehingga tenaga kesehatan dapat segera memberikan saran atau intervensi tambahan jika diperlukan. Pendekatan ini sangat membantu dalam mempercepat respons terhadap perubahan kondisi nyeri anak, mengurangi tingkat stres keluarga, serta memastikan bahwa pengelolaan nyeri dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan profesional yang selalu tersedia.

Selanjutnya, teknologi digital yang semakin berkembang juga memungkinkan munculnya berbagai aplikasi dan alat bantu inovatif yang sangat berguna dalam pemantauan nyeri anak. Saat ini, telah tersedia berbagai aplikasi berbasis smartphone maupun tablet yang dirancang khusus untuk membantu keluarga dan tenaga kesehatan dalam mencatat, memantau, serta mengelola nyeri anak secara lebih terstruktur dan efisien. Aplikasi-aplikasi ini biasanya dilengkapi fitur-fitur menarik seperti skala nyeri visual yang interaktif, jurnal digital untuk mencatat pola nyeri harian, pengingat pemberian obat analgesik, serta rekomendasi intervensi non-farmakologis yang disesuaikan dengan usia dan kondisi anak.

Contoh aplikasi populer yang sering digunakan dalam pemantauan nyeri pediatrik adalah aplikasi dengan skala nyeri digital interaktif seperti Wong-Baker FACES Pain Rating Scale atau FLACC yang dapat dengan mudah digunakan oleh anak maupun orang tua. Aplikasi ini memungkinkan anak atau keluarga untuk secara rutin melaporkan intensitas nyeri melalui gambar ekspresi wajah, warna, atau ikon yang mudah dipahami oleh anak. Data yang dikumpulkan aplikasi tersebut akan

secara otomatis tersimpan dalam bentuk jurnal digital yang mudah diakses oleh tenaga kesehatan. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat melakukan pemantauan nyeri secara lebih detail, melihat pola perkembangan nyeri, serta membuat keputusan klinis berdasarkan data yang akurat dan terstruktur.

Selain aplikasi smartphone, berbagai perangkat wearable atau alat bantu yang dapat dipakai juga mulai dikembangkan untuk membantu pemantauan nyeri secara lebih objektif dan terus-menerus. Perangkat-perangkat ini mampu mengukur berbagai parameter fisiologis seperti denyut jantung, suhu tubuh, tingkat stres, hingga kualitas tidur anak secara kontinu. Data ini memberikan informasi penting tentang bagaimana nyeri mempengaruhi kondisi fisik dan emosional anak. Dengan integrasi data tersebut, tenaga kesehatan dapat memperoleh gambaran komprehensif dan real-time mengenai kondisi nyeri anak, yang memungkinkan intervensi lebih cepat dan lebih tepat sasaran dalam mengelola nyeri.

Di samping penerapan teknologi digital dan telehealth, tren penelitian terkini dalam manajemen nyeri pediatrik juga menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Saat ini, berbagai penelitian ilmiah sedang gencar dilakukan untuk mengeksplorasi metode manajemen nyeri yang lebih efektif dan efisien bagi populasi anak. Salah satu tren penelitian terbaru adalah penggunaan virtual reality (VR) sebagai teknik distraksi yang sangat efektif dalam mengurangi persepsi nyeri pada anak, terutama saat menjalani prosedur medis yang menyakitkan. Melalui VR, anak dapat diajak untuk berinteraksi dengan lingkungan virtual yang menyenangkan, menarik perhatian mereka sehingga secara signifikan mengurangi persepsi nyeri.

Selain VR, penelitian juga sedang mengembangkan intervensi berbasis biofeedback, di mana anak diajarkan untuk mengenali tanda-tanda tubuh mereka sendiri, seperti peningkatan denyut jantung atau ketegangan otot, dan kemudian diberikan pelatihan untuk mengontrol respons tubuh terhadap nyeri melalui teknik relaksasi dan visualisasi yang spesifik. Teknik ini sangat menjanjikan karena memberikan kemampuan bagi anak untuk secara mandiri mengendalikan rasa nyeri mereka sendiri melalui keterampilan yang dipelajari, yang secara langsung berkontribusi terhadap pengurangan kecemasan, peningkatan rasa percaya diri, dan penurunan ketergantungan terhadap penggunaan obat analgesik secara berlebihan.

Tren penelitian lainnya adalah pengembangan algoritma berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu memprediksi tingkat nyeri anak berdasarkan data-data klinis dan fisiologis yang dikumpulkan melalui perangkat wearable. Algoritma ini mampu memberikan prediksi tingkat nyeri secara real-time, memungkinkan tenaga kesehatan untuk segera mengambil langkah-langkah intervensi sebelum nyeri

mencapai tingkat yang tinggi dan sulit dikontrol. Dengan adanya teknologi ini, pengelolaan nyeri pada anak menjadi lebih preventif dan proaktif, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup anak.

J. Tantangan dan Rekomendasi dalam Manajemen Nyeri pada Anak

Manajemen nyeri pada anak merupakan proses yang kompleks dan menantang, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang aspek klinis, psikologis, sosial, serta pendekatan terapeutik yang tepat. Meskipun berbagai inovasi dan kemajuan telah dikembangkan untuk memperbaiki praktik ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan sehari-hari. Tantangan ini tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga mencakup aspek psikososial, kultural, serta sistem pelayanan kesehatan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan nyeri pediatrik.

Salah satu tantangan utama dalam manajemen nyeri pediatrik adalah kesulitan dalam melakukan pengkajian dan pengukuran nyeri secara akurat, khususnya pada anak-anak usia dini atau bayi yang belum dapat mengungkapkan rasa nyerinya secara verbal. Keterbatasan bahasa, kemampuan kognitif, dan komunikasi pada anak usia dini sering kali menyulitkan tenaga kesehatan untuk memahami tingkat keparahan nyeri yang dialami anak. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa manifestasi nyeri pada anak sangat bervariasi, mulai dari tangisan, perilaku rewel, penolakan terhadap aktivitas, hingga perubahan pada tanda-tanda vital. Oleh karena itu, tenaga kesehatan sering kali harus mengandalkan alat bantu pengkajian khusus seperti skala nyeri berbasis observasi (misalnya skala FLACC atau CRIES) untuk menilai kondisi anak secara lebih objektif. Meskipun alat-alat ini tersedia, penggunaannya yang tidak konsisten dan kurangnya pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan primer menjadi hambatan besar dalam pengelolaan nyeri yang efektif.

Selain tantangan pengkajian nyeri, hambatan lainnya yang sering muncul adalah minimnya kesadaran dan pemahaman yang tepat mengenai pentingnya manajemen nyeri pada anak di kalangan tenaga kesehatan, keluarga, maupun masyarakat luas. Masih terdapat anggapan keliru di kalangan masyarakat dan bahkan tenaga kesehatan bahwa anak-anak, terutama bayi, tidak merasakan nyeri dengan intensitas yang sama seperti orang dewasa atau bahwa nyeri pada anak akan hilang dengan sendirinya tanpa intervensi khusus. Pandangan yang keliru ini mengarah pada *under-treatment* atau kurang optimalnya penanganan nyeri, terutama pada anak-anak yang menjalani prosedur medis invasif seperti pemasangan infus, pengambilan darah, atau prosedur bedah. Kurangnya edukasi yang memadai terhadap keluarga dan tenaga kesehatan mengenai pentingnya

manajemen nyeri yang tepat juga semakin memperburuk situasi ini, mengakibatkan tingginya tingkat stres dan kecemasan pada anak maupun keluarganya.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan dalam penerapan intervensi farmakologis yang aman dan efektif bagi anak-anak, terutama bayi dan balita. Anak-anak memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda dibandingkan orang dewasa, seperti metabolisme obat yang berbeda, sensitivitas yang lebih tinggi terhadap efek samping obat, serta risiko lebih besar terhadap toksisitas. Akibatnya, pemilihan obat analgesik yang aman, penentuan dosis yang tepat, serta cara pemberian obat yang sesuai pada populasi anak menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh tenaga kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan yang kurang memiliki tenaga spesialis atau apoteker pediatrik yang terlatih. Di sisi lain, ketakutan akan efek samping serta risiko ketergantungan atau overdosis analgesik sering kali menyebabkan tenaga kesehatan atau keluarga menjadi ragu dalam memberikan pengobatan analgesik yang memadai, sehingga nyeri tidak terkontrol dengan baik.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa strategi efektif dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat yang berperan sentral dalam pengelolaan nyeri pediatrik. Strategi pertama adalah peningkatan pelatihan dan edukasi tenaga kesehatan terkait manajemen nyeri anak, termasuk cara menggunakan alat pengkajian nyeri secara tepat dan konsisten. Pelatihan ini harus bersifat menyeluruh, praktis, dan rutin, sehingga seluruh tenaga kesehatan, mulai dari perawat hingga dokter, memiliki keterampilan yang cukup untuk menilai dan mengelola nyeri secara optimal. Pelatihan juga perlu mencakup pemahaman tentang farmakokinetik dan farmakodinamik obat analgesik pada anak, termasuk cara mengelola efek samping secara aman, sehingga ketakutan akan penggunaan obat analgesik dapat diminimalkan.

Strategi kedua yang penting dilakukan adalah edukasi intensif terhadap keluarga dan masyarakat tentang pentingnya manajemen nyeri yang tepat pada anak. Edukasi ini harus menyampaikan informasi yang jelas, akurat, serta disampaikan dengan pendekatan yang ramah budaya agar dapat dipahami dengan baik oleh semua lapisan masyarakat. Perawat dapat menggunakan berbagai media edukasi yang menarik seperti leaflet, video edukasi, media sosial, hingga pendekatan berbasis komunitas untuk menyampaikan pesan penting tentang cara mengenali tanda nyeri pada anak, pentingnya intervensi dini, serta cara-cara praktis mengatasi nyeri secara farmakologis dan non-farmakologis di rumah. Edukasi ini secara langsung akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan keluarga dalam melaksanakan strategi manajemen nyeri yang efektif.

Selanjutnya, strategi mengatasi tantangan manajemen nyeri pediatrik juga dapat dilakukan melalui implementasi pendekatan interprofesional yang

terkoordinasi. Kolaborasi interprofesional yang melibatkan dokter spesialis anak, perawat, farmasis, psikolog, ahli terapi, dan tenaga kesehatan lainnya sangat penting untuk merancang rencana pengelolaan nyeri yang terintegrasi dan komprehensif. Dengan kolaborasi ini, berbagai kebutuhan anak dalam mengelola nyeri, baik kebutuhan fisik, psikologis, maupun sosial, dapat dipenuhi secara menyeluruh. Pendekatan kolaboratif juga memungkinkan adanya konsensus dalam menentukan terapi terbaik, mengurangi kesalahan medis, serta meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Berdasarkan berbagai tantangan yang telah diuraikan, beberapa rekomendasi praktis maupun rekomendasi masa depan perlu menjadi perhatian utama dalam pengembangan praktik manajemen nyeri pediatrik. Rekomendasi praktis pertama adalah perlunya integrasi rutin antara pengkajian nyeri sebagai bagian dari standar perawatan pada seluruh fasilitas kesehatan pediatrik, baik primer maupun sekunder. Hal ini mencakup penggunaan alat ukur nyeri yang terstandar secara nasional serta dokumentasi yang jelas dalam rekam medis anak. Dengan demikian, pengelolaan nyeri akan dilakukan secara sistematis, terukur, dan konsisten.

Rekomendasi berikutnya adalah perlunya pengembangan panduan klinis nasional yang berbasis bukti (evidence-based guidelines) yang spesifik untuk manajemen nyeri pediatrik. Panduan ini akan menjadi acuan penting bagi tenaga kesehatan dalam memilih intervensi farmakologis maupun non-farmakologis yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan anak. Di masa depan, sangat disarankan untuk memperluas pemanfaatan teknologi digital dan telehealth dalam manajemen nyeri, termasuk aplikasi berbasis smartphone untuk pemantauan nyeri, serta penggunaan virtual reality (VR) sebagai intervensi distraksi efektif dalam berbagai tindakan medis yang menyakitkan.

Selain itu, pengembangan penelitian yang lebih intensif terkait manajemen nyeri anak perlu terus didorong. Penelitian ini harus mencakup aspek-aspek seperti pengembangan alat ukur nyeri yang lebih sensitif, evaluasi efektivitas berbagai intervensi baru, serta eksplorasi lebih dalam tentang dampak psikososial nyeri pada anak dan keluarga. Dengan adanya penelitian lanjutan ini, bukti ilmiah yang lebih kuat dapat dihasilkan sebagai dasar pengembangan praktik terbaik di masa depan.

Dengan memahami dan mengatasi berbagai tantangan ini, serta mengimplementasikan rekomendasi praktis yang diberikan, diharapkan kualitas manajemen nyeri pada anak dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini tidak hanya akan membantu mengurangi penderitaan fisik anak, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan psikologis dan emosional anak serta keluarganya senantiasa terjaga dengan baik. Pada akhirnya, pendekatan ini akan mendukung pencapaian

tujuan utama pelayanan kesehatan pediatrik, yakni kualitas hidup anak yang lebih baik secara keseluruhan.

K. Simpulan

Manajemen nyeri pada anak merupakan bagian esensial dalam praktik pediatrik yang membutuhkan pendekatan komprehensif, multidisiplin, dan berpusat pada keluarga. Nyeri pada anak, baik akut, kronis, maupun prosedural, adalah pengalaman kompleks yang tidak hanya melibatkan aspek fisik tetapi juga psikologis, emosional, dan sosial. Pengkajian nyeri yang akurat melalui alat ukur spesifik, seperti skala Wong-Baker dan FLACC, merupakan langkah penting dalam memberikan intervensi nyeri yang tepat dan efektif.

Intervensi farmakologis seperti parasetamol, NSAID, dan analgesik opioid, harus diberikan dengan hati-hati, memperhatikan aspek keamanan, dosis sesuai usia dan berat badan anak, serta pemantauan efek samping yang ketat. Sementara intervensi non-farmakologis, termasuk teknik relaksasi, distraksi, terapi bermain, sentuhan terapeutik, serta kompres fisik, berperan sebagai metode aman dan efektif yang mendukung pengelolaan nyeri secara holistik.

Perawat memiliki peran sentral dalam pemantauan nyeri, edukasi keluarga, advokasi kebutuhan anak, serta penerapan pendekatan psikososial melalui komunikasi terapeutik dan family-centered care. Inovasi teknologi terkini seperti telehealth, aplikasi digital, perangkat wearable, dan virtual reality juga semakin meningkatkan efektivitas manajemen nyeri anak.

Namun, berbagai tantangan seperti kesulitan pengkajian nyeri pada anak yang masih sangat muda, kurangnya kesadaran tenaga kesehatan dan masyarakat, serta risiko penggunaan analgesik pada anak, masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pelatihan intensif tenaga kesehatan, edukasi kepada keluarga, kolaborasi interprofesional yang efektif, serta pengembangan panduan klinis berbasis bukti.

Dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup anak, meminimalkan dampak negatif nyeri, serta menciptakan pengalaman positif dalam perawatan pediatrik secara keseluruhan.

L. Referensi

- Aydede, M. (Ed.). (2019). *Pain: New essays on its nature and the methodology of its study*. MIT Press.
- Birnie, K. A., Chambers, C. T., Fernandez, C. V., Forgeron, P. A., Latimer, M. A., McGrath, P. J., ... Finley, G. A. (2019). Hospitalized children continue to report undertreated and preventable pain. *Pain Research and Management*, 2019, 1–9. <https://doi.org/10.1155/2019/9320427>
- Chiaretti, A., Pierri, F., Valentini, P., Russo, I., Gargiullo, L., & Riccardi, R. (2021). Current practice and recent advances in pediatric pain management. *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*, 25(1), 318–332. https://doi.org/10.26355/eurev_202101_24426
- Eccleston, C., Fisher, E., Howard, R. F., Slater, R., Forgeron, P., Palermo, T. M., ... Tibboel, D. (2021). Delivering transformative action in paediatric pain: A Lancet Child & Adolescent Health Commission. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 5(1), 47–87. [https://doi.org/10.1016/s2352-4642\(20\)30277-7](https://doi.org/10.1016/s2352-4642(20)30277-7)
- Friedrichsdorf, S. J., Goubert, L., & Braodbent, E. (2018). Chronic pain in children and adolescents: Diagnosis and treatment of primary pain disorders in head, abdomen, muscles and joints. *Children*, 5(1), 1–27. <https://doi.org/10.3390/children5010001>
- International Association for the Study of Pain (IASP). (2020). IASP definition of pain. Diakses dari <https://www.iasp-pain.org/resources/terminology/#pain>
- Manworren, R. C., & Stinson, J. (2016). Pediatric pain measurement, assessment, and evaluation. *Seminars in Pediatric Neurology*, 23(3), 189–200. <https://doi.org/10.1016/j.spen.2016.10.001>
- Moore, R. A., Wiffen, P. J., Derry, S., & Maguire, T. (2018). Non-prescription (OTC) oral analgesics for acute pain—an overview of Cochrane reviews. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2018(11), CD010794. <https://doi.org/10.1002/14651858.cd010794.pub2>
- Palermo, T. M., & Eccleston, C. (2019). Parents of children and adolescents with chronic pain. *Pain*, 160(Suppl 1), S1–S3. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001509>
- Pancekauskaitė, G., & Jankauskaitė, L. (2018). Paediatric pain medicine: Pain differences, recognition and coping acute procedural pain in paediatric emergency room. *Medicina (Kaunas)*, 54(6), 94. <https://doi.org/10.3390/medicina54060094>
- Pancekauskaitė, G., & Jankauskaitė, L. (2022). Emerging technologies for pediatric pain management: Telemedicine, wearable devices, and virtual reality. *Children*, 9(2), 174. <https://doi.org/10.3390/children9020174>
- Thrane, S. E., Wanless, S., Cohen, S. M., & Danford, C. A. (2016). The assessment and

non-pharmacologic treatment of procedural pain from infancy to school age through a developmental lens: A synthesis of evidence with recommendations. *Journal of Pediatric Nursing*, 31(1), e23–e32. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2015.09.002>

Twycross, A., Dowden, S., & Bruce, E. (2018). *Managing pain in children: A clinical guide for nurses and healthcare professionals* (2nd ed.). Wiley Blackwell.

Wong, C., Lau, E., Palozzi, L., & Campbell, F. (2019). Pain management in children: Part 2 — A transition from codeine to morphine for moderate to severe pediatric pain. *Canadian Family Physician*, 65(4), 247–249.

Wong-Baker FACES Foundation. (2021). Wong-Baker FACES Pain Rating Scale. Diakses dari <https://wongbakerfaces.org/>

World Health Organization. (2020). WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses. World Health Organization. Diakses dari <https://www.who.int/publications/i/item/9789241548120>

M. Glosarium

Analgesik

Obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri

Biofeedback

Teknik yang membantu individu mengontrol respons fisiologis tubuh melalui umpan balik real-time seperti denyut jantung atau ketegangan otot

Distraksi

Teknik pengalihan perhatian anak dari nyeri dengan memberikan aktivitas atau stimulus lain yang menarik

Epidemiologi Nyeri

Studi tentang distribusi dan prevalensi nyeri dalam populasi anak

Family-Centered Care

Pendekatan perawatan yang melibatkan keluarga secara aktif dalam semua tahap pengelolaan nyeri pada anak

Farmakodinamik

Studi tentang efek obat terhadap tubuh, termasuk mekanisme kerjanya

Farmakokinetik

Studi tentang bagaimana tubuh menyerap, mendistribusikan, metabolisme, dan mengeliminasi obat

Intervensi Farmakologis

Pendekatan pengelolaan nyeri menggunakan obat-obatan seperti analgesik non-opioid dan opioid

Intervensi Non-Farmakologis

Pendekatan pengelolaan nyeri tanpa menggunakan obat, seperti relaksasi, pijat, atau terapi bermain

Nyeri Akut

Nyeri dengan onset tiba-tiba, intensitas bervariasi, dan durasi relatif singkat

Nyeri Kronis

Nyeri dengan durasi lama, biasanya lebih dari tiga bulan, yang sering dikaitkan dengan kondisi medis kronis

Nyeri Prosedural

Nyeri yang terjadi secara spesifik akibat tindakan medis invasif

Opioid

Jenis obat analgesik kuat seperti morfin atau fentanyl yang digunakan untuk nyeri berat

Pengkajian Nyeri

Proses sistematis dalam mengidentifikasi intensitas, lokasi, sifat, dan penyebab nyeri pada anak

Persepsi Nyeri

Proses interpretasi sensoris dan emosional seseorang terhadap pengalaman nyeri

Play Therapy (Terapi Bermain)

Teknik terapeutik yang menggunakan aktivitas permainan sebagai media untuk mengatasi nyeri dan dampak emosionalnya pada anak

Skala FLACC

Alat ukur nyeri yang mengamati ekspresi wajah, gerakan kaki, aktivitas, tangisan, dan kemampuan ditenangkan pada anak

Skala Wong-Baker

Skala nyeri yang menggunakan gambar wajah dengan ekspresi berbeda untuk menilai intensitas nyeri pada anak

Telehealth

Layanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi untuk konsultasi dan pemantauan kondisi pasien

Virtual Reality (VR)

Teknologi simulasi yang menciptakan lingkungan virtual untuk distraksi efektif dalam mengurangi persepsi nyeri pada anak

CHAPTER 8

KEPERAWATAN ANAK DALAM SITUASI KEGAWATDARURATAN

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.

A. Pendahuluan/Prolog

Situasi kegawatdaruratan pada anak merupakan kondisi klinis yang muncul secara tiba-tiba dan membutuhkan intervensi yang cepat, tepat, serta akurat guna mencegah risiko kecacatan bahkan kematian pada anak. Anak memiliki karakteristik anatomi, fisiologi, dan psikologis yang sangat berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Perbedaan ini mencakup ukuran tubuh yang lebih kecil, sistem pernapasan dan kardiovaskular yang belum matang sepenuhnya, serta kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal yang terbatas, terutama pada usia dini. Oleh karena itu, konsep dasar kegawatdaruratan pada anak harus dipahami dengan baik oleh tenaga keperawatan, termasuk mengenali kondisi darurat yang umum terjadi pada kelompok usia ini, seperti gangguan napas akut, gangguan sirkulasi, trauma berat, hingga kegawatan neurologis seperti kejang-kejang atau cedera kepala.

Dalam menangani situasi kegawatdaruratan pada anak, perawat harus memahami prinsip-prinsip umum keperawatan kegawatdaruratan anak. Prinsip ini mencakup kemampuan melakukan triase secara cepat dan efektif untuk menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat keparahan pasien. Salah satu metode yang umum digunakan adalah pendekatan ABCDE, yaitu Airway (jalan napas), Breathing (pernapasan), Circulation (sirkulasi darah), Disability (status neurologis), dan Exposure (pemeriksaan seluruh tubuh). Dalam situasi kritis, prinsip ini membantu perawat dalam menilai secara cepat kondisi vital anak, mengambil keputusan klinis yang tepat, serta menentukan tindakan keperawatan maupun medis yang dibutuhkan secara mendesak. Selain prinsip ABCDE, perawat juga harus mampu mengenali tanda-tanda klinis bahaya yang spesifik pada anak, seperti penurunan kesadaran, gangguan napas yang berat, serta tanda-tanda syok seperti pucat, denyut nadi cepat, dan ekstremitas yang dingin.

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam situasi kegawatdaruratan anak. Peran ini tidak hanya terbatas pada pemberian intervensi klinis seperti resusitasi kardiopulmoner, pemasangan infus, atau pemberian oksigen, tetapi juga mencakup aspek psikososial seperti komunikasi terapeutik kepada anak maupun keluarga. Dalam kondisi darurat, keluarga dan orang tua sering kali mengalami

kepanikan, kecemasan, bahkan stres emosional yang tinggi. Di sinilah perawat memainkan peran penting sebagai pemberi dukungan emosional, edukator, sekaligus fasilitator dalam komunikasi antara tim medis dan keluarga pasien. Selain itu, perawat juga berperan dalam kolaborasi interprofesional, yaitu bekerja sama dengan dokter, apoteker, ahli gizi, serta petugas medis lainnya untuk memastikan pemberian asuhan yang optimal dan terpadu. Dalam konteks ini, kemampuan komunikasi efektif, kerja tim yang solid, serta ketangkasan dan ketepatan dalam melakukan tindakan sangat dibutuhkan oleh perawat sebagai bagian integral dari tim kegawatdaruratan anak.

Dengan memahami konsep dasar kegawatdaruratan anak, menerapkan prinsip-prinsip keperawatan yang tepat, dan menjalankan peran secara efektif, perawat dapat membantu meningkatkan peluang kesembuhan, mencegah komplikasi lebih lanjut, serta mendukung pemulihan fisik dan emosional pasien maupun keluarganya dalam situasi kegawatdaruratan anak.

B. Pengkajian Awal pada Anak dalam Kondisi Gawat Darurat

Pengkajian awal merupakan tahap kritis dalam penanganan anak yang mengalami kondisi gawat darurat. Tahapan ini menjadi penentu utama dalam memastikan intervensi yang diberikan tepat dan sesuai prioritas, karena kondisi anak dapat berubah secara cepat dan tidak dapat diprediksi. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis depan penanganan kegawatdaruratan pediatrik harus menguasai pengkajian awal ini secara menyeluruh, mulai dari metode triase, penilaian kondisi fisik secara cepat melalui pendekatan ABCDE, hingga penilaian terhadap rasa nyeri dan respons neurologis anak.

Pengkajian awal pada kondisi gawat darurat anak diawali dengan proses triase pediatrik (*pediatric triage*). Triase pediatrik adalah metode evaluasi awal yang digunakan untuk menentukan tingkat kegawatan dan menetapkan prioritas tindakan medis maupun keperawatan pada anak yang datang ke instalasi gawat darurat. Dalam praktiknya, proses triase pediatrik bertujuan untuk secara cepat mengidentifikasi pasien anak yang memerlukan tindakan segera, pasien yang kondisinya berisiko tinggi namun dapat menunggu beberapa saat, serta pasien yang kondisinya stabil. Perawat akan menggunakan indikator klinis seperti tingkat kesadaran, pola pernapasan, sirkulasi perifer, tanda vital, serta adanya cedera atau nyeri berat sebagai acuan untuk menentukan kategori kegawatdaruratan anak. Triase pediatrik ini biasanya menggunakan sistem warna untuk memudahkan identifikasi tingkat keparahan, yaitu warna merah untuk sangat kritis (harus segera ditangani), kuning untuk gawat namun masih dapat menunggu beberapa saat, hijau

untuk pasien stabil, dan hitam untuk anak dengan kondisi tidak tertolong atau meninggal.

Setelah proses triase dilakukan, pengkajian berikutnya menggunakan pendekatan ABCDE. Pendekatan ABCDE merupakan metode penilaian yang sistematis dan terstruktur terhadap kondisi klinis pasien secara cepat dan menyeluruh. Langkah pertama yaitu pengkajian terhadap Airway (jalan napas), yaitu memastikan bahwa jalan napas anak tidak tersumbat atau mengalami obstruksi. Pada tahap ini, perawat memeriksa apakah anak mampu bernapas dengan normal, ada atau tidaknya benda asing, adanya retraksi dinding dada, stridor, atau bunyi napas abnormal lainnya. Tahap selanjutnya adalah Breathing (pernapasan), di mana perawat mengevaluasi pola pernapasan anak, laju napas, saturasi oksigen, penggunaan otot bantu napas, serta adanya sianosis atau tanda hipoksia lainnya. Berikutnya, Circulation (sirkulasi), yaitu memastikan perfusi darah ke seluruh tubuh cukup dengan mengecek denyut nadi, tekanan darah, warna kulit, suhu ekstremitas, serta tanda-tanda syok seperti pucat, kulit lembap dingin, denyut nadi cepat, dan tekanan darah rendah.

Setelah memastikan stabilitas jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi, perawat melanjutkan pengkajian dengan Disability (status neurologis atau disabilitas). Pada tahap ini, perawat mengukur tingkat kesadaran anak menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS) khusus anak atau AVPU (Alert, Voice, Pain, Unresponsive) untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi neurologis anak secara cepat. Penilaian ini sangat penting, terutama pada kasus trauma kepala, kejang, atau kondisi yang menyebabkan penurunan kesadaran mendadak. Langkah terakhir dalam pendekatan ABCDE adalah Exposure (eksposur), yakni mengekspos tubuh pasien secara menyeluruh namun tetap menjaga kehangatan tubuhnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menemukan adanya cedera tersembunyi, luka bakar, perdarahan, atau tanda-tanda lain yang mungkin tidak tampak pada pemeriksaan awal. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, perawat harus tetap mempertahankan privasi dan menjaga suhu tubuh anak agar tidak terjadi hipotermia akibat paparan lingkungan yang dingin.

Selain pendekatan ABCDE, aspek penting lainnya dalam pengkajian awal pada anak dalam kondisi gawat darurat adalah penilaian nyeri dan respons neurologis secara spesifik. Nyeri pada anak seringkali sulit dinilai karena terbatasnya kemampuan verbal anak, terutama anak usia balita atau bayi. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk menggunakan berbagai skala penilaian nyeri yang sesuai dengan usia anak, seperti FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) untuk anak kecil atau skala wajah (Wong-Baker Faces Pain Rating Scale) untuk anak yang lebih

besar. Penilaian nyeri secara akurat sangat penting untuk menentukan tindakan analgesik yang tepat dan memastikan kenyamanan pasien.

Selain nyeri, respons neurologis juga wajib dikaji secara detail. Respons neurologis mencakup tingkat kesadaran, respons pupil terhadap cahaya, refleks tubuh, hingga respons motorik dan sensorik anak. Kondisi neurologis yang buruk bisa menjadi tanda adanya cedera otak, infeksi sistem saraf pusat seperti meningitis atau ensefalitis, atau efek dari gangguan metabolik berat seperti hipoglikemia atau ketoasidosis diabetik. Deteksi dini terhadap gangguan neurologis ini sangat krusial, sebab intervensi yang tertunda dapat menyebabkan kerusakan permanen, kecacatan, bahkan kematian pada anak.

C. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Respirasi pada Anak

Salah satu kondisi gawat darurat yang paling sering terjadi pada anak adalah gangguan sistem respirasi atau pernapasan. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus karena struktur anatomi dan fisiologi jalan napas pada anak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan orang dewasa. Diameter saluran napas anak yang kecil serta ketidakmatangan organ-organ respirasi menyebabkan anak lebih rentan mengalami gangguan pernapasan yang bisa berkembang menjadi kondisi kritis secara cepat. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memahami secara mendalam dan terperinci mengenai berbagai bentuk kegawatdaruratan respirasi yang umum dijumpai pada anak, serta penatalaksanaan yang tepat dan efisien untuk setiap kondisi tersebut.

Salah satu bentuk kegawatdaruratan respirasi pada anak yang paling sering ditemukan adalah obstruksi jalan napas akut, yang biasanya disebabkan oleh benda asing atau tersedak makanan. Kondisi ini sering terjadi pada anak usia balita karena anak-anak pada usia ini cenderung mengeksplorasi lingkungan dengan memasukkan benda asing atau makanan ke dalam mulut tanpa kontrol. Gejala yang muncul pada obstruksi jalan napas akut berupa kesulitan bernapas mendadak, batuk hebat, wajah menjadi kebiruan (sianosis), dan tidak mampu bersuara atau menangis. Penanganan yang tepat adalah segera membuka dan membersihkan jalan napas dengan manuver tertentu, seperti back blows (pukulan punggung) dan chest thrusts (tekanan dada) pada bayi, atau Heimlich maneuver pada anak yang lebih besar. Jika tindakan tersebut gagal, perawat harus segera mengaktifkan tim medis untuk intervensi yang lebih lanjut seperti intubasi endotrakeal atau trakeostomi darurat.

Selain obstruksi jalan napas akut, asma akut berat juga merupakan kegawatdaruratan respirasi pada anak yang sering ditemui. Kondisi ini terjadi ketika serangan asma yang dialami anak semakin memburuk, menyebabkan jalan napas menyempit secara signifikan, peradangan berat, dan peningkatan produksi lendir

yang menyumbat saluran pernapasan. Anak dengan asma akut berat biasanya mengalami kesulitan bernapas hebat, napas yang cepat dan dangkal, retraksi dinding dada, wheezing (bunyi mengi yang terdengar jelas), serta perubahan tingkat kesadaran akibat kekurangan oksigen. Penatalaksanaan utama untuk asma akut berat meliputi pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi, inhalasi bronkodilator seperti salbutamol secara intensif, serta pemberian kortikosteroid sistemik untuk mengurangi peradangan jalan napas. Perawat juga harus memonitor ketat status pernapasan dan tanda vital anak, serta menyiapkan intervensi lanjutan seperti ventilasi mekanik jika kondisi anak terus memburuk.

Epiglottitis akut juga merupakan kegawatdaruratan respirasi pada anak yang membutuhkan perhatian serius karena dapat menyebabkan obstruksi total jalan napas dengan sangat cepat. Epiglottitis adalah peradangan akut pada epiglottis, yaitu tulang rawan kecil yang berfungsi menutup jalan napas saat menelan makanan. Kondisi ini sering disebabkan oleh infeksi bakteri *Haemophilus influenzae* tipe B (Hib). Anak yang mengalami epiglottitis akut biasanya menunjukkan gejala klasik seperti demam tinggi mendadak, kesulitan menelan hingga air liur menetes (drooling), posisi duduk condong ke depan (tripod position) untuk membantu bernapas, dan suara napas kasar (stridor). Penatalaksanaan epiglottitis akut harus dilakukan secara hati-hati; perawat dilarang untuk mencoba memeriksa tenggorokan secara agresif karena dapat memperparah obstruksi. Fokus utama penanganan adalah menjaga ketenangan anak, memberikan oksigen dengan aliran tinggi, serta segera menghubungi tim medis untuk melakukan tindakan pengamanan jalan napas seperti intubasi endotrakeal atau trakeostomi emergensi. Terapi antibiotik intravena segera diberikan untuk mengatasi infeksi bakteri yang menjadi penyebab utamanya.

Kondisi respirasi akut lainnya yang sering dijumpai pada anak adalah croup atau laringotrakeobronkitis akut. Croup merupakan peradangan yang disebabkan oleh virus, biasanya virus parainfluenza, yang menyebabkan pembengkakan pada area laring dan trakea, sehingga menyempitkan jalan napas anak. Kondisi ini sering kali terjadi pada anak usia antara 6 bulan hingga 3 tahun. Anak dengan croup biasanya mengalami batuk khas yang terdengar seperti menggonggong (barking cough), suara serak, suara napas kasar (stridor inspirasi), dan gejala kesulitan bernapas yang umumnya memburuk pada malam hari. Penatalaksanaan croup di antaranya adalah memberikan oksigen lembab (humidified oxygen), pemberian nebulisasi epinefrin (adrenalin) untuk mengurangi edema jalan napas secara cepat, serta pemberian kortikosteroid sistemik seperti dexamethasone untuk mengurangi inflamasi pada saluran napas. Penting bagi perawat untuk memantau secara ketat status pernapasan anak, memperhatikan saturasi oksigen, serta memberikan

edukasi kepada keluarga tentang tanda bahaya yang perlu diperhatikan selama pemantauan di rumah setelah fase akut teratasi.

D. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Kardiovaskular pada Anak

Kegawatdaruratan kardiovaskular pada anak merupakan kondisi kritis yang memerlukan tindakan cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik. Berbagai kondisi yang termasuk dalam kegawatdaruratan kardiovaskular pada anak meliputi keadaan syok (hipovolemik, septik, dan kardiogenik), henti jantung yang memerlukan tindakan resusitasi kardiopulmoner, serta aritmia berat yang mengarah pada gagal jantung akut. Sebagai tenaga kesehatan di garda terdepan, perawat perlu memahami secara mendalam tentang tanda-tanda klinis, mekanisme fisiologis, serta intervensi keperawatan maupun medis yang harus segera dilakukan dalam situasi-situasi tersebut.

Salah satu kondisi kegawatdaruratan kardiovaskular yang sering dijumpai pada anak adalah syok. Syok sendiri merupakan kondisi klinis di mana terjadi penurunan perfusi jaringan yang signifikan, sehingga tubuh tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi yang penting untuk kelangsungan fungsi organ-organ vital. Terdapat beberapa tipe syok yang sering ditemukan pada anak, yaitu syok hipovolemik, syok septik, dan syok kardiogenik. Syok hipovolemik terjadi akibat berkurangnya volume cairan atau darah dalam tubuh, seperti pada kasus perdarahan hebat akibat trauma atau kehilangan cairan tubuh yang masif pada diare berat. Pada kondisi ini, tanda klinis yang terlihat adalah pucat, kulit teraba dingin, denyut nadi cepat dan lemah, tekanan darah menurun, serta gangguan kesadaran. Penatalaksanaan yang dilakukan segera adalah pemberian cairan intravena cepat seperti kristaloid atau koloid untuk memulihkan volume cairan tubuh dan meningkatkan perfusi jaringan secara cepat.

Pada kasus syok septik, penyebab utamanya adalah infeksi yang berat yang menyebabkan terjadinya respons inflamasi sistemik hebat, mengakibatkan vasodilatasi perifer yang ekstrem dan penurunan volume intravaskular efektif. Secara klinis, anak dengan syok septik umumnya akan mengalami demam atau hipotermia, nadi cepat, tekanan darah rendah, gangguan kesadaran, serta kulit yang hangat pada fase awal lalu menjadi dingin dan lembap pada tahap lanjut. Penanganan utama syok septik meliputi pemberian antibiotik spektrum luas secara cepat, pemberian cairan intravena agresif, serta pemberian obat vasoaktif seperti dopamin atau epinefrin untuk mempertahankan tekanan darah dan perfusi jaringan.

Adapun syok kardiogenik merupakan kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah secara efektif akibat gangguan fungsi jantung yang berat. Hal ini biasanya disebabkan oleh kelainan jantung bawaan, miokarditis berat, atau

gangguan irama jantung yang signifikan. Gejala syok kardiogenik pada anak ditandai oleh sesak napas hebat, sianosis, edema paru, denyut jantung sangat cepat atau sangat lambat, tekanan darah yang rendah, dan gangguan kesadaran yang progresif. Penatalaksanaan pada syok kardiogenik termasuk pemberian oksigen dengan aliran tinggi, pemberian cairan hati-hati (dibatasi jumlahnya), dan penggunaan obat inotropik seperti dobutamin untuk meningkatkan kontraktilitas jantung. Anak dengan kondisi ini biasanya memerlukan penanganan di unit perawatan intensif dengan pengawasan yang ketat.

Kondisi kegawatdaruratan lain yang juga sangat kritis dalam kardiovaskular pediatrik adalah henti jantung. Henti jantung pada anak dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti asfiksia akibat tenggelam atau tersedak, gagal napas akut, trauma berat, gangguan irama jantung yang fatal, hingga kondisi elektrolit yang berat. Pada kondisi ini, tindakan segera berupa resusitasi kardiopulmoner pediatrik atau Pediatric Advanced Life Support (PALS) harus segera dilakukan. PALS merupakan serangkaian intervensi yang sistematis yang bertujuan untuk mengembalikan sirkulasi spontan dan mempertahankan fungsi vital tubuh. Tahapan utama dalam PALS meliputi kompresi dada yang efektif, ventilasi paru secara teratur, pemberian obat-obatan emergensi seperti epinefrin atau atropin, serta pemasangan akses intravena atau intraosseus yang cepat. Perawat dalam situasi ini memiliki peran vital dalam melakukan resusitasi, menjaga kelancaran komunikasi antar anggota tim, serta memastikan pemberian intervensi yang sesuai dengan protokol resusitasi terbaru.

Selain syok dan henti jantung, kondisi aritmia berat dan gagal jantung akut pada anak juga merupakan bagian dari kegawatdaruratan kardiovaskular pediatrik. Aritmia berat, seperti bradikardia ekstrem, takikardia supraventrikular, atau fibrilasi ventrikel, dapat dengan cepat menyebabkan penurunan cardiac output yang drastis hingga gagal jantung akut. Tanda klinis dari aritmia berat pada anak meliputi denyut jantung tidak teratur, palpitasi, nyeri dada, sesak napas hebat, pusing, bahkan penurunan kesadaran mendadak. Intervensi awal berupa pemberian oksigen serta pemantauan ketat irama jantung melalui monitor jantung. Jika aritmia sangat parah atau tidak stabil, tindakan segera berupa kardioversi elektrik atau defibrilasi dilakukan oleh tim medis.

Pada kondisi gagal jantung akut pada anak, manifestasi klinis utama yang dapat ditemukan antara lain adalah kesulitan bernapas berat, edema paru, napas cepat, denyut jantung meningkat drastis, hepatomegali, edema perifer, dan sianosis. Penanganan utama mencakup pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi,

pemberian diuretik seperti furosemide untuk mengurangi beban cairan, pemberian inotropik untuk meningkatkan kontraktilitas jantung, serta pemantauan ketat terhadap tanda vital dan status respirasi. Anak dengan gagal jantung akut biasanya memerlukan perawatan intensif di ICU pediatrik.

Secara umum, perawat yang menangani kegawatdaruratan kardiovaskular pediatrik harus memiliki kemampuan klinis yang kuat, kompetensi yang tinggi dalam teknik resusitasi dan stabilisasi pasien, serta kemampuan komunikasi yang baik dalam koordinasi antar anggota tim medis. Pengetahuan yang komprehensif dan kesiapan mental dalam menghadapi situasi kritis sangat menentukan keberhasilan penatalaksanaan serta membantu memperbaiki prognosis jangka panjang anak-anak yang mengalami kondisi kegawatdaruratan kardiovaskular ini.

E. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Neurologis pada Anak

Kegawatdaruratan neurologis pada anak merupakan situasi medis yang serius dan membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Kondisi neurologis akut ini mencakup berbagai gangguan yang mempengaruhi fungsi otak dan sistem saraf, mulai dari kejang demam yang sering ditemui pada anak kecil hingga kondisi yang lebih kompleks seperti status epileptikus, cedera kepala traumatik, infeksi sistem saraf pusat seperti ensefalitis dan meningitis akut, serta kondisi koma atau penurunan kesadaran yang signifikan. Sebagai tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penatalaksanaan kondisi kritis anak, perawat dituntut memahami secara mendalam setiap jenis kondisi neurologis tersebut, mengenali tanda klinis yang khas, dan mampu melakukan tindakan perawatan darurat dengan segera, terstruktur, serta efektif.

Kondisi kegawatdaruratan neurologis pertama yang sering terjadi pada anak adalah kejang demam dan status epileptikus. Kejang demam adalah bentuk kejang yang paling umum terjadi pada anak-anak berusia antara 6 bulan hingga 5 tahun yang dipicu oleh demam tinggi. Meskipun umumnya tidak menyebabkan kerusakan permanen, kondisi ini seringkali menimbulkan kepanikan besar pada keluarga. Anak dengan kejang demam menunjukkan gejala berupa tubuh kaku, gerakan kejang berulang, mata terbalik, hilangnya kesadaran sementara, dan kadang disertai dengan perubahan warna kulit menjadi pucat atau kebiruan. Tindakan utama perawat dalam menangani kejang demam adalah memastikan jalan napas anak tetap terbuka, mencegah cedera akibat kejang, memberikan oksigen bila diperlukan, menurunkan suhu tubuh dengan antipiretik seperti parasetamol, serta memonitor tanda-tanda vital secara ketat.

Pada kasus yang lebih berat, kejang dapat berkembang menjadi status epileptikus, yaitu suatu kondisi kejang yang berlangsung lebih dari 5 menit secara

terus-menerus tanpa pemulihan kesadaran sepenuhnya. Status epileptikus adalah kegawatdaruratan neurologis yang serius, karena berisiko menyebabkan kerusakan otak permanen akibat kekurangan oksigen yang berkepanjangan. Penatalaksanaan status epileptikus meliputi tindakan segera berupa pemberian obat antikonvulsan intravena seperti diazepam atau lorazepam, menjaga jalan napas tetap terbuka, pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi, dan pemantauan tanda vital serta status neurologis secara ketat. Jika kondisi pasien tidak membaik, biasanya anak membutuhkan intervensi lanjutan seperti ventilasi mekanik di unit perawatan intensif.

Cedera kepala traumatik (traumatic brain injury/TBI) merupakan kondisi neurologis akut lainnya yang sering terjadi akibat kecelakaan, jatuh dari ketinggian, atau benturan keras pada kepala. Cedera kepala traumatik pada anak memiliki konsekuensi serius karena bisa menyebabkan perdarahan intrakranial, pembengkakan otak, hingga gangguan fungsi neurologis yang berat. Gejala klinis TBI mencakup sakit kepala hebat, muntah berulang, kejang, penurunan kesadaran yang progresif, pupil yang tidak sama ukurannya, serta tanda-tanda cedera lain yang terlihat jelas. Penatalaksanaan cedera kepala pada anak difokuskan pada memastikan jalan napas bebas hambatan, stabilisasi tulang belakang leher (servikal) dengan collar neck, pemberian oksigen, pemasangan akses intravena untuk cairan atau obat-obatan, serta pemantauan ketat terhadap perubahan neurologis seperti tingkat kesadaran (menggunakan Glasgow Coma Scale anak). Perawat juga bertugas mempersiapkan anak untuk tindakan diagnostik lanjutan seperti CT scan kepala, yang bertujuan mendeteksi perdarahan atau cedera struktural lainnya.

Infeksi sistem saraf pusat, terutama ensefalitis dan meningitis akut, juga merupakan kondisi gawat darurat neurologis yang penting pada anak. Ensefalitis adalah peradangan otak yang sering kali disebabkan oleh infeksi virus seperti herpes simpleks, sedangkan meningitis akut merupakan peradangan selaput otak yang bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Kedua kondisi ini memiliki manifestasi klinis yang mirip, berupa demam tinggi, sakit kepala hebat, mual-muntah, kaku kuduk (leher terasa kaku), kejang, gangguan kesadaran hingga koma, dan kadang disertai ruam kulit khususnya pada meningitis bakterial. Dalam menangani ensefalitis dan meningitis, perawat harus segera memulai pemberian oksigen, memastikan stabilitas jalan napas, pemasangan jalur intravena untuk pemberian cairan dan antibiotik intravena dosis tinggi, serta pemantauan ketat tanda vital, kesadaran, dan gejala neurologis lainnya. Diagnosis definitif biasanya ditegakkan melalui pemeriksaan pungsi lumbal untuk mengambil sampel cairan serebrospinal, sehingga perawat juga harus mempersiapkan dan mendampingi tindakan ini secara hati-hati.

Kondisi terakhir yang menjadi perhatian khusus dalam kegawatdaruratan neurologis pediatrik adalah koma atau penurunan kesadaran yang signifikan. Koma adalah kondisi di mana pasien kehilangan kesadaran secara total dan tidak memberikan respons terhadap stimulus nyeri atau rangsangan eksternal lainnya. Penurunan kesadaran pada anak dapat terjadi akibat berbagai penyebab, seperti trauma kepala berat, infeksi sistem saraf pusat, gangguan metabolik seperti hipoglikemia berat, atau intoksikasi zat tertentu. Penatalaksanaan awal koma meliputi pendekatan ABCDE (memastikan airway terbuka, breathing normal, circulation stabil, evaluasi disabilitas neurologis, dan exposure tubuh secara keseluruhan). Perawat harus secara ketat memantau tingkat kesadaran menggunakan Glasgow Coma Scale anak, mengelola jalan napas pasien termasuk tindakan intubasi bila diperlukan, pemberian cairan dan obat-obatan sesuai kebutuhan, serta mempertahankan suhu tubuh optimal. Dalam kondisi koma, pengawasan ketat terhadap tanda vital, fungsi pernapasan, serta tanda neurologis sangat penting untuk menghindari komplikasi lebih lanjut seperti peningkatan tekanan intrakranial atau gangguan respirasi berat.

F. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Gastrointestinal pada Anak

Kegawatdaruratan gastrointestinal pada anak merupakan kondisi medis yang serius dan memerlukan intervensi segera agar tidak berkembang menjadi komplikasi berat yang mengancam nyawa. Berbagai kondisi seperti diare berat dengan dehidrasi akut, appendisitis akut, intususepsi, dan perdarahan gastrointestinal akut merupakan beberapa masalah umum dalam kegawatdaruratan gastrointestinal yang sering ditemukan pada populasi anak-anak. Sebagai tenaga kesehatan yang menangani pasien di garda terdepan, perawat perlu memahami secara detail mengenai manifestasi klinis, mekanisme terjadinya penyakit, serta tindakan intervensi keperawatan yang diperlukan secara tepat dan cepat.

Salah satu kondisi paling sering terjadi di fasilitas kesehatan adalah diare berat dengan dehidrasi akut. Diare berat pada anak merupakan kondisi di mana anak mengalami buang air besar lebih sering dari biasanya dengan konsistensi feses cair, disertai gejala muntah, penurunan nafsu makan, dan demam. Jika berlangsung secara terus-menerus tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini akan menyebabkan kehilangan cairan tubuh yang signifikan sehingga anak mengalami dehidrasi akut. Manifestasi klinis yang khas dari dehidrasi akut meliputi mata cekung, kulit tampak pucat dan kering, turgor kulit menurun, mulut dan bibir kering, serta anak tampak lesu hingga kesadaran menurun. Penatalaksanaan diare berat disertai dehidrasi akut harus difokuskan pada pemulihan segera cairan tubuh, baik melalui pemberian cairan rehidrasi oral (oralit) pada kondisi ringan-sedang, maupun pemberian cairan

intravena seperti larutan kristaloid (ringer laktat atau normal saline) pada kondisi dehidrasi berat. Perawat juga bertanggung jawab untuk memonitor tanda vital, intake-output cairan secara ketat, dan memberikan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya menjaga kebersihan guna mencegah infeksi berulang.

Appendisitis akut juga merupakan kegawatdaruratan gastrointestinal pediatrik yang sering dijumpai, terutama pada anak usia sekolah dan remaja. Appendisitis akut adalah inflamasi akut pada organ usus buntu (appendiks), yang jika tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan perforasi, peritonitis, hingga sepsis berat. Gejala khas dari appendisitis akut meliputi nyeri hebat pada bagian perut kanan bawah, demam ringan hingga sedang, mual dan muntah, serta nafsu makan yang menurun. Penatalaksanaan awal kondisi ini adalah memastikan anak dalam kondisi stabil, pemberian cairan infus untuk hidrasi dan koreksi elektrolit, serta pemberian analgesik ringan untuk mengurangi rasa nyeri sementara menunggu intervensi bedah. Perawat juga bertanggung jawab untuk mengobservasi secara teliti gejala-gejala yang berkembang seperti tanda-tanda perforasi (misalnya nyeri yang tiba-tiba menghilang lalu diikuti nyeri menyebar hebat ke seluruh abdomen), yang menandakan kondisi darurat bedah segera.

Intususepsi adalah kondisi kegawatdaruratan gastrointestinal lain yang cukup sering terjadi pada anak kecil, terutama bayi dan balita. Intususepsi terjadi ketika salah satu bagian usus masuk ke bagian usus yang lain (teleskopik), menyebabkan penyumbatan atau obstruksi usus akut. Manifestasi klinis intususepsi sangat khas, seperti nyeri perut hebat yang muncul secara tiba-tiba dan bersifat intermiten, anak menangis keras sambil menarik kaki ke arah perut, muntah berulang, dan buang air besar dengan lendir bercampur darah (sering disebut sebagai feses "seperti jelly"). Penatalaksanaan awal intususepsi berfokus pada stabilisasi kondisi pasien melalui pemasangan akses intravena, pemberian cairan untuk mengatasi dehidrasi dan syok, serta pemasangan selang nasogastrik untuk mengurangi tekanan di saluran cerna. Jika diagnosis intususepsi sudah ditegakkan melalui pemeriksaan radiologi (ultrasound abdomen atau foto abdomen), maka intervensi definitif biasanya berupa reduksi non-bedah dengan barium enema atau intervensi bedah jika reduksi non-bedah gagal dilakukan. Perawat memiliki peran penting dalam observasi ketat tanda vital, kondisi abdomen, serta memberikan penjelasan pada orang tua mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.

Perdarahan gastrointestinal akut pada anak juga merupakan kondisi serius yang memerlukan perhatian segera. Perdarahan gastrointestinal bisa terjadi di bagian atas atau bagian bawah saluran cerna dan dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, seperti perdarahan varises esofagus akibat hipertensi portal, perdarahan karena tukak lambung, infeksi gastrointestinal berat, hingga perdarahan usus akibat

penyakit inflamasi atau divertikulum Meckel. Gejala klinis utama berupa muntah darah (hematemesis), buang air besar berwarna kehitaman (melena), atau darah segar bercampur feses (hematokezia). Anak yang mengalami perdarahan gastrointestinal akut biasanya tampak pucat, denyut nadi meningkat, tekanan darah menurun, bahkan bisa mengalami syok hipovolemik berat akibat kehilangan darah yang cepat. Penatalaksanaan awal dalam situasi ini meliputi pemberian oksigen dengan aliran tinggi, pemasangan akses intravena besar untuk pemberian cairan kristaloid atau transfusi darah jika perdarahan sangat banyak, pemasangan selang nasogastrik untuk membantu mengurangi perdarahan, serta pemantauan ketat tanda vital. Selanjutnya, perawat akan mendampingi anak untuk menjalani pemeriksaan endoskopi diagnostik maupun intervensi bedah jika diperlukan, dengan tetap memberikan dukungan emosional kepada keluarga yang sedang mengalami stres akibat situasi kritis ini.

G. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Trauma pada Anak

Kondisi trauma pada anak merupakan kegawatdaruratan yang memiliki implikasi serius dan sering kali membutuhkan intervensi cepat dan terorganisasi guna menghindari konsekuensi jangka panjang, seperti kecacatan permanen bahkan kematian. Trauma pada anak dapat disebabkan oleh berbagai kejadian seperti kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, luka bakar, cedera akibat aktivitas bermain, hingga kasus kekerasan fisik atau penganiayaan (child abuse). Kompleksitas trauma pada anak semakin meningkat karena anak memiliki anatomi, fisiologi, serta respons psikologis yang berbeda dibandingkan orang dewasa, sehingga pendekatan dalam penatalaksanaannya pun perlu disesuaikan secara khusus.

Trauma multisistem atau multiple trauma adalah kondisi yang ditandai oleh cedera berat yang melibatkan lebih dari satu sistem tubuh secara bersamaan, seperti sistem pernapasan, sirkulasi, neurologis, muskuloskeletal, atau gastrointestinal. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh kejadian dengan benturan atau hantaman yang kuat seperti kecelakaan kendaraan bermotor atau jatuh dari tempat tinggi. Anak yang mengalami multiple trauma biasanya datang dengan kondisi yang sangat tidak stabil, seperti gangguan kesadaran, kesulitan bernapas, perdarahan internal maupun eksternal, serta tanda-tanda syok akibat kehilangan darah atau cairan tubuh secara cepat. Penatalaksanaan trauma multisistem pada anak dilakukan dengan pendekatan sistematis ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure). Pertama, perawat harus memastikan jalan napas pasien terbuka (Airway) dan mempertahankan ventilasi yang adekuat (Breathing). Selanjutnya, perawat harus menjaga stabilitas sirkulasi (Circulation) dengan pemberian cairan intravena

agresif dan kontrol perdarahan secara efektif. Penilaian neurologis (Disability) dilakukan untuk mendeteksi cedera kepala atau cedera neurologis lainnya, dan pemeriksaan seluruh tubuh (Exposure) dilakukan untuk menemukan cedera lain yang tidak terlihat secara langsung. Anak dengan trauma multisistem memerlukan koordinasi intensif antara tim multidisiplin, termasuk tim bedah, tim ICU pediatrik, serta perawat spesialis trauma, guna memastikan tindakan diagnostik dan terapeutik dilakukan secara cepat dan akurat.

Selain trauma multisistem, luka bakar akut pada anak merupakan jenis trauma yang sering dijumpai dan memerlukan penanganan segera. Luka bakar pada anak sering terjadi akibat paparan benda panas, air panas, api, bahan kimia, atau listrik. Akibat luka bakar ini, anak dapat mengalami kerusakan kulit, jaringan subkutan, bahkan otot dan jaringan yang lebih dalam tergantung dari kedalaman luka bakar. Anak dengan luka bakar akut mengalami rasa sakit hebat, kerusakan jaringan kulit yang menyebabkan kehilangan cairan tubuh yang signifikan, serta berisiko mengalami infeksi. Penatalaksanaan luka bakar akut pada anak meliputi segera menyingkirkan sumber panas, mendinginkan luka dengan air bersih yang mengalir secara hati-hati, menjaga jalan napas tetap terbuka terutama jika ada luka bakar wajah atau inhalasi asap, memberikan analgesik secara optimal, serta memberikan cairan resusitasi agresif melalui jalur intravena untuk menggantikan cairan yang hilang akibat luka bakar. Perawat juga perlu memastikan pemantauan ketat terhadap tanda vital, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta melakukan perawatan luka yang steril untuk mencegah infeksi sekunder.

Fraktur atau patah tulang dan cedera muskuloskeletal lainnya merupakan bentuk trauma yang sering terjadi pada anak-anak, khususnya akibat jatuh saat bermain atau kecelakaan olahraga. Fraktur pada anak memiliki karakteristik berbeda dibandingkan orang dewasa, mengingat tulang anak masih dalam masa pertumbuhan sehingga dapat mengalami cedera spesifik seperti fraktur greenstick atau epifisis. Anak yang mengalami fraktur biasanya datang dengan keluhan nyeri hebat, bengkak, deformitas pada area cedera, keterbatasan gerak, dan kadang disertai perdarahan atau luka terbuka pada fraktur terbuka. Penatalaksanaan awal pada fraktur mencakup imobilisasi tulang yang cedera menggunakan bidai atau splint untuk mencegah pergerakan yang memperparah cedera, pengelolaan nyeri dengan analgesik yang tepat, elevasi anggota tubuh yang cedera guna mengurangi pembengkakan, serta pemantauan tanda-tanda perfusi jaringan distal dari area yang cedera. Anak biasanya membutuhkan tindakan diagnostik berupa pemeriksaan radiologi (rontgen), serta tindakan lanjutan berupa reposisi atau fiksasi bedah jika diperlukan.

Jenis trauma lain yang sangat penting dan membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya adalah trauma akibat kekerasan atau trauma non-aksidental (child abuse). Kondisi ini biasanya disebabkan oleh tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan yang disengaja dari orang dewasa atau anggota keluarga terdekat. Child abuse sering kali sulit diidentifikasi secara cepat, karena pelaku kekerasan biasanya berusaha menyembunyikan tindakan tersebut. Gejala child abuse bervariasi, mulai dari memar atau lebam pada berbagai bagian tubuh dengan pola tidak wajar, luka bakar dengan pola tertentu, fraktur multipel dengan usia luka berbeda-beda, hingga cedera kepala berat seperti hematoma subdural. Penanganan kasus child abuse memerlukan pendekatan yang sensitif, teliti, dan multidisiplin. Selain penanganan klinis berupa stabilisasi cedera, pemberian analgesik, serta perawatan luka, perawat juga memiliki tanggung jawab penting dalam mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan, mendokumentasikan secara teliti setiap temuan klinis sebagai bukti medis, dan berkoordinasi dengan tim perlindungan anak, psikolog, pekerja sosial, serta pihak berwenang untuk investigasi dan intervensi lebih lanjut. Perawat juga harus memberikan dukungan emosional kepada anak korban serta menjamin perlindungan selama perawatan medis.

H. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Metabolik dan Endokrin pada Anak

Kegawatdaruratan metabolik dan endokrin pada anak merupakan kondisi medis akut yang muncul akibat gangguan metabolisme atau ketidakseimbangan hormon yang terjadi secara tiba-tiba. Kondisi ini membutuhkan deteksi dini, intervensi segera, serta pengelolaan yang tepat untuk mencegah komplikasi berat seperti kerusakan organ permanen atau bahkan kematian. Beberapa kondisi kegawatdaruratan metabolik dan endokrin yang umum dijumpai pada anak meliputi ketoasidosis diabetik, hipoglikemia berat, krisis adrenal, serta gangguan elektrolit akut seperti hiponatremia dan hiperkalemia.

Ketoasidosis diabetik (KAD) merupakan kegawatdaruratan metabolik serius yang sering terjadi pada anak dengan diabetes mellitus tipe 1, terutama jika terjadi keterlambatan dalam diagnosis atau kesalahan dalam pengelolaan insulin. Ketoasidosis diabetik terjadi akibat kurangnya insulin yang menyebabkan tubuh tidak mampu menggunakan glukosa sebagai energi. Sebagai kompensasi, tubuh mulai memecah lemak, yang menyebabkan penumpukan asam keton dalam darah sehingga terjadi asidosis metabolik yang berat. Anak yang mengalami KAD biasanya menunjukkan gejala klasik berupa napas cepat dan dalam (pernapasan Kussmaul), nyeri perut, mual dan muntah, poliuria (sering buang air kecil), polidipsia (rasa haus yang sangat kuat), bau napas seperti buah (buah-buahan fermentasi), hingga gangguan kesadaran. Penatalaksanaan awal kondisi ini bertujuan untuk mengatasi

dehidrasi berat dengan pemberian cairan intravena secara agresif, koreksi ketidakseimbangan elektrolit, serta pemberian insulin intravena secara hati-hati dan bertahap untuk menurunkan kadar gula darah dan mengurangi produksi keton secara aman. Perawat berperan penting dalam memonitor tanda vital secara ketat, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pemantauan gula darah secara teratur guna mencegah terulangnya kondisi ini di masa depan.

Hipoglikemia berat juga merupakan kondisi kegawatdaruratan metabolik yang sering ditemui pada anak, terutama pada mereka yang sedang menjalani terapi insulin atau anak dengan gangguan metabolisme karbohidrat tertentu. Kondisi ini terjadi ketika kadar gula darah turun secara drastis hingga di bawah batas normal, yang dapat menyebabkan gangguan fungsi otak secara cepat. Anak dengan hipoglikemia berat menunjukkan gejala klinis berupa rasa lapar hebat, keringat dingin, pucat, gemetar, gelisah, bahkan dapat terjadi penurunan kesadaran hingga kejang-kejang. Penatalaksanaan hipoglikemia berat meliputi pemberian gula sederhana atau glukosa secara oral pada anak yang sadar, atau pemberian dekstrosa intravena secara cepat pada anak yang mengalami penurunan kesadaran. Selain itu, perawat perlu melakukan pemantauan ketat terhadap gula darah secara berkala, serta melakukan evaluasi respons neurologis setelah gula darah kembali normal. Edukasi kepada keluarga mengenai pengenalan tanda awal hipoglikemia serta cara penanganan dini sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut.

Krisis adrenal adalah kegawatdaruratan endokrin yang serius, terjadi akibat defisiensi akut hormon kortisol yang dapat dialami anak-anak dengan insufisiensi adrenal atau kondisi yang disebut penyakit Addison. Krisis adrenal sering dipicu oleh kondisi stres berat, infeksi, atau trauma, dan manifestasinya berupa hipotensi berat yang tidak responsif terhadap cairan intravena biasa, hipoglikemia, hiponatremia, hiperkalemia, muntah hebat, diare, hingga kehilangan kesadaran. Penatalaksanaan utama dalam krisis adrenal meliputi pemberian cairan intravena dalam jumlah besar untuk mengatasi syok hipovolemik, pemberian segera kortikosteroid intravena seperti hidrokortison dosis tinggi untuk menggantikan hormon kortisol yang kurang, serta pemantauan ketat terhadap tanda vital, gula darah, dan elektrolit darah. Perawat juga berperan dalam memastikan pasien mendapatkan penanganan cepat dan melakukan pemantauan respon klinis secara ketat, karena keterlambatan dalam penanganan krisis adrenal dapat berakibat fatal.

Gangguan elektrolit akut, seperti hiponatremia (penurunan kadar natrium darah) dan hiperkalemia (peningkatan kadar kalium darah), juga merupakan bentuk kegawatdaruratan metabolik yang signifikan pada anak-anak. Hiponatremia pada anak sering disebabkan oleh pemberian cairan intravena yang tidak tepat, sindrom

sekresi hormon antidiuretik yang tidak sesuai (SIADH), atau kondisi kehilangan elektrolit yang berat seperti diare kronik. Anak dengan hiponatremia akut biasanya mengalami gejala neurologis seperti sakit kepala hebat, mual, muntah, hingga kejang-kejang dan penurunan kesadaran. Penatalaksanaan hiponatremia akut dilakukan dengan hati-hati melalui pemberian cairan hipertonik secara perlahan, sambil terus melakukan pemantauan terhadap kadar natrium darah dan status neurologis.

Sementara itu, hiperkalemia adalah peningkatan kadar kalium dalam darah yang bisa terjadi akibat gangguan ginjal akut, pemecahan jaringan yang besar seperti pada trauma berat atau luka bakar luas, maupun pada kondisi seperti insufisiensi adrenal. Manifestasi klinis hiperkalemia meliputi kelemahan otot, gangguan irama jantung, hingga risiko henti jantung mendadak. Penatalaksanaan hiperkalemia meliputi tindakan untuk menurunkan kadar kalium secara cepat melalui pemberian kalsium glukonat intravena untuk melindungi jantung, pemberian insulin intravena bersamaan dengan glukosa untuk memindahkan kalium kembali ke dalam sel, serta penggunaan obat-obatan seperti resin penukar kalium atau dialisis jika kondisi sangat berat. Perawat memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pemantauan ketat tanda vital dan elektrolit, terutama melalui pemeriksaan EKG berulang guna mendeteksi perubahan irama jantung yang berbahaya secara dini.

I. Dukungan Psikososial dalam Keperawatan Anak Gawat Darurat

Situasi gawat darurat pada anak tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kondisi emosional, psikologis, dan sosial, baik bagi anak maupun keluarganya. Saat anak mengalami kondisi darurat, keluarga biasanya mengalami kecemasan yang sangat tinggi, ketakutan akan kehilangan, rasa bersalah, serta kebingungan terhadap situasi yang dihadapi. Anak yang mengalami kondisi gawat darurat pun sering kali merasa takut, nyeri, stres, dan bingung akibat tindakan medis yang tidak familiar atau menyakitkan. Oleh karena itu, dalam konteks keperawatan pediatrik gawat darurat, dukungan psikososial merupakan aspek penting yang harus diberikan secara paralel dengan intervensi fisik atau medis, guna mengurangi trauma psikologis yang dapat berpengaruh jangka panjang pada anak maupun keluarganya.

Dukungan emosional dan psikologis pada anak dalam situasi kegawatdaruratan sangat penting dilakukan oleh perawat, karena anak sering kali belum memiliki kemampuan emosional yang matang untuk memahami sepenuhnya kondisi yang sedang dihadapinya. Anak-anak, terutama pada usia muda, cenderung mengalami stres berat ketika berada di lingkungan rumah sakit yang asing, penuh

suara, cahaya terang, serta dihadapkan dengan berbagai prosedur invasif yang menyakitkan seperti pemasangan infus, pengambilan darah, atau pemasangan alat bantu pernapasan. Dalam situasi ini, perawat perlu menyediakan kenyamanan dan keamanan secara emosional melalui tindakan-tindakan seperti mendampingi anak secara fisik, memberikan sentuhan yang menenangkan, menjaga kontak mata yang hangat dan penuh empati, menggunakan bahasa sederhana yang menenangkan serta sesuai dengan usia anak, serta memberikan penjelasan yang jelas mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, namun dengan pendekatan yang tidak menakutkan. Tindakan ini bertujuan untuk membangun rasa percaya anak terhadap perawat, mengurangi rasa takut dan cemas anak, serta meminimalkan dampak psikologis yang mungkin muncul pasca perawatan.

Tidak kalah penting dari dukungan untuk anak, keluarga atau orang tua anak yang mengalami kondisi kegawatdaruratan juga membutuhkan dukungan emosional yang kuat. Situasi darurat yang terjadi secara tiba-tiba sering kali menyebabkan keluarga mengalami perasaan panik, cemas luar biasa, hingga stres emosional berat yang dapat mengganggu kemampuan mereka dalam mengambil keputusan atau memberikan dukungan pada anaknya. Oleh karena itu, perawat perlu memiliki kepekaan emosional tinggi dalam mengenali kondisi psikologis keluarga pasien, memberikan empati, serta memberikan dukungan melalui pendekatan komunikasi terapeutik yang efektif. Pendekatan komunikasi terapeutik dalam situasi krisis meliputi pemberian informasi secara jelas, tepat waktu, dan penuh empati; mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian terhadap kekhawatiran keluarga; menunjukkan rasa peduli dan perhatian yang tulus; serta melibatkan keluarga secara aktif dalam proses pengambilan keputusan mengenai tindakan medis dan keperawatan yang diberikan. Dengan pendekatan komunikasi terapeutik yang efektif, keluarga akan merasa lebih tenang, didukung, dan terlibat secara positif dalam proses pemulihan anaknya.

Setelah fase akut dari kegawatdaruratan teratasi, keluarga pasien anak juga membutuhkan edukasi yang mendalam mengenai kondisi anaknya serta perawatan yang perlu dilanjutkan di rumah atau setelah keluar dari rumah sakit. Edukasi keluarga pasca-gawat darurat merupakan bagian penting dalam rangka memastikan keluarga memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup tentang cara merawat anaknya setelah keluar dari situasi kritis. Edukasi yang diberikan oleh perawat kepada keluarga mencakup penjelasan detail mengenai kondisi medis anak, pengenalan tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai, instruksi penggunaan obat-obatan yang tepat, informasi tentang kunjungan ulang atau follow-up yang diperlukan, serta petunjuk khusus mengenai cara penanganan kondisi tertentu di rumah, seperti manajemen luka bakar, perawatan luka jahitan, atau tanda bahaya

pada kondisi kejang demam. Dalam proses edukasi ini, perawat harus menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, bebas jargon medis yang rumit, serta memastikan bahwa keluarga benar-benar memahami informasi yang diberikan dengan cara meminta mereka menjelaskan kembali informasi yang diterima.

Selain memberikan edukasi medis, perawat juga berperan penting dalam memberikan edukasi psikologis kepada keluarga tentang cara-cara mendukung pemulihan emosional anak setelah mengalami kejadian traumatis akibat kegawatdaruratan tersebut. Perawat perlu memberikan saran tentang pendekatan yang tepat untuk membantu anak mengungkapkan perasaan takut atau cemas, memberikan rasa aman di lingkungan rumah, serta mengidentifikasi gejala stres pascatrauma yang mungkin muncul di kemudian hari. Jika diperlukan, perawat juga harus menyarankan keluarga untuk menghubungi tenaga profesional di bidang psikologi atau konselor yang dapat membantu dalam proses pemulihan psikologis anak dan keluarganya secara lebih mendalam.

J. Kolaborasi Tim Interprofesional dalam Keperawatan Anak Gawat Darurat

Kolaborasi tim interprofesional merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan penatalaksanaan kasus darurat pediatrik. Penanganan kondisi gawat darurat pada anak sangat kompleks, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus, serta harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan melibatkan berbagai profesi kesehatan. Tim interprofesional dalam konteks kegawatdaruratan pediatrik terdiri dari berbagai tenaga kesehatan yang saling bekerja sama dan saling melengkapi, antara lain dokter spesialis anak, dokter spesialis bedah anak, perawat gawat darurat pediatrik, apoteker, ahli gizi, tenaga radiologi, terapis respirasi, psikolog klinis, pekerja sosial medis, serta petugas transportasi medis darurat. Setiap anggota tim ini memiliki peran dan tanggung jawab spesifik yang harus dijalankan secara bersamaan dalam proses penanganan anak yang mengalami kondisi kritis.

Tim multidisiplin dalam penatalaksanaan kasus darurat pediatrik memiliki peran penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan yang holistik, menyeluruh, serta berkelanjutan dari berbagai aspek medis, keperawatan, psikologis, hingga sosial. Dalam situasi gawat darurat, tim multidisiplin ini bekerja secara simultan dengan mengacu pada protokol atau panduan standar yang telah disepakati bersama. Dokter spesialis anak bertanggung jawab atas diagnosis awal, penentuan prioritas terapi medis, serta memberikan instruksi pengobatan yang tepat. Dokter spesialis bedah anak terlibat aktif apabila kondisi darurat membutuhkan tindakan pembedahan segera. Perawat gawat darurat pediatrik merupakan anggota tim yang sangat krusial, bertugas melakukan triase, stabilisasi awal pasien, pemberian intervensi keperawatan, serta pemantauan ketat terhadap

respons pasien terhadap pengobatan. Selain itu, apoteker juga berperan penting dalam menyediakan obat-obatan darurat dengan dosis dan bentuk yang tepat untuk anak. Tenaga ahli radiologi melakukan pemeriksaan pencitraan darurat seperti rontgen, ultrasonografi, atau CT scan guna menunjang proses diagnosis cepat. Psikolog klinis dan pekerja sosial medis terlibat dalam memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada keluarga serta memastikan kebutuhan sosial pasien terpenuhi dengan baik. Dengan peran masing-masing profesi yang jelas, komprehensif, dan terintegrasi, maka penanganan anak dalam kondisi darurat dapat dilakukan secara lebih optimal, efektif, serta efisien.

Agar tim multidisiplin tersebut dapat bekerja secara maksimal, strategi komunikasi antarprofesi menjadi hal yang sangat esensial. Komunikasi antarprofesi yang efektif dalam situasi gawat darurat anak mencakup berbagai aspek seperti kejelasan pesan, ketepatan informasi, kesegeraan dalam penyampaian informasi penting, dan sikap saling menghargai antar anggota tim. Dalam situasi kritis, komunikasi harus disampaikan secara singkat, jelas, dan menggunakan istilah medis yang dipahami bersama oleh seluruh anggota tim. Salah satu metode yang sering digunakan dalam komunikasi antarprofesi dalam kegawatdaruratan adalah pendekatan SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), yaitu menyampaikan informasi dengan urutan situasi terkini pasien, latar belakang kejadian atau riwayat kesehatan, penilaian terhadap kondisi klinis, dan rekomendasi tindakan medis yang diperlukan. Dengan komunikasi yang terstruktur seperti ini, risiko kesalahan informasi dapat dikurangi, dan tindakan intervensi yang dilakukan akan lebih tepat sasaran dan tepat waktu.

Selain komunikasi internal di antara anggota tim multidisiplin, komunikasi juga diperlukan dalam konteks eksternal, khususnya saat melakukan rujukan dan transportasi medis darurat. Situasi kegawatdaruratan pediatrik sering kali mengharuskan pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan dengan tingkat layanan lebih tinggi atau fasilitas khusus, seperti rumah sakit dengan unit perawatan intensif pediatrik (PICU). Proses rujukan ini memerlukan koordinasi yang ketat, mulai dari penentuan tujuan rujukan yang tepat sesuai kebutuhan medis anak, koordinasi awal melalui komunikasi telepon antara fasilitas kesehatan pengirim dan penerima pasien, hingga persiapan transportasi medis yang aman bagi pasien. Dalam proses ini, perawat memiliki tanggung jawab untuk memastikan kestabilan kondisi pasien sebelum transportasi dilakukan, menyiapkan dokumen medis seperti ringkasan klinis pasien, data pemantauan selama di fasilitas awal, serta menyediakan informasi secara detail mengenai tindakan medis atau keperawatan yang telah diberikan kepada pasien.

Transportasi medis darurat pada anak membutuhkan perhatian khusus karena kondisi fisiologis anak yang lebih rentan terhadap perubahan lingkungan selama proses transportasi. Oleh karena itu, selama transportasi, tim transportasi medis darurat yang terdiri dari perawat atau dokter yang sudah terlatih harus terus memantau tanda-tanda vital pasien, memastikan jalan napas tetap terbuka, menjaga kestabilan cairan dan elektrolit, serta siap melakukan intervensi emergensi jika kondisi pasien memburuk selama perjalanan. Selama proses transportasi ini pula, komunikasi intensif harus terus dilakukan dengan fasilitas kesehatan penerima pasien, memberikan update kondisi pasien secara periodik sehingga tim penerima dapat bersiap untuk melakukan intervensi lanjutan segera setelah pasien tiba.

K. Tantangan dan Isu Terkini dalam Keperawatan Anak Gawat Darurat

Dalam praktik keperawatan pediatrik, kasus kegawatdaruratan anak merupakan suatu hal yang dinamis dan terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Saat ini, terdapat berbagai tren terbaru yang muncul dalam kasus kegawatdaruratan pediatrik, yang menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat anak di unit gawat darurat. Salah satu tren yang menonjol adalah meningkatnya insiden kasus trauma fisik, seperti cedera akibat kecelakaan lalu lintas, kecelakaan rumah tangga, dan cedera akibat kekerasan pada anak. Selain itu, kasus kegawatdaruratan akibat gangguan respirasi akut, seperti serangan asma berat dan infeksi pernapasan akut berat, juga terus meningkat, terutama di masa-masa musim hujan atau saat terjadi wabah penyakit pernapasan tertentu seperti influenza dan COVID-19. Hal ini menuntut kesiapan ekstra dari tim perawat anak dalam melakukan asesmen yang cepat dan tepat, penanganan yang efektif, serta pemantauan kondisi pasien secara ketat untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut.

Selain itu, perkembangan teknologi terbaru dalam penanganan kegawatdaruratan pediatrik juga memberikan tantangan sekaligus peluang bagi perawat anak. Penggunaan teknologi canggih seperti alat diagnostik digital berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi tren yang semakin populer dalam pelayanan gawat darurat. Misalnya, sistem diagnostik otomatis yang dapat mendeteksi gejala kegawatdaruratan secara dini berdasarkan algoritma khusus yang dirancang untuk pediatri, sangat membantu mempercepat proses identifikasi masalah kesehatan anak. Selain alat diagnostik berbasis AI, perkembangan teknologi lain seperti telemedicine juga memegang peranan yang semakin penting dalam penanganan kegawatdaruratan anak, terutama di wilayah yang sulit dijangkau atau terpencil. Teknologi telemedicine memungkinkan tim medis dan

perawat yang berada di pusat kesehatan kecil atau klinik di daerah terpencil untuk berkonsultasi secara langsung dengan dokter spesialis yang berada di kota besar. Dengan demikian, penanganan pasien anak dalam kondisi kritis dapat dilakukan dengan lebih optimal, bahkan meski sumber daya medis di lokasi tersebut terbatas.

Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi canggih ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait keterampilan dan kesiapan sumber daya manusia di lapangan. Tenaga keperawatan pediatrik di layanan gawat darurat perlu terus meningkatkan kompetensi mereka dalam mengoperasikan teknologi terbaru tersebut. Hal ini membutuhkan pelatihan khusus secara berkelanjutan agar tenaga perawat anak mampu beradaptasi secara cepat, memahami cara kerja perangkat medis baru, serta mampu melakukan interpretasi data medis secara akurat demi pengambilan keputusan klinis yang tepat waktu.

Salah satu isu kritis lainnya dalam keperawatan anak gawat darurat adalah tantangan yang muncul dalam memberikan pelayanan di area-area terpencil atau daerah pedalaman. Daerah-daerah ini sering kali menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, minimnya peralatan medis canggih, serta kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang berpengalaman di bidang pediatri gawat darurat. Situasi ini diperburuk oleh faktor geografis seperti medan yang sulit dijangkau, kondisi jalan yang buruk, serta akses transportasi yang sangat terbatas. Hal-hal tersebut berdampak signifikan terhadap waktu respons terhadap kasus kegawatdaruratan anak yang membutuhkan tindakan segera.

Perawat anak yang bertugas di daerah terpencil harus menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan alat diagnostik, minimnya persediaan obat-obatan esensial untuk anak-anak, hingga kurangnya dukungan logistik dan referral yang cepat ke rumah sakit dengan fasilitas lengkap. Situasi ini menuntut perawat untuk memiliki kreativitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menjalankan perannya. Misalnya, mereka perlu menguasai berbagai teknik alternatif dalam penanganan darurat, mampu memanfaatkan sumber daya lokal yang ada untuk membantu stabilisasi kondisi pasien, serta terampil dalam memberikan edukasi kesehatan kepada keluarga pasien agar keluarga mampu memberikan pertolongan pertama secara tepat sebelum pasien mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Dengan berbagai tren, kemajuan teknologi, serta tantangan yang dihadapi, keperawatan anak dalam situasi kegawatdaruratan memerlukan kolaborasi kuat antar profesi kesehatan, dukungan kebijakan yang berpihak pada peningkatan akses layanan kesehatan, serta pengembangan kompetensi tenaga keperawatan secara terus-menerus. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak, baik di daerah perkotaan maupun terpencil, dapat menerima layanan kegawatdaruratan yang cepat, tepat, efektif, dan berkeadilan.

L. Simpulan

Keperawatan anak dalam situasi kegawatdaruratan merupakan aspek penting dari pelayanan kesehatan anak yang membutuhkan respons cepat, tepat, dan terintegrasi untuk mencegah komplikasi berat hingga risiko kematian. Anak-anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari orang dewasa, mencakup aspek anatomi, fisiologi, psikologis, dan komunikasi. Oleh karena itu, perawat perlu menguasai konsep dasar, prinsip-prinsip penanganan awal, serta teknik khusus seperti pendekatan ABCDE, triase pediatrik, dan pengkajian nyeri serta neurologis secara cermat.

Penatalaksanaan kegawatdaruratan pada anak mencakup berbagai kondisi kritis seperti gangguan respirasi akut, masalah kardiovaskular seperti syok dan henti jantung, kegawatan neurologis seperti kejang dan trauma kepala, kegawatdaruratan gastrointestinal seperti diare berat dan intususepsi, trauma fisik termasuk luka bakar dan fraktur, serta kondisi metabolik dan endokrin seperti ketoasidosis diabetik dan krisis adrenal. Dalam setiap kondisi tersebut, tindakan cepat yang terstruktur menjadi kunci utama untuk mencapai hasil klinis yang optimal.

Selain tindakan klinis, perawat juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan psikososial baik kepada anak maupun keluarga yang mengalami stres akibat kondisi darurat. Pendekatan komunikasi terapeutik, edukasi kesehatan, serta dukungan emosional sangat penting dilakukan untuk mengurangi trauma psikologis, meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi situasi darurat, serta mendukung proses pemulihan fisik dan psikologis anak setelah kondisi akut teratasi.

Kolaborasi tim interprofesional menjadi elemen kunci dalam keberhasilan penanganan anak dalam kondisi gawat darurat. Komunikasi efektif antarprofesi, koordinasi rujukan, dan transportasi medis yang aman serta terorganisasi merupakan bagian integral dari pelayanan gawat darurat pediatrik yang berkualitas. Dengan adanya kolaborasi yang baik, intervensi medis dan keperawatan dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan terstandar.

Saat ini, berbagai tantangan dan isu terkini juga muncul dalam praktik keperawatan anak gawat darurat, termasuk meningkatnya tren kasus trauma fisik, penyakit respirasi akut, serta keterbatasan layanan di daerah terpencil. Perkembangan teknologi seperti alat diagnostik berbasis kecerdasan buatan dan telemedicine menjadi peluang besar untuk memperbaiki pelayanan kegawatdaruratan pediatrik, meskipun membawa tantangan tersendiri dalam hal pelatihan dan adaptasi tenaga kesehatan. Perawat yang bertugas di wilayah terpencil juga dihadapkan pada berbagai keterbatasan fasilitas kesehatan, yang menuntut kreativitas, fleksibilitas, serta kompetensi tinggi dalam menangani kondisi kritis dengan sumber daya yang terbatas.

Secara keseluruhan, keperawatan anak dalam situasi kegawatdaruratan membutuhkan kombinasi antara kompetensi klinis, kemampuan komunikasi dan psikososial, kolaborasi tim yang efektif, pemanfaatan teknologi secara optimal, serta dukungan kebijakan kesehatan yang kuat. Dengan demikian, pelayanan keperawatan anak dalam kondisi gawat darurat dapat memberikan hasil terbaik, meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga, serta memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata untuk seluruh anak di berbagai wilayah.

M. Referensi

- American Association of Critical-Care Nurses. (2025). Therapeutic communication with families of pediatric patients. *AACN Advanced Critical Care*, 36(1), 71–79. Diakses dari <https://aacnjournals.org/aacnacconline/article/36/1/71/32692/Therapeutic-Communication-With-Families-of>
- Burns, B., & Hartenstein, M. (2018). Pediatric triage and the principles of caring for kids. Oregon Health Authority. Diakses dari <https://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EMSTRASUMASYSTEMS/EMSFORCHILDREN/PRPResources/Pediatric-Triage-Principles-Caring-Kids-Dr-Burns-M-Hartenstein.pdf>
- Deakin, C., Nolan, J., Soar, J., Perkins, G., Smith, G. B., & Deakin, C. D. (2010). Initial assessment and treatment with the Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (ABCDE) approach. *British Journal of Anaesthesia*, 105(4), 417–420. <https://doi.org/10.1093/bja/aeq348>
- Dieckmann, T., Brownstein, D., & Gausche-Hill, M. (2000). Pediatric assessment triangle. In *Pediatric Education for Prehospital Professionals (PEPP) course materials*. American Academy of Pediatrics. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Pediatric_assessment_triangle
- Matthews, A., & Jones, B. (2022). Interventions to improve nurse–family communication in the emergency department. *Journal of Clinical Nursing*,

31(4), 812–823. <https://doi.org/10.1111/jocn.17068>

Number Analytics. (2025). Pediatric emergency nursing essentials. Diakses dari <https://www.numberanalytics.com/blog/pediatric-emergency-nursing-essentials> Resuscitation Council UK. (n.d.). The ABCDE approach. Diakses dari <https://www.resus.org.uk/library/abcde-approach>

World Health Organization. (2016). Acute psychosocial care of families in paediatric resuscitation settings. *Journal of Pediatric Nursing*. Diakses dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2588994X2030110X>

World Health Organization. (2016). Paediatric emergency triage, assessment and treatment: care of critically-ill children. Geneva: WHO Press. Diakses dari https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204463/9789241510219_eng.pdf

N. Glosarium

ABCDE: Metode penilaian sistematis untuk pasien dalam kondisi gawat darurat yang mencakup jalan napas (*Airway*), pernapasan (*Breathing*), sirkulasi (*Circulation*), disabilitas neurologis (*Disability*), dan pemeriksaan seluruh tubuh (*Exposure*).

Asfiksia: Kondisi kekurangan oksigen pada jaringan tubuh yang menyebabkan gangguan fungsi organ, sering diakibatkan tersumbatnya jalan napas.

Croup: Peradangan akut laring dan trakea yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus, ditandai batuk menggonggong, suara serak, dan kesulitan bernapas.

Epiglottitis: Peradangan akut pada epiglottis, bagian rawan yang menutup jalan napas saat menelan makanan, yang dapat menyebabkan obstruksi jalan napas secara cepat.

Hipoksia: Kondisi kekurangan oksigen pada jaringan tubuh.

Kardioversi: Tindakan medis untuk mengembalikan irama jantung normal melalui pemberian listrik dengan tegangan tertentu.

Kolaborasi Interprofesional: Kerja sama antarprofesi kesehatan yang melibatkan dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, psikolog, dan lainnya untuk memberikan asuhan yang komprehensif.

Krisis Adrenal: Kondisi kegawatdaruratan akibat kurangnya hormon kortisol secara tiba-tiba, ditandai oleh hipotensi berat, hipoglikemia, dan gangguan kesadaran.

Manuver Heimlich: Teknik pertolongan pertama untuk mengatasi tersedak dengan cara memberikan tekanan perut kuat secara tiba-tiba.

Pediatric Advanced Life Support (PALS): Serangkaian tindakan medis dan keperawatan darurat pada anak untuk mengatasi kondisi henti jantung atau kegawatan jantung lainnya.

Perfusi Jaringan: Proses aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh.

Retraksi Dinding Dada: Kondisi dimana kulit di sekitar tulang dada atau iga tertarik ke dalam saat bernapas, tanda kesulitan bernapas berat.

Status Epileptikus: Kondisi kejang yang berlangsung lebih dari 5 menit tanpa pemulihan kesadaran yang memadai, merupakan kegawatdaruratan neurologis serius.

Syok Hipovolemik: Kondisi syok akibat kehilangan volume cairan atau darah dalam jumlah besar, menyebabkan penurunan perfusi jaringan.

Triase Pediatrik: Proses evaluasi cepat untuk menentukan prioritas penanganan pasien anak berdasarkan tingkat keparahan kondisinya.

Intususepsi: Kondisi medis di mana bagian usus masuk ke bagian usus lainnya (teleskopik), menyebabkan obstruksi akut pada saluran cerna anak.

Ketoasidosis Diabetik (KAD): Kondisi akut pada pasien diabetes akibat kurang insulin yang menyebabkan penumpukan keton dalam darah dan asidosis metabolik.

Hipoglikemia: Kondisi di mana kadar gula darah turun drastis, menyebabkan gangguan fungsi otak dan bisa berakhir fatal jika tidak segera ditangani.

Hiponatremia: Kondisi di mana kadar natrium dalam darah rendah secara signifikan, menyebabkan gangguan neurologis serius seperti kejang dan penurunan kesadaran.

Child Abuse (Kekerasan Anak): Tindakan kekerasan atau penganiayaan fisik terhadap anak, baik disengaja atau tidak, yang menyebabkan cedera serius atau trauma emosional.

PROFIL PENULIS



Dwi Susilowati, APPd., M.Kes., Penulis di lahirkan di Bandung, 13 Juli Tahun 1970. Ketertarikan penulis terhadap ilmu kesehatan, khususnya ilmu keperawatan atau kesehatan tentang anak dan remaja dimulai pada tahun 1998 silam. Latar Belakang Penulis yang awalnya mengenyam pendidikan D3 Keperawatan Depkes di Bandung (1989-1992), membuat penulis mengikuti kesempatan yang diberikan pimpinan saat itu di SPKSJ Bogor yang kemudian berubah menjadi Akper Depkes Bogor untuk mengikuti Tugas Belajar dengan melanjutkan pendidikan di D4 Perawat Pendidik – FK

UGM Yogyakarta dan memilih peminatan Keperawatan Anak (1998-1999). Penulis berkesempatan pula melanjutkan pendidikan ke jenjang Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat – Universitas Indonesia dan berhasil menyelesaikan studi S2 di jurusan Kesehatan Reproduksi – FKM UI pada tahun 2002. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Keperawatan Bogor – Poltekkes Kemenkes Bandung (Perubahan dari Akper Depkes Bogor sejak tahun 2001). Sehari-harinya aktif menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Mengajar sebagai dosen pengampu MK.Konsep Keperawatan, Praktik Keperawatan Dasar, Kebutuhan dasar manusia, Keperawatan Anak, dan Promosi Kesehatan; Serta kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Penulis pun aktif dalam kegiatan ilmiah dan organisasi keprofesian PPNI dan IAKMI Kota Bogor. Kegiatan menulis yang pernah dihasilkan penulis berupa sebuah Modul Pembelajaran Jarak Jauh tentang Promosi Kesehatan (Kerjasama Kemenkes RI dan UT), sebuah Buku Monograf terkait Kecemasan pada Remaja dan Buku Ajar diantaranya berjudul: Perempuan dan Kesehatan Keluarga; Pertumbuhan Dan Perkembangan Manusia; Keperawatan Anak sehat dan Sakit (Penerbit: PT Nuansa Fajar Cemerlang); Pedoman Karya Tulis Ilmiah Dengan Desain Studi Kasus Bagi Mahasiswa Keperawatan (Penerbit: DeePublish). Penulis pun pernah mengambil bagian dalam penulisan *Book Chapter: Sistem Perlindungan Anak di Indonesia* (Penerbit: PT.Nuansa Fajar Cemerlang); dan *Mitigasi Bencana Untuk Anak Usia Dini* (Penerbit: Media Sains Indonesia). Pernah terbit juga sebuah artikel ilmiah kesehatan di surat kabar lokal.

Email Penulis: dwi@staff.poltekkesbandung.ac.id

PROFIL PENULIS



Ns. Amatus Yudi Ismanto, M.Kep., Sp. Kep. An., PhD.NS., lahir di Mopuya, 20 September 1982. Ia telah menyelesaikan studi Ners di Universitas Katolik De La Salle Manado (2008), lalu melanjutkan pendidikan Program Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Anak di Universitas Indonesia (2012). Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan Program Doktor (S3) Keperawatan di St. Paul University Philippines (2022). Penulis bekerja aktif sebagai dosen tetap di Universitas Aisyah Pringsewu sejak tahun 2022. Sebelumnya penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Sam Ratulangi Manado (2012-2018). Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, juga merupakan Tim Reviewer Jurnal Lasalle Health Journal dan Celebes Nursing Journal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ismanto_yudi@yahoo.com



Wa Nuliana, S.Kep., Ns., M.Kep., Lahir di Lesane, 11 Maret 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, STIK FAMIKMA MAKASSAR tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2019. Dari tahun 2009 sampai saat ini, penulis berkerja sebagai salah satu dosen pada program studi diploma tiga Keperawatan Masohi Poltekkes Kemenkes Maluku dan mengampu berapa mata kuliah diantaranya; mata kuliah keperawatan anak, metodologi keperawatan, dokumentasi keperawatan, keperawatan jiwa dan ilmu biomedik dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nulianamajid@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Dewi Tiansa Barus, S.Kep., M.K.M., Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Keperawatan Program Sarjana, Fakultas Keperawatan, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Lahir di Galang pada tanggal 11 Februari 1989, penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan (S.Kep) dan Profesi Ners di Institusi yang sama, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat (M.K.M) dan lulus pada tahun 2018. Sebagai Tenaga Pendidik, penulis aktif dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama di bidang keperawatan anak, yang menjadi fokus keilmuan dan minat utama penulis. Berbagai pengalaman mengajar, penelitian, serta publikasi ilmiah telah penulis lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan keperawatan. Buku ajar ini ditulis sebagai bentuk kontribusi nyata penulis dalam memperkaya literatur keperawatan dan mendukung pengembangan ilmu keperawatan anak.



Nur Sophia Matin, S.Keb., Bd., M.Keb., lahir di Malang, 12 April 1997. Setelah lulus dari SMAN 3 Malang, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Airlangga, tepatnya jurusan S1 Kebidanan + Profesi Bidan. Pasca lulus, ia melanjutkan studi di S2 Kebidanan Universitas Brawijaya. Ketika S1, Sophia menjadi salah satu Wisudawan Berprestasi FK UNAIR. Semasa S2, Sophia telah menerbitkan beberapa artikel terindeks Scopus. Sophia pernah bekerja di Klinik Rawat Inap dan Praktik Mandiri Bidan di daerah Gondanglegi, Malang. Ia juga bekerja sebagai asisten peneliti di UPPM FK UNUSA serta sebagai dosen di STIKes Maharani Malang hingga sekarang. Sophia sangat menyukai hal-hal terkait inovasi kesehatan dan inovasi pendidikan. Mari terhubung melalui Instagram (@nursophiaa).

PROFIL PENULIS



Ns. Nita Theresia, S.Kep., M.Kes., Lahir di Barito Utara, 25 September 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu D3 Keperawatan AKPER Notokusumo Yogyakarta Tahun 2003, S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Lambung Mangkurat dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 diterima sebagai Dosen Prodi DIII Keperawatan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Palangka Raya. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangka Raya mengampu mata kuliah Keperawatan Anak dan Maternitas. Dengan lebih dari 19 tahun pengalaman mengajar, penulis telah berkontribusi secara signifikan dalam bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Hasil penelitiannya telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional. Semoga buku ini mampu memberikan nilai tambah, memperkaya pemikiran, dan menginspirasi tindakan yang positif. Jangan ragu untuk terus mengeksplorasi dan memperdalam pengetahuan, karena pembelajaran adalah perjalanan yang tiada henti. Terima kasih telah memilih buku ini sebagai salah satu sumber pengetahuan. Penulis berharap, apa yang telah dituangkan di sini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kita semua pembaca. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nitathere@polkesraya.ac.id
Motto: "Belajar bukan untuk menjadi yang terbaik, tapi untuk menjadi lebih baik dari kemarin."



Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An Lahir di Tegal, 18 September 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII di Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung (AKPERISSA) Tahun 1999, S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Doponegoro tahun 2003, melanjutkan Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Doponegoro tahun 2005. Pendidikan S2 Keperawatan di Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2011 serta melanjutkan Program Spesialis Keperawatan di Universitas Indonesia lulus pada tahun 2012. Saat ini sedang melanjutkan Program Doktorat di Universitas Airlangga Surabaya. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 di AKPERISSA Semarang dan saat ini di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, mengampu mata kuliah Keperawatan Anak. Metodologi Keperawatan, Gizi dan Diet, Biostatistik, Dokumentasi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: indra@unissula.ac.id
Motto: "Jadilah Versi Terbaik Dari Dirimu"

Sinopsis

Buku bunga rampai "Asuhan Keperawatan Anak Komprehensif Berbasis Evidence-Based Practice" hadir sebagai panduan esensial bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada anak. Buku ini disusun dengan pendekatan yang integratif dan berbasis bukti ilmiah terkini, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan anak secara menyeluruh dan profesional.

Topik utama yang diulas dalam buku ini meliputi konsep dasar keperawatan anak yang memberikan landasan teori penting dalam memahami prinsip-prinsip dasar perawatan anak. Selanjutnya, pembaca diajak memahami metode pengkajian keperawatan yang tepat guna merancang dan melaksanakan tindakan yang efektif sesuai dengan kebutuhan anak secara individual.

Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada berbagai kondisi kesehatan yang sering dihadapi oleh anak, termasuk gangguan respirasi, gastrointestinal, penyakit infeksi, dan gangguan neurologis. Setiap topik disajikan secara detail dengan mengintegrasikan hasil penelitian terbaru, sehingga tenaga kesehatan mampu mengidentifikasi gejala, merencanakan, serta mengimplementasikan intervensi yang tepat.

Selain itu, topik manajemen nyeri pada anak dibahas secara mendalam untuk membantu tenaga kesehatan dalam mengenali, mengukur, dan mengelola nyeri anak secara efektif, yang tentunya berkontribusi besar pada kenyamanan dan kesembuhan anak selama menjalani perawatan. Terakhir, pembahasan mengenai keperawatan anak dalam situasi kegawatdaruratan memberikan panduan praktis yang sangat dibutuhkan untuk tindakan cepat dan tepat dalam situasi kritis.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti ilmiah, buku ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi utama bagi mahasiswa keperawatan, praktisi kesehatan anak, dan berbagai pihak yang peduli pada kesehatan anak. Buku ini menjadi langkah penting dalam menciptakan pelayanan kesehatan anak yang berkualitas, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

Buku bunga rampai "Asuhan Keperawatan Anak Komprehensif Berbasis Evidence-Based Practice" hadir sebagai panduan esensial bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada anak. Buku ini disusun dengan pendekatan yang integratif dan berbasis bukti ilmiah terkini, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan anak secara menyeluruh dan profesional.

Topik utama yang diulas dalam buku ini meliputi konsep dasar keperawatan anak yang memberikan landasan teori penting dalam memahami prinsip-prinsip dasar perawatan anak. Selanjutnya, pembaca diajak memahami metode pengkajian keperawatan yang tepat guna merancang dan melaksanakan tindakan yang efektif sesuai dengan kebutuhan anak secara individual.

Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada berbagai kondisi kesehatan yang sering dihadapi oleh anak, termasuk gangguan respirasi, gastrointestinal, penyakit infeksi, dan gangguan neurologis. Setiap topik disajikan secara detail dengan mengintegrasikan hasil penelitian terbaru, sehingga tenaga kesehatan mampu mengidentifikasi gejala, merencanakan, serta mengimplementasikan intervensi yang tepat.

Selain itu, topik manajemen nyeri pada anak dibahas secara mendalam untuk membantu tenaga kesehatan dalam mengenali, mengukur, dan mengelola nyeri anak secara efektif, yang tentunya berkontribusi besar pada kenyamanan dan kesembuhan anak selama menjalani perawatan. Terakhir, pembahasan mengenai keperawatan anak dalam situasi kegawatdaruratan memberikan panduan praktis yang sangat dibutuhkan untuk tindakan cepat dan tepat dalam situasi kritis. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti ilmiah, buku ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi utama bagi mahasiswa keperawatan, praktisi kesehatan anak, dan berbagai pihak yang peduli pada kesehatan anak. Buku ini menjadi langkah penting dalam menciptakan pelayanan kesehatan anak yang berkualitas, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-83-8



9

786347

294838